

CMASR-2

Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisada

2ª edición



Cecil R. Reynolds, Bert O. Richmond



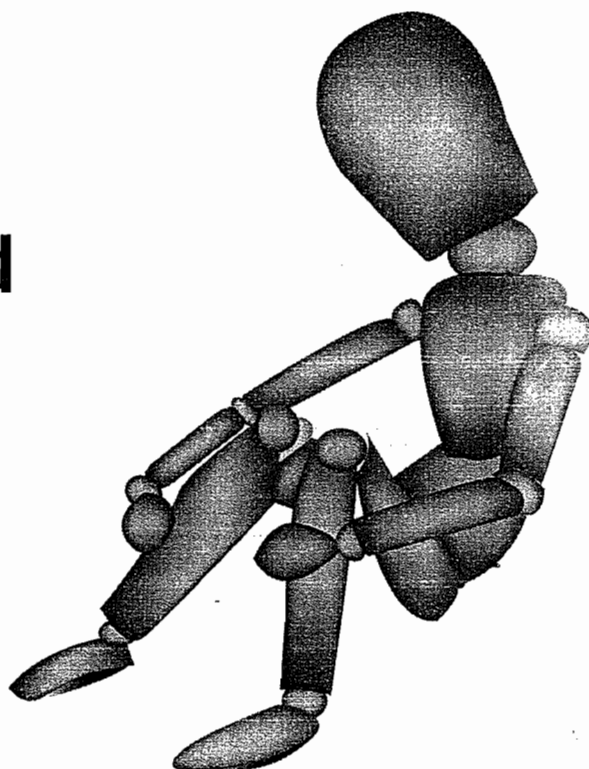
Manual Moderno®

CMASR-2

Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisada

Segunda edición

Manual



Cecil R. Reynolds, Ph.D.,
Bert O. Richmond, Ed.D.

Traducido por:
Lic. Gonzalo María Vélez Espinosa

Análisis estadístico en México:
Mtra. Ma. Refugio Ríos Saldaña
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM

Coordinadora de estandarización en México:
Patricia Corona Duarte
Editorial El Manual Moderno

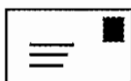


Manual Moderno®

Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.
Av. Sonora 206, Col. Hipódromo, C.P. 06100, México, D.F.

Editorial El Manual Moderno, (Colombia), Ltda
Carrera 12-A No. 79-03/05 Bogotá, DC

**Nos interesa su opinión,
comuníquese con nosotros:**



Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.,
Av. Sonora núm. 206,
Col. Hipódromo,
Deleg. Cuauhtémoc,
06100 México, D.F.



(52-55)52-65-11-00



info@manualmoderno.com
quejas@manualmoderno.com

Para mayor información sobre:

- Catálogo de producto
 - Novedades
 - Pruebas psicológicas en línea y más
- www.manualmoderno.com**

Título original de la obra:

RCMAS-2. Revised Children's Manifest Anxiety Scale, Second Edition

Copyright © 2008 by Western Psychological Services

Translated and reprinted by permission of the publisher, Western Psychological Services.
Not to be reproduced in any form without written permission of Western Psychological
Services, 12031 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90025, USA.
All Rights reserved.

Traducido y publicado con permiso de Western Psychological Services. Ninguna parte
de esta publicación puede ser reproducida sin autorización por escrito de Western
Psychological Services, 12031 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90025, USA.
Todos los derechos reservados.

CMASR-2. Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisada, 2ª edición

D.R. © 2012 por Editorial El Manual Moderno S.A de C.V.

ISBN 978-607-448-265-2

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana, Reg. Núm. 39



Manual Moderno®
es marca registrada de
Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.

Reynolds, Cecil R.

CMASR-2 : escala de ansiedad manifiesta en niños revisada : manual /
Cecil R. Reynolds, Bert O. Richmond ; traducido por Gonzalo María Vélez
Espinosa ; análisis estadístico Ma. Refugio Ríos Saldaña ; coordinadora
de estandarización Patricia Corona Duarte. — segunda edición. — México
: Editorial El Manual Moderno, 2012.
viii, 96 páginas ; 28 cm.

Incluye: Manual, cuestionario-perfil y plantilla.

Traducción: RCMAS-2 : revised children's manifest anxiety scale –
Second edition.

ISBN 978-607-448-265-2

1. Ansiedad en los niños – Pruebas. 2. Psicometría. I. Richmond, Bert
O. II. Vélez Espinosa, Gonzalo María, traductor. III. Ríos Saldaña, Ma.
Refugio. IV. Corona Duarte, Patricia. V. título.

155.41246-scdd21

Biblioteca Nacional de México

Director editorial y producción:
Dr. José Luis Morales Saavedra

Revisión técnica:
Mtra. Claudia Sotelo Arias

Editora asociada:
LCC Tania Uriza Gómez

Diseño de portada:
LDG Elena Frausto Sánchez

Aviso

Las pruebas psicológicas son instrumentos de empleo delicado y por ello su venta está restringida a profesionales que posean la capacidad de emplearlas apropiadamente, quienes deberán acreditarse como psicólogos graduados, pasantes o miembros de una organización nacional de psicólogos.

Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total de este material sin autorización escrita de la Editorial.

Ayúdenos a hacer valer el derecho de autor respetando la propiedad intelectual.

Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.
Av. Sonora núm 206, Col. Hipódromo, 06100
México, D.F.



CeMPro
Centro Mexicano de Protección y Fomento
a los Derechos de Autor
Sociedad de Gestión Colectiva

**Respete el derecho de autor.
No fotocopie esta obra.**

CMASR-2
Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisada, 2ª edición
consta de:

Manual.....	MP 90-1
Cuestionario-perfil.....	MP 90-2
Plantilla.....	MP 90-3

Contenido

PRIMERA PARTE APLICACIÓN, CALIFICACIÓN Y GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN

Capítulo 1. Introducción.....	3
Descripción general	3
Aplicaciones del CMASR-2	4
Cambios en la segunda edición.....	5
Requisitos del usuario	5
Capítulo 2. Aplicación y puntuación.....	7
Aplicación.....	7
Calificación del cuestionario	7
Puntuación del Índice de Respuestas Inconsistentes (INC)	7
Puntuaciones naturales.....	7
Perfiles	12
Capítulo 3. Interpretación y uso clínico.....	13
Interpretación de las puntuaciones del CMASR-2	13
Puntuaciones de validez.....	13
Puntuaciones escalares	14
Contenido individual de los reactivos.....	17
Cómo ayudar al estudiante con problemas de ansiedad	18
Consideraciones adicionales	19
Lo que entendemos acerca de la ansiedad	19
Ansiedad y otras condiciones psicológicas y físicas.....	20

Casos de estudio	21
Caso 1. Perfeccionismo y bajo rendimiento	21
Caso 2. Problema académico y discordia familiar	22
Caso 3. Síndrome de Asperger y conducta disruptiva	23

SEGUNDA PARTE GUÍA TÉCNICA

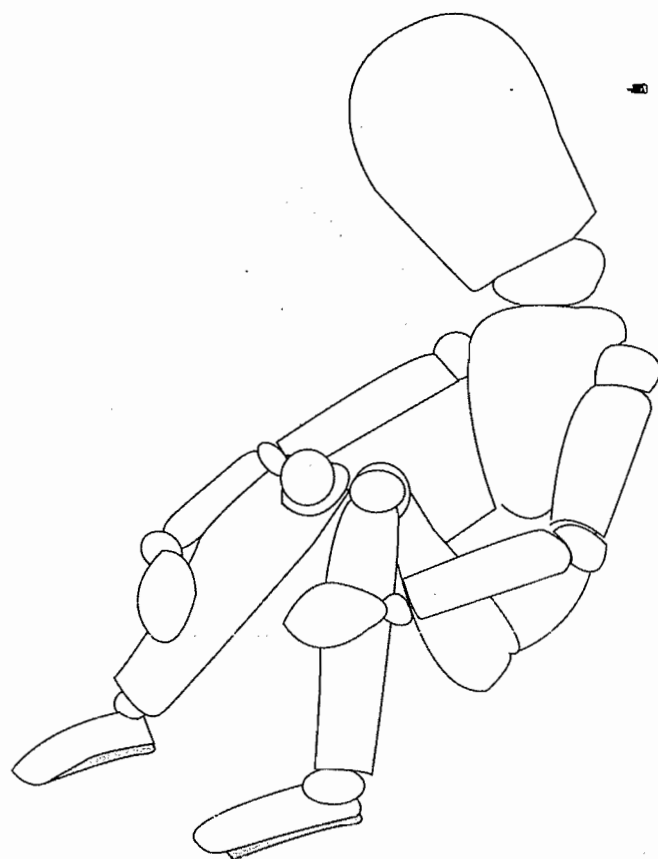
Capítulo 4. Desarrollo y estandarización	27
Desarrollo del CMASR original.....	27
Del CMAS al CMASR	27
Proceso de desarrollo del CMASR	28
Del CMASR al CMASR-2.....	30
Estandarización del CMASR-2 de EUA	32
Variables moderadoras y puntuaciones del CMASR-2	35
Desarrollo del Índice de Respuestas Inconsistentes del CMASR-2.....	37
Capítulo 5. Propiedades psicométricas	39
Confiabilidad como constructo psicométrico	39
Confiabilidad de las puntuaciones del CMASR-2.....	40
Confiabilidad de las puntuaciones del CMASR en muestras especiales.....	41
Subescalas de ansiedad.....	41
Error estándar de medición (EEM).....	42
Defensividad.....	42
Validez.....	42
Evidencia con base teórica.....	43
Evidencia basada en contenido.....	43
Examen empírico del desempeño de los reactivos.....	43
Evidencia de las escalas de relaciones internas.....	44
Estudios de análisis factorial.....	44
Evidencia basada en relaciones con respecto a variables externas.....	51
Puntuaciones CMASR-2 para niños en escenarios clínicos	58
Sesgo de reactivos: grupo étnico y género	58
Resumen	60

Capítulo 6. Investigación sobre ansiedad y el CMASR-2	61
Naturaleza de la ansiedad	61
Medición de la ansiedad manifiesta	64
Revisión de la investigación que utilizan el CMASR	65
Capítulo 7. Proceso de estandarización en México	67
Apéndice 1. Listado de estudios que utilizan el CMASR-2	77
Apéndice 2. Equipo técnico de estandarización CMASR-2 México	81
Referencias	83

11 11 11

Primera parte

Aplicación, calificación y guía para la interpretación



1

Introducción

La *Escala de ansiedad manifiesta en niños revisada, segunda edición* (CMASR-2) es una revisión completa de la *Escala de ansiedad manifiesta en niños revisada* (CMASR; Reynolds y Richmond, 1985), uno de los cuestionarios más utilizados en la investigación de tratamientos para la ansiedad infantil. El instrumento es una medida breve de autoinforme, diseñado como herramienta auxiliar para comprender y tratar problemas de ansiedad que afectan a estudiantes. La segunda edición presenta una muestra de estandarización actualizada, propiedades psicométricas mejoradas y una cobertura más amplia de su contenido. Conserva, sin embargo, las características importantes e intrínsecas del CMASR que contribuyeron a que resultara tan atractivo para los profesionales en evaluación de una amplia variedad de campos de la salud mental y materias afines; su brevedad, su nivel de lectura elemental y sus grupos de reactivos basados en contenido son elementos de gran utilidad para guiar las evaluaciones de seguimiento. De este modo, el CMASR-2 proporciona una herramienta aún más efectiva para entender y tratar la ansiedad de niños en edad escolar.

Descripción general

CMASR-2 es un instrumento de autoinforme de 49 reactivos, diseñado para evaluar el nivel y la naturaleza de la ansiedad en niños de entre 6 y 19 años de edad. El instrumento puede ser administrado de manera individual o grupal, como se describe en el capítulo 2. El niño responde a cada oración con un *Sí* o un *No*. Se responde *Sí* en caso de que el reactivo describa los sentimientos o las acciones del niño y *No* cuando, en términos generales, los reactivos no describan las percepciones que el niño tiene de sí mismo.

CMASR-2 genera puntuaciones para las seis escalas que se identifican en el tabla 1-1. Una puntuación mide la Actitud a la Defensiva, otra, las Respuestas Inconsistentes, y las cuatro restantes brindan una puntuación de Ansiedad Total y puntuaciones para tres escalas relacionadas con la ansiedad —Ansiedad Fisiológica, Inquietud y Ansiedad Social. Además, un grupo de 10 reactivos basados en contenido, que se relacionan específicamente con la ansiedad en el rendimiento, está planteado de tal modo que permite a los clínicos concentrarse en este asunto, en particular durante la evaluación y las actividades del seguimiento en los casos que lo ameriten. Los primeros 10 reactivos del CMASR-2 pueden aplicarse a manera de cuestionario abreviado para generar la puntuación de Ansiedad Total abreviada. Este cuestionario abreviado puede completarse en menos de cinco minutos y resulta adecuado cuando los escolares disponen de poco tiempo, cuando sola-

Tabla 1-1.
Escalas con puntuación en el CMASR-2

Escala	Número de reactivos
Escalas de validez	
Índice de Respuestas Inconsistentes (INC) (nuevo) pares	9
Defensividad (DEF) (antes Mentira)	9
Escalas de ansiedad	
Ansiedad Total (TOT)	40
Ansiedad Fisiológica (FIS)	12
Inquietud (INQ) (antes Inquietud -Hipersensibilidad)	16
Ansiedad Social (SOC) (antes Preocupaciones sociales-Concentración)	12

mente se requiere de una medida breve de la Ansiedad Total con fines de investigación o cuando se realiza un rastreo en numerosos niños.

La muestra de estandarización estuvo compuesta por 2 368 individuos de entre 6 y 19 años de edad, representativos de la población de EUA en términos de variables demográficas determinantes como: género, grupo étnico y estatus socioeconómico. Las normas están estratificadas en tres grupos de edades: de 6 a 8, de 9 a 14 y de 15 a 19. Para mantener el mismo enfoque del CMASR, se recopilaron casos adicionales representativos de los grupos minoritarios, con el fin de proporcionar puntuaciones más estables de la media en los análisis demográficos. Para estos estudios, la muestra total fue de 3 086 niños, incluyendo a 874 afroamericanos y a 495 hispanos. No obstante, es importante advertir que los análisis detallados no han revelado diferencias sistemáticas o significativas en las puntuaciones del CMASR-2, obtenidas por estudiantes de estos grupos. Los hallazgos sugieren poco o ningún impacto de los factores demográficos en las puntuaciones totales o en las puntuaciones escalares. Sin embargo, la muestra, un poco más pequeña indicada antes fue empleada para desarrollar puntuaciones estándar, ya que es más representativa de la población nacional. Esta decisión se tomó al reconocer que la

preocupación detallada por las muestras de representatividad precisa para elaborar normas puede ser un asunto delicado en escenarios tales como escuelas públicas, independientemente de que se haya demostrado o no la influencia de los factores demográficos sensibles en las puntuaciones de las pruebas.

Las estimaciones de confiabilidad de las escalas han sido mejoradas con respecto a las del CMASR, con un valor de 0.92 para la puntuación total y valores en un rango de 0.75 a 0.86 para las puntuaciones escalares. Una descripción detallada del desarrollo y la estandarización del CMASR-2 puede encontrarse en el capítulo 4, y una discusión exhaustiva de su confiabilidad y validez, en el capítulo 5.

Aplicaciones del CMASR-2

Una presentación más extensa del contexto general de la investigación sobre la ansiedad y algunos antecedentes teóricos más específicos del desarrollo de la prueba pueden hallarse en el capítulo 6 de este manual. El apéndice presenta una bibliografía de artículos clave relacionados con la prueba, desde su publicación inicial en 1985. La presente sección proporciona una discusión más sucinta, enfocada en la naturaleza de la ansiedad infantil, en particular, cuando se relaciona con aplicaciones del CMASR-2.

CMASR-2 refleja algunos cambios en las percepciones de los niños del siglo XXI en lo que se refiere a su experiencia sobre la ansiedad. Uno de esos cambios se refleja en la elaboración de la escala de Ansiedad Social. Un segundo cambio se relaciona con la identificación de un nuevo grupo de reactivos referidos a la experiencia de la ansiedad en el desempeño. Las respuestas de los estudiantes a estos reactivos son consistentes con la observación de que los niños en la actualidad presentan una mayor necesidad que antes de tener logros o de desempeñarse adecuadamente en la escuela y entre sus compañeros. CMASR-2 permite al maestro, al orientador, al psicólogo, al padre o a otros adultos significativos tomar consciencia y ayudar al niño a enfrentar mayores presiones para alcanzar el éxito.

La educación escolar y todo lo que conlleva es una fuente común de ansiedad para niños y jóvenes, y el éxito y la utilidad del CMASR en el ámbito escolar han sido gratificantes. Se anticipa que CMASR-2 seguirá siendo útil en escenarios educativos para el diagnóstico de trastornos de ansiedad y para determinar la idoneidad de una educación especial. La ansiedad puede ser una manifestación del desarrollo de sentimientos y temores anormales en circunstancias normales, una de las características distintivas de los candidatos a ese tipo de servicios. No obstante, muchos individuos en edad escolar con problemas de aprendizaje también experimentan ansiedad a niveles clínicos o subclínicos; este tipo de estudiantes deben ser evaluados y supervisados según sus niveles de ansiedad durante su formación académica. Una prueba es un evento académico particular en el que los niños experimentan comúnmente altos niveles de ansiedad que obstaculizan su capacidad de demostrar con precisión sus conocimientos y capacidades. A menudo se documenta que algunos niños se desempeñan mucho mejor en condiciones normales de clase que en una situación

de aplicación de una prueba. Éste es un claro ejemplo de una situación en la que la evaluación por medio del CMASR-2 de niños que no han aprendido a controlar adecuadamente su nivel de ansiedad puede ser sumamente útil para ubicar con precisión el problema, al tiempo que proporciona un punto de partida para la planificación de la intervención.

En el salón de clases puede ser útil para el maestro entender el nivel de ansiedad de cada uno de sus alumnos. Esta información permite que el maestro apoye tanto el desarrollo académico como emocional de los estudiantes. La misma información puede servir para aquellos padres que deseen ayudar a su hijo a adaptarse a las situaciones generadoras de ansiedad y a aprender a responder a ella de un modo más favorable que debilitante. Los datos objetivos sobre la ansiedad son vitales para el consejero o el psicólogo que buscan ayudar al menor que tiene problemas en la escuela, en el hogar, con sus compañeros, con drogas, u otras presiones. La ansiedad es a menudo evidencia sólida del motivo del estrés, y puede guiar al trabajador profesional para que ayude al niño de la manera más efectiva y expedita.

Otras causas comunes de ansiedad infantil son las relaciones del niño con sus compañeros y con su familia. Las relaciones con los compañeros se vuelven cada vez más importantes conforme el niño madura, y al llegar a la adolescencia pueden ser el factor que más influya en su nivel de ansiedad y en su salud mental en conjunto. Los problemas en casa entre los padres, entre alguno de los padres y el hijo o entre hermanos pueden manifestarse como ansiedad debilitante en el niño. A menudo el niño no reconoce ni el grado de la ansiedad que experimenta, ni los antecedentes de la ansiedad. El niño rara vez tiene la capacidad de razonar que las bajas calificaciones se pueden atribuir a un alto nivel de ansiedad ligado a las relaciones entre los miembros de su familia. Es posible que el maestro, el consejero y el psicólogo tampoco estén conscientes de la total interrelación entre las emociones, el estrés y el desempeño del niño.

Así, una medida objetiva de la ansiedad que experimenta el niño puede ser extremadamente útil para determinar con precisión los problemas de su vida que afecten su desempeño académico. En toda evaluación de rutina de un niño que tenga dificultades en la escuela debe incluirse una medida de la ansiedad. CMASR-2 es una medida de la ansiedad que puede ser de máxima utilidad en este contexto, ya que no solamente evalúa el nivel global de ansiedad del niño, sino que también ayuda a determinar su naturaleza. La naturaleza y el alcance de la ansiedad en un niño es una información valiosa para el maestro, los padres y el niño, así como para otros profesionales que puedan trabajar con él mediante una relación de ayuda. Puesto que la ansiedad parece ser resultado inevitable de nuestro modo de vida en un mundo complejo de consecuencias desconocidas, es importante que aprendamos a entenderla y a ayudar al menor a adaptarse a su aparición.

En términos más generales, el CMASR-2 tiene el potencial de ser útil cada vez que surjan interrogantes clínicos o de investigación respecto al nivel o a los patrones de ansiedad experimentados por un individuo o por un grupo de individuos dentro del rango de edades normativo. Aunque las escuelas

y las clínicas han sido los consumidores más frecuentes del CMASR —y CMASR-2 seguirá siendo utilizada por los practicantes en estos escenarios—, ésta también se ha usado ampliamente en la investigación de la ansiedad. El CMASR-2, con su estructura y contenidos actualizados, deberá ser aún más útil en los escenarios de investigación de hoy.

Cambios en la segunda edición

La prueba conserva la sólida puntuación total del CMASR, así como las escalas de Ansiedad Fisiológica, Inquietud y Defensividad. La escala de Preocupaciones Sociales-Concentración fue remplazada por la de Ansiedad Social, y se ha identificado un grupo de reactivos que indagan sobre la ansiedad en el desempeño. Los reactivos de la escala de Mentira que resultaban confusos para los estudiantes debido a la estructura de doble negación de sus enunciados fueron redactados de nuevo, y la escala de Mentira fue renombrada como escala Defensividad. Se añadió un Índice de Respuestas Inconsistentes. Otras mejoras adicionales incluyen la disponibilidad de un Formulario Breve de 10 reactivos, una muestra de estandarización actualizada que contempla la diversidad étnica y mejor apoyo para interpretar los resultados del CMASR-2.

La popularidad del CMASR con estudiantes en edad escolar ha redundado en cientos de reportes de investigación y de opinión con respecto a su utilidad. A la fecha, su presentación original (Reynolds y Richmond, 1978) es el artículo más citado de los publicados en el *Journal of Abnormal Child Psychology*. Es evidente, a partir del extenso uso que del CMASR han hecho educadores, psicólogos, orientadores y otros profesionales que trabajan con niños, así como de los resultados de numerosos estudios de investigación, que CMASR sigue siendo un instrumento útil para entender y tratar los problemas de ansiedad infantil. Este antecedente de una sólida investigación se aplica igualmente en el CMASR-2, debido a su probada equivalencia con el CMASR. Los detalles completos con respecto al desa-

rollo del CMASR-2 y su relación con CMASR pueden encontrarse en el capítulo 4.

Requisitos del usuario

Como requisito mínimo, los individuos que apliquen, marquen la puntuación e interpreten el CMASR-2 deben tener o estar bajo la supervisión de alguien que tenga experiencia en trabajo formal con pruebas y mediciones psicológicas, comprender la psicometría básica que sustenta el uso y desarrollo de pruebas; y contar con experiencia supervisada en aplicación e interpretación de pruebas clínicas. Por lo general, se requiere trabajar también en áreas relacionadas con el desarrollo de trastornos emocionales y de conducta en niños, así como conocimientos de psicopatología evolutiva. Contar con experiencia supervisada en el uso de pruebas de personalidad en el diagnóstico de trastornos emocionales y de conducta en la infancia es lo que se espera de quienes utilicen el CMASR-2 con fines clínicos. Tener nociones de los ámbitos de tratamiento del problema de ansiedad será igualmente de gran ayuda para el usuario. El uso no queda limitado a los psicólogos; aunque anticipamos que serán los psicólogos de distintas áreas (p. ej., psicólogos clínicos especializados en niños y adolescentes, psicólogos, educativos y psicólogos del desarrollo) quienes en su mayoría usarán el CMASR-2. Sin embargo, anticipamos que numerosos investigadores, algunos trabajadores sociales clínicos, orientadores educativos autorizados, psicopedagogos y otras personas con similar capacitación hallarán en el CMASR-2 una herramienta útil. No valoramos los requisitos por sus títulos laborales, sino por los conocimientos, la experiencia y la capacitación, puesto que las condiciones para obtener distintos títulos varían ampliamente de un lugar a otro. Se espera que la totalidad de los usuarios del CMASR-2 estén familiarizados con los estándares más actuales en la aplicación de pruebas educativas y psicológicas, y que se apeguen a los principios éticos y a la normatividad propia de su actividad profesional al emplear la prueba.

En este capítulo se describen los procedimientos básicos para aplicar y obtener la puntuación del CMASR-2. Algunos lineamientos para interpretar las puntuaciones se proporcionan en el capítulo 3.

Aplicación

El CMASR-2 es un instrumento de autoinforme claro y conciso que requiere solamente de 10 a 15 minutos para responderse, su aplicación puede ser individual y grupal. Para contestarlo, los evaluados deben marcar sus respuestas a los reactivos en el Cuestionario. Para obtener la puntuación, se necesita la Hoja de perfil adecuada a la edad para determinar y cotejar las puntuaciones estándar.

Para responder el CMASR-2, el estudiante debe sentarse en una zona cómoda, lo más silenciosa y libre de distracciones posible. Se le debe indicar cómo responder todos los reactivos del cuestionario del CMASR-2, de manera que el puntaje pueda obtenerse con precisión. Hay que explicarle que si faltan algunas de las respuestas a los reactivos, se altera la precisión de los resultados de la prueba, y que si son demasiados los reactivos faltantes, la prueba no se puede calificar en absoluto. Haga que el estudiante lea las instrucciones y responda cualquier pregunta que le pudiera surgir antes de que comience a llenar el cuestionario; permanezca dispuesto a responder preguntas adicionales que el estudiante plantee mientras responde el cuestionario. Si el estudiante pregunta el significado de algún reactivo, se le puede explicar brevemente, ya que no se recomiendan explicaciones extensas. Si luego de la breve aclaración el estudiante continúa indeciso acerca de la respuesta correcta a un reactivo, móvELO a que responda lo mejor que pueda.

Los reactivos del CMASR-2 están escritos de manera que pueden ser entendidos fácilmente por cualquiera con un nivel de lectura de segundo año. Algunos estudiantes más pequeños o con dificultades serias de lectura o atención pueden necesitar más tiempo para completar la prueba. En estos casos, se debe contar de antemano con un lugar adecuado.

Cuando el estudiante indique que terminó de llenar el cuestionario, revíselo para asegurar que haya sido contestado correctamente. Pídale al estudiante que proporcione cualquier información que pudiera faltar, que responda los reactivos que hayan quedado en blanco y que corrija aquellos con doble marca. Si faltan más de cinco o seis respuestas a los reactivos (alrededor de 12%), la precisión de las puntuaciones del CMASR-2 puede verse afectada, y su interpretación debe llevarse a cabo con especial atención. En estos casos, es muy

importante verificar los resultados con información de otras fuentes. Es raro que un estudiante no responda a todos los reactivos si se le motiva a hacerlo.

Calificación del cuestionario

Una muestra de un cuestionario CMASR-2 contestado se proporciona en la figura 2-1. Esta muestra se utilizará para ilustrar los procedimientos de calificación que se describen a lo largo de esta sección.

Una vez que usted haya revisado el cuestionario del CMASR-2 para verificar que fue contestado correctamente y que haya seguido de manera razonable los pasos para hacer que el estudiante corrija la información faltante o marcada de modo incorrecto. Proceda a utilizar la plantilla de calificación para obtener la puntuación natural de cada subescala, siguiendo el orden correspondiente: (1) DEF, 2(FIS), 3(INQ), 4(SOC).

Puntuación del índice de Respuestas Inconsistentes (INC)

Para calcular la puntuación del Índice de Respuestas Inconsistentes (INC) transfiera las respuestas marcadas con un círculo para cada pareja de reactivos INC en la página 2 del cuestionario. Si las respuestas para cualquiera de los primeros ocho pares de reactivos son **diferentes**, anote una marca en la columna de la derecha. Si las respuestas del noveno par de reactivos son **iguales**, trace una marca en la columna. En el ejemplo, las respuestas a los reactivos 2 y 8 son diferentes, por lo que se ha puesto una marca en el espacio a la derecha de esta pareja de reactivos ①. Las respuestas a los reactivos 4 y 10 no son diferentes, por lo que no se ha marcado nada ②. Revise cuántas marcas anotó y escriba el total en el espacio Puntuación del índice INC. En la figura 2-1 se han hecho tres marcas y se han registrado debidamente en el espacio correspondiente ③. Registre también la puntuación INC en el espacio designado en la parte inferior de la Hoja de Perfil. **Nota:** si usted aplicó el Formulario Breve, la puntuación del índice INC no se puede calcular.

Puntuaciones naturales

En el cuestionario, verifique que cada reactivo haya sido contestado correctamente para los reactivos 40, 44 y 48, la puntuación se considera si la respuesta *No* es la que aparece marcada. Si ambas respuestas *Sí* y *No* fueron marcadas y ninguna está tachada, elimínelas, sin importar a qué reactivo correspondan. Si un reactivo quedó sin responder, elimínelo.

CMASR-2
Cuestionario-Perfil

Cecil R. Reynolds, PhD, y Bert O. Richmond, Ed.D

Fecha: _____

Nombre: _____

Edad: _____ Grado escolar: _____

☒ Femenino ☐ Masculino

Instrucciones

Las oraciones que aparecen en este formulario dicen cómo piensas y sienten algunas personas acerca de ellas mismas. Lee con cuidado cada oración y luego encierra en un círculo la palabra que corresponda a tu respuesta. Encierra en un círculo la palabra **Sí** si piensas que así eres. Encierra en un círculo la palabra **No** si crees que no eres así. Responde a cada oración, incluso si te resulta difícil elegir una respuesta que se aplique a ti. No marques **Sí** y **No** para la misma oración. Si quieres cambiar tu respuesta, marca una **X** encima de tu primera respuesta y luego encierra en un círculo tu nueva elección.

No hay respuestas correctas ni incorrectas; sólo tú puedes decirnos cómo piensas y sientes con respecto a ti mismo. Recuerda, después de leer cada oración, pregúntate: "¿Es cierto en mi caso?". Si es así, encierra **Sí** en un círculo; si no lo es, encierra el **No**.

Encierra en un círculo una respuesta por cada oración.

continúa al reverso de esta página

1. Muchas veces siento asco o náuseas.	Sí	☒ No
2. Soy muy nervioso(a).	Sí	☒ No
3. Muchas veces me preocupa que algo malo me pase.	☒ Sí	No
4. Tengo miedo que otros niños se rían de mí durante la clase.	☒ Sí	No
5. Tengo demasiados dolores de cabeza.	Sí	☒ No
6. Me preocupa no agradecerle a los otros.	☒ Sí	No
7. Algunas veces me despierto asustado(a).	Sí	☒ No
8. La gente me pone nervioso(a).	☒ Sí	No
9. Siento que alguien me da de enojo que hago las cosas.	Sí	☒ No
10. Tengo miedo que los demás se rían de mí.	☒ Sí	No
11. Me cuesta tomar algunas decisiones.	☒ Sí	No
12. Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no me salen como quiero.	Sí	☒ No
13. Me parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí.	Sí	☒ No
14. A las personas que conozco me caen bien.	☒ Sí	No
15. Muchas veces siento que me falta el aire.	Sí	☒ No
16. Casi todo el tiempo estoy preocupado(a).	☒ Sí	No
17. Me siento mal si la gente se ríe de mí.	☒ Sí	No
18. Muchas cosas me dan miedo.	Sí	☒ No
19. Siempre soy amable.	☒ Sí	No
20. Me enojo con facilidad.	Sí	☒ No
21. Me preocupa lo que mis papás me vayan a decir.	Sí	☒ No
22. Siento que a los demás no les gusta cómo hago las cosas.	☒ Sí	No
23. Me da miedo hablar en voz alta ante mis compañeros durante la clase.	☒ Sí	No
24. Siempre me porto bien.	Sí	☒ No

Nota: Este cuadernillo está impreso en rojo. NO LO ACEPTES si no cumple ese requisito.

Copyright © 2008 by WESTERN
PSYCHOLOGICAL SERVICES. Not to be
reproduced in whole or in part without
written permission. All rights reserved.



manual moderno®

D.R. © 2012 por
Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.
Av. Sonora 206, Col. Hipódromo, 06100, México, D.F.
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana, Reg. núm. 39

Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida,
almacenada en sistema alguno o transmitida por otro
medio —electrónico, mecánico, fotocopiador, etcétera—
sin permiso previo por escrito de la Editorial.

	DEF	FIS	INQ	SOC
Puntuación natural (reactivos 1-24)	2	3	0	7

MP
90-2

Figura 2-1. Cuestionario CMASR-2 contestado (versión estandarizada para México)

Índice de Respuestas Inconsistentes (INC)

Para calcular la puntuación del índice de Respuestas Inconsistentes (INC) seguir las instrucciones conforme se indique en el manual.

Pares de reactivos INC	Añadir a la puntuación INC
2 — 8	— (marcar si son diferentes)
3 — 35	— (marcar si son diferentes)
4 — 10	— (marcar si son diferentes)
6 — 49	— (marcar si son diferentes)
7 — 39	— (marcar si son diferentes)
19 — 33	— (marcar si son diferentes)
23 — 37	— (marcar si son diferentes)
24 — 29	— (marcar si son diferentes)
38 — 48	— (marcar si son iguales)
Puntuación del índice INC: —	

Encierra en un círculo una respuesta por cada oración.

25. En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a).	☒ Sí	☐ No
26. Me preocupa lo que la gente piense de mí.	☒ Sí	☐ No
27. Me siento solo(a) aunque esté acompañado(a).	☒ Sí	☐ No
28. En la escuela se burlan de mí.	☒ Sí	☐ No
29. Siempre soy bueno(a).	☐ Sí	☒ No
30. Es muy fácil herir mis sentimientos.	☒ Sí	☐ No
31. Me sudan las manos.	☐ Sí	☒ No
32. Me preocupa cometer errores delante de la gente.	☒ Sí	☐ No
33. Siempre soy agradable con todos.	☐ Sí	☒ No
34. Me canso mucho.	☒ Sí	☐ No
35. Me preocupa lo que va a pasar.	☐ Sí	☒ No
36. Los demás son más felices que yo.	☒ Sí	☐ No
37. Temo hablar en voz alta delante de un grupo.	☒ Sí	☐ No
38. Siempre digo la verdad.	☒ Sí	☐ No
39. Tengo pesadillas.	☐ Sí	☒ No
40. A veces me enoja.	☒ Sí	☐ No
41. Me preocupa que durante la clase me hagan participar.	☒ Sí	☐ No
42. Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir en la noche.	☒ Sí	☐ No
43. Me cuesta trabajo concentrarme en mis tareas escolares.	☒ Sí	☐ No
44. A veces digo cosas que no debería decir.	☒ Sí	☐ No
45. Me preocupa que alguien me dé una golpiza.	☐ Sí	☒ No
46. Me muevo mucho en mi asiento.	☐ Sí	☒ No
47. Muchas personas están en mi contra.	☐ Sí	☒ No
48. He dicho alguna mentira.	☐ Sí	☒ No
49. Me preocupa decir alguna tontería.	☒ Sí	☐ No

Nota: Este cuadernillo está impreso en rojo. NO LO ACEPTES si no cumple ese requisito.

Copyright © 2008 by WESTERN
PSYCHOLOGICAL SERVICES. Not to be
reproduced in whole or in part without
written permission. All rights reserved.



Manual Moderno®

D.R. © 2012 por
Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.
Av. Sonora 206, Col. Hipódromo, 06100, México, D.F.
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana, Reg. núm. 39

	DEF	FIS	INQ	SOC
Puntuación natural (reactivos 1-24)	2	3	0	7
Puntuación natural (reactivos 25-49)	2	7	3	5
Puntuación natural total	4	10	3	12
TOT	10	3	12	=25

Figura 2-1. Cuestionario CMASR-2 contestado (versión estandarizada para México).

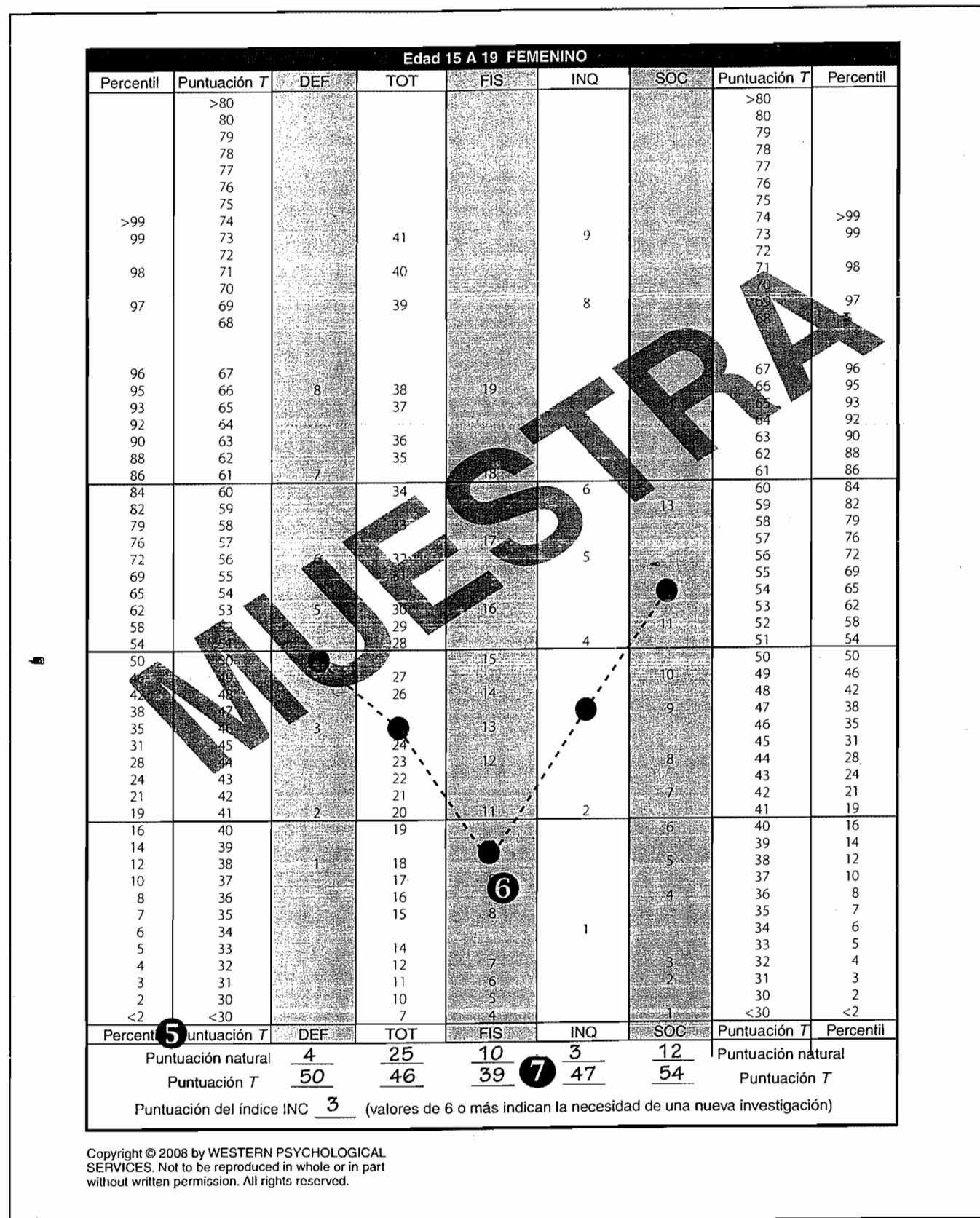


Figura 2-1. Plantilla de calificación CMASR-2 contestado (versión estandarizada para México).

Forma breve FB, por rango de edad FEMENINO						
Percentil	Puntuación T	6 a 8	9 a 14	15 a 19	Puntuación T	Percentil
	>80				>80	
	80				80	
	79				79	
	78				78	
	77				77	
	76				76	
	75				75	
>99	74		10		74	>99
99	73				73	99
	72				72	
98	71				71	98
	70				70	
97	69				69	97
	68				68	
96	67				67	96
95	66		9		66	95
	65				65	
93	65				65	93
	64				64	
92	64				64	92
	63				63	
90	63				63	90
	62				62	
88	62				62	88
	61				61	
86	61				61	86
84	60				60	84
82	59				59	82
	58				58	
79	58				58	79
	57				57	
76	57				57	76
	56				56	
72	56				56	72
	55				55	
69	55				55	69
	54				54	
65	54				54	65
	53				53	
62	53				53	62
	52				52	
58	52				52	58
	51				51	
54	51				51	54
50	50		6		50	50
	49				49	
46	49				49	46
	48				48	
42	48				48	42
	47				47	
38	47				47	38
	46		5		46	
35	46				46	35
	45				45	
31	45				45	31
	44				44	
28	44				44	28
	43				43	
24	43				43	24
	42		4		42	
21	42				42	21
	41				41	
19	41				41	19
16	40				40	16
	39				39	
14	39				39	14
	38		3		38	
12	38				38	12
	37				37	
10	37				37	10
	36				36	
8	36				36	8
	35				35	
7	35				35	7
	34				34	
6	34				34	6
	33				33	
5	33		2		33	5
	32				32	
4	32				32	4
	31				31	
3	31				31	3
	30		1		30	
2	30				30	2
	<30				<30	
<2	<30				<30	<2
Percentil	Puntuación T	6 a 8	9 a 14	15 a 19	Puntuación T	Percentil
Puntuación natural FB-TOT			5		Puntuación natural FB-TOT	
Puntuación T FB-TOT			12		Puntuación T FB-TOT	



Manual Moderno®

D.R. © 2012 por
Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.
Av. Sonora 206, Col. Hipódromo, 06100, México, D.F.
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana, Reg. núm. 39

Figura 2-1 (continúa). Hoja de perfil del CMASR-2 contestado

Para generar la puntuación natural de cada subescala del CMASR-2, localizar la columna de la subescala, colocar la plantilla en el área correspondiente, sumar las repuesta que se hayan marcado en las casillas de dicha columna y anotar la sumatoria en el espacio denominado **Puntuación natural**, que se presenta en la parte inferior de cada página del cuestionario, se suman los subtotales de las puntuaciones naturales de cada subescala y se coloca el resultado en el espacio llamado **Puntuación Natural Total** que aparece en la segunda página del cuestionario. Para calcular el TOT de la puntuación natural, haga un recuento únicamente de las puntuaciones de las escalas FIS, INQ y SOC, y escriba a continuación la suma en el espacio proporcionado. En el ejemplo, la respuesta Si fue encerrada en un círculo en los reactivos 8, 11, 16, 25, 27, 28, 34, 36, 42 y 43 de la escala FIS y la puntuación natural de 10 para la escala FIS fue registrada debidamente ④.

Para el Formulario Breve, simplemente cuente el número de respuestas *Sí* que se hayan dado para los primeros 10 reactivos para obtener la puntuación natural FB-TOT y registre el total en el espacio que se proporciona.

Perfiles

Seleccione el Perfil que corresponda a la edad y género del examinado –de 6 a 8, de 9 a 14 o de 15 a 19– y transfiera la puntuación natural para cada escala del CMASR-2 al espacio correspondiente que se proporciona en la parte inferior de la Hoja de Perfil ⑤. Si usted aplicó el Formato Breve, seleccione el Perfil para Formulario breve y anote la puntuación natural FB-TOT en el espacio que corresponda a la edad del examinado. A continuación, encuentre el valor de la puntuación natural en la columna superior de cada puntuación y enciérrelo en un círculo. Siga la fila en la que el valor de la puntuación natural aparece en el margen izquierdo o derecho de la Hoja de Perfil. Ahí encontrará la Puntuación *T* y el rango de percentil que corresponde al valor de esa puntuación natural. Anote la Puntuación *T* en el espacio que se proporciona debajo de la puntuación natural correspondiente, en la parte inferior de la Hoja de Perfil. En el ejemplo, la puntuación natural de 10 en la escala FIS corresponde a una Puntuación *T* de 39 y a un rango de percentil de 14 ⑥, por lo que se ha escrito 10 en el espacio para la Puntuación *T* de la columna FIS ⑦. En todas las Hojas de Perfil, con excepción del Formulario Breve ⑧, conecte con líneas rectas los valores que encerró en círculos para generar una representación gráfica de los resultados del CMASR-2.

3

Interpretación y uso clínico

La interpretación de los resultados del CMASR-2 se realiza de manera gradual. Primero se debe evaluar la validez de las respuestas proporcionadas; luego, examinar la puntuación de Ansiedad Total, para después evaluar las puntuaciones escalares resultantes y, por último, considerar el contenido específico de los reactivos aprobados. En este capítulo se proporciona una guía para cada uno de estos pasos. Como ocurre con cualquier evaluación psicológica cuantitativa, el resultado de este proceso será el esbozo de hipótesis clínicas que deberán verificarse y cotejarse con toda la información disponible en cada caso, incluyendo un historial completo, entrevistas con el cliente y con otras personas allegadas y los resultados de evaluaciones psicológicas adicionales.

La presentación de lineamientos de interpretación basados en puntuaciones que se ofrece en la siguiente sección es seguida por una discusión de algunas cuestiones generales importantes relativas a la intervención relacionada con la ansiedad y a los contextos educativos y clínicos en los que se utiliza el CMASR-2. Estas cuestiones se refieren al modo en que se integran los resultados basados en puntuaciones al ejercicio completo de la práctica profesional con niños y adolescentes ansiosos y sus familias y maestros.

Interpretación de las puntuaciones del CMASR-2

Como ocurre con cualquier escala que se emplee para medir los aspectos psicológicos de la conducta humana, la validez de las respuestas del CMASR-2 es de primera importancia. Pueden hacerse algunas observaciones clínicas generales para ayudar a determinar la validez probable de las respuestas de un niño. Cualquier tipo de observaciones acerca de la conducta que se relacionen con la buena disposición del examinado para responder de manera cuidadosa y honesta a los reactivos durante la administración de la prueba deberán indicarse. Si hay una resistencia evidente o incapacidad para revelar la ansiedad que el examinado percibe de sí mismo, deberá indicarse. Debido a la sencillez del CMASR-2, es muy raro que un niño o adolescente no lo llene según las instrucciones. En casos excepcionales, quizá uno entre cien o menos, un examinado insiste en responder al azar a pesar de las instrucciones y de que se le motive a hacer lo contrario. Casi con la misma frecuencia, algunos examinados que evidentemente son muy ansiosos revelarán poca o ninguna ansiedad en el CMASR-2. En ambas situaciones, los resultados del CMASR-2 no deben ser interpretados como medida de la ansiedad. Por otro lado, en ambas situaciones la respuesta general del examinado a la

prueba proporciona en sí misma información clínica adicional que puede ser útil para comprenderlo y ayudarlo.

Puntuaciones de validez

Las dos puntuaciones de validez del CMASR-2 —el Índice de Respuestas Inconsistentes (INC) y la puntuación de Defensividad (DEF)— ayudan a revelar y a documentar cuándo un examinado ha dado respuestas inválidas o sesgadas a los reactivos del CMASR-2. El índice INC alude a respuestas que pudieran haber sido dadas al azar o sin tomar en cuenta el contenido de los reactivos del CMASR-2 debido al incumplimiento, descuido, problemas de la vista o falta de comprensión del contenido de un reactivo. La puntuación DEF refiere si las respuestas fueron dadas con una Defensividad, con la intención de presentar una imagen positiva del examinado que probablemente no sea realista y difiera de su verdadero estado. No se dispone de puntuaciones de validez cuando sólo se aplica el Formulario Breve del CMASR-2, por lo que en estos casos las observaciones de la conducta son particularmente importantes.

Índice de Respuestas Inconsistentes (INC). El Índice de Respuestas Inconsistentes (INC) está compuesto por los nueve pares de reactivos del CMASR-2 que se enlistan en el tabla 3-1. Los primeros ocho pares de reactivos reciben por lo general la misma respuesta. Por ejemplo, el primer par de reactivos está compuesto por el 2, "Soy muy nervioso(a)", y el 8, "La gente me pone nervioso(a)". El noveno par de reactivos consta de dos oraciones a las que por lo general se responde de manera opuesta: "Siempre digo la verdad", reactivo 38, y "He dicho alguna mentira", reactivo 48. La puntuación del INC cuenta el número de pares de reactivos a los que se dieron respuestas discordantes. Cuando seis de estos pares de reactivos tienen respuestas discordantes (una puntuación INC de 6), hay 81% de probabilidades de que el examinado haya respondido a los reactivos del CMASR-2 sin tomar en cuenta lo suficiente su significado para proporcionar una descripción fiel de sí mismo. Cuando la puntuación INC es 7, la probabilidad de que las respuestas hayan sido dadas de manera descuidada o al azar asciende a 89%. Una puntuación INC de 8 indica 92% de probabilidades de que las respuestas en el CMASR-2 fueran dadas aleatoriamente.

Cuando la puntuación INC es alta, siempre es importante verificar con el examinado para determinar si se presentaron circunstancias inusuales durante la aplicación de la prueba a las que se les pudieran atribuir las respuestas discrepantes a los pares de reactivos del INC. Ese tipo de información debe ser incluida en cualquier reporte o investigación subsecuente a las puntuaciones del CMASR-2. Cuando se haya determinado que la elevada puntuación INC estuvo relacionada con distraccio-

Tabla 3-1.
Pares de reactivos del índice
de Respuestas Inconsistentes (INC)

2. Soy muy nervioso(a).	
8. La gente me pone nervioso(a).	
3. Muchas veces me preocupa que algo malo me pase.	
35. Me preocupa lo que va a pasar.	
4. Tengo miedo que otros niños se rían de mí durante la clase.	
10. Tengo miedo que los demás se rían de mí.	
6. Me preocupa no agradarle a los otros.	
49. Me preocupa decir alguna tontería.	
7. Algunas veces me despierto asustado(a).	
39. Tengo pesadillas.	
19. Siempre soy amable.	
33. Siempre soy agradable con todos.	
23. Me da miedo hablar en voz alta ante mis compañeros durante la clase.	
37. Temo hablar en voz alta delante de un grupo.	
24. Siempre me porto bien.	
29. Siempre soy bueno(a).	
38. Siempre digo la verdad.	
48. He dicho alguna mentira. (<i>puntuación inversa</i>)	

nes temporales ocurridas durante la aplicación del instrumento, se puede volver a aplicar el CMASR-2 en condiciones más favorables. En ocasiones una puntuación INC alta se relaciona con problemas de lenguaje o de lectura. En tales casos, los reactivos del CMASR-2 pueden ser leídos al estudiante. Sin embargo, cualquier reporte o investigación subsecuente a las puntuaciones del CMASR-2 debe realizarse con precaución y se debe mencionar que ese procedimiento no fue evaluado sistemáticamente durante la estandarización de la prueba.

Defensividad (DEF). La puntuación se basa en las respuestas a los nueve reactivos que se enlistan bajo ese encabezado en el Tabla 3-2. Estas respuestas a los reactivos indican si el examinado tiene disposición para aceptar las imperfecciones cotidianas que comúnmente se experimentan. Los niños más pequeños pueden marcar cinco, seis o más de estos reactivos, pero los niños mayores y los adolescentes por lo general marcan solamente unos cuantos. Así, una puntuación DEF elevada sugiere que un individuo no está dispuesto a admitir las imperfecciones comunes, o bien, ha tratado de dar una imagen muy positiva de sí mismo de una manera un tanto ingenua o inmadura. Puntuaciones relativamente altas indican que se debe llevar a cabo una indagación adicional con el examinado para mejorar la compenetración y establecer si es posible garantizar los resultados de subsecuentes interpretaciones del CMASR-2.

En muchos casos, la visión idealizada que transmite una puntuación DEF alta no tiene la intención de engañar a nadie, sino que se trata más bien de una perspectiva generalizada del sí mismo inexacta o demasiado inflada. El niño puede parecer que no está consciente de que no alcanza el nivel de "perfección" que se considera deseable. En algunos casos, niños con una puntuación DEF elevada expresan de otras múltiples maneras una necesidad exageradamente alta de ser deseados o aceptados socialmente. Estándares altos poco realistas que fueron establecidos por los padres o por sí mismo pueden presentarse en las experiencias formativas de algunos niños con puntuaciones DEF excepcionalmente altas. En otros casos, una puntuación elevada parece relacionarse con sentimientos de aislamiento o rechazo social en el niño. Así, una puntuación DEF alta puede proporcionar información sobre problemas en niños o adolescentes, como una puntuación alta de Ansiedad Total. Los problemas emocionales, las relaciones de pareja inadecuadas, los problemas académicos en la escuela y las situaciones estresantes en casa pueden relacionarse con una puntuación DEF elevada.

Si una puntuación DEF alta parece reflejar una aversión inextricable a revelar información sobre sí mismo o una completa falta de capacidad de autoobservación, la subsecuente interpretación de las puntuaciones, si acaso se realiza, debe llevarse a cabo con extrema precaución. Si el resultado parece indicar un determinado miedo a las consecuencias de revelar información sobre sí mismo en el CMASR-2, el cual pudiera ser reducido o eliminado, el CMASR-2 se podría volver a aplicar, siempre y cuando se hayan tomado antes las medidas necesarias para enfrentar el miedo.

Puntuaciones escalares

Las puntuaciones del CMASR-2 son puntuaciones estándar que se conocen como puntuaciones *T* normalizadas. Las puntuaciones *T* tienen una media de 50 y una desviación estándar de 10. El término **normalizado** denota que cada valor de la puntuación *T* corresponde al mismo rango de percentil para todas las escalas. Un rango de percentil especifica el porcentaje de un grupo particular que obtuvo puntuaciones inferiores a la que se está manejando. Si una puntuación *T* de 57 está asociada con un rango de percentil de 76, esto indica que 76% del grupo de referencia obtuvo una puntuación inferior a 57 *T*. El uso de puntuaciones estándar normalizadas facilita la comparación directa de puntuaciones entre escalas con distinta cantidad de reactivos y distinta distribución de puntuaciones, y entre pruebas. También permite comparar automáticamente las puntuaciones de un individuo determinado con el desempeño promedio del grupo normativo en el que se basaron las puntuaciones estándar. Para el CMASR-2, el grupo normativo es un grupo no clínico disperso por todo EUA de 2 368 niños y adolescentes estratificados en tres grupos de edad: 479, de 6 a 8 años; 1 219, de 9 a 14, y 670, de 15 a 19.

Cuando revise el perfil del CMASR-2, fíjese especialmente en las puntuaciones que se desvían por más de 10 puntos de la puntuación *T* (una desviación estándar [DE]) con respecto al promedio de 50 *T* para un determinado grupo de edad —es decir, puntuaciones *T* menores que 40 *T* o mayores que 60 *T*. Las puntuaciones superiores a 60 *T* sugieren que el examinado tiene por lo menos algunas dificultades con la ansiedad, y

Dirgo Alanis

Tabla 3-2.
Reactivos incluidos en cada una de las escalas del CMASR-2

Defensividad (DEF)	Inquietud (INQ) (continuación)
14. Todas las personas que conozco me caen bien. 19. Siempre soy amable. 24. Siempre me porto bien. 29. Siempre soy bueno(a). 33. Siempre soy agradable con todos. 38. Siempre digo la verdad. 40. A veces me enoja. (<i>nueva redacción; puntuación inversa</i>) 44. A veces digo cosas que no debería decir. (<i>nueva redacción; puntuación inversa</i>) 48. He dicho alguna mentira. (<i>nueva redacción; puntuación Inversa</i>)	8. La gente me pone nervioso(a). (<i>reactivo nuevo</i>) 12. Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no me salen como quiero. 16. Casi todo el tiempo estoy preocupado(a). 17. Me siento mal si la gente se ríe de mí. (<i>reactivo nuevo</i>) 18. Muchas cosas me dan miedo. 21. Me preocupa lo que mis papás me vayan a decir. 26. Me preocupa lo que la gente piense de mí. 30. Es muy fácil herir mis sentimientos. 32. Me preocupa cometer errores delante de la gente. (<i>reactivo nuevo</i>) 35. Me preocupa lo que va a pasar. 42. Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir en la noche. 45. Me preocupa que alguien me dé una golpiza. (<i>reactivo nuevo</i>) 49. Me preocupa decir alguna tontería. (<i>reactivo nuevo</i>)
Ansiedad Fisiológica (FIS)	Ansiedad Social (SOC)
1. Muchas veces siento asco o náuseas. 5. Tengo demasiados dolores de cabeza. (<i>reactivo nuevo</i>) 7. Algunas veces me despierto asustado(a). 11. Me cuesta trabajo tomar decisiones. 15. Muchas veces siento que me falta el aire. 20. Me enoja con facilidad. 25. En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a). 31. Me sudan las manos. 34. Me canso mucho. 39. Tengo pesadillas. 43. Me cuesta trabajo concentrarme en mis tareas escolares. (<i>extraído de la escala de Preocupaciones sociales/ Concentración y añadido a la escala de Ansiedad Fisiológica</i>) 46. Me muevo mucho en mi asiento.	4. Tengo miedo que otros niños se rían de mí durante la clase. (<i>reactivo nuevo</i>) 9. Siento que alguien va a decirme que hago mal las cosas. 10. Tengo miedo que los demás se rían de mí. (<i>reactivo nuevo</i>) 13. Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí. 22. Siento que a los demás no les gusta cómo hago las cosas. 23. Me da miedo hablar en voz alta ante mis compañeros durante la clase. (<i>reactivo nuevo</i>) 27. Me siento solo(a) aunque esté acompañado(a). 28. En la escuela se burlan de mí. (<i>reactivo nuevo</i>) 36. Los demás son más felices que yo. 37. Temo hablar en voz alta delante de un grupo. (<i>reactivo nuevo</i>) 41. Me preocupa que durante la clase me hagan participar. (<i>reactivo nuevo</i>) 47. Muchas personas están en mi contra.
Inquietud (INQ)	
2. Soy muy nervioso(a). 3. Muchas veces me preocupa que algo malo me pase. 6. Me preocupa no agradarle a los otros. (<i>reactivo nuevo</i>)	

puntuaciones inferiores a 40 T indican que está excepcionalmente libre de ansiedad. La mayoría de los examinados con una puntuación alta en alguna escala del CMASR-2 obtendrá puntuaciones altas en una o más de las escalas adicionales. No obstante, cada conjunto de reactivos es lo suficientemente independiente como para garantizar una interpretación por separado, seguida de una indagación y de una comparación relativa entre escalas diferentes. En términos generales, los descriptores cualitativos que aparecen en el tabla 3-3 pueden utilizarse para describir las puntuaciones del CMASR-2. El significado de las escalas individuales se discute con mayor detalle en las secciones siguientes.

Debe advertirse que cuando se haya obtenido una puntuación muy baja o muy alta que entre en conflicto con la

preponderancia de otra evidencia disponible sobre el nivel de ansiedad del examinado, la puntuación del CMASR-2 debe interpretarse con extrema precaución. La experiencia clínica sugiere de manera tentativa que los niños con puntuaciones sumamente bajas en las escalas del CMASR-2 pueden, de hecho, estar experimentando ansiedad, pero tienen dificultades para expresarlo.

Puntuación de Ansiedad Total (TOT). En el tabla 3-2 se presentan los reactivos que integran cada una de las escalas del CMASR-2. La puntuación de Ansiedad Total (TOT) se basa en los 40 reactivos enlistados en el Tabla 3-2 que indagan acerca de la Ansiedad Fisiológica, la Inquietud y la Ansiedad Social. Ninguno de los reactivos de la escala de la puntuación DEF se incluye en la puntuación TOT.

Tabla 3-3.
Descriptor cualitativo sugerido para los rangos de puntuación del CMASR-2

Rango de la puntuación	Descriptor
71 y mayor	Extremadamente problemático
61-70	Moderadamente problemático
40-60	No más problemático que para la mayoría de los estudiantes
39 y menor	Menos problemático que para la mayoría de los estudiantes

La puntuación TOT es la más sólida de las escalas del CMASR-2, en especial para niños pequeños y para examinados con antecedentes de minorías étnicas. Además, como evaluación del nivel de ansiedad total que experimenta un determinado niño, la puntuación TOT representa también el centro de atención principal de los resultados del CMASR-2. Como se trata con mayor detalle más adelante en este capítulo, el CMASR-2 está diseñado para ser útil como auxiliar en la estimación del nivel general de ansiedad de un niño o adolescente; pero no como ayuda para ubicar al niño en una u otra subcategoría de diagnóstico relacionada con la ansiedad. Esto se debe, en lo que respecta a la presencia de ansiedad, a que existe un traslape considerable entre las distintas categorías de diagnóstico. Aunque un niño muy ansioso puede obligarse a lavarse las manos reiteradamente y otro puede tener miedo a la gente, ambos podrían beneficiarse con intervenciones que tengan como objetivo un nivel de ansiedad bajo, lo cual se considera el foco de atención más útil para el adulto que quiere ayudar al niño. De hecho, niños y adolescentes que califican para una diversidad de diagnósticos médicos o psiquiátricos que no son trastornos de ansiedad *per se*, o incluso aquellos que no califican en absoluto para ningún diagnóstico, pueden obtener una puntuación TOT elevada. Se considera que todos esos examinados se beneficiarían con intervenciones para reducir la ansiedad como las que se discuten más adelante en este capítulo. Aunque el examen de las puntuaciones específicas de otras escalas del CMASR-2 y de las respuestas a reactivos individuales se realiza propiamente para esclarecer la naturaleza o las causas de la ansiedad de un niño y los procedimientos directos de seguimiento, esto no debe tomarse en ningún caso como base confiable para delinear alguna categoría de diagnóstico.

Aun así, debe decirse que un nivel de ansiedad elevado tiene en particular muchas probabilidades de asociarse con la presencia de un trastorno de ansiedad o depresivo. Además, un nivel de ansiedad general alto, indicado por una puntuación TOT alta, puede ser un factor significativo dentro de una amplia gama de problemas que se manifiestan en la vida de los niños y adolescentes, incluso en escenarios académicos, como bajo rendimiento, rechazo a la escuela o abandono de la escuela a temprana edad. Por otra parte, la ansiedad puede interactuar con otros factores –pocas aptitudes, dificultades en el hogar, problemas con los padres, abuso de sustancias, tras-

tornos alimenticios o automutilación– que agravan cualquier tipo de disfunción. Identificar la presencia de ansiedad elevada que actúa para mantener la disfunción ofrece una valiosa aportación para diseñar el tratamiento más efectivo para todas las situaciones antes mencionadas.

Puntuación de Ansiedad Total del Formulario Breve (FB-TOT). La puntuación se basa en los primeros 10 reactivos del protocolo CMASR-2. Los 10 reactivos se enlistan en el tabla 3-4. Tres de ellos son de la escala de Ansiedad Fisiológica; cuatro, de la de Inquietud, y tres, de la de Ansiedad Social. La puntuación FB-TOT se relaciona estrechamente con la puntuación de Ansiedad Total de 40 reactivos descrita previamente y debe interpretarse de manera similar para reflejar el nivel general de ansiedad que experimenta un determinado examinado. Sin embargo, puesto que no es posible obtener puntuaciones de validez para el Formulario Breve, y las puntuaciones FB-TOT son ligeramente menos confiables que las puntuaciones TOT, es de particular importancia verificar las interpretaciones cotejándolas con toda la información disponible para un caso determinado. Por otra parte, las interpretaciones de las áreas de contenido separadas no pueden ir más allá de considerar los reactivos individuales que fueron marcados. Por estos motivos se recomienda que los 49 reactivos del CMASR-2 sean aplicados en su totalidad siempre que sea posible.

Ansiedad Fisiológica (FIS). La escala de Ansiedad Fisiológica (FIS) está compuesta por 12 reactivos; cada uno de ellos indaga acerca de la ansiedad cuya característica es la expresión fisiológica. La escala se dirige a aspectos somáticos como náusea (“Muchas veces siento asco o náuseas”), dificultades de sueño (“En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a)”), dolores de cabeza (“Tengo demasiados dolores de cabeza”) y fatiga (“Me canso mucho”). Una puntuación alta

Tabla 3-4.
Reactivos incluidos en la versión abreviada del CMASR-2

Ansiedad Fisiológica (FIS)
1. Muchas veces siento asco o náuseas.
5. Tengo demasiados dolores de cabeza.
7. Algunas veces me despierto asustado(a).
Inquietud (INQ)
2. Soy muy nervioso(a).
3. Muchas veces me preocupa que algo malo me pase.
6. Me preocupa no agradarle a los otros.
8. La gente me pone nervioso(a).
Ansiedad Social (SOC)
4. Tengo miedo que otros niños se rían de mí durante la clase.
9. Siento que alguien va a decirme que hago mal las cosas.
10. Tengo miedo que los demás se rían de mí.

en esta escala sugiere que el niño experimenta las respuestas fisiológicas que a menudo acompañan a la ansiedad.

Inquietud (INQ). La escala de Inquietud (INQ) contiene 16 reactivos que indagan acerca de una variedad de preocupaciones obsesivas ("Soy muy nervioso(a)", "Muchas veces me preocupa que algo malo me pase", "Me preocupa no agradarle a los otros"). La mayoría de estas preocupaciones son imprecisas y poco claras, e incluyen temores a ser lastimado(a) o a un aislamiento emocional. Una puntuación INQ elevada sugiere que el examinado está temeroso, nervioso, o que de algún modo es hipersensible a las presiones del entorno. Una puntuación alta en esta escala puede indicar a un niño o adolescente que internaliza gran parte de la ansiedad que experimenta y que por ello puede sentirse abrumado al tratar de aliviar esta ansiedad. También puede sugerir una fuerte necesidad en el niño de aprender a hablar acerca de sus sentimientos de ansiedad y de aprender a sobrellevar la ansiedad de una manera más abierta compartiendo estos sentimientos con las personas que desean ayudarlo.

Ansiedad Social (SOC). La escala de Ansiedad Social contiene 12 reactivos que indagan acerca de la ansiedad en situaciones sociales y de desempeño ("Tengo miedo que otros niños se rían de mí durante la clase", "Siento que alguien va a decirme que hago mal las cosas"). Esta puntuación puede ser especialmente útil para evaluar a niños con problemas escolares. Una puntuación SOC elevada indica la preocupación de confrontar al yo con otras personas. Los niños o adolescentes con alto puntaje en esta escala pueden experimentar cierta ansiedad al sentirse incapaces de estar a la altura de las expectativas de las personas que son importantes en sus vidas. Al parecer, su preocupación primordial es no ser tan buenos, efectivos o capaces como los demás, lo que ciertamente es un sentimiento relacionado con la ansiedad.

Los examinados con el tipo inusual pero intenso de ansiedad social conocida como mutismo selectivo pueden obtener una puntuación alta en la escala SOC. Los examinados con esta condición parecen absolutamente incapaces de hablar en algunos escenarios. Puede ser que hablen en casa, pero no en la escuela. El rechazo a la escuela, una de las formas más comunes de ansiedad social, tiene como resultado dejar de asistir con regularidad a la escuela, o incluso completamente. Las respuestas a los reactivos del CMASR-2 SOC en especial pueden ayudar a clarificar las situaciones difíciles de los niños y adolescentes que muestran estos problemas.

Contenido individual de los reactivos

A pesar de que las respuestas individuales a los reactivos deben combinarse para obtener puntuaciones confiables en la prueba, la examinación del contenido específico de cada reactivo marcado por un determinado examinado puede ser de gran valor. En este sentido, el CMASR puede emplearse de modo similar al de otras técnicas informales, como las pruebas de completar oraciones, para visualizar más profundamente los sentimientos del niño en situaciones muy diversas. La información suministrada puede usarse en sesiones de asesoría para el seguimiento con el fin de determinar las causas y los posibles remedios para los miedos que interfieran en el crecimiento escolar, emocional o social del niño. Por ejemplo, los niños que responden *Sí* a los reactivos "Me preocupa lo que mis papás me vayan a decir" y "Siento que a los demás no les gusta cómo hago las cosas" pueden expresar una reacción a la

crítica paterna o expectativas altas irreales de los padres. Por otro lado, puede ser un malentendido de parte del examinado sobre algo que los padres le hayan dicho o hecho. A menudo es útil hablar con el niño, en alguna sesión de orientación posterior, sobre las motivaciones de esos tipos de ansiedad cuando se presentan.

En este sentido, las respuestas a los reactivos pueden ofrecer una considerable información clínica. Los maestros, los consejeros y los psicólogos pueden emplear estas respuestas para comprender más a fondo las maneras en que el niño percibe su propia ansiedad, así como su aceptación social según lo expresan los reactivos DEF. Tal como lo indicó Koppitz (1982) para el CMASR, el CMASR-2 puede ser usada como vehículo para indagaciones adicionales con respecto al niño. Esta investigadora reportó que una niña que marcó *Sí* en el reactivo "Muchas veces me preocupa que algo malo me pase", en realidad estaba expresando su preocupación acerca de las relaciones con otros niños de su edad. Al ser presionada para explicar su respuesta, esta niña expresó su temor de involucrarse en una pelea con otras niñas y salir lastimada. Koppitz reportó que otra niña que marcó *Sí* en el mismo reactivo explicó que su preocupación se debía a que sus abuelos pudieran morir, ya que los abuelos pasaban más tiempo con ella que sus padres. Asimismo, reportó sobre una tercera niña que también marcó *Sí* en el mismo reactivo para expresar su miedo de que su madre pudiera ser lastimada. Las tres niñas respondieron de igual manera a este reactivo, lo cual motivó que cada una tuviera una oportunidad de expresar y de discutir temores que nunca antes habían verbalizado. De este modo, el CMASR-2 puede funcionar eventualmente como un instrumento clínico informal de manera suplementaria a su uso normal como medida objetiva de autoinforme de la ansiedad. Koppitz sugirió también utilizar las respuestas a los reactivos del CMASR en la parte inicial de una evaluación para ayudar a formular una entrevista clínica con máxima precisión y profundidad.

De este modo, examinar las respuestas individuales a los reactivos puede arrojar importante información o hipótesis clínicas sobre correlatos o antecedentes específicos de ansiedad. Además, con esto se motiva al examinado a que exprese verbalmente sus sentimientos de ansiedad, lo que en todo caso es una intervención introductoria adecuada. Los antecedentes de

Tabla 3-5.
Reactivos del CMASR-2 relacionados con
ansiedad en el desempeño

Reactivo
4. Tengo miedo que otros niños se rían de mí durante la clase.
8. La gente me pone nervioso(a).
10. Tengo miedo que los demás se rían de mí.
13. Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí.
23. Me da miedo hablar en voz alta ante mis compañeros durante la clase.
26. Me preocupa lo que la gente piense de mí.
32. Me preocupa cometer errores delante de la gente.
37. Temo hablar en voz alta delante de un grupo.
41. Me preocupa que durante la clase me hagan participar.
49. Me preocupa decir alguna tontería.

ansiedad pueden ser esclarecidos, y sus efectos en el aprendizaje académico, las relaciones con los compañeros, la salud emocional y otros ámbitos pueden explorarse. La planeación de la intervención probablemente se lleve a cabo mejor en el contexto de un esclarecimiento exhaustivo de cada expresión de ansiedad. Aunque normalmente un enfoque de seguimiento tan detallado se utilizaría sólo si las puntuaciones escalares del examinado revelaran un grado de ansiedad inusual, podría ser un enfoque útil para temas de ansiedad patentes incluso en aquellos cuyo nivel general de ansiedad está dentro del promedio.

Muchos niños que experimentan estrés inusual especialmente en sus hogares o en la escuela expresarán esto en el CMASR-2. En algunos casos, como aquellos en los que al niño se le aplican pruebas de manera individual, es posible que empiece a hablar de los sentimientos o las situaciones que se relacionan con un reactivo de ansiedad en particular. Evidentemente, este tipo de información y de conducta debe ser registrado por el examinador. El niño que trata de hablar sobre los sentimientos que experimentó durante la sesión de pruebas es típicamente alguien que responderá favorablemente a las estrategias de seguimiento que se diseñen para calmar o dirigir la ansiedad.

Ansiedad en el desempeño. Un grupo de reactivos del CMASR-2 que puede ser de especial interés —los 10 reactivos que indagan la ansiedad en el desempeño— se enumera en la tabla 3-5. Aparte de la experiencia general de la ansiedad respecto a su desempeño social, como lo reflejan las puntuaciones SOC, los niños y adolescentes que en la escuela participan en eventos de música, de teatro o donde tengan que hablar en público pueden experimentar ansiedad de desempeño, ya sea de manera ocasional o cada vez que se presentan en público. Esta ansiedad de desempeño puede ir desde un nivel que motive a mejorar el desempeño hasta un nivel que puede ser paralizante e impedir que alguien cante, actúe o hable delante de un grupo. Los examinados que marcan de manera preponderante reactivos del CMASR-2 que indagan la ansiedad de desempeño pueden tener un riesgo relativamente alto de este último tipo de ansiedad paralizante.

Por ello, se ha puesto, en general, mayor énfasis en el desempeño en escenarios académicos y, en particular, en resultados de pruebas, no solamente en el salón de clases, sino también para cumplir con los lineamientos estatales y nacionales. La ansiedad de desempeño en pruebas es, en consecuencia, cada vez más común entre estudiantes. Esto intensifica la tensión y la ansiedad asociadas con la competencia por las alternativas de mayor relevancia, tales como becas académicas o colocación en universidades y centros de estudio de prestigio que exigen en el examen de admisión puntuaciones cada vez más altas.

La materia académica que por lo común se asocia más con la ansiedad de desempeño es matemáticas. Hopko (1998), al igual que muchos otros investigadores, describe un enfoque para que los estudiantes entiendan y se preparen para la ansiedad que sientan con ese tema y con otros trabajos académicos. El *School Motivation and Learning Styles Inventory* (SMALSI; Stroud y Reynolds, 2006) ofrece una excelente evaluación de seguimiento para casos en los que la ansiedad parece estar concentrada primordialmente en el desempeño en pruebas, en particular, o en el desempeño académico, en general.

Cómo ayudar al estudiante con problemas de ansiedad

Cuando queda establecido que el niño sufre de ansiedad, debe iniciarse cuanto antes un programa de intervención. Cuando se trata de niños pequeños, en particular, los padres deben ser informados de la ansiedad que padece su hijo para que así puedan ayudarlo. Si la ansiedad parece tener su origen en conductas familiares o de los padres, por lo general es necesario tratar la ansiedad del niño en un contexto de trabajo con su familia.

En otras instancias, por lo común con alumnos que están terminando la primaria o un poco mayores, una fuente importante de ansiedad puede relacionarse con la escuela. El aislamiento social o un trauma producto de burlas, acoso [*bullying*] o violencia más severa en la escuela pueden ser una fuente de la ansiedad del estudiante. El primer acercamiento a la ansiedad originada por estas condiciones puede radicar en modificar los programas y entornos escolares para muchos estudiantes.

Ofrecer actividades específicas a los estudiantes es a menudo útil para reducir algunos tipos de ansiedad. El peor cauce para la ansiedad es que el estudiante continúe preocupándose sin hacer nada al respecto. Las actividades físicas, el ejercicio, las prácticas de relajación o meditación y algunas actividades extracurriculares y sociales han demostrado sus beneficios para mitigar la ansiedad.

Para estudiantes con trastornos de ansiedad que no se remedian con las prácticas mencionadas, puede ser necesario referirlos —y quizás a sus familiares también— a una psicoterapia más intensa, o bien, a ayuda psiquiátrica o psicofarmacológica. Psicólogo educativo, psicólogo social y psicólogo clínico con especialidad en niños y adolescentes o algún otro profesional similar pueden involucrar al estudiante en una terapia continua para crear cambios duraderos en la ansiedad. La terapia cognitiva de la conducta (CBT) es mencionada regularmente en la literatura especializada como una técnica terapéutica particularmente efectiva para niños que experimentan trastornos de ansiedad. Esta técnica puede ser especialmente útil, ya que asiste al niño para entender la causa y la naturaleza de su ansiedad y, asimismo, le proporciona prácticas constructivas para eliminar las condiciones bajo las cuales existe ansiedad. Por ejemplo, el niño que experimenta ansiedad social-severa puede beneficiarse participando en actividades sociales que no le resulten amenazantes y que le ofrezcan una reafirmación positiva. Varias situaciones específicas que producen ansiedad pueden volverse menos amenazantes si se presentan en circunstancias controladas y positivas.

Existe un debate importante acerca del uso de tratamiento psicofarmacológico con niños. Algunas personas se oponen al uso de medicamentos como tratamiento para cualquier persona que experimente ansiedad severa (Drummond, 1997). Por otro lado, hay muchos educadores, psicólogos y padres de familia que creen que determinados niños no pueden desempeñarse adecuadamente sin la ayuda de medicación como tratamiento para su ansiedad y su depresión. En todo caso, la decisión de prescribir un tratamiento con medicamentos para la ansiedad del niño debe ser tomada por un clínico con autorización para

recetar medicinas psicoactivas y con capacitación adecuada en el uso de esas sustancias y en conducta infantil.

Consideraciones adicionales

El propósito principal de cualquier técnica de evaluación en psicología o en educación es obtener una mejor comprensión del examinado, con el fin de ayudar a mejorar su desempeño cotidiano. El CMASR-2 se diseñó para conseguir un mejor entendimiento de la naturaleza y del nivel de la ansiedad de los individuos que completan este instrumento de autoinforme. Se espera que la escuelas, el y el adolescente, psicólogos educativos, orientadores vocacionales, los maestros, otros profesionales y los padres puedan hacer uso de esos hallazgos acerca de la ansiedad de los niños para ayudarlos a sobrellevarla de manera más eficaz en la escuela y en otros aspectos de su vida cotidiana. También es posible que la administración de la escuela aproveche este conocimiento adicional sobre la ansiedad infantil con el fin de planear programas para padres, maestros u otro tipo de personal escolar en posición de ayudar a entender y mitigar los niveles de ansiedad no deseados en niños en edad escolar.

Lo que entendemos acerca de la ansiedad

Como se indicó antes en este manual, existen numerosas investigaciones, experiencias y opiniones acerca de la ansiedad, ya que todos la sentimos en diversos momentos de nuestras vidas; algunos más que otros. Las personas experimentan ansiedad por diferentes causas; y la ansiedad en niveles moderados puede servir como motivación. A veces, la ansiedad alcanza efectivamente niveles en los que inhibe o impide el desempeño. La ansiedad difiere de otros numerosos síntomas psicológicos en que puede ser un trastorno en sí mismo, o bien, simplemente un síntoma de otro trastorno (p. ej., Trastorno Depresivo Severo). El deseo de quienes trabajan con niños en la escuela o en la comunidad es ayudarlos a que mantengan un nivel de ansiedad que no interfiera en su salud o en su capacidad de desempeñarse de manera óptima, sin importar cuál sea su nivel de capacidad.

Un reporte del National Institute for Mental Health cita un estudio de Kessler, Chiu, Demler y Walters (2005), el cual indica que cada año alrededor de 40 millones de estadounidenses adultos de 18 años y mayores son afectados por trastornos de ansiedad. En una vertiente similar, Wijnant (2000) cita un reporte de la Organización Mundial de la Salud en donde se advierte que para el año 2020 se estima que los trastornos depresivos se conviertan en la segunda causa principal de enfermedad y discapacidad en todo el mundo. Los trastornos de ansiedad se encuentran estrechamente correlacionados con la depresión, de modo que el niño sumamente ansioso tiene más probabilidades de sufrir depresión y de ser propenso al suicidio que los niños que experimentan niveles bajos de ansiedad. El U. S. Department of Health and Human Services (1999) reportó que 13 de cada 100 niños de entre 9 y 17 años de edad experimentan algún tipo de trastorno de ansiedad y que las mujeres son más vulnerables que los varones. El *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Text Revision (DSM-IV-TR; American Psychiatric Association, 2000)* intenta clasificar la ansiedad en distintos tipos, de modo que los tras-

tornos de ansiedad puedan entenderse y tratarse de manera más eficaz. Nueve tipos de trastornos (excepto el Trastorno de Ansiedad, NOS) se enlistan a continuación, seguidos de una breve explicación de cada uno basada en el *DSM-IV-TR*.

1. Trastorno de Estrés Agudo: puede experimentarse en casos de guerra, terrorismo, terremoto, motines u otros eventos de similar intensidad.
2. Agorafobia: miedo a encontrarse en un lugar o situación en la que escapar pudiera resultar difícil o vergonzoso.
3. Trastorno de Ansiedad Generalizado: preocupación general con duración de por lo menos seis meses con al menos tres de las múltiples indicaciones de ansiedad especificadas.
4. Trastorno Obsesivo-Compulsivo: conducta marcada por un exceso de actos repetitivos realizados como ritual (lavarse las manos repetidamente es el ejemplo clásico de éste).
5. Trastorno de Pánico: por lo general, es un sentimiento de terror que acomete súbitamente y que puede redundar en sudoración excesiva, en aumento del ritmo cardíaco o en casi una parálisis.
6. Trastorno de Estrés Postraumático: lo más probable es encontrarlo en quienes han prestado servicio militar en el frente de guerra. Asimismo, puede ser resultado de ataque sexual, disparos de arma de fuego en la calle o de otras situaciones de violencia extrema.
7. Ansiedad de Separación: puede ser causada por el primer día del niño en la escuela, por la separación de los padres, por irse a estudiar la universidad a otro lugar, en el caso de adolescentes, y situaciones de este tipo.
8. Trastorno de Ansiedad Social: miedo general a las multitudes, la gente, las fiestas, o a conocer personas y hablar con ellas.
9. Trastorno de Ansiedad Específico: por ejemplo, miedo a las alturas, a los espacios cerrados, a las víboras, a volar, etc.

A pesar de la creación de estas subcategorías de ansiedad, es importante tener en mente que entre sí se traslapan más de lo que se distinguen. En otras palabras, es difícil establecer distinciones confiables o consistentes entre estas subcategorías de ansiedad. A menudo puede ser más útil determinar el nivel de ansiedad de un niño que intentar situarlo en una de las nueve subcategorías. Como se mencionó antes, un niño ansioso puede expresarlo lavándose las manos reiteradamente, mientras que otro puede tener miedo a la gente; sin embargo, ambos pueden beneficiarse con un nivel de ansiedad disminuido, y eso representa un foco de atención apropiado para el adulto que quiere ayudar al niño. El punto central del CMASR-2 es determinar el nivel general de ansiedad de un niño. Además, las puntuaciones específicas en las escalas del CMASR-2 o las respuestas a reactivos individuales pueden usarse para entender con mayor claridad la naturaleza o las causas de la ansiedad del niño. No se recomienda que los resultados del CMASR-2 se usen para ubicar al niño en un diagnóstico de subcategoría de ansiedad en los términos del *DSM-IV-TR*, ni tampoco es necesario situar al niño en alguna categoría para ayudarlo a entender y a manejar su nivel de ansiedad. Es mucho más importante determinar las causas del alto nivel de ansiedad de un niño para planear un remedio al problema.

Si el niño padece una fuerte ansiedad, debe examinarse el entorno parental y de la casa. Como lo han señalado Kendall y Ollendick (2004), los padres juegan un papel determinante

en el desarrollo, así como en el tratamiento, de los trastornos de ansiedad. Múltiples reportes, como el de Rodríguez (2003), indican que el tipo de disciplina que utilicen los padres puede afectar la ansiedad del niño. Un estilo de disciplina severa, y obviamente el abuso físico y sexual por parte de los padres, a menudo ocasiona que el niño esté más ansioso. Ginsburg, Siqueland, Masia-Warner y Heatke (2004) apoyan el planteamiento de que las conductas de la familia y de los padres están asociadas con la etiología de los trastornos de ansiedad en niños. Explicaciones suplementarias como las de Sheldon (1998), Bennoun (1998), Bogels y van Melik (2004), Suveg, Zeman, Flannery-Schroeder y Cassano (2005), y Bennet (1998) dejan claro que el desarrollo de altos niveles de ansiedad en niños se asocia con una diversidad de características de los padres y la familia, tales como sobreprotección, distanciamiento emocional, expresión de emociones más negativas que positivas hacia los niños o altos niveles de ansiedad entre los padres.

No siempre es posible obtener la cooperación de los padres, en especial de aquellos cuyos hijos experimentan ansiedad. Esto sucede particularmente cuando los propios padres experimentan altos niveles de ansiedad. No obstante, una entrevista con ellos y lograr su participación para ayudar a cambiar el ambiente del hogar que provoca angustia resulta a veces crucial para tratar al niño con trastorno de ansiedad. Los padres pueden no estar conscientes de la ansiedad de su hijo, ni tampoco de su contribución al desarrollo y mantenimiento de esa ansiedad. Se debe hacer un esfuerzo para procurar su comprensión y cooperación.

Además de involucrar a los padres en la comprensión y el tratamiento de trastornos de ansiedad en niños, es preciso examinar también el ambiente comunitario y escolar. Como se señala en varios estudios (Boyd, Cooley, Lambert y Jalongo, 2003; Brackis-Cott, Melbins y Block, 2003; Storch, Brassard y Masia-Warner, 2003, y Storch *et al.*, 2004), el acoso, las burlas y la violencia en las escuelas y en la comunidad contribuyen a intensificar los niveles de ansiedad y de depresión de los estudiantes. Para los adolescentes en particular, la amenaza de abuso sexual, de violencia y de drogas es a menudo genuina. Algunas comunidades experimentan niveles de violencia superiores que llevan a niveles superiores de ansiedad y depresión. La ansiedad que surge como resultado de la interacción con los compañeros en el ambiente escolar y comunitario a menudo se manifiesta como una especie de ansiedad social. Ya sea que se trate de ansiedad por separación cuando el niño pequeño es apartado por primera vez de su casa y puesto en un entorno escolar, o de la ansiedad que más adelante puede resultar de sentimientos de rechazo o aislamiento social: el estudiante está experimentando una forma de ansiedad cuya causa radica en aspectos sociales. Para mitigar estas formas de ansiedad social, es útil modificar las causas o las percepciones que el estudiante tiene en particular sobre esos eventos sociales. En la medida en que las escuelas crecen, tienen más estudiantes y, al parecer, se vuelven más impersonales, y la administración escolar se torna menos capaz de controlar la violencia estudiantil y el uso de drogas y alcohol, por lo que es más probable que el entorno escolar contribuya a la ansiedad social del estudiante. En la actualidad, muchas escuelas cuentan con programas para sensibilizar a sus alumnos acerca de los efectos perniciosos del acoso y de las burlas, así

como de los desafíos evidentes de las armas, drogas y otras formas de abuso de sustancias.

Como se ha mencionado, una de las consecuencias de un énfasis excesivo en los logros académicos es la tensión y la ansiedad que resultan de la competencia con otros estudiantes y de exámenes demasiado temidos. En la actualidad, con la creciente incidencia de la aplicación de pruebas, se presenta la ocasión para que la ansiedad se incremente. Igualmente, universidades y centros educativos de prestigio pueden exigir puntuaciones cada vez más altas en el examen de admisión, generando así la posibilidad de una mayor ansiedad por someterse a pruebas. Numerosos autores, como Van Ameringen, Mancini y Farvolden (2003), Heinrichs (1998) y Zeidner (1998), han atestiguado la realidad de la ansiedad causada por pruebas entre estudiantes en edad escolar.

3

Ansiedad y otras condiciones psicológicas y físicas

Hasta este momento se ha subrayado que la ansiedad disfuncional se comprende mejor como condición que surge a partir de causas sociales y del entorno que pueden ocurrir desde la infancia, que emerge como un patrón de la conducta familiar y de la expresión emocional, o que resulta de amenazas reales o percibidas en la casa, escuela o comunidad. La importancia de discernir la(s) causa(s) de la ansiedad ha sido explicada en detalle. Sin embargo, también es importante comprender que la ansiedad está estrechamente vinculada con otros problemas psicopatológicos y físicos que experimentan los estudiantes. El más significativo es la relación entre ansiedad y depresión. Algunos investigadores que han escrito sobre el tema (Chavira, Stein, Bailey y Stein, 2004) consideran que la ansiedad y la depresión son inseparables; otros señalan que la ansiedad puede darse primero en niños pequeños y convertirse más adelante en una forma de depresión más severa si no se trata con eficacia. En general, se considera que la depresión es una condición más seria que la ansiedad, pero una ansiedad severa en cualquier estudiante debe despertar la preocupación de que el niño también sufra o vaya a sufrir de depresión. No es necesario separar las dos condiciones cuando se entienden mejor como una forma continua y progresiva de trastorno.

La ansiedad ha sido ligada también a un rango completo de trastornos alimenticios —desde anorexia nerviosa y bulimia hasta obesidad. La ansiedad es considerada por muchos como un elemento integral del abuso de sustancias, de fumar y de los trastornos de automutilación. Para estudiantes jóvenes, programas de prevención prematura centrados en sobrellevar la ansiedad pueden ayudar a disminuir la incidencia de estos otros problemas en su vida más adelante. En la misma línea, la relación entre ansiedad y diversidad de condiciones de salud es más propensa a surgir al final de la adolescencia o ya en la adultez —a menudo luego de muchos años de padecer ansiedad. Problemas cardíacos, presión sanguínea alta, diabetes y cáncer son factores que han sido vinculados con un inicio prematuro de un trastorno de ansiedad. Esta vinculación ofrece motivos adicionales para una intervención prematura que maneje la ansiedad de manera eficaz por parte de quienes trabajan en los muy diversos tipos de programas para ayudar a los niños.

Casos de estudio

Esta sección presenta varios casos ilustrativos. Es importante tener en mente que las puntuaciones de ansiedad altas no se asocian necesariamente con la presencia de un trastorno de ansiedad. La ansiedad a niveles superiores a lo normal se vincula con un extenso rango de trastornos clínicos, así como de problemas no clínicos. En todo caso, es probable que un trastorno clínico u otro problema pueda enfrentarse por lo menos parcialmente trabajando con el niño o adolescente ansioso para desarrollar modos efectivos de sobrellevar su ansiedad, al mismo tiempo que se tratan otros síntomas, circunstancias y causas de un trastorno o problema específico.

Caso 1. Perfeccionismo y bajo rendimiento

Ashley cursaba el primer grado de secundaria y acababa de cumplir 12 años cuando fue referida para una evaluación psicológica completa. Sus padres reportaron que era muy brillante y creativa. Estaban preocupados de que ella no obtuviera buenas calificaciones en la escuela, a pesar de que dedicaba mucho tiempo a sus tareas escolares todos los días. Durante muchos años, Ashley se había quejado a menudo de tener dolores de cabeza, en especial durante las clases de matemáticas y ocasionalmente antes de ir a la escuela en la mañana. Su doctor no identificó problemas de la vista ni otra causa médica. Asimismo, su madre expresó cierta preocupación por la creciente renuencia de Ashley a participar en actividades sociales o extracurriculares con sus compañeros.

Los padres reportaron no tener problemas maritales serios, y su comportamiento durante la entrevista denotó entre ellos una relación de pareja solidaria y bien avenida. Reportaron no tener problemas de disciplina fuera de lo común con ninguna de sus dos hijas—Ashley y su hermana de 9 años—. Dijeron que era muy placentero tenerlas alrededor y que participaran en actividades y conversaciones “casi como si fueran adultos”; esta descripción fue consistente con los reportes escolares.

En la prueba cognitiva, Ashley obtuvo un CI compuesto de 128 en las *Reynolds Intellectual Assessment Scales* (RIAS; Reynolds y Kamphaus, 2003). En el *Wide Range Achievement Test, Fourth Edition* (WRAT-4; Wilkinson y Robertson, 2006), recibió puntuaciones estándar de 107 en Aritmética y 107 en Lectura. En vista de las afirmaciones de sus padres acerca de su creatividad, se aplicaron los *Torrance Tests of Creative Thinking* (Torrance, 1966), en donde obtuvo un Índice de Creatividad general de 94 ($M = 100$), con puntuaciones de 100 en Fluidez, de 103 en Flexibilidad y 103 en Originalidad. Su desempeño en estas tareas se caracterizó en términos generales por su rigidez y su reticencia a correr riesgos, y por preferir mantener sus límites en vez de ampliarlos.

Antes de la entrevista clínica, Ashley completó el CMASR-2 junto con una medida breve de detección de depresión. Su puntuación de depresión se ubicó en el rango de promedio alto, lo que señala la posibilidad de síntomas depresivos emergentes. Sus resultados del CMASR-2 se muestran en la figura 3-1. Su puntuación DEF de 60 *T* es alta, al igual que su puntuación TOT de 62 *T*. En las tres escalas de ansiedad, sus puntuaciones escalares fueron de 50 *T*, 65 *T* y 59 *T* para las mediciones FIS, INQ y SOC, respectivamente. La niña marcó 5 de los 10 reactivos relacionados con ansiedad en el desempeño.

Ashley presentó un comportamiento sorprendentemente maduro durante la entrevista. Cuando se le pidió que explicara sus respuestas a los reactivos DEF, se obstinó en mantener su visión de ella misma como niña amable, amorosa y perfecta. Este nivel de autocontrol y Defensividad sugiere que sus puntuaciones en el CMASR-2 podrían estar de hecho subestimando el nivel de ansiedad experimentado y que sus puntuaciones de depresión podrían haber sido suprimidas también intencionalmente. Cuando se le preguntó acerca de algunos de los reactivos que marcó en la escala INQ, como “Soy muy nervioso(a)”, “Casi todo el tiempo estoy preocupado(a)”, “Me preocupa lo que va a pasar” y “Me preocupa lo que mis papás

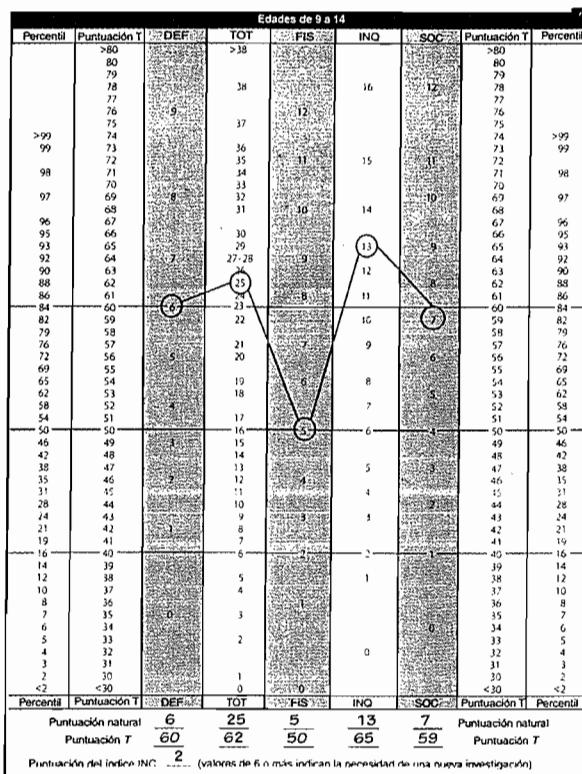


Figura 3-1. Caso 1. Hoja de Perfil de Ashley (versión CMASR-2 EUA).

me vayan a decir”, señaló que se sentía en extremo infeliz por su incapacidad para tener siempre “10 en todo” en la escuela. Ella sentía que la situación daría por resultado una irreparable y significativa pérdida de oportunidades en el futuro. En consecuencia, dedicaba tiempo y energía en exceso a repasar sus trabajos para asegurarse de que todo estuviera completo y correcto. Su nivel de desconfianza de sí misma y el hecho de revisar todo tantas veces se había vuelto contraproducente en cuanto a que ahora casi nunca le daba tiempo de terminar todas sus tareas. No podía disfrutar de estar en compañía de sus amigos, ya que se mantenía preocupada con la inquietud de la tarea que aún tenía que terminar. Al pasar menos tiempo con ellos, también fue perdiendo cada vez más contacto con sus actividades y preocupaciones, de las cuales ella dijo que, en todo caso, le empezaban a parecer “infantiles”.

Por lo general, este patrón de puntuaciones y de conducta sugiere que Ashley estaba haciendo demasiados esfuerzos para tratar de satisfacer las altas expectativas irreales que ella misma y sus padres exigían de ella en todos los frentes. De manera contradictoria, su ansiedad por fallar en el cumplimiento de estos elevados estándares estaba empezando a interferir seriamente en su capacidad de desempe-

ñarse tanto académica como socialmente, y probablemente se relacionaba también con sus problemas físicos. A pesar de que Ashley efectivamente parecía tener un potencial considerable en todas las áreas, estaba empezando a ser obstaculizada por una espiral de miedo a tener una experiencia real de fracaso.

La principal recomendación para Ashley fue ayudarla a ella y a sus padres a desarrollar una aceptación más realista de sus fortalezas y debilidades, parte de lo cual requería fortalecer su capacidad de sobrellevar de manera efectiva la ansiedad a la hora de explorar y desarrollar nuevas actividades y capacidades. Se motivó a la niña a buscar experiencias creativas como vehículos efectivos para desarrollar un enfoque de vida con menos aversión a los riesgos y que le permitiera sobrellevar parte de su ansiedad. Sus padres estuvieron de acuerdo en participar en terapia con ella hasta el grado en que les fuera pedido, y Ashley aceptó también participar en un programa de terapia artística. Al mismo tiempo se aplicó un programa especial para reducir la ansiedad, con la finalidad específica de tratar el contraproducente hábito de repasar y revisar obsesivamente sus tareas de la escuela.

Caso 2: Problema académico y discordia familiar

Nick tenía 8 años de edad y cursaba el segundo grado al momento de ser canalizado para evaluación psicológica. Sus padres hicieron que fuera referido porque les preocupaba la súbita caída de su desempeño académico en la escuela. Su madre afirmó que el niño no se estaba concentrando en sus tareas, que a menudo parecía nervioso y que estaba obteniendo calificaciones cada vez más bajas en las tareas que le dejaban en la escuela y en las evaluaciones realizadas por los maestros. Valoraciones previas no habían revelado ninguna discapacidad de aprendizaje, trastorno de comunicación o algún otro tipo de problema que pudiera interferir en su capacidad para aprender en el escenario de un salón de clases normal.

Durante la entrevista, ambos padres admitieron estar experimentando cierta discordia familiar. Ninguno de ellos había terminado la preparatoria, ya que ambos habían abandonado la escuela en el segundo año de preparatoria para encontrar un empleo. Se casaron más o menos un año después, y Nick nació aproximadamente al año siguiente del matrimonio; un hermano y una hermana menores nacieron en los siguientes tres años. El padre consiguió un empleo seguro en mantenimiento trabajando para el ayuntamiento y la madre obtuvo trabajo como personal de asistencia nocturna en una escuela de estudios superiores de la localidad. De este modo, el padre laboraba durante el día y la madre salía a trabajar justo cuando él regresaba a casa. Ambos comprendían que sus problemas maritales se debían, en parte, a sus frenéticos horarios de trabajo y temían no darles suficiente tiempo a sus hijos ni a su matrimonio, pero necesitaban el ingreso de ambos empleos para mantener a sus tres hijos y a ellos mismos. El padre y la madre señalaron que Nick "siempre trataba de hacer que todos estuvieran felices". Asimismo, se mostraron preocupados por el efecto del estrés familiar sobre sus tres hijos.

En evaluaciones anteriores, Nick había obtenido un CI Verbal de 95, un CI No Verbal de 96 y un CI Compuesto de 95 en la RIAS. Sus puntuaciones más altas fueron en subpruebas para medir la conciencia práctica y social, así como el razona-

miento abstracto. Sus puntuaciones más bajas en las subpruebas fueron en aquellas que estaban más correlacionadas con logro académico y con aprender de memoria y concentración. En el WRAT-4, Nick obtuvo puntuaciones estándar de 100 tanto en Lectura como en Deletreo, y 101 en Aritmética. Obtuvo una puntuación estándar de 80 en el *Koppitz Developmental Scoring System for the Bender Gestalt Test, Second Edition*

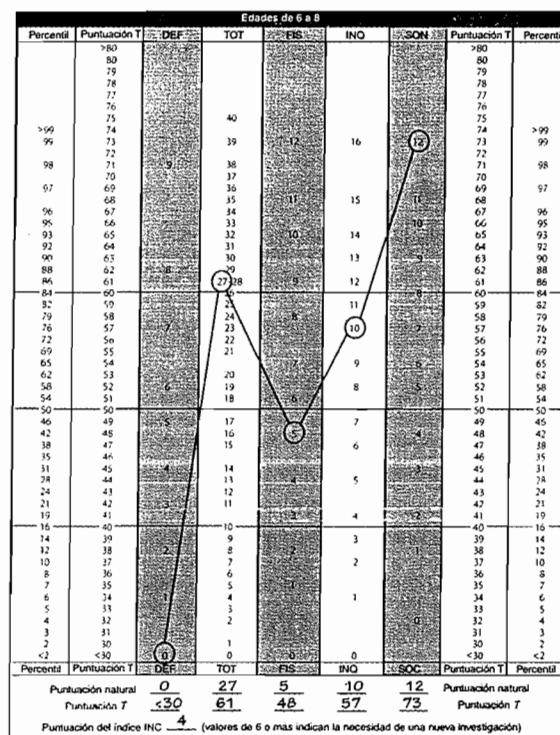


Figura 3-2. Caso 2. Hoja de Perfil de Nick (versión CMASR-2 EUA).

(KOPPITZ-2; Reynolds, 2006). Su conducta en esta última prueba fue tipificada como impulsiva, y se caracterizó por los numerosos borrones y segundos intentos al dibujar, y por el reducido tamaño de los dibujos. Se aplicó la *Roberts-2* (Roberts y Gruber, 2005), la cual reveló un fuerte sentido de independencia y de responsabilidad hacia los demás.

Nick completó el CMASR-2 antes de la entrevista, junto con una medida breve de depresión. Su puntuación de depresión se ubicó en el promedio, en el rango no clínico. Sus puntuaciones del CMASR-2 se muestran en la figura 3-2. Nick obtuvo una puntuación escalar de $< 30 T$ en la escala DEF y una puntuación TOT de $61 T$, lo que es elevado. Sus puntuaciones en la escala de ansiedad fueron $48 T$, $57 T$ y $73 T$ para FIS, INQ y SOC, respectivamente. Estas puntuaciones señalaron un nivel de ansiedad moderadamente alto, con especial énfasis en la ansiedad social.

Durante la entrevista, Nick se mostró un tanto aprensivo y distraído, a pesar de que era buena su capacidad para concentrarse e involucrarse adecuadamente en la discusión inmediata. Sin embargo, durante la indagación acerca de sus respuestas en el CMASR-2, se hizo evidente que a pesar de que tenía ciertas preocupaciones realistas acerca de los problemas y tensiones que su familia estaba experimentando, no estaba demasiado perturbado por ello. Esto fue consistente con sus respuestas de *No* a reactivos como "Me preocupa lo que va a pasar", "Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir en la noche" y "Muchas veces me preocupa que algo malo me pase".

Cuando se le preguntó acerca de varios reactivos a los que respondió *Sí*, como "Los demás son más felices que yo", "Siento que alguien va a decirme que hago mal las cosas", "Muchas personas están en mi contra" y otros reactivos de la escala SOC, luego de titubear bastante, dijo que le estaba costando mucho trabajo entender qué era lo que tenía que hacer en los ejercicios durante las clases y en sus tareas en casa.

Por eso entregaba trabajos incompletos o insuficientes. Tenía pavor de ser llamado en clase o de que se le pidiera participar en actividades grupales en el salón. Estaba quedándose atrás de sus compañeros, quienes estaban empezando a burlarse de él por su bajo desempeño, con lo que se le hacía todavía más difícil concentrarse. Nick dijo que "se enfurecía muchísimo" con los otros niños, lo cual, por supuesto, sólo aumentaba su entusiasmo para burlarse de él. Él no les había mencionado estas dificultades a sus padres porque sabía que ellos ya estaban lidiando con los otros asuntos que ya se mencionaron, y se mostraba renuente a contribuir a sus dificultades. De hecho, durante la entrevista dijo que todavía tenía esperanzas de que esos problemas se pudieran resolver sin tener que involucrar a sus padres. De este modo, la situación en el hogar había contribuido efectivamente a sus dificultades en la escuela, pero no exactamente del modo en que sus padres temían.

Una vez que fueron informados acerca de estos aspectos, el clínico y los padres de Nick fueron capaces de reafirmarle el hecho de que podían y estaban dispuestos a ayudarlo con sus problemas, aunque al mismo tiempo estuvieran ocupándose de otros asuntos familiares. Los padres de Nick trabajaron con su maestro y con un terapeuta educativo para comprender mejor y tratar las dificultades del niño con sus asignaturas académicas. Su enfoque hacia su trabajo escolar era impulsivo y muchas veces empezaba a trabajar antes de terminar de revisar lo que se le pedía que hiciera. Combinado con este enfoque, se mostraba renuente a pedir ayuda o explicaciones. Cuando comprendía la tarea, tenía dificultades para planear la secuencia de pasos necesarios para completarla. Mientras que sus padres, el maestro y el terapeuta educativo trabajaban con él para desarrollar las habilidades académicas requeridas, el clínico trabajaba en estrategias para enfrentar con éxito la agresión de los otros niños, y también para desarrollar estrategias adecuadas de seguridad en sí mismo con el fin de obtener ayuda siempre que la necesitara, tanto en casa como en la escuela.

Caso 3. Síndrome de Asperger y conducta disruptiva

Noah tenía 11 años de edad y cursaba el sexto grado cuando sus padres lo refirieron para una evaluación psicológica completa porque sus maestros se quejaron de su conducta disruptiva en el salón de clases. Ésta consistía primordialmente en interrumpir con frecuencia a sus maestros o compañeros de clase con preguntas de enfoque reducido que sólo eran tangenciales con respecto al asunto que se estuviera tratando. Unas cuantas veces había abandonado bruscamente el salón de clases a la mitad de la discusión de algún tema. La conducta disruptiva nunca había sido un problema antes cuando cursaba los grados anteriores, y nunca se identificó que el niño tuviera problemas de atención o algún trastorno de aprendizaje. Una evaluación neuropsicológica reciente no reveló ninguna disfunción neurológica relacionada.

Noah comenzó el jardín de niños a los cinco años de edad y entró al primer grado a los seis. Cuando cumplió siete, estando en segundo grado, se le diagnosticó síndrome de Asperger. En términos generales, el niño tenía un buen desempeño académico y disfrutaba de sus experiencias en el salón de clases. De vez en cuando había participado en clases especiales para

ayudarlo a maximizar su capacidad de leer de manera adecuada las situaciones sociales. Sin embargo, estas clases no le gustaban porque eran difíciles y porque lo apartaban de los demás niños de su grado, de modo que normalmente se quedaba en ellas poco tiempo y luego sus padres pedían que fuera eximido de ellas. Dado que sus calificaciones eran excelentes, que su comportamiento en clase era adecuado y que aparentemente había logrado un nivel de inclusión razonable en las actividades con sus compañeros, Nick era dispensado.

Cuando ingresó a la secundaria, Noah tuvo muchas dificultades para adecuarse a su nuevo entorno social. La relativa falta de atención individualizada en el salón de clases que encontró en el entorno de la secundaria, en comparación con sus experiencias anteriores en la primaria, lo dejó sintiéndose inseguro acerca de sus rutinas escolares. Cada vez más el niño era excluido de las actividades por compañeros que antes habían tolerado sus particularidades sociales, pero que ahora se preocupaban más por sus propios esfuerzos de integración social.

En una reciente aplicación de pruebas cognitivas, Noah obtuvo un CI Verbal de 116 y un CI No Verbal de 132, lo que resulta en un CI compuesto de 124 en la RIAS. Sus puntuacio-

nes en el KOPPITZ-2 resultaron en una puntuación estándar de 130, la cual era consistente con su puntuación de CI No Verbal. Su desempeño en el WRAT-4 se ubicó en el nivel de promedio alto. Obtuvo puntuaciones de 115 en Lectura, 112 en Deletreo y 127 en Aritmética. En la *Piers-Harris Children's Self-Concept Scale, Second Edition* (Piers-Harris 2; Piers, Harris y Herzberg, 2002), una evaluación del autoconcepto, su nivel general de autoestima fue señalado por estar a casi dos desviaciones estándar por debajo del promedio.

Noah completó el CMASR-2 antes de la entrevista y sus puntuaciones se muestran en la figura 3-3. Obtuvo una puntuación de 46 T en la escala DEF. Su puntuación TOT fue de 59 T, en el rango promedio alto. El patrón de escalas de ansiedad incluyó una puntuación de 54 T en FIS, de 54 T en INQ y de 62 T en SOC. Estos resultados subrayan que una falta de competencia social no se traduce necesariamente en una falta de preocupación por la exclusión social.

En la entrevista, Noah se mostró como un jovencito silencioso y cooperativo que solamente se entusiasmó al hablar de su profundo interés por las carreras de bicicletas. Era alto, esbelto, bien vestido y cooperativo, pero rara vez habló de manera espontánea. Solamente cuando se habló de bicicletas él se abrió y reveló sus sentimientos e intereses. Su conocimiento sobre carreras y su capacidad de trabajar con bicicletas en cualquier aspecto mecánico fue avalado por él y por sus padres.

Noah respondió *Sí* a reactivos del CMASR-2 como "En la escuela se burlan de mí", "Me preocupa que alguien me dé una golpiza", "La gente me pone nervioso(a)", "Los demás son más felices que yo" y "Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí". Cuando se le dio oportunidad de abundar al respecto, dijo que los demás niños se burlaban de él, pero que en realidad nunca había sido atacado físicamente. Pero se sentía nervioso porque sabía que podía ocurrir y porque había visto a otros niños pelearse. Dijo estar seguro de no agradarles a algunos de los niños mayores, y que en realidad no sabía qué tan lejos podría llegar la hostilidad. Comentó que algunos compañeros del salón lo motivaron para que siguiera haciendo preguntas durante la clase porque les parecía divertido.

La ansiedad de Noah podía atribuirse a su dificultad para desarrollar habilidades sociales más avanzadas que le permitieran adaptarse al nuevo escenario de la escuela secundaria, más complejo en cuanto a las relaciones sociales. Como resultado de su creciente frustración a este respecto, el niño estaba desarrollando un repertorio estrecho de conductas en el salón de clase que le proporcionaban cierto alivio inmediato para su propia ansiedad, pero que lo estaban apartando cada vez más de sus compañeros de clase. Había llegado a una crisis en su desarrollo social en la que la exclusión general por parte de sus compañeros era inminente. No obstante, rechazaba cualquier tipo de atención especial para mejorar su funcionamiento social, ya que eso implicaba frustraciones adicionales y representaba un doloroso golpe a la ya de por sí baja imagen de sí mismo, con la experiencia exacerbada de la hostilidad de sus compañeros.

A los padres de Noah se les involucró en una discusión para ayudarlos a reconocer el bajo autoconcepto y el alto nivel de ansiedad que presentaba su hijo, y a que aceptaran la necesidad de atender su inadecuado nivel de habilidades sociales. Noah fue incluido en la discusión a un nivel adecuado para su edad. De las diversas opciones que se le ofrecieron, aceptó el que se le asignara a un muchacho mayor como mentor entre sus compañeros para que le ayudara a navegar por su mundo social. La maestra de Noah accedió a proporcionarle descripciones preparatorias más detalladas y de manera más frecuente de las actividades planeadas para el salón de clases y de los cambios en la rutina que ella estaba acostumbrada a plantearles a sus alumnos. Esto ayudó a disminuir su nivel general de ansiedad, al hacer que su día académico fuera más previsible. Los padres de Noah, con una mayor conciencia de la situación, estuvieron de acuerdo en trabajar con el personal de la escuela para identificar las oportunidades grupales y las actividades académicas adecuadas que pudieran subrayar y desarrollar sus fortalezas. La familia comenzó también a ser más proactiva en cuanto a hacer un uso efectivo de los servicios y las oportunidades ofrecidos por la comunidad para que Noah desarrollara suplementariamente tanto sus habilidades sociales como sus intereses personales.

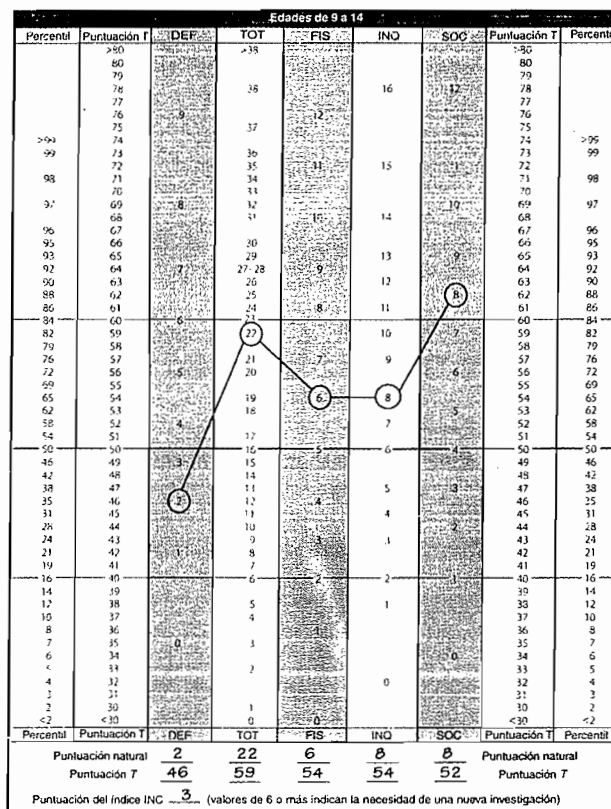
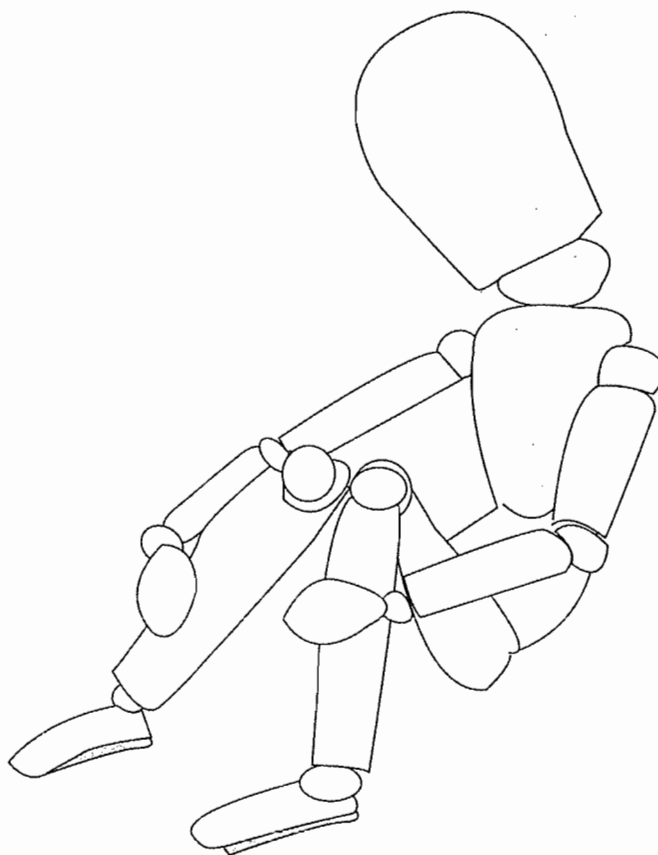


Figura 3-3. Caso 3. Hoja de Perfil de Noah (versión CMASR-2 EUA).

Segunda parte

Guía técnica



4

Desarrollo y estandarización

Este capítulo proporciona una breve descripción de la evolución de este instrumento, desde la *Manifest Anxiety Scale* (MAS; Taylor, 1951) hasta la *Children's Manifest Anxiety Scale* (CMAS; Castaneda, McCandless y Palermo, 1956), desde el CMAS hasta la *Escala de ansiedad manifiesta en niños (revisada)* (CMASR; Reynolds y Richmond, 1985), y del CMASR hasta el CMASR-2. A continuación se ofrece una presentación más detallada del desarrollo del CMASR-2. Finalmente, se describen la muestra de estandarización y las normas del CMASR-2, y se consideran los efectos de las variables de los moderadores demográficos en el CMASR-2. En el capítulo 5, se proporciona información adicional sobre la confiabilidad y la validez de las puntuaciones del CMASR-2.

Desarrollo del CMASR original

Un primer instrumento de autoinforme para medir la ansiedad manifiesta en adultos fue realizado por Taylor (1951). Este instrumento se compiló con base en reactivos extraídos del *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI; Hathaway y McKinley, 1943) y se consideró útil para identificar a individuos caracterizados por síntomas de ansiedad crónica. Pocos años después, Castaneda, McCandless et al. (1956) modificaron la escala y reportaron datos de estandarización iniciales para la versión para niños del CMAS. Durante los primeros 20 años, más de un centenar de artículos referidos al instrumento aparecieron en la literatura especializada en un esfuerzo por definir de manera más precisa la naturaleza de la ansiedad manifiesta en niños y su relación con numerosas variables cognitivas, afectivas, de logro, entre otras. Diversos investigadores usaron el CMAS para ayudar a entender la ansiedad manifiesta en niños en relación con sus antecedentes socioeconómicos (p. ej., Boyce, 1974; Ziv y Luz, 1973), diferencias culturales (p. ej., Muralidharan y Sharma, 1971; Ziv y Shauver, 1969), situaciones específicas de estrés (p. ej., Donald 1973; Melamed y Siegel, 1975), logro e inteligencia (p. ej., Chansky, 1966; Merryman, 1974), autoconcepto y otras variables de la personalidad (p. ej., Brady, Richards y Felker, 1975; Stanwyck y Felker, 1973), y con el retraso mental (p. ej., Carrier, Orton y Malpass, 1962; Cochran y Cleland, 1963).

Del CMAS al CMASR

El continuo interés en la escala a lo largo de los años ha sido un indicador de la relevancia de la ansiedad en el desempeño de un niño. Investigadores han subrayado la importancia de la ansiedad como variable que afecta el logro individual (Gaudry

y Spielberger, 1971; Peck y Mitchell, 1967). El peso abrumador de la evidencia indica de manera consistente una relación negativa entre los altos niveles de ansiedad y el logro académico. A pesar de este tremendo interés que tienen en común clínicos e investigadores, durante mucho tiempo hubo pocas escalas objetivas de ansiedad para niños y sólo algunas contaban con una base amplia de datos normativos. Estos aspectos dieron lugar, en consecuencia, a la revisión, o más propiamente dicho, a un nuevo desarrollo del CMAS al CMASR. El uso del CMAS por parte de uno de los autores del CMASR (Richmond) como herramienta de detección y clínica durante más de una década, había hecho evidente la necesidad de su revisión y de una interpretación estadística suplementaria. Entre las quejas más frecuentes de maestros que aplicaban la escala estaba el que ésta no evaluaba suficientes áreas de ansiedad en niños y que algunas de las palabras eran demasiado difíciles para los niños de primaria, de lento aprendizaje y con retraso mental. Con frecuencia este grupo de niños es aquel cuyo nivel de ansiedad buscamos entender mejor. Asimismo, maestros, investigadores y clínicos querían un instrumento que pudiera emplearse desde primer grado hasta preparatoria para poder entender los cambios de desarrollo en la ansiedad, igual que los posibles efectos del tratamiento en el nivel de ansiedad manifiesta. Una inquietud omnipresente adicional entre los profesionales es la eficiencia de los instrumentos de medición, por lo que lo más deseable era que la escala se mantuviera tan breve como fuera posible, conservando al mismo tiempo su utilidad.

Una fuerte crítica estadística del CMAS original proviene de datos proporcionados por Flanagan, Peters y Conry (1969). Estos autores proporcionaron datos para indicar que sólo 12 de los 42 reactivos del CMAS realmente satisfacen los criterios de un buen reactivo de prueba. Los datos normativos que le habrían dado a la escala valor clínico eran asimismo notablemente precarios, a pesar de que los clínicos utilizaron el CMAS durante muchos años. No obstante, los datos disponibles en la escala ni con mucho se aproximaban a los estándares requeridos por la práctica psicométrica más contemporánea o las pruebas profesionales actuales.

Una revisión indicó que el uso de estándares psicométricos clásicos era deseable en el nuevo desarrollo del CMAS. La intención primordial era que el instrumento fuera lo suficientemente preciso como para ser de utilidad tanto para las personas que investigan sobre la ansiedad como para los clínicos, y que conservara la base teórica del CMAS. En consecuencia, se aplicaron procedimientos estándar de análisis de reactivos durante este nuevo desarrollo para aumentar la precisión de las mediciones en el CMASR a través de todo el rango de puntuaciones y para ayudar a garantizar la medición de un solo

rasgo, en este caso, la ansiedad. A pesar de que estos procedimientos estándar pudieron haber tenido como consecuencia la eliminación de algunos reactivos patognomónicos que rara vez se refrendan y que se relacionan con trastornos graves, no se creyó que esto fuera una consideración primordial para la población objetivo –niños ansiosos en edad escolar, en contraposición a la población de pacientes con trastornos severos o anormales. Se pensó que la documentación de los excepcionales indicadores de patología grave era buscada más propiamente en la evaluación de seguimiento de niños con problemas de ansiedad.

Proceso de desarrollo del CMASR

Los objetivos principales en el desarrollo del CMASR fueron varios: crear una medida objetiva de la ansiedad en niños, adecuada para la aplicación en grupo; mantener el tiempo de aplicación al mínimo requerido para la evaluación exacta válida; promover la claridad de los reactivos con un nivel de legibilidad propia para emplearse con niños de primaria; cumplir, hasta donde sea posible, estándares psicométricos contemporáneos sin dejar de tener una escala práctica; desarrollar normas a gran escala e información sobre las puntuaciones de ansiedad de diversos grupos de niños; y determinar si la ansiedad manifiesta se trata mejor como unidimensional o si se facilitaría la interpretación al poseer múltiples escalas. El proceso de desarrollo del CMASR se describe con cierto detalle en las siguientes secciones, ya que su resultado fue el conjunto básico de reactivos y la estructura que integran la base del CMASR2 y de sus propiedades psicométricas.

La primera prueba. En el estudio del desarrollo del CMASR participaron 329 niños en edad escolar, del primero al doceavo grados. A todos se les aplicó la prueba el mismo día en sus respectivas escuelas de una pequeña comunidad urbana en el sureste de EUA. También se le aplicó la prueba a un segundo grupo de 167 niños de los grados 2º, 5º, 9º, 10º y 11º, una vez que el instrumento estuvo terminado para obtener la validación cruzada de la confiabilidad.

Prueba de campo para el CMASR. Se le pidió a un panel de maestros y clínicos experimentados que revisara el CMAS original y sugiriera indicadores de ansiedad manifiesta en niños que no estuvieran cubiertos por la escala. Esto dio como resultado 20 reactivos adicionales, como "Algunas veces me despierto asustado(a)" y "No me acuerdo muy bien de las cosas". Después, los 73 reactivos resultantes se sometieron a un grupo de universitarios especialistas en lectura para obtener la dificultad adecuada de palabras para niños de primer grado. Los especialistas en lectura aconsejaron un nivel de legibilidad aproximado de tercer grado, de modo que la prueba pudiera leerse a los niños de primero y segundo grados. El lector promedio de tercer grado estaría en posibilidades de completar el instrumento por sí mismo. Resultaron numerosos cambios en el CMAS original, como la sustitución de "sanitario" por "baño" en el reactivo 23 y la eliminación de "secretamente" en el reactivo 11. Los pocos cambios en el lenguaje por lo general reflejan algunos cambios en el uso del idioma, y quizá otros cambios en el estilo del discurso coloquial en el sureste estadounidense. Al instrumento se le dio el título inocuo de "Lo que pienso y siento", el cual apareció en la portada del cuestionario de la prueba.

Análisis de datos para el desarrollo de la prueba y la selección de los reactivos. Siguiendo las pautas para las pruebas psicológicas que estaban en boga en ese momento (*American Psychological Association*, 1974; Ebel, 1965; Flanagan et al., 1969; Guilford, 1954), se computaron dos estadísticas de reactivos para cada uno de los 73 reactivos de la prueba –el índice de dificultad p , y la correlación biserial corregida del reactivo en cuanto a la calificación total de la prueba, r_b . Se eliminaron todos los reactivos, con excepción de los que en ese momento estaban agrupados como Mentira (lo que ahora es la escala Defensividad), que no cumplieron ambos criterios de $.3 \leq p \leq .7$ y $r_b \geq .4$. Se eliminaron los reactivos de Mentira que correlacionaban .30 o más con la puntuación de Ansiedad Total o que no se correlacionaban de manera significativa con cualquier otro reactivo en la escala de Mentira.

Después de la selección de reactivos para su inclusión en el CMASR, se computaron las medias y las desviaciones estándar por grado, grupo étnico y sexo para la puntuación de Ansiedad Total y la puntuación de la subescala de Mentira. Posteriormente, las puntuaciones de Ansiedad Total y de la subescala de Mentira se sometieron a un ANOVA en tres direcciones y las varianzas a pruebas F independientes. La prueba de rango múltiple de Duncan se ejecutó con base en puntuaciones por grado. Debido a que la confiabilidad estimada puede estar falsamente inflada cuando se base en la misma muestra que los análisis de reactivos, se aplicó el nuevo instrumento a un grupo de 167 alumnos procedentes de un distrito escolar aparte, con el propósito expreso de contar con un segundo cálculo de confiabilidad.

Resultado del análisis de reactivos. Se retuvieron un total de 28 reactivos de ansiedad y 9 de Mentira del borrador de 73 reactivos. Las estadísticas para los correspondientes reactivos de ansiedad retenidos se presentan en la tabla 4-1. Estos reactivos proporcionaron un estimado de confiabilidad K-R 20 de .83 para la puntuación de Ansiedad Total con la muestra para selección de reactivos. El examen del segundo grupo de 167 estudiantes arrojó un estimado de confiabilidad K-R 20 de .85 para la puntuación de Ansiedad Total. Ambos cálculos de confiabilidad se encontraban dentro del rango superior de estimados de consistencia interna de cuestionarios de personalidad para niños, y de manera firme apoyaron la selección de reactivos para la escala final.

Resumen de resultados del desarrollo de la prueba para el CMASR. El nuevo desarrollo de el CMAS representó una reducción de 33% en la longitud de la escala sin afectar de manera apreciable la confiabilidad. Los estimados de confiabilidad que se obtuvieron aquí (.83 con la muestra de selección de reactivos y .85 con un grupo de validación cruzada) resultaron muy comparables con los coeficientes de confiabilidad reportados para la escala original en otros estudios (.86 en Kitano, 1960; .77 en Finch, Montgomery y Deardoff, 1974, y .84 para niños y .88 para niñas en Allison, 1970). La reducción en el tiempo de aplicación lo hizo también considerablemente más atractivo como instrumento de exploración de grupo.

Se observó que, en las muestras, los niños más pequeños tendían a obtener calificaciones relativamente altas en Mentira y se recomendó a los usuarios emplearla con precaución al interpretar las calificaciones del CMASR para estos niños, aunque se observó que las puntuaciones del CMASR son confiables incluso para niños de primer grado. También se observó que por lo general las mujeres obtuvieron puntuaciones de Ansiedad Total más altas que los varones, resultado que es consistente con investigaciones anteriores que utilizaron el CMAS

Tabla 4-1.
Estadísticas de reactivos para la muestra de desarrollo del CMASR y del CMASR-2

Reactivo	CMASR		CMASR-2	
	<i>p</i>	<i>rb</i>	<i>p</i>	<i>rb</i>
1. Muchas veces siento asco o náuseas.	.67	.52	.37	.47
2. Soy muy nervioso(a).	.36	.50	.35	.52
3. Muchas veces me preocupa que algo malo me pase.	.67	.59	.41	.55
7. Algunas veces me despierto asustado(a).	.39	.53	.36	.47
9. Siento que alguien me va a decir que hago mal las cosas.	.50	.49	.42	.47
11. Me cuesta trabajo tomar decisiones.	.69	.46	.53	.42
12. Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no me salen como quiero.	.61	.47	.46	.36
13. Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí.	.60	.41	.48	.37
14. Todas las personas que conozco me caen bien.	.55	.18	.42	.21
15. Muchas veces siento que me falta el aire.	.33	.47	.31	.37
16. Casi todo el tiempo estoy preocupado(a).	.45	.50	.37	.51
18. Muchas cosas me dan miedo.	.44	.52	.29	.41
19. Siempre soy amable.	.35	.10	.46	.22
20. Me enojo con facilidad.	.45	.50	.48	.29
21. Me preocupa lo que mis papás me vayan a decir.	.63	.47	.48	.42
22. Siento que a los demás no les gusta cómo hago las cosas.	.50	.43	.40	.46
24. Siempre me porto bien.	.43	.09	.52	.19
25. En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a).	.48	.50	.48	.44
26. Me preocupa lo que la gente piense de mí.	.52	.45	.43	.44
27. Me siento solo(a) aunque esté acompañado(a).	.30	.43	.30	.45
29. Siempre soy bueno(a).	.28	.15	.40	.23
30. Es muy fácil herir mis sentimientos.	.46	.60	.38	.48
31. Me sudan las manos.	.44	.42	.34	.29
33. Siempre soy agradable con todos.	.34	.21	.44	.27
34. Me canso mucho.	.55	.57	.48	.41
35. Me preocupa lo que va a pasar.	.70	.56	.48	.52
36. Los demás son más felices que yo.	.39	.44	.42	.39
38. Siempre digo la verdad.	.23	.19	.33	.26
39. Tengo pesadillas.	.50	.61	.47	.46
40. A veces me enojo.	.55	.25	.29	.10
42. Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir en la noche.	.35	.61	.32	.50
43. Me cuesta trabajo concentrarme en mis tareas escolares.	.38	.52	.47	.38
44. A veces digo cosas que no debería decir.	.44	.24	.40	.05
46. Me muevo mucho en mi asiento.	.51	.40	.39	.34
47. Muchas personas están en mi contra.	.33	.42	.30	.35
48. He dicho alguna mentira.	.40	.13	.34	.09
Reactivo 26 del CMASR: Me siento muy mal cuando se enojan conmigo. eliminado del CMASR-2)	.64	.47	.-	.-

original (Bledsoe, 1973; Castaneda, McCandless *et al.*, 1956) y otras escalas de ansiedad bien conocidas (Sarason, Davidson, Lighthall, Waite y Ruebush, 1960). Las diferencias de grado en la ansiedad no aparecieron en las muestras de desarrollo del CMASR como lo habían hecho en algunas investigaciones previas (p. ej. Bledsoe). Castaneda, McCandless *et al.* también fracasaron para encontrar efectos de grado en la adaptación original de el CMAS. Sin embargo, la tendencia general fue que disminuyeran de alguna manera las calificaciones de ansiedad con la edad, un descubrimiento que es coherente con la información anterior de el CMAS. Estos datos se tomaron de

manera colectiva debido a que proporcionaban un fuerte apoyo para el trabajo continuo con el CMASR. Se llevó a cabo un esfuerzo de normatividad a nivel nacional en Estados Unidos que tuvo como resultado la elaboración de normas estratificadas por edad, género y grupo étnico que se han asociado con esta prueba durante los últimos 30 años. La muestra de estandarización del CMASR incluyó a niños de entre 6 y 19 años de edad. El desempeño en el CMASR de una muestra de 97 niños de jardín de niños fue incluido también en el resumen, pero cabe advertir que no se incluyó a ningún niño menor de 6 años en los esfuerzos de estandarización del CMASR-2.

Del CMASR al CMASR-2

Dado lo extenso del contenido y de los análisis empíricos involucrados en la derivación de los reactivos para el CMAS y subsecuentemente para el CMASR, se anticipó que muchos de los reactivos seguirían funcionando tan bien como algunos lo han hecho por más de 50 años y otros por más de 30 años. No obstante, como un esfuerzo para mejorar la escala y garantizar una adecuada cobertura de constructos que resultara coherente con las conceptualizaciones actuales de ansiedad manifiesta en niños y jóvenes, se generaron nuevos reactivos para ser puestos a prueba. Estos se produjeron para reflejar aspectos de ansiedad social y de desempeño importantes para niños contemporáneos en edad escolar. Se concibieron nuevos reactivos basados parcialmente en una revisión de la literatura especializada actual. Otra fuente para los nuevos reactivos o para su nueva redacción fue la opinión que se pidió a un amplio número de profesionales que emplean el CMASR en sus prácticas cotidianas. Los cambios en la redacción, así como también los reactivos nuevos, surgieron, en consecuencia, de las sugerencias de los usuarios al igual que de la nueva información disponible. Este proceso ha tenido como resultado un instrumento mejorado y actualizado para evaluar, comprender y tratar la ansiedad en niños y adolescentes en edad escolar.

Cuarenta nuevos reactivos y cambios en la redacción de reactivos existentes se desarrollaron para ser sometidos a prueba. El cuestionario resultante se aplicó a 308 niños y adolescentes de 6 a 19 años de edad. El CMASR de 1985 y un tercer cuestionario con opciones de escala de valoración fueron aplicados al mismo tiempo. Además de probar los reactivos nuevos y los de nueva redacción, este proceso permitió estudiar las implicaciones y las mejoras potenciales que se pudieron inferir del uso de una escala de evaluación para respuestas de el CMASR, con las opciones de respuesta *Nunca*, *A veces*, *Frecuentemente* y *Siempre* en contraposición con las opciones de respuesta *Sí* y *No* de el CMASR. Con base en el estudio de prueba comparativo utilizando ambos formatos de respuesta, se conservó el formato de opción de respuesta *Sí* y *No*. Estas alternativas para responder son más sencillas de entender para los niños que las opciones de evaluación, y al ser más fácil la elección se reduce la duración de la prueba. Además, y lo que resultó sorprendente, el enfoque de escala de evaluación no arrojó puntuaciones cuya confiabilidad fuera equivalente a las derivadas de respuestas *Sí* y *No*. Por ello, el conservar las opciones de *Sí* y *No* mantiene la continuidad del CMASR-2 en relación con las fortalezas y aplicaciones bien establecidas de los formularios que le antecedieron.

Casi en su totalidad, los reactivos del CMASR fueron sólidos y la mayoría se conservó. Las puntuaciones para la muestra de prueba incluyeron puntuaciones en las escalas de el CMASR. Las puntuaciones promedio de la muestra de prueba y de la muestra de estandarización del CMASR de 1985 se muestran en la tabla 4-2. La única diferencia de puntuación significativa en términos estadísticos indica que los niños y los adolescentes en la muestra de prueba más reciente parecieron describirse a sí mismos de una manera ligeramente más defensiva que los de la muestra de 1985. El tamaño del efecto de .31 para esta diferencia es moderado. (Para una discusión adicional del tamaño del efecto, vea la sección "Diferencias significativas" que aparece más adelante en este capítulo.) Además, el análisis factorial de respuestas de la muestra de prueba arrojó una estructura de factores que apoyan la estructura de escala que se estableció en la muestra anterior. Los resultados de este análisis se muestran en la tabla 4-3.

Se usaron técnicas estadísticas tradicionales para examinar el desempeño de los conjuntos de reactivos de la prueba y de los originales, incluyendo la inspección de los cálculos de homogeneidad de la escala, correlaciones de cada reactivo con respecto al total, correlaciones entre escalas y análisis de factores. Este proceso tuvo como resultado que se conservaran 33 de los 37 reactivos del CMASR sin ningún cambio. La redacción de tres reactivos de Mentira se cambió para eliminar formulaciones con doble negación, y la escala de Mentira se renombró como Defensividad, con nueve reactivos. Trece reactivos nuevos –12 de ellos relacionados con ansiedad social y de desempeño– se seleccionaron para ser incluidos en el CMASR-2.

La tabla 4-4 presenta un resumen de los cambios de reactivos realizados para el CMASR-2. De igual modo, la tabla 3-2 (en el capítulo 3) proporciona una lista detallada de los reactivos, con una nota para señalar si son nuevos o fueron reformulados. Los tres reactivos de la escala de Mentira que se reformularon fueron: "Nunca me enoja", "Nunca digo cosas que no debo decir" y "Nunca digo mentiras", los cuales cambiarían a "A veces me enoja", "A veces digo cosas que no debería decir" y "He dicho alguna mentira". Estos reactivos recibieron puntuación inversa en la escala DEF. Seis de los nuevos reactivos fueron añadidos a la escala de Inquietud/Hipersensibilidad y seis fueron agregados a la escala de Preocupaciones Sociales/Concentración. Estas dos escalas fueron renombradas como Inquietud (16 reactivos) y Ansiedad Social (12 reactivos), respectivamente. Uno de los reactivos originales, "Me siento muy mal cuando se enojan conmigo", parecía no funcionar muy bien con los niños en el contexto actual, por lo que fue eliminado de la escala de Inquietud. Con seis nuevos reactivos centrados en la ansiedad social que incrementaban la escala de Preocupaciones Sociales/Concentración, las respuestas a uno de los reactivos de la escala anterior de siete reactivos que preguntaba directamente acerca de la concentración, "Me cuesta trabajo concentrarme en mis tareas escolares", están más fuertemente asociadas con la puntuación de Ansiedad Fisiológica ($r = .29$) que con las de Ansiedad Social ($r = .23$) o de Inquietud ($r = .21$). Este reactivo se evalúa ahora en la escala de Ansiedad Fisiológica. El nuevo reactivo que se añadió a la escala de Ansiedad Fisiológica es "Tengo demasiados dolores de cabeza". Finalmente, se desarrolló un Formulario Breve para el CMASR-2, integrado por los primeros 10 reactivos del cuestionario, como se enlista en la tabla 3-4, los cuales también se cuentan entre los reactivos del CMASR-2 con las más altas correlaciones de cada reactivo en relación con el total. El Formulario Breve arroja solamente una puntuación de Ansiedad Total (FB-TOT), cuya correlación con la puntuación de Ansiedad Total del cuestionario completo es de .90. No sorprende que las escalas conformadas de esta manera tengan una alta correlación con las de el CMASR, como lo muestran las que se presentan en la tabla 4-4. Las correlaciones de puntuación entre los formularios son sustancialmente más altas que los cálculos de consistencia interna y que la confiabilidad observada en el test-retest para las puntuaciones en cada uno de los formularios. En consecuencia, las puntuaciones del CMASR-2 pueden considerarse equivalentes a las correspondientes a el CMASR, y se puede dar por sentado que la investigación previa que se realizó empleando el CMASR es extensiva igualmente para el CMASR-2. En el capítulo 5, se proporciona información más detallada acerca de las propiedades psicométricas de las puntuaciones del CMASR-2.

Tabla 4-2.
Puntuaciones naturales promedio para la muestra de estandarización del CMASR de 1985 y para la muestra de prueba del CMASR-2

Escala	Muestra de estandarización del CMASR de 1985 (N = 4 972)		Muestra de prueba del CMASR-2 (N = 308)	
	M	DE	M	DE
Mentira	3.1	2.6	3.8*	2.0
Ansiedad Total	11.7	5.6	11.6	6.1
Ansiedad Fisiológica	4.1	2.5	4.2	2.6
Inquietud/Hipersensibilidad	4.8	3.0	4.4	2.7
Preocupaciones Sociales/Concentración	2.8	1.4	3.0	1.9

* La diferencia en las puntuaciones promedio entre las dos muestras es significativa en términos estadísticos, $p < .01$. Los tamaños del efecto para estas diferencias son moderados, con valores de .31 para la puntuación de Mentira y .55 para la de Ansiedad Total.

Tabla 4-3.
Cargas de factores para la muestra de prueba del CMASR-2

Reactivos por escala	Factor		
	1	2	3
Ansiedad Fisiológica			
1. Muchas veces siento asco o náuseas.	.56		
7. Algunas veces me despierto asustado(a).			.55
11. Me cuesta trabajo tomar decisiones.	.33	.45	
15. Muchas veces siento que me falta el aire.	.60		
20. Me enoja con facilidad.	.51		
25. En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a).	.43		
31. Me sudan las manos.	.64		
34. Me canso mucho.	.42		
39. Tengo pesadillas.			.59
46. Me muevo mucho en mi asiento.	.45		
Inquietud/Hipersensibilidad			
2. Soy muy nervioso(a).	.33	.47	
3. Muchas veces me preocupa que algo malo me pase.			.61
16. Casi todo el tiempo estoy preocupado(a).		.66	
18. Muchas cosas me dan miedo.			.44
21. Me preocupa lo que mis papás me vayan a decir.		.49	
26. Me preocupa lo que la gente piense de mí.		.37	.40
30. Es muy fácil herir mis sentimientos.		.54	
35. Me preocupa lo que va a pasar.		.61	
42. Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir en la noche.		.52	
Reactivo 26 del CMASR: Me siento muy mal cuando se enojan conmigo.		.35	
Preocupaciones Sociales/Concentración			
9. Siento que alguien va a decirme que hago mal las cosas.	.35		
13. Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí.	.33	.37	
22. Siento que a los demás no les gusta cómo hago las cosas.	.42		
27. Me siento solo(a) aunque esté acompañado(a).	.67		
36. Los demás son más felices que yo.			.49
43. Me cuesta trabajo concentrarme en mis tareas escolares. (eliminado de la escala de Preocupaciones Sociales/Concentración y añadido a la escala de Ansiedad Fisiológica)			.59
47. Muchas personas están en mi contra.			.57

Nota. N = 308. Sólo se muestran los valores superiores a .30.

Tabla 4-4.
Escala incluida en el CMASR y el CMASR-2

Escala	Número de reactivos del CMASR	Número de reactivos del CMASR-2	Reactivos nuevos	Reactivos reformulados	Reactivos eliminados	Correlación (r) entre el CMASR y CMASR-2
Escala de validez						
Índice (nuevo) de Respuestas Inconsistentes (INC)	—	9 pares				—
Defensividad (DEF) (antes Mentira)	9	9	0	3	0	—
Escala de ansiedad						
Ansiedad Total (TOT)	28	40	13	0	1	.96
Ansiedad Fisiológica (FIS)	10	12	2 ^a	0	0	.97
Inquietud (INQ) (antes Inquietud/Hipersensibilidad)	11	16	6	0	1	.93
Ansiedad Social (SOC) (antes Preocupaciones Sociales/Concentración)	7	12	6	0	1 ^b	.88

^a Un reactivo nuevo y un reactivo trasladado a la escala FIS de la SOC.

^b Un reactivo cambiado de la escala SOC a la FIS.

Estandarización del CMASR-2 de EUA

Después de las pruebas de los nuevos reactivos, de la selección de reactivos y de los ajustes menores al cuestionario del CMASR-2, el cuestionario final de 49 reactivos fue aplicado a una muestra normativa amplia y diversa de niños en edad escolar en sedes distribuidas en todo Estados Unidos. La muestra, a la que en la siguiente discusión y en el capítulo 5 nos referiremos como la muestra completa de referencia, incluyó una muestra total de 3 086 niños, con un número aproximadamente igual de sujetos varones y mujeres de entre 6 y 19 años de edad. La muestra completa de referencia incluyó también un número relativamente amplio de estudiantes negros/afroamericanos ($n = 874$) e hispanos/latinos ($n = 495$), distribuidos uniformemente a lo largo del rango de edades de 6 a 19 años. El muestreo de estos grupos fue para duplicar la provisión de puntos de referencia estables específicos de grupos del CMASR de 1985 para quienes estén interesados en examinar cuestiones referidas a temas de ansiedad específicos de estas comunidades étnicas. Sin embargo, como se verá en la presentación que sigue, las puntuaciones promedio del CMASR-2 obtenidas por dichos grupos no difirieron de ningún modo sistemático o significativo de las calificaciones promedio obtenidas ya sea en esta muestra completa de referencia o en la muestra de estandarización que se describe en el siguiente párrafo.

La muestra de estandarización del CMASR-2 es un subgrupo de la muestra completa de referencia descrita más arriba, que fue tomado para corresponder de manera más estrecha con la composición demográfica de la población de Estados Unidos. Las características demográficas de la muestra de estandarización del CMASR-2 se muestran en la tabla 4-5. La distribución a lo largo de las edades es sumamente uniforme, y la representación de los grupos demográficos identificados es razonablemente consistente con su representación en la

población de Estados Unidos en general. Las puntuaciones estándar para del CMASR-2 se basan en este grupo representativo de 2 368 encuestados. Todos los principales análisis subsiguientes se efectuaron utilizando tanto la muestra completa de referencia como la submuestra de estandarización. Los resultados fueron virtualmente idénticos. En consecuencia, con el fin de evitar redundancias inadecuadas y para proporcionar las estimaciones más estables como punto de partida para investigaciones futuras con el CMASR-2, los resultados que se reportan aquí son los de la muestra completa de referencia.

Las puntuaciones naturales promedio obtenidas por el grupo entero y por estudiantes de distintos géneros, antecedentes étnicos y edades se muestran en las tablas 4-6, 4-7, 4-8 y 4-9, respectivamente. Las puntuaciones estándar se desarrollaron en primer término para la muestra completa, y se evaluó la pertinencia de las puntuaciones-7 resultantes como puntos de referencia para diferentes subgrupos dentro de la muestra. Se hizo evidente que para propósitos prácticos, las diferencias de puntuaciones observadas entre los subgrupos basados en el género y los antecedentes étnicos no eran lo suficientemente grandes o sistemáticas como para justificar el uso de normas separadas para interpretar clínicamente las pruebas, aunque algunos investigadores podrán encontrar de interés los cuadros separados que se proporcionan en este capítulo. Las diferencias de puntuaciones que se observaron en diversas edades no fueron grandes en su mayoría, pero la manera sistemática en que aparecieron fue suficiente para justificar la estratificación de normas por edades. El proceso de evaluación se describe en la siguiente sección. En última instancia, ese proceso resultó en la incorporación de calificaciones estándar del CMASR-2 basadas en los tres subgrupos estratificados por edades de la muestra de estandarización que ya han sido mencionados—de 6 a 8 años de edad, de 9 a 14 y de 15 a 19 años.

Tabla 4-5.
Características demográficas de la muestra de estandarización del CMASR-2

Edad	Total	Porcentaje de la muestra	Varones	Mujeres	Negros/afroamericanos	Hispanos/latinos
6	92	3.9	48	44	17	18
7	178	7.5	90	88	18	24
8	192	8.1	102	90	22	21
9	249	10.5	122	127	35	32
10	253	10.7	124	129	37	42
11	144	6.1	76	68	31	27
12	178	7.5	94	84	20	36
13	202	8.5	97	105	23	40
14	203	8.6	87	116	33	52
15	186	7.9	93	93	31	31
16	211	8.9	106	105	35	32
17-19	280	11.8	146	134	49	51

Raza/grupo étnico	Total	Porcentaje de la muestra	Porcentaje de la población de Estados Unidos menor de 17 años de edad ^a
Asiático/de las Islas del Pacífico	84	3.5	3.5
Negro/afroamericano	351	14.8	14.7
Hispano/latino	406	17.1	17.1
Indio americano	24	1.0	0.9
Blanco	1,457	61.5	60.9
Otro	46	1.9	2.9

Años de educación concluidos por el (la) jefe de la familia	Total	Porcentaje de la muestra	Porcentaje de la población de Estados Unidos ^a
No se graduó de la preparatoria	489	20.7	11.4
Graduado(a) de preparatoria	817	34.5	31.9
Algunos estudios universitarios	513	21.7	28.0
Graduado(a) de la universidad	322	13.6	19.9
Postgraduado(a)	215	9.1	8.8
Información faltante	12	0.5	

Región geográfica	Total	Porcentaje de la muestra	Porcentaje de la población de Estados Unidos ^a
Noreste	540	22.8	19.0
Medio Oeste	587	24.8	22.9
Sur	772	32.6	35.6
Oeste	469	19.8	22.5

Nota. N = 2 368.

^a Según el censo de 2000 en Estados Unidos (U. S. Census Bureau).

Tabla 4-6.

Puntuaciones naturales promedio de la muestra completa de referencia del CMASR-2

Escala	M	DE
Ansiedad Total (TOT)	15.7	8.0
Ansiedad Fisiológica (FIS)	5.0	2.7
Inquietud (INQ)	6.4	3.9
Ansiedad Social (SOC)	4.3	2.9
Defensividad (DEF)	3.6	2.3
Formulario Breve de Ansiedad Total (FB-TOT)	3.6	2.6

Nota. N = 3 086.

Tabla 4-7.

Puntuaciones naturales promedio para varones y mujeres en la muestra completa de referencia del CMASR-2

Escala	Varones (n = 1 502)		Mujeres (n = 1 584)	
	M	DE	M	DE
Ansiedad Total (TOT)	14.4	7.8	16.9	8.1
Ansiedad Fisiológica (FIS)	4.7	2.6	5.3	2.7
Inquietud (INQ)	5.6	3.7	7.1	3.9
Ansiedad Social (SOC)	4.1	2.8	4.5	2.9
Defensividad (DEF)	3.5	2.3	3.9	2.4
Formulario Breve de Ansiedad Total (FB-TOT)	3.2	2.5	4.0	2.6

Tabla 4-8.

Puntuaciones naturales promedio para subgrupos en la muestra completa de referencia del CMASR-2 con base en antecedentes étnicos

Escala	Asiático/de las Islas del Pacífico (n = 120)		Negro/afroamericano (n = 874)		Hispano/latino (n = 495)	
	M	DE	M	DE	M	DE
Ansiedad Total (TOT)	16.8	6.5	16.4	6.4	16.1	7.2
Ansiedad Fisiológica (FIS)	5.0	2.3	5.0	2.3	5.0	2.4
Inquietud (INQ)	6.6	3.0	6.7	3.2	6.5	3.5
Ansiedad Social (SOC)	5.2	2.6	4.7	2.5	4.5	2.6
Defensividad (DEF)	3.9	2.0	3.8	1.9	3.9	2.2
Formulario Breve de Ansiedad Total (FB-TOT)	4.0	2.1	4.1	2.2	3.7	2.4

Tabla 4-9.

Puntuaciones naturales promedio por grupo de edad en la muestra completa de referencia del CMASR-2

Escala	6 (n = 116)		7 (n = 225)		8 (n = 240)		9 (n = 313)		10 (n = 324)		11 (n = 220)		12 (n = 210)		13 (n = 252)		14 (n = 265)		15 (n = 244)		16 (n = 277)		17-19 (n = 400)	
	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE
Ansiedad Total (TOT)	18.4	7.9	18.2	7.8	17.5	8.8	16.6	8.2	16.3	8.1	16.4	7.6	14.0	8.3	15.5	7.4	16.0	7.0	14.8	7.5	13.7	8.1	13.4	7.9
Ansiedad Fisiológica (FIS)	5.9	2.7	5.8	2.7	5.5	2.9	5.4	2.7	5.1	2.8	5.0	2.6	4.5	2.6	4.8	2.4	5.2	2.4	4.9	2.6	4.5	2.7	4.4	2.5
Inquietud (INQ)	7.4	3.6	7.6	3.6	7.3	4.1	6.9	3.9	6.9	3.9	6.6	3.7	5.6	4.1	6.2	3.7	6.3	3.5	5.8	3.6	5.5	3.8	5.4	3.9
Ansiedad Social (SOC)	5.1	2.7	4.9	2.7	4.8	3.2	4.4	3.0	4.3	2.9	4.7	2.8	3.9	2.9	4.5	2.8	4.5	2.6	4.1	2.6	3.7	2.8	3.6	2.8
Defensividad (DEF)	5.3	1.9	5.2	2.1	4.6	2.5	3.9	2.5	3.8	2.4	3.5	2.1	3.0	2.2	3.2	2.3	3.5	2.0	2.8	2.1	2.7	2.0	3.0	2.1
Formulario Breve de Ansiedad Total (FB-TOT)	4.4	2.5	4.4	2.7	4.2	2.8	3.9	2.7	3.9	2.6	4.0	2.5	3.1	2.6	3.5	2.4	3.7	2.3	3.3	2.4	2.9	2.5	2.8	2.5

Para garantizar que las escalas fueran comparables entre sí y con las puntuaciones de otras pruebas que se aproximan a una distribución normal, las distribuciones de las puntuaciones naturales para todas las puntuaciones del CMASR-2 fueron "normalizadas", como lo describió Angoff (1984), antes de convertirse en puntuaciones estándar. La normalización se consideró adecuada, ya que las distribuciones de puntuación del CMASR-2 para todas las muestras fueron aproximadamente normales, lo que indica sólidamente puntuaciones latentes con distribución normal. Las calificaciones estándar fueron derivadas entonces por medio de transformación lineal simple de las distribuciones de la puntuación natural normalizada, como se describe en la mayoría de los textos básicos sobre mediciones. Este proceso resulta en puntuaciones-*T* que corresponden con los mismos rangos de percentiles a través de cada una de las escalas.

Variables moderadoras y puntuaciones del CMASR-2

Las variables moderadoras cuyo efecto se examinó en las puntuaciones del CMASR-2 fueron género, antecedentes étnicos y edad. Se formaron subgrupos para examinar si las puntuaciones promedio de la muestra completa proporcionan un punto de referencia satisfactorio para el desempeño de cada subgrupo. Las puntuaciones-*T* basadas en la muestra completa permiten el desempeño relativo de los subgrupos para ser evaluados fácilmente. Las puntuaciones-*T* promedio para varones y mujeres en la muestra completa de referencia se presentan en la tabla 4-10; los resultados promedio para quienes definieron sus antecedentes étnicos como asiático/de las Islas del Pacífico, egro/afroamericano o hispano/latino se muestran en la tabla 4-11, y las calificaciones promedio de diversos grupos de edad se presentan en la tabla 4-12. El concepto de *tamaño del efecto*, que se describe en la siguiente sección, proporciona un marco útil para discusiones suplementarias de estos datos en términos de sus diferencias significativas. En este capítulo se discuten únicamente comparaciones de puntuaciones de subgrupos demográficos con puntuaciones promedio para la muestra completa. Éstas son las comparaciones que se relacionan directamente con la factibilidad de las pruebas actuales para proporcionar un punto de referencia adecuado (50*T*) para interpretar puntuaciones a través de diversos subgrupos demográficos. La discusión de comparaciones directas de puntuaciones entre grupos dentro de los grupos demográficos se desarrolla en el capítulo 5.

Diferencias significativas. Cuando las puntuaciones obtenidas de muestras grandes se comparan mediante técnicas simples de análisis de varianza, las diferencias confiables que se identifican entre puntuaciones de grupo son a menudo significativas en términos estadísticos, simplemente porque se utilizaron muestras grandes, en vista de que las diferencias reales son sumamente pequeñas —en algunos casos, de una fracción de un punto en las puntuaciones escalares. Tales diferencias significativas en términos estadísticos no son muy importantes para propósitos clínicos. El saber, por ejemplo, que los varones obtienen de manera confiable puntuaciones de prueba de un tercio de punto mayores que las que obtienen las mujeres no le aporta ninguna información útil al clínico que está tratando de decidir si una puntuación-*T* de 58*T* debe interpretarse de manera diferente para un varón que para una mujer. Para propósitos prácticos, la puntuación se interpretará de manera similar, incluso si se ajusta hacia arriba o hacia abajo un tercio de punto en caso de que se tomen en cuenta las diferencias de género.

Se utilizan tamaños del efecto para evaluar si una diferencia significativa en términos estadísticos tiene también pro-

babilidades de ser significativa en términos clínicos (Cohen, 1992; Horst, Tallmadge y Wood, 1975). En general, dimensiones de efecto de 0.1 a 0.3 unidades de desviación (o de 1 a 3 puntos de la puntuación-*T*) se consideran pequeñas y de poca importancia práctica, dimensiones de efecto entre 0.3 y 0.5 unidades de desviación (o de 3 a 5 puntos de la puntuación-*T*) se consideran moderadas y dimensiones de efecto mayores de 0.5 unidades de desviación (o 5 puntos de la puntuación-*T*) se consideran grandes. Los tamaños del efecto de moderados a grandes indican diferencias significativas en términos clínicos, en particular cuando se observan a través de una variedad de puntuaciones en un patrón consistente con otros conocimientos acerca de las comparaciones que se estén realizando.

Las puntuaciones estándar, y en especial las puntuaciones-*T*, ofrecen un modo conveniente de observar los datos cuando los tamaños del efecto son tomados en consideración al tener una media de 50 y una desviación estándar de 10. Por ejemplo, el saber que la puntuación natural promedio de Ansiedad Total obtenida por un determinado grupo es 28, no le permite a uno inferir nada acerca del tamaño del efecto comparativo. Sin embargo, si el desempeño promedio para un grupo se expresa como una puntuación-*T* de 56*T*, el tamaño del efecto para este promedio grupal comparado con el desempeño promedio del grupo de referencia relevante puede ser determinado de inmediato. En nuestro ejemplo, la puntuación de 56-*T* para el grupo en consideración está 6*T* puntos por encima de la puntuación promedio de 50*T* de la muestra de referencia. Estos 6*T* puntos representan 0.6 de la desviación estándar de 10*T* en la muestra de referencia. El tamaño del efecto para la comparación es por lo tanto 0.6, una diferencia relativamente grande. Las puntuaciones promedio que se presentan en las tablas 4-10 a la 4-14, así como en otras tablas de este manual, se expresaron como puntuaciones-*T* para lograr este tipo de facilidad al comparar el desempeño del CMASR-2 a través de una diversidad de muestras.

Puntuaciones promedio del CMASR-2 para diversos agrupamientos demográficos. Las puntuaciones-*T* promedio de varones y mujeres que se muestran en la tabla 4-10 indican que a pesar de existir variaciones pequeñas, confiables, entre las puntuaciones promedio obtenidas por varones y mujeres, la media esperada de 50*T* caracteriza por igual, de manera adecuada, las puntuaciones de ambos grupos. Los varones obtuvieron puntuaciones promedio ligeramente más bajas que el promedio esperado de 50*T*; en cambio, las mujeres tuvieron una calificación ligeramente más alta que la del promedio esperado. Aun cuando las diferencias son significativas en términos estadísticos, los tamaños del efecto reducidos, con un rango de 0.07 a 0.18 (mediana = 0.13; menos de 2 puntos de puntuación-*T*), demuestran que las diferencias estadísticas no conllevan una importancia significativa para interpretaciones clínicas.

Las puntuaciones-*T* promedio para individuos asiáticos/de las Islas del Pacífico, negros/afroamericanos e hispanos/latinos, presentadas en la tabla 4-11, sugieren de nueva cuenta que la media de 50*T* proporciona una caracterización satisfactoria de las puntuaciones promedio del CMASR-2 en estos grupos. Una excepción notable es la puntuación de Ansiedad Social superior al promedio para el grupo de asiáticos/de las Islas del Pacífico. El tamaño del efecto para esa diferencia es moderado (0.31; alrededor de 3 puntos de puntuación-*T*), mientras que los demás tamaños del efecto son pequeños, en un rango de 0.09 a 0.15 (mediana = 0.10 o 1 punto de puntuación-*T*).

En oposición a los demás agrupamientos, las puntuaciones-*T* promedio de los diferentes grupos de edad en la muestra, presentados en la tabla 4-12, muestran variaciones de pequeñas a moderadas en relación con el promedio esperado

Tabla 4-10.
Puntuaciones-T promedio de varones y mujeres en la muestra completa de referencia del CMASR-2

Escala	Varones (n = 1 502)		Mujeres (n = 1584)	
	M	de ^a	M	de
Ansiedad Total (TOT)	48.5*	0.15	51.5*	0.15
Ansiedad Fisiológica (FIS)	49.0*	0.10	51.0*	0.10
Inquietud (INQ)	48.2*	0.18	51.8*	0.18
Ansiedad Social (SOC)	49.3*	0.07	50.8*	0.08
Defensividad (DEF)	49.8		50.4	

^a de = tamaño del efecto.

*p < .01 para una prueba t de una sola muestra, comparando el valor obtenido con la media esperada de 50T.

Tabla 4-11.
Puntuaciones-T promedio de subgrupos en la muestra completa de referencia del CMASR-2 basada en antecedentes étnicos

Escala	Asiático/de las Islas del Pacífico (n = 120)		Negro/afroamericano (n = 874)		Hispano/latino (n = 495)	
	M	de ^a	M	de	M	de
Ansiedad Total (TOT)	51.6		50.9	0.09	50.5	
Ansiedad Fisiológica (FIS)	49.9		50.1		50.0	
Inquietud (INQ)	50.8		51.0	0.10	50.5	
Ansiedad Social (SOC)	53.1*	0.31	51.5	0.15	51.0	
Defensividad (DEF)	51.3		51.0	0.10	51.3*	0.13

*p < .01 para una prueba t de una sola muestra, comparando el valor obtenido con la media esperada de 50T.

Tabla 4-12.
Puntuaciones-T promedio por grupo de edad en la muestra completa de referencia del CMASR-2

Escala	6 (n = 116)		7 (n = 225)		8 (n = 240)		9 (n = 313)		10 (n = 324)		11 (n = 220)		12 (n = 210)		13 (n = 252)		14 (n = 265)		15 (n = 244)		16 (n = 277)		17-19 (n = 400)	
	M	de ^a	M	de	M	de	M	de	M	de	M	de	M	de	M	de	M	de	M	de	M	de	M	de
Ansiedad Total (TOT)	53.3	0.33	53.1*	0.31	52.2*	0.22	51.1		50.8		50.9		47.9*	0.21	49.8		50.5		49.0		47.5*	0.25	47.2*	0.28
Ansiedad Fisiológica (FIS)	53.4*	0.34	52.7*	0.27	51.5*		51.3		50.3		50.0		48.1*	0.19	49.1		50.8		49.7		48.1*	0.19	47.9*	0.21
Inquietud (INQ)	52.7*	0.27	53.2*	0.32	52.3*	0.23	51.4		51.4		50.7		47.9*	0.21	49.7		49.8		48.7		47.8	0.22	47.6*	0.24
Ansiedad Social (SOC)	52.8*	0.28	52.2*	0.22	51.8		50.5		50.2		51.7*	0.17	48.8		50.8		50.8		49.4		48.0*	0.20	47.6*	0.24
Actitud a la Defensividad (DEF)	57.0*	0.70	56.5*	0.65	54.4*	0.44	51.3		50.9		49.6		47.5*	0.25	48.3*	0.17	49.8		46.7*	0.33	46.4*	0.36	47.7*	0.23

^a de = tamaño del efecto.

*p < .01 para una prueba t de una sola muestra, comparando el valor obtenido con la media esperada de 50T.

de 507 que aparece de manera sistemática a través del rango de edad. Los niños más pequeños tendieron a obtener puntuaciones relativamente altas en todas las escalas, en particular en la escala Defensividad. Los adolescentes más grandes obtuvieron puntuaciones más bajas que los niños pequeños, en particular en la escala Defensividad. La mitad de las puntuaciones promedio a través de los rangos de edad (30 de 60) son significativamente diferentes del promedio esperado de 507. Los tamaños del efecto van de pequeños a grandes, en un rango de 0.17 a 0.70 (mediana = 0.25). La estratificación en tres grupos de edad para las normas del CMASR-2, en edades de 6 a 8, de 9 a 14 y de 15 a 19 años se determinó con base en el grado de generalización y en el patrón sistemático de estas diferencias. Las puntuaciones ajustadas por edad que se obtuvieron con base en estos tres agrupamientos por edad se muestran en la tabla 4-13. Solamente 5 de las 60 puntuaciones-*T* promedio representan valores significativamente distintos del promedio esperado de 507, y todos los tamaños del efecto son pequeños, con rangos de 0.17 a 0.23 (mediana = 0.21). La tabla 4-14 presenta puntuaciones-*T* promedio ajustadas por edad para subgrupos basados en el género y el grupo étnico. Las puntuaciones promedio son extremadamente similares a las que ya se presentaron en las tablas 4-10 y 4-11, sin ninguna diferencia significativa en términos clínicos con respecto al promedio esperado de 507. El tamaño del efecto marginalmente moderado de 0.32 del grupo asiático/de las Islas del Pacífico en la escala SOC es una excepción que se espera sea aclarada en futuros esfuerzos de investigación.

Debe advertirse aquí que incluso si se identifican diferencias confiables en puntuaciones promedio y éstas se repiten a través de varias muestras conformadas alrededor de características demográficas, no deberían afectar necesariamente la interpretación de las puntuaciones de una prueba. Las diferencias de grupo confiables que reflejen verdaderas diferencias en el dominio medido por las puntuaciones afectadas simplemente aportarían un apoyo adicional a la validez de la medida. La interpretación de las puntuaciones se vería afectada únicamente cuando se demuestre que las diferencias en las puntuaciones promedio se deben a diferencias en el significado percibido de los reactivos en la escala para un determinado grupo, lo que podría resultar, por ejemplo, en distintos patrones de relaciones entre puntuaciones de pruebas y otras

mediciones de constructos relacionados. Se espera que futuros estudios investiguen de manera más rigurosa las diferencias de puntuaciones del CMASR-2 que pudieran garantizar normas separadas o interpretaciones alternativas de las puntuaciones para determinados grupos de niños y adolescentes.

Desarrollo del índice de Respuestas Inconsistentes del CMASR-2

Las respuestas inconsistentes dadas por un estudiante pueden comprometer la precisión de los resultados del CMASR-2 y disminuir su utilidad para la evaluación y la planeación. Se desarrolló un índice de Respuestas Inconsistentes para el CMASR-2 para ayudar a identificar cuándo tal posibilidad debe considerarse. Para desarrollar este índice, se revisaron las respuestas a los 49 reactivos del cuestionario final del CMASR-2 para hallar pares de reactivos cuyas respuestas estuvieran altamente correlacionadas entre sí. Se identificaron pares de reactivos cuyas respuestas estaban correlacionadas en .40 o más en la muestra completa de referencia. La correlación entre respuestas de reactivos para cada par de éstos del Índice INC se presenta en la tabla 4-15. La puntuación INC se determina contando el número de pares de reactivos para los cuales los valores de la respuesta difieran, con excepción del par de reactivos 38 y 48; este último par se contabiliza en el índice INC si las respuestas dadas son iguales. La puntuación INC promedio individual en la muestra completa de referencia fue 2.88 (*DE* = 1.78). La puntuación INC promedio en respuestas al azar generadas para el CMASR-2 fue 5.43 (*DE* = 1.45). De este modo, tomando en consideración un estimado de confiabilidad para pares de reactivos INC (.73) cuando el índice INC es 6, aproximadamente 1.5 desviaciones estándar por encima del promedio de la muestra de referencia completa, la probabilidad estimada de que las respuestas se generaran al azar es de 81%. Cuando la puntuación INC es 7, más de 2 desviaciones estándar por encima del promedio, la probabilidad de que las puntuaciones se produjeran por respuestas al azar se estima en 89%. Puntuaciones INC de 8 o 9 se encuentran alrededor de 3 desviaciones estándar por encima del promedio y su probabilidad tiene un estimado de 92% y 94%, respectivamente, de que las respuestas hayan sido producidas al azar.

Tabla 4-13.
Puntuaciones-*T* promedio por grupo de edad ajustadas a la edad en la muestra completa de referencia del CMASR-2

Escala	6 (<i>n</i> = 116)		7 (<i>n</i> = 225)		8 (<i>n</i> = 240)		9 (<i>n</i> = 313)		10 (<i>n</i> = 324)		11 (<i>n</i> = 220)		12 (<i>n</i> = 210)		13 (<i>n</i> = 252)		14 (<i>n</i> = 265)		15 (<i>n</i> = 244)		16 (<i>n</i> = 277)		17-19 (<i>n</i> = 400)	
	<i>M</i>	<i>de</i> ^a	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>
Ansiedad Total (TOT)	50.6		50.5		49.5		50.9		50.6		50.6		47.7*	0.23	49.5		50.2		51.3		49.7		49.4	
Ansiedad Fisiológica (FIS)	51.1		50.4		49.3		51.3		50.3		49.9		48.0*	0.20	49.1		50.8		51.3		49.7		49.5	
Inquietud (INQ)	50.1		50.7		49.7		51.1		51.2		50.5		47.7*	0.23	49.4		49.6		50.8		50.0		49.7	
Ansiedad Social (SOC)	50.9		50.2		49.7		50.1		49.9		51.3		48.4		50.4		50.4		51.4		49.9		49.5	
Estado a la Defensividad (DEF)	51.4		50.9		48.7		51.7*	0.17	51.3		49.9		47.9*	0.21	48.6		50.1		49.7		49.5		50.9	

^a *de* = tamaño del efecto.

**p* < .01 para una prueba *t* de una sola muestra, comparando el valor obtenido con la media esperada de 507.

Tabla 4-14. Puntuaciones-*T* promedio por género y antecedentes étnicos ajustadas a la edad en la muestra completa de referencia del CMASR-2

Escala	Varones (<i>n</i> = 1 502)		Mujeres (<i>n</i> = 1 584)		Asiático/de las Islas del Pacífico (<i>n</i> = 120)		Negro/ afroamericano (<i>n</i> = 874)		Hispano/latino (<i>n</i> = 495)	
	<i>M</i>	<i>de</i> ^a	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>
Ansiedad Total (TOT)	48.4*	0.16	51.5*	0.15	51.8		51.0*	0.10	50.6	
Ansiedad Fisiológica (FIS)	49.0*	0.10	51.0*	0.10	50.1		50.2*	0.02	50.1	
Inquietud (INQ)	48.1*	0.19	51.9*	0.19	51.0		51.1*	0.11	50.5	
Ansiedad Social (SOC)	49.3*	0.07	50.8*	0.08	53.2*	0.32	51.6*	0.16	51.0	
Defensividad (DEF)	49.7		50.4		51.7		51.1*	0.11	51.5*	0.15

^a *de* = tamaño del efecto.

**p* < .01 para una prueba *t* de una sola muestra, comparando el valor obtenido con la media esperada de 50.7.

**Tabla 4-15.
Correlaciones de pares de reactivos en el índice de
Respuestas Inconsistentes (INC)**

Par de reactivos	<i>r</i>
4. Tengo miedo que otros niños se rían de mí durante la clase.	.67
10. Tengo miedo que los demás se rían de mí.	
19. Siempre soy amable.	.61
33. Siempre soy agradable con todos.	
24. Siempre me porto bien.	.48
29. Siempre soy bueno(a).	
6. Me preocupa no agradarle a los otros.	.45
49. Me preocupa decir alguna tontería.	
23. Me da miedo hablar en voz alta ante mis compañeros durante la clase.	.45
37. Tengo miedo de hablar en voz alta delante de un grupo.	
7. Algunas veces me despierto asustado(a).	.44
39. Tengo pesadillas.	
3. Muchas veces me preocupa que algo malo me pase.	.43
35. Me preocupa lo que va a pasar.	
2. Soy muy nervioso(a).	.41
8. La gente me pone nervioso(a).	
38. Siempre digo la verdad.	.41
48. He dicho alguna mentira. (nueva redacción; puntuación inversa).	

5

Propiedades psicométricas

Este capítulo proporciona información acerca de la confiabilidad de las puntuaciones del CMASR-2 y evidencias pertinentes con respecto a la validez de las interpretaciones de las puntuaciones de la prueba del CMASR-2 que se proporcionaron en el capítulo 3. El capítulo comienza con una breve revisión de la confiabilidad en tanto concepto psicométrico, para luego dirigirse a una discusión de la confiabilidad de las puntuaciones del CMASR-2 en particular. En seguida, se repasa la cuestión de la validez junto con evidencia relacionada con el uso y la interpretación de las puntuaciones del CMASR-2.

Confiabilidad como constructo psicométrico

El concepto de confiabilidad se refiere a la consistencia y precisión relativa con que las puntuaciones tomadas de un instrumento de medición (p. ej., una prueba, una regla, un reloj) calculan la cantidad o alguna característica numérica de algún rasgo u otra variable para cuya medida ha sido diseñada la prueba (p. ej., ver Reynolds, 1998). Se trata de un concepto clave en la teoría de las mediciones, ya que se relaciona con la utilidad práctica de todos los tipos y sistemas de medición. Sin importar lo que se esté midiendo —tiempo, peso, altura, distancia, logro, aptitud o ansiedad—, la confiabilidad de las puntuaciones que se obtienen es importante y debe ser tomada en consideración no sólo al elegir las pruebas, sino también en su aplicación e interpretación. Todas las mediciones contienen error, sean de atributos físicos, objetos o constructos. Las ciencias físicas a menudo se ven restringidas debido al error de medición y deben lidiar con variaciones en sus mediciones, así como los psicólogos y los educadores deben hacerlo con las pruebas psicológicas y educativas.

Al medir constructos en psicología y en educación, los reactivos de las pruebas son generados típicamente para relacionarse con el constructo en cuestión. Sin embargo, es imposible formular todas las preguntas posibles, de modo que se elige una muestra de reactivos potenciales. La extensión con la que el conjunto de preguntas elegido es realmente representativo del dominio de preguntas posibles es un componente clave de la confiabilidad para pruebas como el CMASR-2. Las escalas con alta confiabilidad arrojarán resultados consistentes y precisos a través de conjuntos de reactivos tomados de un dominio común. Las escalas con una confiabilidad pobre arrojarán puntuaciones marcadamente diferentes si se elige y se aplica una muestra distinta de reactivos presuntamente del mismo dominio. A las estimaciones de qué tan bien un conjunto de reactivos calcula la puntuación que se obtendría en el caso de que todas las preguntas posibles pudiesen ser formuladas, se les conoce comúnmente como estimados de la confiabilidad de la consistencia interna y se emplean para calcular

errores de muestreo de dominio (Nunnally, 1978; Reynolds, Livingston y Willson, 2006), el tipo de errores que más preocupan en pruebas como el CMASR-2.

Una estadística que se usa comúnmente para examinar esta forma de confiabilidad es el coeficiente alfa de Cronbach (Cronbach, 1951). Se puede considerar que los coeficientes alfa proporcionan un estimado de la suficiencia de contenido o del muestreo de dominio. A los estimados de confiabilidad con base alfa también se les considera representativos de un límite inferior de confiabilidad (Cronbach, 1988; Rajaratnam, Cronbach y Gleser, 1965). El rango de los coeficientes alfa va de 0 a 1.00. Para pruebas psicológicas del tipo del CMASR-2, se consideran adecuados estimados de .70 o superiores.

Los estimados de confiabilidad como los coeficientes alfa pueden utilizarse en conjunto con estimados de desviación estándar para calcular un valor de error estándar de medición (*EEM*; $EEM = DE * \text{RaízCuadrada}[1 - r]$). Con la intención de enfrentar los posibles efectos de variación aleatoria debidos a error de medición, el *EEM* indica el rango en que sería probable que cayera la calificación "verdadera" de un estudiante (con una probabilidad de 68%), dada la calificación obtenida en la prueba. Un valor de *EEM* de $\pm 4T$, por ejemplo, indica que si un estudiante obtiene una puntuación de prueba real de 50T, su calificación de prueba verdadera con ausencia de error de medición probablemente caería entre $50T - 4T$ y $50T + 4T$ o entre 46T y 54T.

El nivel de confianza de 68% asociado con el valor de *EEM* se utiliza a menudo en pruebas psicológicas, y por lo tanto proporciona un estándar familiar para la interpretación de puntuaciones del CMASR-2. No obstante, si se desea un nivel de confianza mayor, se puede conseguir por lo menos de dos maneras. En primer lugar, el *EEM* puede usarse para especificar el nivel de confianza de que la puntuación verdadera de un estudiante caiga ya sea por encima o por debajo de la obtenida ± 1 *EEM*. De este modo, en el ejemplo del estudiante cuya puntuación real es 50T, puede decirse con un nivel de certeza de 84% o que la puntuación verdadera del estudiante cae en algún lugar por debajo de $50T + 4T$, o bien, por debajo de 54T, o a la inversa, que existe un nivel de certeza de 84% de que la calificación verdadera del estudiante caiga en algún lugar por encima de $50T - 4T$, o por encima de 46T. Este enfoque es adecuado cuando el interés se centra ante todo en la implicación de las puntuaciones solamente en un extremo de una determinada escala.

Otro modo de mejorar el nivel de confianza en la interpretación de las puntuaciones de pruebas es multiplicar el valor de *EEM* antes de aplicarlo. Por ejemplo, multiplicar el *EEM* por 1.5 permite especificar con un nivel de confianza de 86% el rango en que cae la puntuación verdadera de un estudiante. En el ejemplo previo del estudiante que obtiene una puntuación de prueba real de 50T, este rango se especificaría como que

cae entre $50T - 6T$ y $50T + 6T$, o entre $44T$ y $56T$. Un nivel de certeza aún mayor (95%) puede alcanzarse duplicando el valor de EEM . En el ejemplo, un valor de EEM de $\pm 4T$ indica que la puntuación verdadera del estudiante, dada la puntuación obtenida de $50T$, caería posiblemente (con 95% de probabilidad) entre $50T - 8T$ y $50T + 8T$, o entre $42T$ y $58T$. Incorporar estas estimaciones a las interpretaciones de las puntuaciones de pruebas exige que el profesional tome en consideración el propósito de la evaluación y que se esfuerce en equilibrar la precisión estadística con la coherencia práctica y la utilidad apropiada para un escenario y un propósito particulares. El uso de intervalos de confianza reconoce de este modo la imprecisión inherente a cualquier puntuación de prueba psicológica o educativa. También evita hacer demasiado énfasis en un solo número como si fuera una representación exacta o casi exacta de una característica.

Confiabilidad de las puntuaciones del CMASR-2

Como se ha comentado, la fuente principal de preocupación en cuanto a la confiabilidad de las puntuaciones del CMASR-2 está en el muestreo de dominio o contenido. Aquí, esto se refiere a la probabilidad de que los niños hubieran obtenido la misma puntuación si se les hubiera planteado un conjunto diferente de preguntas, formuladas igualmente con la intención de evaluar ansiedad. Hay muchas oraciones que reflejan ansiedad, y no es ni deseable ni factible plantear cada una de las preguntas, de modo que se realiza un muestreo del dominio de reactivos. Afortunadamente, los errores debidos al muestreo de dominio son los más fáciles de estimar con precisión (cf. Nunnally, 1978; Reynolds et al., 2006). Para el CMASR-2, el coeficiente alfa se ha calculado de manera rutinaria, ya que es la medida preferida para la confiabilidad de una prueba y proporciona un estimado de la correlación teórica entre formas alternas verdaderas de una prueba, y se puede mostrar que es la media de todas las posibles confiabilidades divididas en mitades de un determinado conjunto de reactivos (cf. Nunnally; Reynolds et al.).

Los estimados alfa de Cronbach para el CMASR-2, que representan la homogeneidad de contenido de las puntuaciones escalares resultantes y el límite inferior de su confiabilidad, no solamente fueron adecuadas, sino mejoradas por el CMASR. Los valores para las respuestas dadas por la muestra completa

Tabla 5-1. Estimaciones de confiabilidad para la muestra completa de referencia del CMASR-2

Escala	Alfa de Cronbach ^a	Test-retest ^b
Ansiedad Total (TOT)	.92	
Ansiedad Fisiológica (FIS)	.75	.73
Inquietud (INQ)	.86	.71
Ansiedad Social (SOC)	.80	.64
Defensividad (DEF)	.79	.67
Formulario Breve de Ansiedad Total (BF-TOT)	.82	.54

^aN = 3 086. ^bN = 100; una semana de intervalo entre cada prueba.

de referencia se muestran en la tabla 5-1. El estimado para la puntuación de Ansiedad Total (TOT) es .92. Para las escalas del CMASR-2, los estimados alfa de confiabilidad fueron .75 para Ansiedad Fisiológica (FIS), .86 para Inquietud (INQ), .80 para Ansiedad Social (SOC) y .79 para Defensividad (DEF). Como se demuestra en la tabla 5-2, se obtuvieron coeficientes alfa de confiabilidad similares para grupos divergentes en cuanto a género, edad y antecedentes étnicos. No hubo tendencias por edad evidentes. Estos valores son particularmente atractivos dadas la relativa brevedad de la escala y la naturaleza un tanto amorfa de la ansiedad (Reynolds et al., 2006). Estimados alfa de confiabilidad comparables se observaron en la muestra clínica del CMASR-2 que se describe más adelante, en la sección de validación de este capítulo. En la muestra clínica, se observó un valor alfa de confiabilidad de .92 para la calificación TOT, y valores de .70, .89, .82 y .81 para las calificaciones FIS, INQ, SOC y DEF, respectivamente.

Los estimados de retest de confiabilidad mostrados en la tabla 5-1 se obtuvieron de una muestra de 100 niños que completaron el CMASR-2 una vez, y luego una semana más tarde. Los valores se encuentran en un rango consistente con los estimados de consistencia interna y apoyan la estabilidad general de las puntuaciones del CMASR-2. Como se esperaba, el valor más alto (.76) se obtuvo en la puntuación TOT. Los valores de las puntuaciones escalares del CMASR-2 fueron .73 para la puntuación FIS, .71 para la INQ y .64 para la SOC. La confiabilidad de retest para la puntuación escalar DEF fue .67. El estimado de confiabilidad

Tabla 5-2. Estimaciones de consistencia interna (alfa de Cronbach) para respuestas del CMASR-2 dadas por subgrupos en la muestra completa de referencia

Escala	Varones (n = 1 502)	Edad						Negro/ afroame- ricano (n = 874)	Hispano/ latino (n = 495)
		Mujeres (n = 1 584)	6 (n = 116)	7 (n = 225)	8 (n = 240)	9-14 (n = 1 584)	15-19 (n = 921)		
Ansiedad Total (TOT)	.91	.92	.92	.90	.92	.91	.91	.91	.90
Ansiedad Fisiológica (FIS)	.73	.76	.76	.73	.77	.74	.72	.73	.70
Inquietud (INQ)	.85	.86	.84	.81	.87	.86	.85	.85	.84
Ansiedad Social (SOC)	.78	.81	.79	.75	.83	.80	.78	.78	.75
Defensividad (DEF)	.78	.80	.60	.70	.80	.78	.67	.69	.80
Formulario Breve de Ansiedad Total (BF-TOT)	.81	.82	.81	.83	.83	.81	.79	.81	.80

de retest más bajo en la tabla 5-1, .54, es el de la puntuación de Ansiedad Total en el Formulario Breve (BF-TOT). Esto se esperaba, debido a la brevedad y a la naturaleza relativamente heterogénea de los reactivos del Formulario Breve. El resultado subraya que la puntuación TOT debe ser usada siempre que sea posible, puesto que es la medida más estable.

Confiabilidad de las puntuaciones del CMASR en muestras especiales

Se dispone de evidencia adicional con respecto a la confiabilidad de las puntuaciones del CMASR en muestras especiales de niños. A pesar de que no se cuenta todavía con datos de muestras paralelas para el CMASR-2, la equivalencia de las puntuaciones del CMASR-2 con las del CMASR indica que es probable que los investigadores que examinen tales datos obtengan resultados similares. Para el CMASR, una muestra de niños preescolares proporcionó estimados de confiabilidad totalmente comparables con los valores de la muestra total para los grados del 1 al 12. Para los 97 niños de kínder reportados por Reynolds, Bradley y Steele (1980), el alfa de la puntuación TOT fue .82. Para los 53 varones, el alfa fue .79; para las 44 mujeres, .85. Para una muestra de 106 niños con diagnóstico de discapacidad de aprendizaje, se obtuvo un estimado de confiabilidad de coeficiente alfa de .79 (.77 para los varones y .83 para las mujeres) para la calificación TOT (Paget y Reynolds, 1984). Pela y Reynolds (1982) aplicaron el CMASR a dos muestras de niños nigerianos angloparlantes. Para la primera muestra de 291 niños que cursaban la primaria de la University of Benin Staff School [Escuela para el Personal de la Universidad de Benin], se obtuvo un estimado alfa de confiabilidad de .81 para la puntuación TOT para los 158 niños varones y .84 para las 133 niñas. Valores idénticos se obtuvieron para una segunda muestra de niños de primaria en la Ogbe Primary School, en la ciudad de Benin: .81 para los 52 niños varones y .84 para las 84 niñas.

Reynolds y Scholwinski (1985) reportaron datos de confiabilidad en el CMASR para 531 niños que cursaban los grados del 2 al 12, todos con IQ de Wechsler o Binet de 130 o más. Los resultados con esta muestra amplia reflejan los reportados para el CMASR-2 y para las puntuaciones del CMASR de niños en otras muestras. Los estimados (alfa) de confiabilidad en el rango de .80 fueron la regla general para estos niños tanto en la edad como en el género. El alfa fue .82 para varones, .83 para mujeres y .82 para el grupo completo. Estos estimados son particularmente buenos a la luz de la restricción de rango advertida para esta muestra (Reynolds y Scholwinski).

E. N. Argulewicz (comunicación personal, 1984) reportó coeficientes de confiabilidad (K-R 20) para la puntuación TOT del CMASR para muestras de niños blancos, afroamericanos e hispanos del primero al tercer grado escolar. La K-R 20 fue .84 para 474 niños blancos, .80 para 133 hispanos y .79 para 73 afroamericanos. No hubo diferencias significativas en estos grupos en cuanto a la confiabilidad del CMASR. Otros agrupamientos de participantes por género y grado obtuvieron como resultado estimados de confiabilidad de la puntuación TOT en el CMASR constantes de alrededor de .80. Argulewicz comparó también el CMASR con la *Child Anxiety Scale* (Gillis, 1980). En siete de las ocho comparaciones, los estimados de confiabilidad fueron mayores para el CMASR, una separación que indicaba una confiabilidad superior para el CMASR ($p < .01$) por aproximación normal a la distribución binomial.

De este modo, se observó que la confiabilidad del CMASR era consistente a través de los antecedentes étnicos, el género y el grado escolar (de 1° a 3°) en el estudio de Argulewicz, además de ser superior a la confiabilidad de la *Child Anxiety Scale*. Las confiabilidades que reportó Argulewicz son consistentes con otros estudios de la confiabilidad del CMASR reportados previamente, con lo que constituyen una aportación relevante a la evidencia que apoya la confiabilidad del CMASR y, por extensión, del CMASR-2.

Los estimados de confiabilidad de test-retest en el manual del CMASR estaban disponibles solamente para la puntuación TOT y la subescala Mentira. Reynolds (1981) reportó un coeficiente de confiabilidad de test-retest de .68 para la puntuación TOT de 534 niños de primaria a los que se les aplicó nuevamente la prueba después de un intervalo de nueve meses. Para este mismo grupo, la puntuación de la subescala Mentira tuvo una correlación de .58 luego de nueve meses. Los resultados para la puntuación TOT proporcionan evidencia razonable de estabilidad de la ansiedad característica general a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. Los resultados para la subescala Mentira son menos impresionantes, pero de todos modos resultan alentadores. Estos resultados se tomaron para apoyar la estabilidad temporal del CMASR y su uso en la evaluación de ansiedad crónica en niños, una conclusión con la que Finch y Rogers (1984) concuerdan esencialmente en su revisión de instrumentos de autoinforme para la medición de ansiedad en niños. Esto es especialmente válido si se le considera en comparación con estudios de test-retest de corto plazo. Pela y Reynolds (1982) aplicaron la prueba a 99 niños nigerianos dos veces, con un intervalo de tres semanas. La puntuación TOT tuvo correlatos de .97 para los 52 muchachos, .98 para las 47 muchachas y .98 para el grupo combinado. Estos resultados son sumamente notables y proporcionan un apoyo sólido para la estabilidad a corto plazo de la puntuación TOT. Los resultados fueron casi igualmente buenos para la subescala Mentira, que produjo coeficientes de confiabilidad de test-retest de .90 para los muchachos, .98 para las muchachas y .94 para el grupo combinado.

Subescalas de ansiedad

Para las subescalas de ansiedad del CMASR, los reportes acerca de la confiabilidad son menos extensos, pero aún así proporcionan información considerable. Los estimados alfa de confiabilidad reportados para los 4 972 niños en la muestra de estandarización del CMASR fueron consistentes en torno a .60 y a .70. A pesar de que en esa muestra las confiabilidades para adolescentes mayores de 15 años aparecieron más bajas (en torno a .50) que las de los estudiantes más jóvenes, ningún efecto de ese tipo fue evidente para las puntuaciones del CMASR-2. Las puntuaciones de la subescala Inquietud/hipersensibilidad se asociaron con los más altos estimados de confiabilidad de subescala para el CMASR, como sucede también con el CMASR-2. Considerando la brevedad de las subescalas del CMASR, los estimados de confiabilidad se consideraron adecuados para la tarea. Para el CMASR-2, como ya se ha observado y es evidente a partir de los resultados reportados en las tablas 5-1 y 5-2, las escalas más largas se asocian con una confiabilidad mejorada.

Al igual que era válido para el CMASR, las escalas del CMASR-2 demuestran intercorrelaciones de moderadas a altas (tabla 5-3). Consecuentemente, a menudo se da el caso de

Tabla 5-3. Correlaciones entre escalas para la muestra completa de referencia del CMASR-2

Escala	TOT	FIS	INQ	SOC
Ansiedad Total (TOT)	—			
Ansiedad Fisiológica (FIS)	.83	—		
Inquietud (INQ)	.93	.64	—	
Ansiedad Social (SOC)	.88	.59	.73	—
Defensividad (DEF)	.02	-.06	.08	.01

Nota. $N = 3\,086$.

que cuando se obtiene un aumento en la puntuación, también se verán otros aumentos. La relación entre las puntuaciones INQ y SOC es particularmente fuerte. Sin embargo, las correlaciones entre las escalas se encuentran por debajo de la correlación entre cada puntuación escalar y la puntuación TOT, de modo que se apoya la interpretación por separado de la puntuación escalar. No obstante, al hacer comparaciones a través de las puntuaciones escalares, el EEM debe ser tomado en cuenta para cada puntuación, como se describe en la sección siguiente.

Error estándar de medición (EEM)

El EEM de una prueba es una estadística práctica basada en estimados de confiabilidad y desviación estándar que puede usarse al interpretar la puntuación de una prueba de un individuo. Con conocimiento del EEM, los intervalos de confianza, o "bandas de error", pueden construirse alrededor de las puntuaciones de los individuos. El EEM se calcula mejor con base en estimados de consistencia interna, excepto en los casos donde tales coeficientes son inadecuados para la prueba en cuestión. La tabla 5-4 reporta el EEM para puntuaciones del CMASR-2 basado en la muestra completa de referencia. Estos valores están expresados en unidades de puntuación- T . De este modo, si se obtiene una puntuación TOT de 58 T , es probable que la puntuación verdadera para el encuestado se ubique entre 58 T más o menos 3 T , o entre 55 T y 61 T . Si se observa una puntuación FIS de 43 T , la puntuación verdadera para el encuestado es probable que se encuentre entre 38 T y 48 T . Nótese que 1 EEM corresponde al intervalo de confianza de 68%, 1.96 EEM al intervalo de confianza de 95%, y 2.58 EEM al intervalo de confianza de 99%. Para el CMASR, los valores del EEM se presentaron por subgrupos determinados por edad, género y antecedentes étnicos. La uniformidad de los estimados de confiabilidad para el CMASR-2 indica que una estratificación tan detallada del EEM para estas puntuaciones sería redundante.

Tabla 5-4. Estimados del error estándar de medición (EEM) para puntuaciones del CMASR-2

Escala	EEM expresado como unidades de puntuación- T
Ansiedad Total (TOT)	± 3
Ansiedad Fisiológica (FIS)	± 5
Inquietud (INQ)	± 4
Ansiedad Social (SOC)	± 4
Defensividad (DEF)	± 5

Debe subrayarse que las comparaciones de las escalas del CMASR-2 en un protocolo individual deben hacerse con cuidado y únicamente como ayuda para generar hipótesis con respecto a manifestaciones más específicas de ansiedad para un niño. La evaluación de seguimiento cuidadosa de tales hipótesis es correcta, a pesar de la evidencia que apoya la validez de la interpretación escalar individual. El CMASR-2 es una medida breve, y la ansiedad y su impacto funcional son complejos. Además, el análisis de perfil de puntuaciones en el CMASR-2 se ha investigado poco.

Defensividad

Los estimados de confiabilidad para la escala DEF son sorprendentemente buenos, comparables con lo que se ve en una subprueba de una escala cognitiva bien elaborada. Para el CMASR fue evidente una tendencia firme por edad. Para el CMASR-2, esa tendencia no es tan clara. Esta diferencia se debe probablemente a la presencia de oraciones con doble negación en el cuestionario previo, lo cual se observó que confunde a los niños de menor edad, y a su eliminación del cuestionario actual.

Validez

La validez es la meta principal de la psicometría. Si nuestras interpretaciones de las puntuaciones de las pruebas carecen de alguna validez establecida, todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano. El término *validación de pruebas* es de uso común; sin embargo, es un término equivocado si se le interpreta con rigidez. Nosotros no validamos pruebas; únicamente podemos perseguir la validación de los significados que adscribimos a las puntuaciones derivadas de la prueba. La validez no es un concepto estático, sino que representa un proceso en curso de acumulación y evaluación de investigación, teoría, y desarrollo y refinamiento de conceptos, y de la continua síntesis de esta información en una asociación compuesta por los autores de las pruebas, los editores y los usuarios de las pruebas. El *Standards for Educational and Psychological Testing* (American Educational Research Association [AERA], American Psychological Association [APA] y National Council of Measurement in Education [NCME], 1999) hace énfasis en esta conceptualización de validez, como se presenta en el Manual del CMASR. El *Standards* describe la validez como "el grado al cual la evidencia y la teoría apoyan la interpretación de las puntuaciones de pruebas vinculadas con los usuarios propuestos" (p. 9) de la prueba particular en cuestión. Puede decirse entonces que la validez se refiere a la precisión y a qué tan apropiada resulta la interpretación de la puntuación

de una prueba (Reynolds, 1998). La evidencia asociada con la interpretación propuesta de las puntuaciones de pruebas presentada en un manual de pruebas, como éste, lo único que puede proporcionar es una instantánea de la evidencia en un determinado punto en el tiempo en unos cuantos escenarios específicos. Los usuarios del CMASR-2 también deben dar seguimiento a la literatura especializada acerca de los constructos evaluados por las escalas del CMASR-2, así como a futuras investigaciones específicas sobre el CMASR-2 y el modo en que debe ser empleada e interpretada.

El *Standards* propone un esquema para la organización conceptual de la evidencia de validez, pero reconoce también que otros esquemas organizativos alternos pueden ser iguales o más adecuados. Los tipos de evidencia de validez que se consideran de mayor importancia para una prueba en particular habrán de variar también de acuerdo con los constructos que se estén evaluando, los usos e interpretaciones propuestos de las puntuaciones de las pruebas, las consecuencias de los errores de interpretación y la población para la cual se pretende aplicar la prueba. Dados el propósito del CMASR-2 y las variables adicionales comentadas previamente, la evidencia con base teórica (como se describe en AERA, APA y NCME, 1999) y la evidencia basada en el contenido de la prueba son los aspectos más importantes de la validación de la interpretación de puntuaciones escalares del CMASR. Información adicional basada en las relaciones internas de los reactivos y las escalas del CMASR entre sí, y las relaciones de las puntuaciones escalares del CMASR-2 con respecto a variables externas a la propia prueba se presentan en este capítulo y en la revisión de literatura especializada y en la bibliografía proporcionada en el capítulo 6.

Se advertirá que buena parte de la evidencia que se presenta en esta sección se relaciona con puntuaciones del CMASR y se extrajo del anterior Manual del CMASR. Además, la totalidad de la investigación subsecuente que se presenta en el capítulo 6 se refiere a puntuaciones del CMASR. Toda la información que se discute se considera fundamentalmente relevante para la validez de las puntuaciones del CMASR-2, debido al traslape sustancial entre ambas formas —89% de los reactivos del CMASR fueron conservados en el CMASR-2, la estructura de las escalas es esencialmente la misma y la equivalencia estadística en términos de altas correlaciones de puntuaciones entre ambas formas se establece adicionalmente en el capítulo 4.

Evidencia con base teórica

La base teórica para la elección de las escalas que constituyen el CMASR y CMASR-2 ha sido identificada en capítulos previos. La evidencia empírica asociada con cada dominio de escala también ha sido citada ahí. Es conveniente repetir aquí que décadas (en algunos casos más de un siglo) de investigación y desarrollo teórico han sido consagradas a los constructos evaluados por el CMAS, el CMASR y, por extensión, el CMASR-2. Cada una de las escalas representa un constructo que ha permanecido largo tiempo en la psicología, que está muy lejos de ser un capricho y que no es producto de ninguna forma de moda clínica. Como se ha descrito, el CMASR se derivó a partir de una teoría de ansiedad rasgo seguida por Taylor (1951) y posteriormente por otros en varios grados (p. ej., Spielberg, 1972). La ansiedad rasgo difiere de la ansiedad estado en que es una predisposición más duradera para experimentar la ansiedad en una variedad de ambientes. Entonces

las puntuaciones deben ser relativamente estables a lo largo del tiempo, y la evidencia antes citada apoya este argumento, en particular para la puntuación TOT.

Evidencia basada en contenido

Como también ha sido comentado en capítulos previos, la redacción de los reactivos del CMASR fue dirigida por el amplio conjunto de literatura especializada relacionada con los constructos teóricos por evaluar. Numerosos reactivos fueron escritos y luego revisados por expertos a nivel doctoral en educación y psicología clínica, desarrollo infantil y de adolescentes, y psicología escolar. Se llevaron a cabo revisiones iterativas para lograr consistencia y coherencia entre los constructos. Con base en esas revisiones realizadas por expertos, se aceptaron reactivos para un estudio piloto empírico, o bien, se rechazaron o fueron revisados para mejorar su coherencia con los constructos escalares del CMASR.

Los usuarios encontrarán que las interpretaciones propuestas son consistentes con el contenido de los reactivos de las escalas. No solamente los nombres de las escalas tienen sentido desde un punto de vista lógico basado en el contenido de los reactivos, sino que también reflejan claramente lo que los clínicos y los investigadores han descubierto a partir de muy diferentes vías de obtención de información acerca de la angustia y sus manifestaciones en niños (ver capítulo 6). A los usuarios del CMASR, en su calidad de expertos en varios aspectos del proceso de diagnóstico, se les alienta para que efectúen su propia revisión de expertos del contenido de los reactivos y de la coherencia entre reactivo y constructo.

Durante la revisión del CMAS —a partir de la cual se derivó el CMASR—, maestros, psicólogos clínicos infantiles y psicólogos educativos (todos capacitados de manera profesional que interactúan ampliamente con niños) fueron encuestados acerca de si los reactivos existentes parecían relacionarse con manifestaciones de ansiedad en niños y si debía incluirse cualquier otra indicación. Para la inclusión de reactivos en el CMASR final, sólo se eligieron aquellos designados por este grupo como relacionados con la ansiedad. La selección del conjunto final de reactivos se describió antes. El uso clínico subsecuente de la escala por los autores con más de 200 casos indujo un cambio en algunos reactivos. Los reactivos finales para el CMASR se seleccionaron entonces sobre una base empírica. Para el CMASR-2, como se ha descrito en detalle en capítulos anteriores, los reactivos fueron revisados, y los reactivos adicionales fueron redactados por clínicos con muchos años de experiencia en el uso del CMASR y de otras escalas para la evaluación de ansiedad, y en exámenes psicométricos para probarlos. Los reactivos resultantes fueron consistentes con teorías contemporáneas sobre ansiedad rasgo. Se conservó la totalidad de los reactivos originales del CMASR para ser sometida a una prueba empírica junto con los nuevos conjuntos de reactivos. Los reactivos finales fueron elegidos de este grupo ya selecto y derivado racionalmente de reactivos para prueba basados en resultados empíricos.

Examen empírico del desempeño de los reactivos

En el capítulo 4 se describen procedimientos adicionales de selección de reactivos que son relevantes para la validez de la interpretación de las escalas CMASR y CMASR-2. El uso de correlaciones corregidas de reactivo con respecto al total para seleccionar reactivos garantiza cierto grado de coherencia

entre reactivo y constructo. El grado en el que este enfoque es exitoso para desarrollar escalas con contenido de reactivos homogéneos se evalúa por medio de medidas de consistencia interna. Los estimados de consistencia interna para cada una de las escalas del CMASR-2 reportados anteriormente en este capítulo son suficientemente amplios como para apoyar los reactivos de las escalas del CMASR al evaluar cada una de ellas un constructo razonablemente homogéneo, con los reactivos que proporcionan un muestreo adecuado del dominio del reactivo.

Evidencia de las escalas de relaciones internas

Las correlaciones entre las escalas para el CMASR fueron de moderadas a altas, con rangos de .49 a .68 (mediana = .57) para las escalas de ansiedad y de .82 a .90 (mediana = .85) para correlaciones entre las escalas y la puntuación TOT. Como puede apreciarse en la tabla 5-3, las correlaciones interescalas son similares en patrón y ligeramente superiores para el CMASR-2. El rango de los valores es de .59 a .73 (mediana = .64) para las escalas de ansiedad y de .83 a .93 (mediana = .88) para correlaciones entre las escalas y la puntuación TOT. Para cada una de las escalas de ansiedad, el valor está lo suficientemente por debajo del estimado de consistencia interna y de la correlación con la puntuación TOT, como para justificar evaluación e interpretación de manera independiente. Nótese que los resultados divergentes esperados se observan en el hecho de que todas las puntuaciones de ansiedad exhiben correlaciones de pequeñas a desdénables con la escala Mentira (CMASR) o con la escala DEF (CMASR-2). Los valores absolutos de esas correlaciones tuvieron un rango de .06 a .27 (mediana = .20) para el CMASR y de .01 a .08 (mediana = .05) para el CMASR-2. No obstante, vale la pena repetir que la naturaleza compleja de la ansiedad y la brevedad del CMASR-2 dictan que la interpretación de escalas para un protocolo individual debe llevarse a cabo únicamente como una ayuda para la generación de hipótesis que debe ser verificada durante la evaluación de seguimiento y en contraste con toda la demás información disponible en un caso determinado.

Estudios de análisis factorial

El análisis factorial se ha convertido en una técnica común y valiosa en la evaluación de la validez de constructo de las interpretaciones de resultados de pruebas (cf. Cronbach, 1984). Se dispone de una cantidad considerable de evidencia que sugiere que la ansiedad es de naturaleza multidimensional (Cattell y Scheier, 1961; Fenz y Epstein, 1965; Finch, Kendall y Montgomery, 1974; Logan y Loo, 1979; Loo, 1979; Naylor, 1978; Spielberger, 1972). Si las manifestaciones de ansiedad en niños asumen formas diferentes, identificables, el CMASR debe ser multidimensional, en especial debido a que los reactivos se seleccionaron en parte para representar de manera amplia el concepto de ansiedad rasgo.

El análisis factorial de la versión 1956 del CMAS realizado por Finch, Kendall, et al. (1974), que usa un método de rotación oblicua, produjo tres factores de ansiedad: Inquietud/Hipersensibilidad, Fisiológico y Concentración. De acuerdo con Koppitz (1977), estos tres factores diferencian entre niños que exhiben características conductuales distintas, conclusión apoyada por los resultados de Finch, Anderson y Kendall (1976).

Una variedad de estudios de análisis factorial del CMASR se completaron posteriormente. Reynolds y Richmond (1979) examinaron la estructura del CMASR para la muestra de de-

sarrollo de la prueba con 329 niños. Se hizo un análisis factorial de las respuestas de estos 329 niños a los 28 reactivos de ansiedad del CMASR mediante el método de factorización principal con repeticiones, utilizando R^2 como estimados iniciales de comunalidad. Se realizaron rotaciones oblicuas (oblimin) y ortogonales (varimax) para dos, tres, cuatro, cinco y seis factores. También se obtuvo una solución de componentes principales como una comparación de los resultados de Bledsoe (1975) con el CMAS original. La solución varimax de tres factores se retuvo como la solución factorial psicológica y estadísticamente más sólida. El factor I contenía los 10 reactivos de Ansiedad Fisiológica, los cuales produjeron una media de 4.57 ($SD = 2.14$) y un estimado de confiabilidad K-R 20 de .65 con esta muestra. El factor II contenía 10 de los 11 reactivos de Inquietud/Hipersensibilidad (todos menos el reactivo "Muchas cosas me dan miedo") y produjo una media de 5.39 ($SD = 2.34$) y un estimado de confiabilidad K-R 20 de .64. El factor III contenía los siete reactivos de Preocupaciones sociales/Concentración, además del onceavo reactivo de Inquietud/Hipersensibilidad y de una sustancial carga parcial para el reactivo "Me sudan las manos" de la escala de Ansiedad Fisiológica. Este último factor produjo una media de 3.88 ($SD = 2.14$) y un estimado de confiabilidad K-R 20 de .60. La solución varimax de tres factores estuvo relativamente "limpia", con excepción de un solo reactivo con una carga mayor de .30 en más de un factor, y un reactivo que cargaba una escala que no parecía encajar plenamente desde un punto de vista racional. Los autores, por lo tanto, retuvieron esencialmente los mismos nombres de los factores como lo hicieron Finch, Kendall et al. (1974) debido al alto grado de similitud de los resultados de los dos estudios. Los análisis subsecuentes con muestras mayores y la aplicación clínica del CMASR después provocaron que al factor III, inicialmente denominado Miedo/Concentración y luego sólo Ansiedad de concentración, se le cambiara el nombre por Preocupaciones sociales/Concentración, ya que la mayor parte de los miedos se centran alrededor de otros individuos y sólo de manera secundaria se refieren a una interferencia consecuente con la capacidad del niño para concentrarse.

La consistencia de los resultados a través de los estudios de la estructura factorial del CMASR fue demostrada ampliamente. De 15 reactivos de ansiedad con carga en los tres factores identificados por Finch, Kendall et al. (1974), se retuvieron 11 en el CMASR. De los 11 reactivos, 10 tuvieron una carga mayor en los mismos factores. Cuando se obtuvo una solución de componentes principales para la muestra de desarrollo utilizando los mismos criterios que Bledsoe (1975), surgió un solo factor de ansiedad que era muy consistente con los resultados de Bledsoe. Los resultados de este estudio proporcionan un fuerte apoyo para la validez de constructo del CMASR y para los argumentos de que la ansiedad es multidimensional por naturaleza. No obstante, era obvia la necesidad de un análisis factorial con una muestra mucho mayor. Reynolds y Paget (1981) efectuaron un análisis factorial del CMASR que incluía todos los reactivos de Mentira al igual que los de ansiedad para los niños en la muestra de estandarización del CMASR. Debido a que éste es el análisis principal de la estructura del CMASR, el estudio de Reynolds y Paget se describirá con mucho detalle.

A las respuestas de los 4 972 niños en la muestra de estandarización del CMASR a los 28 reactivos de ansiedad y 9 de Mentira se les realizó un análisis factorial inicialmente me-

diante el método de factores principales con R^2 en la diagonal de la matriz de correlación de reactivos como estimados de comunalidad inicial (h^2). Se llevó a cabo una repetición hasta que no hubo más aumento significativo en h^2 . Entonces, los factores extraídos mediante este método se rotaron de manera ortogonal a través del procedimiento varimax, el cual maximiza las cargas factoriales por columnas en lugar de filas; de este modo se maximiza la varianza explicada por cada factor y se aumenta la distinción entre factores. La rotación varimax es de máxima utilidad cuando se pretende descubrir factores que tienen la mayor utilidad clínica o de aplicación. Para la investigación puramente teórica, quizá sean preferibles muchas otras rotaciones.

En primer término, se observó un importante factor de ansiedad general (Ag) cuando se examinó el primer factor principal. Las cargas para ese factor se presentan en la tabla 5-5 para la muestra de estandarización del CMASR. También se ofrecen los valores para la muestra completa de referencia del CMASR-2. La similitud de patrones y valores en los formularios y las muestras aporta un apoyo adicional a la equivalencia psicométrica del CMASR y el CMASR-2. Todos los reactivos de ansiedad de ambos formularios mostraron cargas sustanciales de este factor, mientras que no lo hizo ninguno de los reactivos de Mentira o de DEF con cargas más allá de .21 en Ag para cada una de las muestras. El factor es representativo para aproximadamente la mitad de la varianza común de ambas muestras. La aparición de un factor tan fuerte en ambas proporciona un saludable apoyo a la interpretación de la puntuación TOT como una medida de Ag (en gran parte debido a que un factor así apoyaría la presencia de "g" en una escala cognitiva). Ante una inspección visual, este factor ciertamente parece ser constante en los grupos y formularios. Para el CMASR se obtuvieron resultados paralelos al examinar resultados de análisis factorial para subagrupaciones de la muestra de estandarización basadas en antecedentes étnicos y en género. El cálculo de los dos índices de similitud factorial para estos grupos proporcionó la confirmación de la consistencia. Los valores de r_c para las comparaciones varón/mujer y negro/blanco fueron .99 y .98, respectivamente. El valor de s fue 1.00 para cada comparación.

Para determinar el número de factores que se obtendrán, Reynolds y Paget emplearon una combinación de métodos. Se exploraron el "diagrama de ladera" y valores específicos, y se extrajeron no menos factores que lo indicado por el "diagrama de ladera" y no más que los indicados por el uso del criterio del valor específico de 1.0. Dentro de estos límites inferiores y superiores, se exploraron con cuidado todas las soluciones posibles, con los resultados de la investigación anterior en mente, en un intento para establecer la solución con el mayor significado psicológico. Una vez que se determinó el número de factores adecuados para la muestra del CMASR, se aplicó esta solución a submuestras de sólo varones, sólo mujeres, sólo negros y sólo blancos para determinar si la solución era apropiada para cada uno de estos grupos. El primer factor sin rotar para cada grupo se tomó como un estimado crudo de la fuerza de cualquier factor general que pudiera estar presente en la escala.

Para determinar el grado de semejanza de los diversos factores a través del género y el grupo étnico, se calcularon dos índices de similitud factorial entre pares de factores igualados de manera visual: el coeficiente de congruencia (r_c ; Harman, 1976; Mulaik, 1971) y el índice de similitud de variable do-

minante (s^* [*N. de la E. Se emplea la sigla s por la inicial de la denominación en inglés *salient* para "dominante".]; Cattell, 1978; Cattell y Baggaley, 1960). Cattell aboga por el empleo de cargas factoriales de ± 1.0 para indicar las variables dominantes. Cuando se adopta una posición conservadora, se emplea un valor de ± 0.20 . En este estudio se adoptó una postura aún más conservadora para garantizar que los resultados no se iban a sobreinterpretar, y se eligió un valor de ± 0.25 para indicar el carácter dominante de cada variable. Existen numerosos métodos para determinar la significación de la diferencia entre soluciones de dos factores (Reynolds, 1982a, 1982b); sin embargo, no hay mucho acuerdo sobre si éste es el procedimiento más apropiado. El poder de las diversas pruebas de significación con muestras del tamaño aquí disponible es muy sustancial, y se puede mostrar con facilidad que diferencias menores, casi sin importancia, son estadísticamente significativas. En un sentido de mayor aplicación, el interés real se encuentra en el grado de similitud de factores entre grupos, ya que es el grado de semejanza el que determina la posibilidad de generalización de la interpretación de factores entre grupos.

El coeficiente de congruencia es un índice de similitud factorial con rasgos interpretativos parecidos a la r de Pearson; es decir, denota la varianza compartida entre factores, pero evita un número de peligros latentes en el uso de r simple entre factores (Cattell, 1978; Reynolds, 1978). Sin embargo, r_c puede afectarse por la violación de la hipótesis de matrices varianza-covarianza equivalentes, y también es posible la contaminación si el tamaño del factor es una característica de identificación de los factores que se están comparando. Por estas y otras razones, r_c se suplementa mediante la s no paramétrica. Ambos índices oscilan en valor de -1.00 a +1.00 (acuerdo perfecto), con 0 que representa que no hay similitud. Aunque se encuentran disponibles pruebas estadísticas para determinar si r_c y s difieren de manera significativa de 0, la cuestión más pertinente aquí es la magnitud pura de la relación entre factores. Para r_c , por lo general se ha requerido un valor de .90 o más, aunque de manera arbitraria, para indicar la similitud factorial o invarianza. Aunque Mulaik (1971) discute en contra de comparaciones de factores ortogonales, su argumento es sumamente cauto y no se sostiene cuando trata con muestras experimentalmente independientes. En cualquier caso, las críticas de Mulaik deben dar como resultado una atenuación del valor de r_c , convirtiéndolo de esta manera en un estimado conservador del verdadero grado de similitud de dos factores. No hay consenso en relación con el valor de s para invarianza, debido a que éste no es una medida de varianza compartida, y por tanto uno debe apoyarse en una prueba de significación, con un valor de 1.00 tomado aún para indicar el acuerdo perfecto.

Una exploración del "diagrama de ladera" y valores específicos derivados en el análisis inicial para la muestra total indica que es posible que entre tres y ocho factores podrían proporcionar la solución más adecuada para el CMASR. Utilizando las técnicas de análisis factorial ya descritas, se examinó cada una de estas soluciones (p. ej., tres, cuatro, ... ocho). Desde el punto de vista de la investigación anterior y las teorías de ansiedad manifiesta (Finch, Kendall et al., 1974; Reynolds y Richmond, 1979), las soluciones más atractivas fueron las de cinco y seis factores. La exploración del contenido de los reactivos de las diversas agrupaciones factoriales mostró que la solución de cinco factores era la más clara y la más fácil de interpretar. Cada una de las soluciones de seis, siete y ocho

Tabla 5-5. Cargas de factores en el primer factor principal (ansiedad general)

Reactivo del CMASR-2	Muestra de estandarización ^a del CMASR	Muestra completa de referencia ^b CMASR-2 (todos los reactivos CMASR-2)
1. Muchas veces siento asco o náuseas.	.50	.42
2. Soy muy nervioso(a).	.52	.54
3. Muchas veces me preocupa que algo malo me pase.	.58	.53
7. Algunas veces me despierto asustado(a).	.42	.44
9. Siento que alguien va a decirme que hago mal las cosas.	.45	.49
11. Me cuesta trabajo tomar decisiones.	.39	.36
12. Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no me salen como quiero.	.37	.34
13. Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí.	.34	.36
14. Todas las personas que conozco me caen bien.	.19	.14
15. Muchas veces siento que me falta el aire.	.37	.37
16. Casi todo el tiempo estoy preocupado(a).	.47	.46
18. Muchas cosas me dan miedo.	.44	.40
19. Siempre soy amable.	.15	.09
20. Me enojo con facilidad.	.29	.24
21. Me preocupa lo que mis papás me vayan a decir.	.44	.41
22. Siento que a los demás no les gusta cómo hago las cosas.	.40	.45
24. Siempre me porto bien.	.14	.05
25. En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a).	.39	.36
26. Me preocupa lo que la gente piense de mí.	.38	.46
27. Me siento solo(a) aunque esté acompañado(a).	.39	.43
29. Siempre soy bueno(a).	.16	.12
30. Es muy fácil herir mis sentimientos.	.53	.48
31. Me sudan las manos.	.29	.31
33. Siempre soy agradable con todos.	.16	.12
34. Me canso mucho.	.40	.32
35. Me preocupa lo que va a pasar.	.52	.47
36. Los demás son más felices que yo.	.43	.37
38. Siempre digo la verdad.	.16	.16
39. Tengo pesadillas.	.46	.38
40. A veces me enojo.	.21	.04
42. Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir en la noche.	.50	.45
43. Me cuesta trabajo concentrarme en mis tareas escolares.	.36	.30
44. A veces digo cosas que no debería decir.	.17	.10
46. Me muevo mucho en mi asiento.	.34	.30
47. Muchas personas están en mi contra.	.45	.34
48. He dicho alguna mentira.	.16	.03
Reactivo 26 del CMASR: Me siento muy mal cuando se enojan conmigo. (eliminado del CMASR-2)	.49	.48

Nuevos reactivos del CMASR-2

4. Tengo miedo que otros niños se rían de mí durante la clase.	—	.54
5. Tengo demasiados dolores de cabeza.	—	.36
6. Me preocupa no agradarle a los otros.	—	.52
8. La gente me pone nervioso(a).	—	.51
10. Tengo miedo que los demás se rían de mí.	—	.54
17. Me siento mal si la gente se ríe de mí.	—	.45
23. Me da miedo hablar en voz alta ante mis compañeros durante la clase.	—	.38
28. En la escuela se burlan de mí.	—	.35
32. Me preocupa cometer errores delante de la gente.	—	.45
37. Temo hablar en voz alta delante de un grupo.	—	.39
41. Me preocupa que durante la clase me hagan participar.	—	.33
45. Me preocupa que alguien me dé una golpiza.	—	.43
49. Me preocupa decir alguna tontería.	—	.47
Valor específico	5.46	7.22
Porcentaje de varianza	52	48

Nota. Los números de los reactivos corresponden a los del formulario de aplicación del CMASR-2.

^aN = 4 972, ^bN = 3 086.

factores contenía uno o más factores solos o en pareja, haciendo difícil una comparación clara, e incluso más difícil una interpretación. La solución de tres factores reveló dos factores de mentira y un gran factor de ansiedad. La solución de cuatro factores dividió el factor de ansiedad en agrupaciones que no tenían una distinción psicológica clara. La solución de cinco factores retuvo los dos factores de mentira (al igual que la mayor parte de las soluciones) y proporcionó tres factores de ansiedad que se parecían a los de los investigadores anteriores (Finch, Kendall, et al.; Reynolds y Richmond).

La tabla 5-6 se presenta la solución de cinco factores para el CMASR y en la tabla 5-7, para el CMASR-2. En gran medida, los resultados son similares. La subescala de Mentira se divide claramente en dos factores. En la muestra del CMASR, el segundo estaba compuesto por tres reactivos de Mentira que presentaban conceptos que potencialmente podrían prestarse a confusión, a los cuales se puede atribuir el patrón de respuesta distinto para los reactivos. Cada uno de estos reactivos presenta al niño una doble negación potencial (p. ej. para el reactivo "Nunca digo mentiras", el niño tiene que responder ya sea *Sí* o *No*). El primer factor estuvo compuesto de todos los restantes reactivos de Mentira del CMASR. Curiosamente, como puede verse en tabla 5-8, la misma escisión entre agrupamientos de reactivos DEF se observó en la muestra más nueva, a pesar de que las redacciones con doble negación se eliminaron en el CMASR-2. Los resultados para el CMASR-2 son similares a los del CMASR también en otros aspectos. Los factores que representan las escalas FIS e INQ fueron replicados razonablemente bien. Para la escala SOC, sin embargo, hay algunas diferencias interesantes. Antes de considerar las implicaciones de las diferencias observadas con respecto a la interpretación del CMASR-2, es importante completar la revisión de la invarianza factorial que fue reportada para el CMASR.

En la muestra del CMASR, los tres factores de ansiedad son esencialmente los mismos que los identificados en el análisis preliminar de Reynolds y Richmond (1979). Las diversas anomalías observadas en estudios previos no aparecieron, y el análisis está muy limpio. Reynolds y Paget (1981) retuvieron los mismos nombres de factor que se emplearon en la investigación anterior (Finch, Kendall et al., 1974; Reynolds y Richmond, 1979) debido a la similitud de los resultados y al hecho de que estos nombres tienden a describir de manera muy precisa el contenido de los reactivos de los tres factores. El factor de Ansiedad Fisiológica de ansiedad manifiesta consta de 10 reactivos, y con excepción de uno ("Me cuesta trabajo tomar decisiones"), el factor está relativamente limpio, sin que alguno de estos reactivos muestre cargas elevadas en cualquier otro factor. Este reactivo con cargas sustanciales en múltiples factores se retuvo en este factor como opuesto al segundo factor por muchas razones. En el estudio de Reynolds y Richmond, el reactivo tenía una carga en este factor de más de dos veces la magnitud de estas cargas sobre cualquier otro factor. En los análisis del estudio del grupo étnico y del género separados, tuvo una carga mayor en este factor en tres de los cuatro grupos. En el análisis de sólo blancos, se revirtió el patrón de cargas sobre este factor. El factor Inquietud/Hipersensibilidad contenía 11 reactivos, y el factor de ansiedad Preocupaciones sociales/Concentración comprendía los siete reactivos de ansiedad restantes. Cada uno de estos factores era muy distinto, como lo reveló el patrón de cargas factoriales observado. Los tres factores de ansiedad y los dos de mentira aparecieron de manera invariable en los subgrupos que se

formaron en la muestra de estandarización del CMASR basada en el género y en los antecedentes étnicos. Los coeficientes de congruencia, r_c , para las comparaciones con base en el género fueron de .99 para la Ansiedad Fisiológica, .99 para Inquietud/Hipersensibilidad, .96 para Preocupaciones sociales/Concentración, .99 para Mentira 1 y .98 para Mentira 2. Los índices correspondientes de s fueron .79, .92, .92, 1.00 y 1.00, respectivamente. Todos los valores de s fueron altamente significativos ($p < .01$). Las comparaciones transétnicas proporcionaron resultados similares. Los coeficientes de congruencia entre grupos étnicos fueron .94 para Ansiedad Fisiológica, .94 para Inquietud/Hipersensibilidad, .91 para Preocupaciones sociales/Concentración, .99 para Mentira 1 y .92 para Mentira 2. Los valores de s correspondientes fueron .81, .75, .73, 1.00 y 1.00, respectivamente. Una vez más, todos los valores de s probaron ser significativos de manera amplia y elevada ($p < .01$), en especial considerando la postura conservadora que se tomó en su cálculo.

La conclusión de invarianza factorial del CMASR no fue un artefacto del método de comparación factorial. Reynolds y Harding (1983) calcularon ocho índices de similitud factorial empleando seis métodos de comparación para la solución de cinco factores del CMASR ya mencionada. Su análisis sólo incluyó la comparación de géneros. Los resultados demostraron claramente el alto grado de semejanza de la solución elegida entre géneros. Los cálculos subsecuentes produjeron esencialmente las mismas conclusiones para la comparación transétnica. El análisis factorial con otros grupos también confirmó la solución de cinco factores del CMASR, al igual que el amplio factor de ansiedad general (Ag). De este modo, hay un apoyo considerable para la presencia de un amplio factor de ansiedad general (Ag) en la medición de ansiedad crónica manifiesta. Asimismo, queda claro que también hay varios factores de ansiedad específicos, y que han aparecido de manera consistente en la investigación sobre el CMASR original dirigida por Finch, Kendall et al. (1974) y sobre la muestra de desarrollo de la prueba para la revisión de 1978 (Reynolds y Richmond, 1979).

Los factores de ansiedad general (Ag) y específica (As) también aparecieron sistemáticamente en otros estudios. De un análisis factorial del CMASR para 106 niños diagnosticados con problemas de aprendizaje en escuelas públicas, Paget y Reynolds (1984) también extrajeron una solución de cinco factores como la que mejor se ajustaba a sus datos desde el punto de vista psicológico y estadístico. Sin embargo, cuando se compararon los resultados con la muestra normativa, se notaron algunas diferencias. Los factores de Ansiedad Fisiológica, Preocupaciones sociales/Concentración, Mentira 1 y ansiedad general fueron esencialmente equivalentes en las dos muestras. No obstante, el factor de Mentira 2 tenía dos reactivos de ansiedad con amplias cargas, y el factor Inquietud/Hipersensibilidad de alguna manera se fragmentó, aunque era identificable y ninguna otra solución se ajustaba a los datos de una manera más significativa. Así, mientras la solución de cinco factores es sensata para esta muestra, no es tan clara o firme para la que se observó en los niños de la muestra normativa del CMASR. La razón de este resultado no es segura, aunque el tamaño pequeño de la muestra ($N = 106$) ciertamente contribuye a este descubrimiento. Cuando Reynolds y Scholwinski (1985) llevaron a cabo un análisis factorial del CMASR con una amplia muestra de niños dotados, se observó un alto grado de similitud entre la solución de factores derivada para esta muestra de

Tabla 5-6. Solución de cinco factores para la muestra de estandarización del CMASR

Reactivo ^a	Factor de ansiedad			Factor de Mentira	
	Ansiedad Fisiológica	Inquietud/ Hipersensibilidad	Preocupaciones sociales/ Concentración	1	2
11. Me cuesta trabajo tomar decisiones.	.26	.26	.16	.06	.09
15. Muchas veces siento que me falta el aire.	.39	.12	.11	.07	.01
20. Me enoja con facilidad.	.23	.14	.19	.12	.07
25. En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a).	.45	.06	.15	.04	.08
1. Muchas veces siento asco o náuseas.	.43	.24	.15	.11	.10
21. Me sudan las manos.	.32	.06	.08	.10	.07
34. Me canso mucho.	.34	.10	.18	.03	.03
39. Tengo pesadillas.	.49	.21	.02	.08	.10
7. Algunas veces me despierto asustado(a).	.37	.26	.03	.03	.05
46. Me muevo mucho en mi asiento.	.31	.15	.14	.04	.02
12. Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no me salen como quiero.	.13	.39	.08	.01	.00
16. Casi todo el tiempo estoy preocupado(a).	.20	.43	.15	.05	.05
18. Muchas cosas me dan miedo.	.28	.33	.12	.03	.06
21. Me preocupa lo que mis papás me vayan a decir.	.17	.44	.12	.04	.03
26. Me preocupa lo que la gente piense de mí.	.02	.47	.22	.03	.04
30. Es muy fácil herir mis sentimientos.	.22	.46	.18	.10	.02
35. Me preocupa lo que va a pasar.	.13	.61	.12	.05	.02
42. Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir en la noche.	.35	.36	.11	.06	.00
2. Soy muy nervioso(a).	.32	.39	.16	.09	.02
3. Muchas veces me preocupa que algo malo me pase.	.29	.49	.17	.02	.08
13. Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí.	.11	.14	.42	.02	.06
22. Siento que a los demás no les gusta cómo hago las cosas.	.07	.27	.47	.09	.02
27. Me siento solo(a) aunque esté acompañado(a).	.22	.21	.30	.01	.07
36. Los demás son más felices que yo.	.22	.14	.50	.00	.01
9. Siento que alguien va a decirme que hago mal las cosas.	.14	.33	.35	.04	.08
43. Me cuesta trabajo concentrarme en mis tareas escolares.	.25	.17	.28	.06	.02
47. Muchas personas están en mi contra.	.24	.18	.43	.04	.04
14. Todas las personas que conozco me caen bien.	.13	.04	.04	.48	.19
19. Siempre soy amable.	.01	.02	.01	.76	.05
24. Siempre me porto bien.	.05	.01	.03	.69	.07
29. Siempre soy bueno(a).	.05	.00	.01	.73	.19
33. Siempre soy agradable con todos.	.00	.04	.03	.78	.06
38. Siempre digo la verdad.	.07	.00	.01	.57	.19
40. A veces me enoja.	.12	.03	.02	.24	.46
44. A veces digo cosas que no debería decir.	.07	.02	.05	.13	.51
48. He dicho alguna mentira.	.05	.03	.02	.13	.58
Reactivo 26 del CMASR: Me siento muy mal cuando se enojan conmigo. (eliminado del CMASR-2)	.22	.45	.10	.07	.08
Valor específico	2.24	2.84	1.59	2.95	0.98
Porcentaje de varianza	34	42	24	75	25

Nota. N = 4 972. Las negritas indican las cargas más altas.

^aLos números de los reactivos corresponden a los del formulario de aplicación del CMASR-2.

Tabla 5-7. Solución de cinco factores para la muestra completa de referencia del CMASR-2
Respuestas a la serie de 37 reactivos del CMASR de 1985

Reactivo ^a	Factor de ansiedad			Factor de Mentira	
	Ansiedad Fisiológica	Inquietud/ Hipersensibilidad	Preocupaciones sociales/ Concentración	1	2
11. Me cuesta trabajo tomar decisiones.					-.34
15. Muchas veces siento que me falta el aire.	.37				
20. Me enoja con facilidad.	.38				
25. En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a).	.51				
1. Muchas veces siento asco o náuseas.	.44				
31. Me sudan las manos.					
34. Me canso mucho.	.55				
39. Tengo pesadillas.	.34	.39			
7. Algunas veces me despierto asustado(a).	.32	.47	-.33		
46. Me muevo mucho en mi asiento.	.43				
12. Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no me salen como quiero.		.37			-.41
16. Casi todo el tiempo estoy preocupado(a).		.53			
18. Muchas cosas me dan miedo.		.45			
21. Me preocupa lo que mis papás me vayan a decir.		.40			
26. Me preocupa lo que la gente piense de mí.		.53			
30. Es muy fácil herir mis sentimientos.		.46			
35. Me preocupa lo que va a pasar.		.52			
42. Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir en la noche.		.48			
2. Soy muy nervioso(a).		.53			
3. Muchas veces me preocupa que algo malo me pase.		.57			
13. Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí.			.55		
22. Siento que a los demás no les gusta cómo hago las cosas.		.41			
27. Me siento solo(a) aunque esté acompañado(a).		.32			
36. Los demás son más felices que yo.			.52		
9. Siento que alguien va a decirme que hago mal las cosas.		.43	.30		
43. Me cuesta trabajo concentrarme en mis tareas escolares.	.50				
47. Muchas personas están en mi contra.	.41				
14. Todas las personas que conozco me caen bien.				.51	
19. Siempre soy amable.				.70	
24. Siempre me porto bien.				.65	
29. Siempre soy bueno(a).				.66	
33. Siempre soy agradable con todos.	.00	.04	.03	.70	
38. Siempre digo la verdad.				.45	.39
40. A veces me enoja.					.65
44. A veces digo cosas que no debería decir.					.52
48. He dicho alguna mentira.					.59
Valor específico	2.4	3.6	1.4	2.3	2.0
Porcentaje de varianza	33	48	19	54	46

Nota. N = 3 086. Sólo se muestran valores superiores a .30.

^aLos números de los reactivos corresponden a los del formulario de aplicación del CMASR-2.

Tabla 5-8. Solución de cinco factores para la muestra completa de referencia del CMASR-2
Respuestas a todos los 49 reactivos del CMASR-2

Reactivo	Factor de ansiedad			Factor de Defensividad	
	Ansiedad Fisiológica	Inquietud	Ansiedad social	1	2
11. Me cuesta trabajo tomar decisiones.					.43
15. Muchas veces siento que me falta el aire.	.40				
20. Me enoja con facilidad.	.38				
25. En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a).	.41				
1. Muchas veces siento asco o náuseas.	.45				
31. Me sudan las manos.					
34. Me canso mucho.	.47				
39. Tengo pesadillas.	.34	.33			
7. Algunas veces me despierto asustado(a).	.37	.38			
46. Me muevo mucho en mi asiento.	.41				
5. Tengo demasiados dolores de cabeza.	.51				
43. Me cuesta trabajo concentrarme en mis tareas escolares.	.43				
12. Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no me salen como quiero.					.46
16. Casi todo el tiempo estoy preocupado(a).	.33	.33			
18. Muchas cosas me dan miedo.		.30			
21. Me preocupa lo que mis papás me vayan a decir.		.34			
26. Me preocupa lo que la gente piense de mí.		.56			
30. Es muy fácil herir mis sentimientos.		.45			
35. Me preocupa lo que va a pasar.		.38			.31
42. Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir en la noche.	.43	.32			
2. Soy muy nervioso(a).		.40			
3. Muchas veces me preocupa que algo malo me pase.		.49			
17. Me siento mal si la gente se ríe de mí.		.51			
32. Me preocupa cometer errores delante de la gente.		.46			
6. Me preocupa no agradarle a los otros.		.59			
8. La gente me pone nervioso(a).		.43	.30		
45. Me preocupa que alguien me dé una golpiza.		.54			
49. Me preocupa decir alguna tontería.		.51			
13. Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí.			.40		
22. Siento que a los demás no les gusta cómo hago las cosas.		.36			
27. Me siento solo(a) aunque esté acompañado.	.34				
36. Los demás son más felices que yo.			.30		
9. Siento que alguien va a decirme que hago mal las cosas.		.48			
47. Muchas personas están en mi contra.	.41		.66		
23. Me da miedo hablar en voz alta ante mis compañeros durante la clase.					
28. En la escuela se burlan de mí.			.56		
37. Temo hablar en voz alta delante de un grupo.			.49		
41. Me preocupa que durante la clase me hagan participar.		.55			
4. Tengo miedo que otros niños se rían de mí durante la clase.		.58			
10. Tengo miedo que los demás se rían de mí.				.50	
14. Todas las personas que conozco me caen bien.				.69	
19. Siempre soy amable.				.63	
24. Siempre me porto bien.				.66	
29. Siempre soy bueno(a).				.70	
33. Siempre soy agradable con todos.				.47	
38. Siempre digo la verdad.					-.32
40. A veces me enoja.					-.60
44. A veces digo cosas que no debería decir.					-.48
48. He dicho alguna mentira.					-.53
Valor específico	3.2	4.6	2.1	2.6	2.3
Porcentaje de varianza	33	46	21	54	46

Nota. N = 3 086. Sólo se muestran valores superiores a .30.

niños con un IQ elevado ($IQ \pm 130$) y la solución de Reynolds y Paget (1981) derivada para la muestra normativa total.

Para la muestra completa de referencia amplia del CMASR-2, una confirmación razonable del factor fuerte del CMASR, se obtuvieron resultados analíticos. Como ya se mencionó, la solución de cinco factores incluye la misma escisión en los reactivos DEF que se había observado previamente de manera repetida para la subescala Mentira del CMASR, a pesar de que la coherencia de la escala se extiende más en los dos subgrupos de reactivos de Mentira. Los reactivos de Ansiedad Fisiológica e Inquietud/Hipersensibilidad formaron factores fuertes, únicos, como habían sido confirmados en alguna otra parte para el CMASR. Sin embargo, el factor de Preocupaciones sociales/Concentración estuvo fragmentado en la muestra actual. Las respuestas a unos cuantos reactivos estuvieron más fuertemente asociadas con los de la escala de Ansiedad Fisiológica, otras pocas con los de la escala de Inquietud/Hipersensibilidad, y solamente unas cuantas formaron un tercer factor, débil, de ansiedad.

Como puede verse en la tabla 5-8, la adición de los nuevos reactivos SOC produjo resultados similares, a pesar de que la mayor parte de la varianza compartida es más clara entre las respuestas de los reactivos SOC e INQ. Este descubrimiento es consistente con la alta correlación entre las dos puntuaciones escalares (.73). Aunque los alfa de escala y otros patrones en los datos indican independencia suficiente entre las escalas como para apoyar una evaluación e interpretación por separado, la alta correlación y los resultados de análisis factorial presentes sugieren que en la práctica es probable que las puntuaciones estándar de INQ y de SOC sean similares en muchos casos. Sin embargo, los reactivos que se traslapan en términos de cargas de factor no parecen diferir con la suficiente sistematicidad como para indicar alguna estructura de evaluación alternativa fuerte para las escalas del CMASR-2. Además, cuando el análisis factorial es conducido para este conjunto de datos únicamente en los reactivos de INQ y de SOC, no emergen agrupamientos de reactivos razonablemente coherentes más allá de los dos en cuestión. Puede ser que las respuestas a los reactivos que preguntan acerca de la ansiedad social sean impulsadas en parte por el contexto social acerca del que se pregunta y en parte por la ansiedad rasgo, la cual es independiente del contexto. Esta idea es apoyada por la observación de que cuando los seis reactivos nuevos en la escala INQ que preguntan acerca de la ansiedad social se eliminan del análisis, las respuestas a los reactivos restantes en las escalas INQ y SOC quedan demarcadas con mayor nitidez en dos factores claros. Por otra parte, puede ser que el traslape sea idiosincrático en relación con la muestra actual o que se relacione con restricción de rangos de puntuación debido a que la muestra no es clínica.

Sin tener confirmaciones de estos descubrimientos en una diversidad de muestras independientes, y sin ninguna estructura de evaluación alternativa que sea convincente desde una perspectiva teórica o racional, lo más sabio parece ser quedarse con la estructura escalar que ha sido establecida de manera fuerte y repetida en la investigación con el CMASR. Se espera que la investigación adicional con el CMASR-2 ayude a clarificar este aspecto. Mientras tanto, prestar atención a los reactivos particulares refrendados cuando la puntuación INQ o SOC es elevada ayudará a determinar si el resultado debe interpretarse como manifestación de aspectos de ansiedad diferenciados. Además, como

se ha subrayado repetidamente a lo largo de este manual, la puntuación TOT del CMASR-2 es claramente la medida más estable ofrecida por la prueba, y las interpretaciones que se centran de manera más estrecha en las puntuaciones escalares del CMASR-2 deben ofrecerse siempre como puntos de partida para la evaluación y la verificación de seguimiento, más que como aseveraciones clínicas definitivas.

La evidencia analítica factorial apoya hasta aquí la presencia de un fuerte factor de ansiedad general (Ag), representado por la puntuación TOT y por las diversas escalas de ansiedad, así como por la escala DEF. Éstas son relativamente constantes en muchas variables, incluyendo género, grupo étnico, IQ y algunas condiciones de discapacidad. Se necesita trabajo adicional para explorar aún más la relevancia clínica de los reactivos en la escala SOC. De igual modo, será importante seguir evaluando las respuestas en el CMASR-2 de niños y adolescentes en escenarios clínicos, en particular con los perturbados emocionalmente de manera grave y niños neuróticos, y con grandes muestras de niños con problemas de aprendizaje. Las valoraciones de la estructura factorial del CMASR-2 en niños con desarrollo anormal serán especialmente valiosas en la evaluación de la utilidad de la escala y de sus interpretaciones recomendadas con estos niños.

Evidencia basada en relaciones con respecto a variables externas

Uno de los métodos más poderosos de validación de constructo es la comparación del desempeño en una escala particular con el desempeño en otras medidas (mediante hipótesis) de los mismos rasgos o similares, así como medidas de rasgos que se creen teóricamente distintos. Se han efectuado muchos de estos estudios con el CMASR, y algunas evidencias de este tipo se encuentran disponibles también para el CMASR-2.

Reynolds (1980) investigó la validez de constructo del CMASR por medio de la examinación de la validez concurrente y divergente de la escala bajo circunstancias de aplicación convergente con otras medidas aceptadas de ansiedad rango y estado. El *Inventario de ansiedad estado-rasgo para niños* (STAIC; Spielberger, 1973) se eligió como una medida de criterio, con base en el cuerpo sustancial de evidencia de investigación que apoya la validez de este inventario. Para apoyar la validez del CMASR, debe presentarse una amplia correlación con la escala STAIC Rasgo. Para los 42 niños en el estudio, se calcularon medias y desviaciones estándar por cada una de las tres escalas (CMASR, STAIC Rasgo, STAIC Estado), y se determinaron los coeficientes de correlación producto-momento de Pearson entre cada par de variables.

En el CMASR y la escala STAIC Rasgo, los niños obtuvieron una puntuación muy cercana a la media de la muestra normativa para cada escala: para el CMASR, $M = 13.8$, $SD = 5.6$; para la escala STAIC Rasgo, $M = 39.3$, $SD = 7.6$. En la escala STAIC Estado, los niños de alguna manera calificaron por debajo de la muestra normativa: $M = 31.3$, $SD = 6.7$. Como se sospechaba al examinar los datos de estandarización de las tres escalas, ninguna de las puntuaciones de éstas se correlacionó de manera significativa con la edad real o mental ($p < .05$). Con base en estos resultados, se examinaron las correlaciones de orden cero entre cada una de las escalas. Una correlación significativa muy amplia se dio entre el CMASR y la escala STAIC Rasgo ($r = .85$, $p < .001$). La magnitud de esta relación es sustancial, ya que la correlación se aproximaba al límite teórico de la correlación entre estas dos escalas, dadas

sus respectivas confiabilidades. El límite teórico de la correlación de población verdadera entre dos grupos de puntuaciones de pruebas es igual a $\sqrt{(r_{xx})(r_{yy})}$. El CMASR no se correlacionó de manera significativa con la escala STAIC Estado ($r = .35$, $p < .05$). Ninguna de las escalas de ansiedad se correlacionó de manera significativa con las puntuaciones estándar de la prueba de inteligencia.

Los resultados del estudio proporcionan apoyo considerable para la validez de constructo del CMASR como una medida de ansiedad manifiesta crónica, independiente de la ansiedad estado o situacional. Aunque necesitaran emplearse las puntuaciones estándar para hacer comparaciones directas, la magnitud de la correlación entre el CMASR y la escala STAIC Rasgo sugiere que las dos pueden utilizarse como formas alternas de medida.

En un estudio muy similar con 465 niños con un IQ elevado (Reynolds, 1985), la puntuación TOT del CMASR se correlacionó en .78 con la escala STAIC Rasgo y sólo .08 con la escala STAIC Estado. Una vez más estos resultados proporcionan apoyo para la interpretación del CMASR como una medida de disposición a la ansiedad crónica.

En un estudio más ambicioso (Reynolds, 1982c), se generó una matriz de validación multirrasgos modificada para evaluar la validez del CMASR como una medida de ansiedad. Los resultados se reportaron por separado para varones y mujeres. Los estudios multimétodo-multirrasgos son un enfoque más exacto para el análisis de la validez de interpretaciones de puntuaciones de pruebas; por tanto, este estudio se describirá con cierto detalle.

En el procedimiento multimétodo-multirrasgo, los factores relacionados con la variable que se estudia (en este caso, ansiedad crónica) se miden utilizando una variedad de métodos (para control de la varianza de método) junto con factores que se creen esencialmente no relacionados con la variable en cuestión. Entonces se explora el patrón de correlación para determinar si iguala al patrón que se pronosticó.

Los participantes en el estudio fueron 86 alumnos de tercero y cuarto grados (47 varones, 39 mujeres) de cuatro salones en un distrito escolar suburbano de clase media a media alta en una ciudad grande del medio oeste estadounidense. Los niños tenían una edad media de 110.4 meses ($SD = 8.4$ meses). La media del IQ de la *Prueba de dibujo Goodenough-Harris* (Goodenough y Harris, 1963) del grupo fue de 101.1 ($SD = 13.9$). No hubo diferencias de género en edad o IQ, aunque algunas fueron evidentes en otras variables. Por ésta y otras razones, todos los resultados se informan por separado para varones y mujeres. La tabla 5-9 se proporcionan datos de muestra más extensos.

Para suministrar la evaluación de validez tanto concurrente como divergente del CMASR, se eligieron diversas variables, incluyendo las medidas tradicionales de inteligencia y personalidad, y una evaluación conductual de los niños en el salón de clases.

Para proporcionar una medición neutral de inteligencia, se recolectaron dibujos de figura humana de cada niño. Éstos fueron calificados para brindar un IQ por desviación de acuerdo con el sistema Goodenough-Harris. Se anticipó un cero para las pequeñas correlaciones negativas entre el CMASR y la medida de IQ.

Además del CMASR, se incluyeron dos cuestionarios que miden ansiedad. Se aplicaron las escalas de Estado y Rasgo de la STAIC, en un diseño contrabalanceado con el CMASR, en

los salones de clase. Al igual que en estudios antes analizados, debido a que la escala de Rasgo del STAIC es una medida de ansiedad crónica, debe mostrar una correlación sustancial con el CMASR, en especial la puntuación TOT, que ha sido definida en estudios de análisis factorial como una puntuación de ansiedad crónica general. La escala de Estado no debe mostrar correlación significativa con el CMASR o con la escala de Rasgo.

Para valorar dimensiones múltiples de la conducta de los niños, cada uno de los maestros completó el *Walker Problem Behavior Identification Checklist* (WPBIC; Walker, 1971) durante 14 días de aplicación de todas las pruebas. El WPBIC es una lista de verificación observacional en la que los maestros marcan, a partir de una lista de 50 conductas, aquellas observadas en el niño en cuestión. Se proporcionan normas separadas para varones y mujeres que escalan todas las puntuaciones a calificaciones-T. Se proporcionaron cinco escalas o dimensiones de conducta: *Acting-out*, Introversión, Distractibilidad, Relaciones problemáticas con los compañeros e Inmadurez. El CMASR debe mostrar correlaciones consistentemente pequeñas pero significativas con las observaciones de conducta de los maestros, con quizá mayores correlaciones entre el CMASR y dimensiones más activas de conducta, como *Acting-out*, Distractibilidad y Relaciones problemáticas con los compañeros, ya que es probable que la ansiedad en los niños produzca reacciones manifiestas. Se determinó una puntuación total de la conducta problema mediante la suma de las puntuaciones naturales, como una medida amplia del nivel general de conductas problema exhibidas.

Se proporcionaría el mayor apoyo para el CMASR y sus escalas con el siguiente patrón de resultados: ninguna correlación o una pequeña correlación negativa entre el CMASR y el IQ, ninguna correlación entre el CMASR y la medida STAIC de ansiedad estado, una amplia correlación entre el CMASR y la STAIC de ansiedad rasgo, y correlaciones pequeñas pero positivas y significativas de manera consistente entre el CMASR y las observaciones de conducta de los maestros. Reynolds (1982c) también incluyó la subescala de Mentira del CMASR en todos los análisis. Con la excepción de pocas variables, los niños obtuvieron una calificación cercana a las medias de la muestra normativa de las diversas escalas (véase tabla 5-9). Las puntuaciones más bajas fueron evidentes en las escalas STAIC Rasgo, CMASR y de introversión del WPBIC, en cambio, la escala STAIC Estado mostró una puntuación por arriba del promedio relativa a la muestra de estandarización de las diversas escalas. Sin embargo, es importante señalar que algunas restricciones de rango, de diversos niveles de gravedad, se presentaron en tres de las cinco medidas conductuales y la medida de IQ (ligeramente). Se notó una grave restricción de rango sólo en la escala de Introversión del WPBIC, una serie de conductas expuestas de manera poco frecuente por este grupo de niños.

Las correlaciones entre cada par de variables se presentan por separado para varones y mujeres en la tabla 5-10. Aunque las correlaciones entre las medidas de autoinforme y las conductas observadas de alguna manera son menores a lo previsto, el patrón total de correlación en mucho es como se anticipó para ambos grupos. La puntuación TOT del CMASR se correlacionó de manera sustancial con la escala STAIC Rasgo, con correlaciones de .65 para varones y .67 para mujeres. Estas correlaciones son ligeramente menores que las referidas por Reynolds (1980, 1985), pero continúan siendo de una magnitud considerable. El descubrimiento de que no era evidente

Tabla 5-9. Medias y desviaciones estándar para las variables demográficas, de conducta y de personalidad en el estudio multimétodo-multirrasgo

Variable	Varones (n = 47)		Mujeres (n = 39)		Total (n = 86)	
	M	SD	M	SD	M	SD
Edad en meses	112.8	9.6	108.0	7.9	110.4	8.4
IQ del Goodenough-Harris	101.9	16.9	100.1	8.9	101.1	13.9
Puntuaciones del WPBIC^a						
Acting-out	48.9	8.0	51.1	8.5	49.9	8.3
Introversión	47.8	6.3	46.6	5.3	42.3	5.9
Distractibilidad	21.1	9.8	5.5	10.4	52.2	10.1
Relaciones problemáticas con los compañeros	50.5	7.9	50.9	12.2	50.7	10.0
Inmadurez	51.1	9.4	50.0	6.4	59.6	8.0
Tasa de conducta total	9.8	9.0	4.8	6.1	7.5	8.2
Puntuaciones del CMASR^b						
Ansiedad Fisiológica	3.7	2.2	4.5	2.4	1.1	2.3
Inquietud/Hipersensibilidad	3.3	2.7	4.7	2.8	4.0	2.8
Preocupaciones sociales/Concentración	3.0	2.1	3.3	2.3	3.1	2.2
Ansiedad Total	9.9	6.1	12.5	6.2	11.1	6.2
Mentira	3.6	2.3	4.5	2.5	4.0	2.5
Puntuaciones de la STAIC^c						
Ansiedad Estado	44.9	4.1	43.8	4.8	44.4	4.5
Ansiedad Rasgo	36.1	7.1	38.5	6.5	37.2	6.9

Nota. Adaptado por Reynolds (1982c).

^aWPBIC = Walker Problem Behavior Identification Checklist.

^bPuntuaciones naturales reportadas al no estar disponibles las puntuaciones estándar.

^cSTAIC = State-Trait Anxiety Inventory for Children.

una relación significativa entre la escala STAIC Estado con ninguna de las dos medidas de ansiedad crónica sirve para apoyar la validez divergente del CMASR al igual que la de la escala STAIC Rasgo. Tampoco la medida de ansiedad rasgo mostró una correlación significativa con el IQ como se midió en este estudio. Curiosamente, la escala Estado de la STAIC mostró una correlación moderada con el IQ para varones (.47), pero no para mujeres (.03).

Casi todas las correlaciones entre las subescalas del CMASR y las cinco escalas conductuales del WPBIC fueron positivas y las más altas para las escalas más activas, como se anticipó. La correlación de la puntuación TOT con la calificación Clasificación Total de Conducta fue .32 para varones y .29 para mujeres. La subescala de Preocupaciones sociales/Concentración se relacionó más de cerca con los problemas de conducta observados por los maestros, pero sólo para las mujeres. Se obtuvieron correlaciones de .39, .53 y .35 entre la subescala de Preocupaciones sociales/Concentración y las escalas *Acting-out*, *Distractibilidad* y *Relaciones problemáticas* con los compañeros, respectivamente. Para los varones, la subescala de Ansiedad Fisiológica se relacionó más de cerca con la conducta observada.

En este estudio, la subescala Mentira de hecho pareció ser una medida de Defensividad o conveniencia social. Mostró

correlaciones pequeñas pero negativas de manera consistente con la mayoría de las variables; la principal excepción fue la escala STAIC Estado. El descubrimiento de que la subescala Mentira se correlacionó -.50 con la escala Estado para mujeres y -.31 para varones tiende a confirmar la interpretación de esta escala como una medida de conveniencia social o Defensividad.

Los resultados presentados por Reynolds (1982c) son promisorios en relación con el CMASR, y son consistentes con los resultados de otros estudios que han mostrado amplias correlaciones entre el CMASR y la escala STAIC Rasgo (Reynolds, 1980). Las correlaciones entre los síntomas de ansiedad referidos por el niño y los problemas de conducta observados por el maestro, aunque pequeñas, también constituyen evidencia de apoyo para la validez de la escala.

En un estudio de latencia reciente, se examinaron las puntuaciones obtenidas por 64 niños diagnosticados con Trastorno de Déficit de Atención (TDA). Se computaron las correlaciones entre el CMASR, los formularios para padres y maestros de las *Conners' Rating Scales* (CRS-P y CRS-T; Conners, 1989) y las puntuaciones del formulario abreviado del *Children's Depression Inventory* (CDI; Kovacs y personal de MHS, 2003). Los resultados se muestran en la tabla 5-11. Todas las puntuaciones

Tabla 5-10. Correlaciones entre pares de variables en el estudio multimétodo-multirasgo

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. IQ	—	.01	.03	-.05	-.16	-.27	-.14	-.04	.01	-.27	-.10	-.05	.47	-.01
Puntuaciones del WPBIC^a														
2. Acting-out	-.09	—	-.00	.66	.05	.04	.60	.21	.03	.11	.13	.01	-.11	.17
3. Introversión	-.28	.10	—	.12	.23	.33	.43	.26	.25	.18	.27	-.20	-.07	.15
4. Distractibilidad	.07	.55	.30	—	.35	.31	.82	.30	.20	.19	.26	-.16	-.04	.13
5. Relaciones problemáticas con los compañeros	.00	.14	.44	.58	—	.58	.64	.06	.12	.09	.11	-.03	-.16	-.09
6. Inmadurez	-.30	.32	.25	.17	-.16	—	.58	.08	.00	.00	.03	-.01	-.15	-.04
7. Tasa de conducta total	-.15	.74	.57	.84	.57	.41	—	.35	.24	.26	.32	-.21	-.08	.12
Puntuaciones del CMASR														
8. Ansiedad Fisiológica	.14	.14	-.01	.18	.20	.00	.15	—	.55	.69	.85	-.09	-.06	.55
9. Inquietud/Hipersensibilidad	.03	.11	.13	.09	.01	-.02	.13	.49	—	.68	.87	-.23	.01	.57
10. Preocupaciones sociales/ Concentración	.15	.39	.09	.53	.35	.06	.47	.58	.49	—	.90	-.27	-.07	.58
11. Ansiedad Total	.12	.25	.08	.31	.21	.02	.29	.82	.83	.82	—	-.23	-.04	.65
12. Mentira	.00	-.11	.00	.03	.01	-.22	-.06	-.15	.17	-.06	.00	—	-.31	-.11
Puntuaciones del STAIC^b														
13. Ansiedad Estado	.03	.05	.16	.02	.06	.18	.10	.03	.03	-.19	-.07	-.10	—	-.11
14. Ansiedad Rasgo	.07	.14	.29	.26	.50	.60	.32	.52	.62	.51	.51	.67	-.03	—

Nota. Tomado de Reynolds (1982c). Las correlaciones por encima de la diagonal son para varones, y por debajo de la diagonal son para mujeres.

^aWPBIC = Walker Problem Behavior Identification Checklist.

^bSTAIC = State-Trait Anxiety Inventory for Children

de ansiedad del CMASR se correlacionan con las puntuaciones CDI de niños. Se observó una relación especialmente estrecha entre las puntuaciones SOC y CDI ($r = .65$), ambas basadas en medidas de autoinforme. Las puntuaciones del CMASR obtenidas por la media de los niños fueron en promedio en ascenso, y las puntuaciones del CMASR se correlacionaron diferencialmente con las clasificaciones de Conner —clasificaciones de los padres acerca de la ansiedad, el perfeccionismo y síntomas específicos de sus hijos relacionados con síntomas de TDA con base en el *DSM-IV*. Las clasificaciones de los maestros en la mayoría de las áreas exhibieron correlaciones de pequeñas a moderadas con las puntuaciones SOC obtenidas por los niños, y la correlación más alta ($r = .43$) fue con clasificaciones de maestros de síntomas específicos relacionados con el diagnóstico *DSM-IV* del TDA. Aunque la magnitud de estas correlaciones es moderada, las correlaciones son commensurables con los niveles de acuerdo observados comúnmente entre un autoinforme y un observador que reporta síntomas clínicos. Además, el patrón de correlaciones observado es consistente con constructos medidos por el CMASR.

Variables externas y puntuaciones del CMASR-2. El cuerpo de investigación referente a la validez del CMASR se aplica también en el CMASR-2 en virtud de la equivalencia demostrada por esta última con el CMASR. Además, tres fuentes de evidencia más recientes están disponibles actualmente con respecto en el CMASR-2. La primera es la correlación de puntuaciones

del CMASR-2 con otra medida de ansiedad que se concentra en síntomas obsesivo-compulsivos. La *Children's Measure of Obsessive-Compulsive Symptoms* (CMOCS; Reynolds y Livingstone, en imprenta) cuenta con tres escalas compuestas: Obsesiones (preocupaciones mentales), Compulsiones (rutinas conductuales repetitivas para mitigar la ansiedad) y Resultados (efectos en el funcionamiento cotidiano). Las correlaciones entre las puntuaciones en el CMASR-2 y la CMOCS para un grupo grande de niños en la muestra completa de referencia del CMASR-2 se presentan en la tabla 5-12. Las correlaciones con DEF son bajas, y las correlaciones con las puntuaciones de ansiedad del CMASR-2 son moderadas. Las correlaciones más altas son aquellas entre las puntuaciones de la CMOCS y la puntuación TOT. La correlación más alta entre las escalas es entre las puntuaciones de Obsesión y las de INQ. Estos resultados son completamente consistentes con lo esperado con base en los constructos ideados para ser medidos por cada instrumento.

Las correlaciones entre las puntuaciones de la CMOCS y del CMASR-2 también estuvieron disponibles para una muestra clínica de 341 niños diagnosticados con diversos problemas clínicos: TDA ($n = 57$), trastornos del espectro autista (TEA; $n = 36$), depresión ($n = 101$), trastornos de ansiedad ($n = 32$), Trastorno Negativista Desafiante ($n = 42$) y Trastorno de Conducta ($n = 73$). Estos se muestran en la tabla 5-13. Para este grupo clínico, las correlaciones son fuertes. Las asociaciones

Tabla 5-11. Correlaciones entre las puntuaciones de CMASR, CDI y CRS

Escala	CMASR				
	Ansiedad Total	Ansiedad Fisiológica	Inquietud Hipersensi-	Preocupaciones sociales/ Concentración	Mentira
Children's Depression Inventory (CDI)					
Puntuación del Formulario Breve	.50	.45	.39	.65	-.29
Conners' Rating Scales (CRS): Parent Ratings					
Oposicional	-.05	.00	-.07	.05	-.09
Problemas cognitivos/Desatención	.16	.09	-.09	.28	.03
Hiperactividad	.04	.07	.01	.11	-.08
Ansiedad-Vergüenza	.34	.30	.38	.16	-.13
Perfeccionismo	.27	.22	.28	.24	-.23
Problemas sociales	.16	.13	.15	.20	.00
Problemas psicosomáticos	.03	.09	-.03	-.05	-.05
Índice ADHD	.10	.08	.09	.18	.00
Conners' Global Index:					
Intranquilo-Impulsivo	.04	.07	.01	.11	-.03
Labilidad emocional	.14	.16	.12	.10	-.18
Total	.06	.09	.03	.11	-.08
DSM-IV:					
DSM-IV. Síntomas	.13	.08	.09	.23	-.04
DSM-IV. Desatento	.07	.12	.06	.09	-.06
DSM-IV. Hiperactivo-Impulsivo	.12	.12	.09	.18	-.05
Conners' Rating Scales (CRS): Teacher Ratings					
Oposicional	.10	.14	.00	.18	-.12
Problemas cognitivos/Desatención	.17	.09	.01	.38	-.11
Hiperactividad	.14	.19	.03	.18	-.17
Ansiedad-Vergüenza	.20	.13	.17	.24	-.10
Perfeccionismo	.14	.08	.14	.22	-.04
Problemas sociales	.07	.17	-.11	.21	.07
Índice ADHD	.19	.22	.06	.30	-.11
Conners' Global Index:					
Intranquilo-Impulsivo	.14	.22	-.04	.26	-.12
Labilidad emocional	.18	.24	.08	.19	-.21
Total	.20	.25	.06	.29	-.19
DSM-IV:					
DSM-IV. Síntomas	.24	.18	.09	.43	-.16
DSM-IV. Desatento	.12	.18	.03	.18	-.16
DSM IV. Hiperactivo Impulsivo	.19	.21	.05	.33	-.15

Nota. N = 64, edades de 6 a 18 años.

Tabla 5-12. Correlaciones entre las puntuaciones de CMASR-2 y CMOCS

Escala del CMASR-2	Escala de la CMOCS		
	Obsesiones	Compulsiones	Resultados
Ansiedad Total (TOT)	.52	.41	.46
Ansiedad Fisiológica (FIS)	.40	.32	.41
Inquietud (INQ)	.47	.36	.38
Ansiedad Social (SOC)	.42	.35	.36
Defensividad (DEF)	.16	.23	.06

Nota. $N = 2\,550$, edades de 8 a 19 años.

Tabla 5-13. Correlaciones entre las puntuaciones de CMASR-2 y CMOCS para niños en escenarios clínicos

Escala del CMASR-2	Escala de la CMOCS		
	Obsesiones	Compulsiones	Resultados
Ansiedad Total (TOT)	.73	.55	.701
Ansiedad Fisiológica (FIS)	.59	.46	.60
Inquietud (INQ)	.74	.57	.67
Ansiedad Social (SOC)	.58	.41	.57
Defensividad (DEF)	.14	.28	.08

Nota. $N = 341$, edades de 8 a 18 años.

Tabla 5-14. Correlaciones entre las escalas de CMASR-2 para niños en escenarios clínicos

Escala	TOT	FIS	INQ	SOC	DEF
Ansiedad Total (TOT)	—				
Ansiedad Fisiológica (FIS)	.78				
Inquietud (INQ)	.94	.59			
Ansiedad Social (SOC)	.91	.58	.80		
Defensividad (DEF)	.14	.04	.08	-.10	—

Nota. $N = 341$, edades de 8 a 18 años.

más fuertes son entre el reporte de obsesiones de los niños y las puntuaciones TOT e INQ ($r = .73$ y $.74$, respectivamente). La relación es más baja para las compulsiones que para las otras escalas, como sería de esperar, dada la función reductora de la ansiedad de las conductas compulsivas. Resulta de interés el que las correlaciones interescales para este grupo, mostradas en la tabla 5-14, muestren un patrón similar al de la muestra completa de referencia. La fuerte relación entre las escalas INQ y SOC es evidente.

De un grupo de 75 niños referidos para evaluaciones de TDA, se examinaron las correlaciones con las puntuaciones de los formularios de la CRS-P y de la CRS-T y el abreviado del CDI. Las correlaciones se muestran en la tabla 5-15. Es evidente un patrón similar al ya descrito para el CMASR-2. Todas las puntuaciones de ansiedad del CMASR-2 exhiben correlaciones moderadas con puntuaciones del CDI de autoinforme de niños. Para este grupo, la relación más cercana se observó entre las puntuaciones TOT y CDI ($r = .68$). Las puntuaciones del CMASR-2 obtenidas por la media de los niños fueron en promedio en ascenso, y sus puntuaciones TOT e INQ se correla-

cionaron diferencialmente con las calificaciones de los padres de la ansiedad y el perfeccionismo de sus hijos, así como con las calificaciones de los padres de problemas sociales y síntomas psicossomáticos. Entre las calificaciones de los padres, la asociación más alta para la puntuación FIS fue con la medida de problemas Psicossomáticos.

Las calificaciones de los maestros en la mayoría de las áreas exhibieron una relación positiva con las puntuaciones FIS obtenidas de los niños para este grupo, y la correlación positiva más alta para FIS ($r = .32$) fue con las calificaciones de los maestros de síntomas hiperactivos-impulsivos relacionados con el diagnóstico del DSM-IV del TDA. Aunque la magnitud de estas correlaciones es pequeña, como sucede normalmente en casos de autoinforme de características psicológicas al compararse con las calificaciones establecidas por otros, las correlaciones siguen un patrón diferencial que corresponde con los constructos medidos por cada escala.

Por otro lado, algunas de las relaciones más fuertes que se observaron para las calificaciones de los maestros y puntuaciones del CMASR-2 basadas en autoinformes de niños fueron

Tabla 5-15. Correlaciones entre las puntuaciones de CMASR-2, CDI y CRS

Escala	CMASR-2				
	Ansiedad Total (TOT)	Ansiedad Fisiológica (FIS)	Inquietud (INQ)	Ansiedad Social (SOC)	Defensividad (DEF)
Children's Depression Inventory (CDI)					
Puntuación del Formulario Breve	.68	.45	.62	.60	-.21
Conners' Rating Scales (CRS): Parent Ratings					
Oposicional	.09	.17	.04	.04	-.20
Problemas cognitivos/Desatención	.01	.07	-.05	.05	-.17
Hiperactividad	.11	.10	.06	.15	-.11
Ansiedad-Vergüenza	.22	.07	.24	.20	-.14
Perfeccionismo	.22	.18	.23	.12	-.01
Problemas sociales	.21	.13	.22	.16	-.15
Problemas psicosomáticos	.28	.23	.30	.12	-.07
Índice ADHD	.12	.14	.06	.12	-.11
Conners' Global Index:					
Intranquilo-Impulsivo	.14	.12	.09	.14	-.14
Labilidad emocional	.15	.12	.10	.14	-.07
Total	.12	.13	.07	.13	-.15
DSM-IV:					
DSM-IV. Síntomas	.01	.10	-.05	.03	-.09
DSM-IV. Desatento	.02	.03	-.02	.06	-.17
DSM-IV. Hiperactivo-Impulsivo	.07	.17	-.02	.07	-.06
Conners' Rating Scales (CRS): Teacher Ratings					
Oposicional	.03	.27	-.07	-.09	-.17
Problemas cognitivos/Desatención	-.26	.08	-.37	-.27	.27
Hiperactividad	.26	.25	.23	.14	-.06
Ansiedad-Vergüenza	-.02	.00	-.07	.05	-.04
Perfeccionismo	.19	.21	.15	.12	.06
Problemas sociales	.10	.15	.10	.00	.08
Índice ADHD	.04	.21	-.02	-.06	.23
Conners' Global Index:					
Intranquilo-Impulsivo	.11	.23	.05	.02	.19
Labilidad emocional	.20	.28	.10	.14	-.08
Total	.13	.27	.05	.04	.09
DSM-IV:					
DSM-IV. Síntomas	.09	.28	-.01	-.02	.18
DSM-IV. Desatento	-.08	.16	-.17	-.13	.26
DSM-IV. Hiperactivo-Impulsivo	.24	.32	.17	.10	-.03

Nota. N = 75, edades de 6 a 18 años.

asociaciones positivas de desatención y puntuaciones de diagnóstico de TDA con DEF. De este modo, en unas cuantas áreas, entre más grande era el problema reportado por el maestro, más a la defensiva parecían estar los niños en sus respuestas en el CMASR-2, con puntuaciones *Ra* de .27, .23 y .26 para Problemas cognitivos/Desatención, Índice ADHD y *DSM-IV*: Desatención, respectivamente. Esto puede justificar la sorprendente observación de que entre las más altas asociaciones de puntuaciones del CMASR-2 de autoinforme con las calificaciones de los maestros hubiera relaciones negativas entre puntuaciones TOT, INQ y SOC, basadas en autocalificaciones y en calificaciones de los maestros de Problemas cognitivos/Desatención. La elaboración adicional de estos descubrimientos no se garantiza sin una confirmación sistemática, y se espera que la comunidad de investigación las encuentre de suficiente interés como para proseguir con su clarificación.

Puntuaciones del CMASR-2 para niños en escenarios clínicos

Las puntuaciones naturales promedio del CMASR-2 para niños en una diversidad de grupos clínicos se muestran en la tabla 5-16. Las puntuaciones TOT y las puntuaciones escalares promedio más altas se observaron en niños con trastornos de ansiedad. La mayoría de sus puntuaciones estuvieron muy por encima de los promedios para la muestra de estandarización. Las puntuaciones TOT para el grupo con trastornos de ansiedad excedieron a las de la muestra de estandarización por una desviación estándar completa. Las puntuaciones INQ y SOC para los niños con trastornos de ansiedad excedieron a las de la muestra de estandarización por más de una desviación estándar. Las puntuaciones FIS fueron más o menos iguales a las de la muestra de estandarización. Los niños con depresión también obtuvieron puntuaciones promedio del CMASR-2 más altas que las obtenidas por la muestra de estandarización, aunque las diferencias son un poco menos dramáticas. Como se esperaba, las puntuaciones FIS fueron más altas en el grupo con depresión, lo que es consistente con la tendencia de los niños deprimidos a manifestar síntomas somáticos. Los niños con TDA obtuvieron puntuaciones TOT e INQ promedio ligeramente más altas que las obtenidas por los de la muestra de estandarización.

Todos los demás agrupamientos clínicos representados en la tabla 5-16 son de niños con trastornos clínicos externalizados. Como se esperaba, todos esos niños obtuvieron pun-

tuaciones promedio del CMASR-2 menores que las obtenidas por los niños en la muestra de estandarización. Este descubrimiento es completamente consistente con la falta de control de impulsos y la intolerancia de afectos fuertes que normalmente caracteriza a los niños con trastornos de conducta externalizados o disruptivos.

Sesgo de reactivos: grupo étnico y género

El sesgo cultural es un tema muy importante en la evaluación, y como se ha descrito en las secciones y capítulos previos, el CMASR se ha estudiado a partir de una variedad de perspectivas relativas a este tema. Sin embargo, todavía no se ha analizado la posibilidad del sesgo de reactivos, el cual, si se presenta en cualquier grado significativo, seguramente puede arrojar serias dudas sobre la validez transcultural de la escala. Reynolds, Plake y Harding (1983) llevaron a cabo una valoración extensa del sesgo de reactivos en el CMASR, examinando el sesgo para el grupo étnico (afroamericano, blanco y otros; el último casi es totalmente hispano) y género en las respuestas a los reactivos, y extender así el estudio de la validez diferencial del CMASR hacia el nivel de los reactivos. Aunque se observaron efectos estadísticos confiables durante este estudio, éstos son muy pequeños en términos del tamaño del efecto, y virtualmente no tendrían ningún impacto en la interpretación de las puntuaciones del CMASR o del CMASR-2. Además, el análisis reactivo por reactivo de los efectos observados indica que no son lo suficientemente sistemáticos como para ser razonablemente justificados en términos de diferencias culturales, y son más probablemente un resultado del aniplo tamaño de la muestra y diferencias leves pero sistemáticas en la media de la puntuación entre los grupos. En los siguientes párrafos se presentan detalles adicionales acerca del estudio.

En el estudio de Reynolds et al. (1983), los más de 5 000 niños a los que se les aplicó la prueba durante la estandarización del CMASR sirvieron como muestra. Además de los niños afroamericanos y blancos ya descritos, también se incluyeron 475 niños esencialmente hispanos (242 varones y 233 mujeres). Del grupo inicial de niños, se seleccionaron al azar por computadora cuatro submuestras independientes sin reemplazo de 50 niños de cada combinación de grupo étnico y género (p. ej., mujeres blancas, varones afroamericanos), proporcionando 25 submuestras y una *N* final de 1 200. Para cada submuestra, se determinó la proporción de niños que respondían en la

Tabla 5-16. Puntuaciones promedio de CMASR-2 para niños en escenarios clínicos

Escala	Trastorno de déficit de atención (<i>n</i> = 57)	Trastornos del espectro autista (<i>n</i> = 36)	Trastornos de ansiedad (<i>n</i> = 32)	Depresión (<i>n</i> = 101)	Trastorno negativista desafiante (<i>n</i> = 42)	Trastorno de conducta (<i>n</i> = 73)
Ansiedad Total (TOT)	14.6	16.9	25.6	20.8	9.6	11.7
Ansiedad Fisiológica (FIS)	4.9	4.8	5.5	5.9	3.9	4.3
Inquietud (INQ)	5.8	7.3	11.8	8.3	2.1	3.8
Ansiedad Social (SOC)	3.9	4.9	8.4	6.6	3.6	3.7
Defensividad (DEF)	4.0	2.4	1.4	2.0	0.1	1.7

Nota. Los niños en la muestra estuvieron distribuidos con bastante regularidad en el rango de edad de 8 a 18 años; 64% fueron varones y 36%, mujeres.

dirección clave a cada reactivo de ansiedad. Entonces las proporciones se sometieron a un análisis de varianza de tres factores, donde el género y el grupo étnico (afroamericano, blanco, otro) eran factores entre sujetos y los reactivos se consideraron un factor interno (Laksana y Coffman, 1980). Si un reactivo en una prueba se define como sesgado (si se emplea el término sesgo en su bien reconocido sentido estadístico denota error constante o sistemático en oposición a error aleatorio) cuando ocurren tasas diferenciales de respuesta en una dirección específica hacia el reactivo como una función de pertenencia a un grupo particular después que se ha explicado cualquier diferencia media en una puntuación total (p. ej., Berk, 1982; Reynolds, 1982a), entonces la metodología ANOVA, un término de interacción significativa de Grupo étnico x Género x Reactivos, señalará la presencia de reactivos sesgados. Es decir, una vez que se ha removido estadísticamente de las puntuaciones de reactivos el efecto de la puntuación total de la prueba, no deben permanecer diferencias de grupo étnico o género en el nivel de reactivos.

Se ha señalado que, si los grupos presentan diferentes niveles de "capacidad" o rasgo, la metodología ANOVA será sensible y detectará significación no deseada como un artefacto del efecto principal entre grupos (Hunter, 1975; Lord, 1977). El problema con el método ANOVA es que la diferencia de medias del grupo completo se utiliza para comparar todos los reactivos, donde cualquier reactivo que tenga una diferencia de medias totales por más o menos de lo esperado para otros reactivos se considerará sesgado. Para este análisis, el desempeño total de los subgrupos por grupo étnico y género fue similar, aunque obviamente se presentaron algunas diferencias entre los grupos más extremos. El método particular de análisis en el estudio de Reynolds *et al.* (1983) permite una evaluación más confiable de lo que se espera por casualidad. Sin embargo, el efecto de la falta de equivalencia de las medias de la puntuación total de la prueba y la complejidad factorial del CMASR es para sobrestimar el grado del sesgo presente.

El ANOVA arrojó diferencias significativas ($p < .001$) entre efectos (género, grupo étnico, género x grupo étnico) y dentro de efectos (reactivos, reactivos x género, reactivos x grupo étnico, reactivos x género x grupo étnico). La tabla 5-17 se presenta un resumen del ANOVA. La presencia de reactivos de prueba sesgados se confirmó de manera estadística. Para determinar qué reactivos estaban contribuyendo a la interacción significativa Reactivos x Género x Grupo étnico, se empleó un seguimiento de tipo Bonferroni sobre los contrastes de interacción (para varones y mujeres por separado).

Para los sujetos varones, se identificaron 25 instancias de sesgo de reactivos entre los tres grupos étnicos: nueve para el grupo blanco, 10 para el grupo afroamericano y seis para el grupo otros. Para los niños varones blancos, se identificaron cinco reactivos como sesgados contra el grupo y cuatro sesgados en favor del grupo. Se determinaron siete reactivos como sesgados en contra de los varones afroamericanos y tres mostraron un sesgo que los favorecía. Para los demás sujetos varones, se observaron cuatro instancias de sesgo positivo y dos instancias de sesgo negativo. No se encontró ningún reactivo que estuviera sesgado de manera consistente, a pesar del el grupo étnico.

Cuando se consideraron los datos de las mujeres, se encontraron 38 instancias de sesgo de reactivos: 14 para niñas

Tabla 5-17. Resultados ANOVA para la prueba de sesgo de reactivos

Fuente	gl	MC	F
Entre			
Género	1	.77	41.28
Grupo étnico	2	.60	32.01
Género x Grupo étnico	2	.09	4.71
Error	16	.02	
Dentro			
Reactivos	27	.30	101.71
Reactivos x Género	27	.03	11.10
Reactivos x Grupo étnico	54	.01	3.78
Reactivos x Género x Grupo étnico	54	.01	2.29
Error	486	.003	

Nota. Tomado de Reynolds, Plake y Harding (1983). Para todos los casos $p < .001$.

blancas, 14 para niñas afroamericanas y 10 para otros sujetos. Para las mujeres blancas participantes se identificaron ocho reactivos que funcionan de manera negativa, mientras que seis mostraron un sesgo en favor del grupo blanco. Se reveló un cuadro idéntico para las mujeres afroamericanas: ocho reactivos funcionaron de manera negativa y seis de manera positiva. Para el grupo otros, siete de los reactivos mostraron un sesgo negativo y tres, un sesgo positivo. Se encontró que cuatro reactivos proporcionaron una respuesta sesgada entre todos los grupos étnicos y 10 mostraron sesgo para dos de los grupos étnicos.

En general, entre los participantes varones, se encontró una presentación equilibrada de dirección de sesgo de los reactivos para los grupos blanco y otros, con un ligero sesgo negativo contra los varones afroamericanos. Para el grupo de mujeres, el sesgo de alguna manera está menos equilibrado en términos generales, pero es consistente entre los tres grupos étnicos. Los resultados de los contrastes de seguimiento se resumen en la tabla 5-18.

Un ensayo en el análisis de contenido de los reactivos sesgados y no sesgados resultó infructuoso. No se presentó ningún tema consistente o similitud de contenido dentro de algún grupo que señalara un tipo característico de reactivo que fuera probable determinarlo como sesgado. Éste no es un suceso raro, y es una de las grandes frustraciones de la investigación de sesgo de reactivos en el dominio cognoscitivo. Hasta aquí, la única "característica" de los reactivos que se encontró de manera consistente como sesgada es que tienden a ser más pobres (psicométricamente) en la prueba, con menos confiabilidad y más ambigüedad que otros reactivos.

Cuando se emplea una metodología ANOVA para identificar reactivos sesgados, es importante considerar dos aspectos empíricos de los datos: la complejidad factorial y la proporción de varianza total explicada por los efectos ANOVA significativos. Como se señaló anteriormente, el análisis factorial del CMASR produce cinco factores: tres de ansiedad y dos de mentira. Por lo tanto, algo de la varianza en los datos puede atribuirse a la complejidad factorial del instrumento. También, como ya se señaló, la no equivalencia de las medias iniciales de la puntuación total de la prueba incrementa el grado de

**Tabla 5-18. Reactivos identificados como aportes a la interacción
Reactivo x Género x Grupo étnico**

Grupo	Sesgo favorable		Sesgo desfavorable	
	Número de reactivos	Reactivos	Número de reactivos	Reactivos
Varones				
Blancos	4	12, 16,, 18, 39	5	13, 15, 20, 22, 36
Negros	3	21, 22, 39	7 ^a	9, 16, 36, 43, 46, 58
Otros	4 ^a	13, 20, 43	2	12, 21
Mujeres				
Blancas	6 ^a	3, 9, 15, 18, 39	8	11, 12, 13, 22, 25, 26, 36, 46
Negras	6	12, 13, 22, 25, 27, 36	8	1, 3, 11, 15, 16, 18, 39, 47
Otras	3	7, 11, 26	7	3, 12, 27, 36, 42, 46, 47

Nota. Adaptado por Reynolds, Plake y Harding (1983). Los reactivos de Mentira se excluyeron del análisis.

^aEste número incluye el reactivo 26 del CMASR: "Me siento muy mal cuando se enojan conmigo", que fue eliminado del CMASR-2.

sesgo detectado, haciendo aún más crucial la exploración del tamaño del efecto, como el amplio tamaño de la muestra disponible. El cálculo del tamaño del efecto a partir de los resultados del ANOVA mostró que el término de interacción reactivos x grupo étnico x género explica menos de 1% de la variación total en el desempeño de la prueba. Así, aunque se encontraron efectos muy significativos estadísticamente, su relativo impacto sobre la variación de las puntuaciones de la prueba parece ser mínimo. Este tamaño del efecto es muy comparable con los encontrados en pruebas de aptitudes y logro que de manera típica varían de 2% a 5% (Jensen, 1980; Reynolds, 1982a).

La modificación en la interpretación de la puntuación de la prueba CMASR como una función del género o antecedente étnico del niño no puede recomendarse con base en el resultado de cualquiera de los estudios del CMASR a la fecha. El tamaño del efecto es lo suficientemente pequeño para considerarse insignificante, y los reactivos sesgados detectados casi se contrabalancearon entre los grupos étnicos. Otros estudios han mostrado similitud factorial del CMASR entre género y

grupo étnico para afroamericanos y blancos (Reynolds y Paget, 1981), y estimados de consistencia interna comparables para todos los grupos en el CMASR y CMASR-2.

Resumen

La confiabilidad y validez del CMASR-2 como una medida de ansiedad crónica en niños parece bien establecida por la literatura especializada existente y la investigación actual. Pocas escalas de ansiedad para niños tienen tanta confiabilidad y evidencia de validez disponible para su consideración. Obviamente, se necesita continuar la investigación. Sin embargo, basándonos en resultados pasados, el optimismo parece totalmente justificado respecto a que el CMASR-2 habrá de continuar sirviendo durante muchas décadas por venir como una medida de ansiedad con integridad psicométrica útil para los clínicos e investigadores, así como también para los niños ansiosos y sus familias.

6

Investigación sobre ansiedad y el CMASR-2

Este capítulo proporciona un panorama general de la investigación de la ansiedad que resulta pertinente para el desarrollo de la ansiedad como constructo clínico, así como para el desarrollo del CMASR y CMASR-2. Este apartado no pretende hacer una revisión de los centenares de estudios que ha usado el CMASR desde su publicación inicial, sino que más bien le ofrece al lector una visión más general de las áreas en las que se emplean. El Apéndice proporciona un listado tópico de artículos selectos que han aparecido en la literatura especializada profesional desde la publicación del CMASR.

Naturaleza de la ansiedad

En la historia no se registra ninguna época ni tampoco ningún lugar en los que el miedo y la ansiedad no hayan formado parte de la existencia humana. El miedo a los eventos perjudiciales o que amenazan la vida es una experiencia común en el mundo animal, y una respuesta adaptativa para la especie humana. En consecuencia, el niño aprende prematuramente en la vida, mediante experiencias dolorosas y de las enseñanzas de los adultos o de sus compañeros, a anticipar o a evitar circunstancias potencialmente perjudiciales.

En un libro que se publicó originalmente en 1872, Darwin (1965) sugiere que las reacciones de miedo se desarrollan a través de un proceso de selección natural; describe manifestaciones físicas específicas del miedo, y advierte que las reacciones de miedo varían desde una leve sorpresa hasta pánico o terror extremos. Desde el siglo XI se menciona a un filósofo árabe, quien sostenía que la ansiedad es una condición universal y básica de la existencia humana (Kritzech, 1956). En la misma vertiente de enfatizar la universalidad de la ansiedad, el autor de *Paradise Lost* [*El Paraíso perdido*] señaló que preocuparse es la más natural y espontánea de todas las funciones humanas (Milton, 1993). A pesar de que la ansiedad es universal, ocurre a lo largo de nuestras vidas, y en niveles inferiores sirve como fuerza de impulso o motivacional, Akiskal (1985) afirma que si se experimenta de manera repetida y con la suficiente intensidad, puede resultar una conducta inadaptada.

Un aspecto intrigante de la ansiedad es su función como fuerza movilizadora para el logro individual. Una joven estudiante de doctorado en Iowa, Janet Taylor, estaba buscando un posible tema de tesis en su investigación inicial sobre los efectos de la ansiedad manifiesta. En una publicación de un trabajo de investigación, ahora muy conocido en lo referente a la explicación científica de la ansiedad, ella reportó que la ansiedad constituía una fuerza de empuje hacia logros mayores para los participantes en su estudio (Taylor, 1951). Su trabajo

inicial fue seguido de numerosos estudios de investigadores ocupados en indagar la relación entre ansiedad y logro. Esta relación entre ansiedad y logro se aplica no solamente en el ámbito académico, sino también en el atlético, en el del desempeño, así como en otros tipos de logros. Existen diferencias individuales en el nivel de ansiedad que proporciona motivación o interferencia en relación con el logro. Es de particular importancia identificar niveles de ansiedad en niños que sean lo suficientemente elevados como para interferir con sus mejores logros posibles en lo académico y en otras áreas.

Aunque el miedo como respuesta a la amenaza se considera por lo general adaptativo, en algunas instancias la ansiedad puede actuar en detrimento del funcionamiento efectivo del individuo. El nivel de ansiedad del individuo puede ser tan alto, que le resulta imposible tomar decisiones o emprender acciones adecuadas para resolver un problema. Claramente, los altos niveles de ansiedad pueden interferir en los procesos de pensamiento racional y lógico. En este caso, la ansiedad se convierte en un problema que quienes están interesados en el bienestar de los niños en edad escolar deben tratar de aliviar. Puede ser necesario involucrar a maestros, psicólogos escolares, orientadores y padres de familia, así como a terapeutas profesionales o médicos ajenos a la escuela, para proporcionar asesoría con el fin de resolver los problemas del niño asociados con ansiedad.

Spielberger (1972) distingue entre estrés, amenaza y ansiedad. Este autor apunta que "el estrés se refiere a las propiedades objetivas estimulantes de una situación; la amenaza, a una percepción idiosincrásica de un individuo de una situación particular como física o psicológicamente peligrosa" (p. 30). En contraste, la ansiedad estado, como la describe Spielberger, es una reacción emocional que se evoca cuando el individuo percibe una situación específica como amenazante, sin importar si existe algún peligro presente. El estrés se ha convertido en un término tan popular en el siglo XXI, que con frecuencia se utiliza, en especial en la literatura popular en boga, como sinónimo de ansiedad. Una autoridad tan reputada como el *DSM-IV-TR* clasifica un tipo de ansiedad como Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD). Sin embargo, el estrés se entiende mejor como una interacción entre ansiedad y circunstancias especiales del entorno. Por ejemplo, conducir un coche puede ser una experiencia placentera en el campo, pero muy estresante en el tráfico denso de una superavenida. La investigación científica requiere de definiciones cuidadosas tanto de la ansiedad como del estrés en una investigación de estos constructos.

La emoción de miedo o de ansiedad como reacción a un estímulo amenazante externo puede inducir al individuo a em-

prender una acción rápida y a veces drástica para evitar una situación perjudicial. Las respuestas fisiológicas del organismo, como un incremento en el flujo de adrenalina, palpitaciones aceleradas del corazón, aumento en la transpiración y otros cambios, señalan el intento de confrontar o de escapar de la amenaza. Sin embargo, cuando el incidente percibido como amenazante no lo es en realidad, entonces el estado emocional de ansiedad es una conducta inadecuada y constituye una respuesta de inadaptación al medio. Una respuesta normal al miedo puede ocurrir cuando alguien aparece en el salón de clases empuñando un arma; sin embargo, un estado de ansiedad ocurre cuando un estudiante tiene un fuerte miedo de que alguien pueda aparecer en el salón de clases empuñando un arma.

En algunas instancias, el entrenamiento que se proporciona a un niño o a un adulto se calcula para que éste aborte una respuesta natural de miedo, como un esfuerzo para lograr que el individuo se involucre en situaciones que amenazan la vida. A menudo, a los muchachos se les instruye o se les condiciona para no expresar ansiedad. Las fuerzas militares, la policía y otras ocupaciones peligrosas enseñan a sus empleados a manejar las situaciones productoras de ansiedad sin expresar miedo. En general, con frecuencia se considera inapropiado que los varones expresen miedo o ansiedad, mientras que a las mujeres se les permite expresar estas emociones más libremente.

Una serie de eventos desastrosos ocurridos en la primera mitad del siglo XX dieron lugar a un incremento general en la ansiedad a escala mundial. En un periodo de aproximadamente 30 años hubo dos guerras mundiales; la Gran Depresión, que dejó a millones de personas en la pobreza; un holocausto que provocó un genocidio a una escala nunca antes experimentada; y el desarrollo y uso de armas nucleares, que provocó miedo en la gente del mundo entero por la destrucción de la humanidad y tal vez de nuestro planeta. Estos eventos, junto con un acelerado crecimiento del interés por el estudio científico de la conducta humana, dieron lugar a un creciente interés por la investigación y el tratamiento de la ansiedad en adultos y en niños.

A mediados del siglo XX, personalidades de la literatura, psicólogos y filósofos se refirieron a esta centuria como la "época de la ansiedad". Auden (1947), en su conocido poema titulado "The Age of Anxiety", describe los sentimientos realzados de soledad y de incapacidad de amar como indicadores de ansiedad. Muchos de los escritores, poetas, sociólogos y filósofos que observaron la creciente ansiedad del siglo XX atribuyeron su aumento a la creciente incertidumbre y a la interferencia burocrática con los esfuerzos del individuo hacia su autorreconocimiento y autorrealización.

Psicólogos, orientadores y terapeutas también estuvieron conscientes del aumento de la ansiedad, ya que cada vez más pacientes suyos aparecían con enfermedades relacionadas con ella. Debido a esto, se desarrolló un volumen considerable de investigación y teoría en el siglo XX, especialmente después de la segunda guerra mundial, en un esfuerzo por entender las causas y tratar los efectos de la ansiedad. Estos psicólogos, orientadores y terapeutas, así como maestros y padres de familia, se volvieron cada vez más conscientes de los efectos de la ansiedad en los logros académicos de los niños y en su posterior estado de salud psicológico y fisiológico. Los niños y

los adultos siguen siendo un foco de atención de los esfuerzos en investigación y tratamiento, en la medida en que influencias amenazadoras persistan en nuestro entorno. El siglo XXI ha sido testigo de un aumento del sida, de muertes y lesiones imputables a armas de fuego, y de violencia en el hogar y en las calles. Los ataques mortales a niños en las escuelas, a menudo perpetrados por otros estudiantes, aumentan nuestra necesidad de comprender las causas y tratar los efectos de la ansiedad en niños.

May (1977) describe la ansiedad como una respuesta humana dirigida a reducir o destruir fuerzas como la agresión, la fatiga, el aburrimiento y la muerte. En palabras de May, la ansiedad es la "experiencia del ser afirmándose a sí mismo en contra del no ser" (p. xv). May presenta una diversidad de interesantes antecedentes filosóficos, culturales y psicológicos de la ansiedad, y ofrece un registro del incremento de la ansiedad en el mundo entero. Este autor discute también el tratamiento de la ansiedad desde el marco de los psicoterapeutas y otros profesionales que colaboran en una relación de ayuda. Kierkegaard (1944) señala en su obra del siglo XIX que aventurarse provoca ansiedad, y May concluye que "los aspectos positivos de la personalidad se desarrollan en la medida en que el individuo confronta, se desplaza a través de ellas y supera las experiencias generadoras de ansiedad" (p. 393).

Tanto Kierkegaard como May parecen estar ensalzando el potencial para el crecimiento humano que emana de una respuesta satisfactoria a un incidente que produce ansiedad. En efecto, existe una cantidad considerable de teoría y algunas evidencias que sugieren que la creatividad es un antídoto para la ansiedad (Torrance, 1965). Tal vez a partir de esta suposición puede deducirse que la ansiedad proporciona el estímulo que provoca un enfoque creativo para la resolución de problemas. Muchos psicólogos y educadores en la actualidad describen una relación curvilínea entre el aprendizaje y la ansiedad, en donde niveles de ansiedad muy altos y muy bajos se relacionan negativamente con el aprendizaje, lo que resulta en la bien conocida curva con forma de "U" invertida entre la ansiedad y el desempeño en tareas complejas. Como lo sugería alguna vez un comercial de televisión, todo el mundo necesita un poco de ansiedad en la vida.

Frankl (1963) presenta las bases de la ansiedad existencial. Una pérdida del sentimiento de que la vida es valiosa y la comprensión de que la vida humana es finita, contribuyen al estado continuo de ansiedad. Este autor advierte también que la tensión resultante de los esfuerzos de una persona por encontrar significado a la vida es una forma de estimular y producir ansiedad. La ansiedad anticipatoria, sin embargo, en la que el individuo teme que ocurra un evento desagradable, a menudo provoca que tal evento ocurra. Por ejemplo, la persona que tiene miedo de hablar frente a un grupo debido a que le puede temblar la voz puede sufrir angustia grave justo antes del discurso y descubrir entonces que su voz efectivamente tiembla. Frankl halló que a menudo la intención paradójica era una técnica logoterapéutica efectiva para liberar a la persona de este tipo de ansiedad anticipatoria.

En años recientes, los psicólogos de la conducta han descartado el concepto de ansiedad como un estado emocional. Ellos prefieren examinar la ansiedad en términos de un estímulo o condición específicos bajo los cuales ocurre. Por ejemplo,

la ansiedad causada por las pruebas se debe a que la persona que la realiza tiene miedo de obtener malos resultados. El pánico escénico, las matemáticas, las relaciones románticas y las figuras de autoridad son otros estímulos que generan ansiedad para muchas personas, por lo cual han sido examinados con frecuencia.

Otros psicólogos consideran a la ansiedad no como una respuesta o una emoción, sino como una interrelación compleja de emociones o rasgos humanos. Cattell (1966) y Cattell y Scheier (1961) describen la ansiedad como un factor de segundo orden. Los componentes de primer orden de la ansiedad incluyen debilidad del ego, tensión érgica, propensión a sentir culpa, integración defectuosa del autosenntimiento y pretensión o sospecha. Estos términos pueden parecer más vagos y confusos que la noción de ansiedad, que tiene un valor comunicativo más universal. Sin embargo, Cattell y sus colegas ponen de manifiesto que la ansiedad es un concepto complejo y posee numerosos orígenes y múltiples métodos de expresión. Izard (1972) ofrece mayor claridad y especificidad en su definición de ansiedad como una "combinación variable de emociones fundamentales de angustia, ira, vergüenza (incluye timidez y culpa) e interés-entusiasmo" (p. 102). Su tesis principal es que la ansiedad no es un concepto unitario, sino más bien una mezcla compleja de emociones y sus interacciones con antecedentes en aspectos culturales, de aprendizaje, psicológicos y fisiológicos del individuo.

Gottschalk y Gleser (1969) también contemplan la ansiedad como un concepto multimodal. La describen, desde la perspectiva de su trabajo clínico con clientes, como clasificable en seis categorías: muerte, mutilación, separación, culpa, vergüenza y ansiedad difusa o no específica. Aparentemente, cada una de estas categorías puede asociarse con sentimientos de ansiedad graves en el individuo que busca ayuda a través de orientación o terapia.

Katz y Zigler (1967) relacionan los aspectos tanto de autoconcepto como de culpa con la ansiedad. En sus conceptualizaciones, el individuo puede percibir una brecha cada vez más ancha entre el yo ideal y el yo real conforme la edad aumenta. En determinada etapa del desarrollo, a menudo en la adolescencia o al comenzar la edad adulta, el individuo puede sentir culpa y ansiedad por no lograr lo que esperaba alcanzar. Como lo comprende la mayoría de los clínicos, este fenómeno de sentir culpa a causa de las metas no alcanzadas puede presentarse también posteriormente en la vida en los últimos años de una carrera profesional. Maher (1966) y Spielberger (1979) aluden también a la culpa como forma o instancia social de la ansiedad. En contraste con quienes equiparan la ansiedad y la culpa, Mosher (1966) las describe como conceptos relacionados, cada uno con un cierto grado de autonomía. Este autor informa acerca de una medida de la culpa que correlaciona .65 con la *Taylor Manifest Anxiety Scale* (Taylor, 1951). Si bien dos medidas de ansiedad por lo general se correlacionan más alto que .65, el autor sostiene que la culpa, a pesar de estar relacionada con la ansiedad, no es la misma emoción.

Sullivan (1953) parece describir la ansiedad desde el punto de vista del cliente, cuando reconoce que ésta se caracteriza por un sentimiento, siempre desagradable, de que "nada está saliendo bien" (p. 378). Este autor refiere también, como lo hacen muchos cronistas de la ansiedad, que las expresiones

faciales, los temblores de la voz, la sudoración de las manos, las sensaciones de músculos tensos y un malestar en la boca del estómago pueden indicar la presencia de un estado de ansiedad. También menciona la naturaleza compleja de la ansiedad y comenta sobre su relación con la vergüenza, la culpa y la timidez.

Aunque no existe un acuerdo universal en la actualidad sobre una definición de la ansiedad, hay algunos aspectos comúnmente aceptados de este concepto. Por ejemplo, la noción expresada en el siglo pasado por Freud (1924) de que la ansiedad es algo que se siente como un estado afectivo desagradable o una condición que es una respuesta simple a un estímulo, a un estado emocional o a una interacción compleja de varias emociones, constituye un debate candente entre los promotores de diversas posturas teóricas. A pesar de que esta definición descriptiva puede parecer vaga en la superficie, la ansiedad es de manera incuestionable algo que todos conocemos, experimentamos y reconocemos en nosotros mismos y con frecuencia en otros. La ansiedad es un fenómeno universal de la humanidad. ¿Sabemos muy bien cuándo la sentimos!

Teóricos e investigadores que analizan la naturaleza de la ansiedad, por lo general están de acuerdo también en que el concepto debe distinguirse del de miedo. El miedo es una respuesta inmediata a una situación amenazante que probablemente se haya desarrollado a través del proceso de selección natural de las especies humana y animal. La ansiedad, sin embargo, puede ocurrir sin que exista ninguna amenaza real para el individuo. Esta percepción frecuente de amenaza, en particular cuando no existe ninguna amenaza física o psicológica real, puede crear un estado de ansiedad que interfiera seriamente en la efectividad del individuo en sus actividades diarias, y puede perturbar los procesos de pensamiento normales.

La ansiedad se entiende también como un rasgo de la personalidad en algunos individuos. Esta idea sugiere que se trata de un aspecto más permanente del modo de funcionar del individuo. Si el estado de ansiedad se suscita o no en un momento determinado, depende de la situación dada y del estímulo provocador. La ansiedad rasgo, no obstante, describe la personalidad de un individuo que experimenta ansiedad frecuentemente, a menudo cuando la fuerza del estímulo que despierta la ansiedad es relativamente débil. La ansiedad rasgo se refiere a la propensión del individuo a sentir ansiedad. Al parecer, este rasgo varía, con base en informes clínicos, desde infrecuente en algunas personas hasta una experiencia casi constante de ansiedad en otras, y tiene una base amplia, no específica de un episodio breve o de una situación altamente específica.

En las experiencias individuales de ansiedad hay muchas diferencias significativas. Información preponderante avala la realidad de que las mujeres expresan más ansiedad que los varones. Esto puede deberse en parte a que a las mujeres se les motiva más a que expresen sus emociones que a los varones. Algunos investigadores sostienen que la ansiedad ocurre en gran parte como respuesta a circunstancias del entorno, mientras que otros describen a algunas personas sujetas a un estado de ansiedad más permanente. Diversas explicaciones de la ansiedad se concentran en sus componentes emocionales, y otras enfatizan los antecedentes cognitivos, fisiológicos y/o ambientales de la ansiedad. Es probable que exista algún

elemento de verdad en cada teoría, pero hasta ahora nadie tiene la respuesta final ni en lo que se refiere a la causa, ni al tratamiento de la ansiedad. El surgimiento del fenómeno de la ansiedad computacional (Brosnan, 1998; Yaghi y Bentley Abu-Saba, 1998), que probablemente apareció por primera vez en la década de 1970, pero que ha continuado hasta este siglo, avala la probabilidad de que la ansiedad puede cambiar en la medida en que cambia nuestro entorno. Sin embargo, todos aquellos cuyo trabajo profesional involucra el tratamiento de factores de ansiedad persisten en afirmar que normalmente algunas personas son más ansiosas que otras.

La psicología del desarrollo humano también deja en claro que el organismo humano cambia con la edad y con las circunstancias ambientales. Obviamente, los niños reflejan las condiciones de sus hogares, las presiones de sus compañeros y el apoyo y la instrucción de los padres. Por eso, es necesario comprender la naturaleza y la extensión de la ansiedad, y su tratamiento puede cambiar en la medida en que cambian las metas, las necesidades, los recursos, las habilidades y las limitaciones de un individuo. Para los niños de corta edad, las experiencias con los padres y en el hogar son normalmente sus influencias ambientales más significativas. Los estilos de paternidad, el nivel de ansiedad de los padres y la buena voluntad para confiar y para tolerar la ambigüedad son factores que pueden influir en la resiliencia temprana del niño al confrontar las experiencias que provocan ansiedad. Al llegar a la adolescencia, los niños pueden estar más influidos por sus compañeros que por sus padres, y sus niveles de ansiedad pueden estar más interrelacionados con experiencias sociales fuera del hogar.

El hogar parece ser un aspecto central en la inclinación prematura del niño a la inhibición de la conducta, lo cual está correlacionado con trastornos de ansiedad posteriores, especialmente con la ansiedad social. La inhibición de la conducta es la tendencia a mostrar recelo al enfrentar eventos o situaciones inéditos, incluyendo habitaciones, juguetes, compañeros y adultos desconocidos (Hirshfeld-Becker, Biederman y Rosenbaum, 2004). Esta inhibición de la conducta por parte del niño de corta edad desemboca normalmente en fuertes sentimientos de angustia de separación cuando el niño entra a la escuela.

Tanto factores genéticos como ambientales se consideran como influencias en el desarrollo de trastornos de ansiedad en el niño ("Children's Fears and Anxieties", 2004). En estudios tanto de gemelos como de casos de adopción que proponen a la herencia como uno de los factores en el desarrollo de la ansiedad, se reporta que la inhibición de la conducta se presenta ya desde los cuatro meses de edad. El niño no solamente se retrae ante los desconocidos, sino que también su corazón empieza a latir más de prisa, y la amígdala, un órgano del cerebro que a menudo se asocia con el miedo, la ansiedad y la expresión de emociones, muestra un alto nivel de actividad.

Algunas de las investigaciones más promisorias, de hoy y para la futura comprensión de la ansiedad, radican en estudiar la relación entre el comportamiento del cerebro y la ansiedad. La amígdala, que consiste de dos pequeños órganos con forma de almendra en el cerebro, parece estar involucrada de manera activa en la expresión o inhibición de la ansiedad. Como lo reportaron Miham *et al.* (2005), los pacientes pediátricos con

trastornos de ansiedad revelaron reducción en la materia gris de la amígdala izquierda al ser comparada con la de niños sin ansiedad.

Otro estudio, que analizó a los participantes y su relación con el miedo, reveló a través de las imágenes de resonancia magnética que la amígdala estaba involucrada de manera más importante en contextos emocionales negativos (Hare, Tottenham, Davidson, Glover y Casey, 2005). En la medida en que continúan acumulándose evidencias con respecto al papel que desempeña la amígdala en la ansiedad, la depresión, el abuso de sustancias y otras experiencias emocionales negativas, aumentan las oportunidades para un tratamiento más efectivo de estas condiciones.

Medición de la ansiedad manifiesta

Debido a que la ansiedad es una experiencia incisiva, sin que aparentemente tengan que ver con ello las circunstancias culturales, intelectuales, sociales o económicas de una persona, existe un esfuerzo considerable para medir su ocurrencia y su intensidad. Desde la perspectiva de Martin (1961), la ansiedad es un complejo de respuestas neuropsicológicas, y tanto éstas como los estímulos que las provocan deben ser medidos para comprenderla.

A partir de una amplia revisión de la literatura especializada en psicología y psiquiatría, Krause (1961) reporta que la ansiedad se infiere, por lo general, de (a) autoinformes, (b) indicios fisiológicos, (c) conducta (como postura corporal, habla, inquietud), (d) desempeño de tareas, (e) intuición clínica y (f) respuesta al estrés. Este autor registra también que el autoinforme se usa con mayor frecuencia para describir la ansiedad que experimenta un individuo.

Taylor (1951) reporta uno de los primeros esfuerzos al obtener una medida objetiva por separado de la ansiedad. Esta autora seleccionó reactivos del *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI; Hathaway y McKinley, 1943) para constituir una *Manifest Anxiety Scale* (MAS). Su teoría era que la ansiedad manifiesta era una medida del impulso, y por lo tanto las personas que reportaran niveles de ansiedad altos deberían de alcanzar logros más altos que las personas que reportaran menos ansiedad. Taylor sometió a 30 estudiantes con puntuaciones altas en la MAS y a 30 estudiantes con puntuaciones bajas a un experimento que condicionaba las respuestas de los párpados. Su descubrimiento de que los participantes más ansiosos eran superiores en cuanto a la cantidad de condicionamiento exhibido ofreció apoyo a su teoría de que la ansiedad se relaciona con el impulso y la motivación.

Numerosos estudios siguieron al trabajo inicial de Taylor, en la medida en que los investigadores fueron usando su MAS recientemente desarrollada para medir la ansiedad en la población adulta. Unos cuantos años después, Castaneda, McCandless y Palermo (1956) reportaron una versión para niños de la MAS, a la que llamaron *Escala de ansiedad manifiesta en niños* (CMAS). En esencia, la CMAS utilizó reactivos de la MAS, pero éstos fueron reformulados con el fin de hacerlos más adecuados para niños. A un total de 386 niños del 4o. al 6o. grados se les aplicó el CMAS, lo cual arrojó un factor general de ansiedad y una escala de Mentira. En este estudio

inicial, las muchachas tuvieron puntuaciones más altas que los muchachos, tanto en el factor de ansiedad como en la escala de Mentira. Los alumnos de sexto grado tuvieron puntuaciones más bajas que los de cuarto y quinto en la escala de Mentira, pero no hubo otras diferencias entre grados.

Un estudio relacionado que publicó al mismo tiempo Castaneda, Palermo y McCandless (1956) utilizó el CMAS para determinar si la ansiedad estaba relacionada con la dificultad de las tareas en una tarea de aprendizaje complejo. El estudio incluyó a 15 niños y 22 niñas de quinto año, divididos de manera más o menos igual en cuanto a haber reportado alta ansiedad o baja ansiedad en el CMAS. Los resultados de este estudio revelaron una interacción significativa entre la ansiedad y la dificultad de la tarea. Esta interacción se basó en la tendencia del desempeño de niños altamente ansiosos a ser inferior que el de niños menos ansiosos en los componentes difíciles de la tarea. Sin embargo, los niños más ansiosos superaron a los menos ansiosos en los componentes menos difíciles de la tarea.

El CMAS original fue sumamente popular como instrumento clínico y de investigación. Más de 100 artículos aparecieron en la literatura especializada a lo largo de dos décadas que avalaron la utilidad del CMAS. En nuestra propia experiencia en clínica para niños con problemas emocionales, el CMAS fue útil para identificar la extensión y la naturaleza específica de la ansiedad experimentada por niños.

Varias críticas en el CMAS original surgieron cuando se tomó la decisión de desarrollar el CMASR en 1978. Por ejemplo, hubo maestros que protestaron debido a que algunas de las palabras eran demasiado difíciles y a que determinadas áreas de la ansiedad no eran evaluadas por el CMAS. Maestros e investigadores querían un instrumento que pudiera ser usado a lo largo de todo el ciclo escolar, del 1o. al 12vo, grados. Las críticas cada vez más copiosas por parte de investigadores y psicometristas eran en el sentido de que los reactivos no cumplían con todos los criterios de un buen reactivo de prueba. Debido a lo anterior, la revisión del CMAS se llevó a cabo para tratar todas estas preocupaciones (Reynolds y Richmond, 1978).

Revisión de la investigación que utiliza el CMASR

La popularidad del CMASR para su uso con estudiantes en edad escolar ha resultado en centenares de reportes de investigación y opinión con respecto a su utilidad. Como reportan Silverman y Treffers (2004), el CMASR es uno de los cuestionarios más ampliamente utilizados en la investigación para el tratamiento de la ansiedad en niños. James, Reynolds y Dunbar (1994) proporcionan información similar con respecto a la frecuencia de uso del CMASR.

Otros estudios informan acerca del análisis factorial del CMASR (Stark y Laurent, 2001); de la validez del CMASR (Pavuluri, Henry y Allen, 2002); y de la validez concurrente del CMASR en relación con una variedad de medidas de psicopatología (Lee y Piersel, 1987; Lee, Piersel y Unruh, 1989; Seligman, Ollendick, Langley y Baldacci, 2004). Lee, Piersel, Grindlander y Collamer (1988), que compararon el CMASR con los perfiles de adolescentes del MMPI, concluyen que el CMASR

es una medida de ansiedad válida para adolescentes. Otros numerosos estudios reportan acerca de la confiabilidad y otras fortalezas relevantes del CMASR (Dadds, Perrin y Yule, 1998; Hagborg, 1991; Hooper, Richmond y McChesney, 1987; Lee y Piersel, 1987; Merrell, Anderson y Michael, 1997; Ryngala, Shields y Caruso, 2005; Sheftall, 1987; y Wisniewski, Mulick, Genshaft y Coury, 1987).

El CMASR ha encontrado también un uso considerable en la validación de otras escalas nuevas. Por ejemplo, Kamps, Roberts y Varela (2005) emplearon el CMASR como la medida principal para examinar la validez de la *Fear of Hypoglycemia Scale*. Ólason, Sighvatsson y Smámi (2004) evaluaron la validez transcultural de la *Multidimensional Anxiety Scale for Children* usando el CMASR como variable clave de criterio. La administración y la validez de constructo de la *Social Anxiety Scale for Adolescents* fue evaluada por Inderbitzen-Nolan y Walters (2000) al utilizar el CMASR como variable clave de criterio. Muris et al. (1998) investigaron la validez de la *Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders* (SCARED) y determinaron una relación positiva y teóricamente significativa con el CMAS. El CMASR ha sido una medida popular para ser usada en disertaciones que evalúan también la validez de otras escalas —incluso escalas multidimensionales complejas, como el *Millon Adolescent Clinical Inventory* (p. ej., ver Carrillo, 2005). Estos estudios sirven únicamente para destacar que el CMASR se ha convertido en un estándar ampliamente aceptado para evaluar ansiedad en niños y para la evaluación de la validez y la utilidad de otras escalas diseñadas para medir los mismos constructos u otros similares. Existen muchos otros estudios de este tipo, pero solamente hemos destacado aquí algunas de las aplicaciones más interesantes.

El CMASR ha encontrado un extenso uso en la evaluación de los efectos de tratamiento y ha demostrado ser sensible a los cambios en los niveles de ansiedad de niños y adolescentes. Chemtob, Nakashima y Carlson (2002), por ejemplo, reportan reducciones sustanciales en las puntuaciones del CMASR de niños con PTSD relacionado con un desastre, incluso después de un tratamiento breve aunque dirigido. Se descubrió que el diagnóstico de PTSD en niños y adolescentes se facilitaba con el hallazgo de puntuaciones del CMASR elevadas en múltiples estudios realizados por Saigh (1989, 1991). Se ha demostrado que las puntuaciones del CMASR fluctúan como respuesta a niveles de plaquetas de oxidasa monoamina y otros indicadores con base en plasma de los estados de ansiedad (p. ej., ver Pliszka, Rogeness y Medrano, 1988). Ladd (2000) reporta decrementos generales significativos en las puntuaciones del CMASR de adolescentes después de tan solo cinco horas de capacitación en técnicas cognitivas diseñadas para mejorar el autocontrol de los adolescentes y para que adquieran habilidades para sobrellevar altos niveles de ansiedad generalizada. Seligman et al. (2004), en un artículo de revisión, concluyeron que el CMASR es efectivamente sensible a los beneficios del tratamiento de pacientes niños y adolescentes dominados por la ansiedad.

Niños y adolescentes de educación especial también han sido el foco de atención de una variedad de estudios que emplean el CMASR, lo cual no es de sorprender, dada la popularidad de este instrumento en escenarios escolares. Algunos de los estudios más interesantes al respecto incluyen la eva-

luación de los efectos de inclusión en los niveles de ansiedad entre niños que participan en programas de educación especial (Snowden, 2004), el rango general de los niveles de ajuste y ansiedad entre los hermanos y hermanas de niños con discapacidades crónicas (Lyons-Sjostrom, 2004) y los niveles de ansiedad de niños con diagnóstico de una discapacidad de aprendizaje específica que estaban recibiendo instrucciones de rehabilitación. También han sido reportados estudios de poblaciones con una discapacidad altamente específica, por ejemplo, la identificación y medición de ansiedad y de tendencias obsesivo-compulsivas en niños y adolescentes con diagnóstico de Síndrome de Williams (Cook, 2000) y trastorno de apoplejía (Williams *et al.*, 2003).

Otras investigaciones que emplean el CMASR para diversos propósitos abarcan un amplio rango de intereses. Como ejemplos, apuntaríamos el uso del CMASR en el estudio de la relación entre ansiedad rasgo y dependencia de la nicotina en adolescentes (DiFranza *et al.*, 2004); en el estudio de cambios en los niveles de ansiedad durante programas de control de peso para niños y adolescentes con sobrepeso (Brehm, Rourke, Cassell y Sethuraman, 2003); en la evaluación de los niveles de ansiedad de niños que perdieron a uno de los dos padres recientemente y la manera en que se adaptan con el tiempo (Kalter *et al.*, 2002-2003); en una evaluación sistemática de los miedos y los niveles de ansiedad de niños que tienen compañeros imaginarios crónicos (Bouldin y Pratt, 2002); en estudios comparativos de ajustes generales y niveles de ansiedad de niños de la calle contrapuestos a niños que anteriormente habían vivido en la calle y a los que nunca fueron niños de la calle (Menke y Wagner, 1997); en el ajuste en segundos matrimonios (Singleton-Winston, 2003); en estudios de percepción de expresión facial de emoción como una función del nivel de ansiedad (Dingwall, 1997); e incluso en la evaluación de los niveles de ansiedad relativa de estudiantes de escuelas públicas en comparación con los de estudiantes de escuelas católicas (Johnson, 2004).

Es evidente, a partir del extenso uso del CMASR por parte de educadores, psicólogos, orientadores y otros profesionales que trabajan con niños, así como de los resultados de numerosos estudios de investigación, que el CMASR sigue siendo un instrumento útil en la comprensión y el tratamiento de los problemas de ansiedad que experimentan los estudiantes.

El CMASR también se utiliza ampliamente en estudios transculturales que buscan comprender las semejanzas y diferencias en la expresión de la ansiedad en niños (Boehnke, Silbereisen, Reynolds y Richmond, 1986; Ferrando y Aguilar,

1992; Ginter, Glauser y Richmond, 1994; Ginter, Lufi, Troitzky y Richmond, 1989; Richmond, 1990; Richmond, Sukemune, Ohmoto, Kawamoto y Hamazaki, 1984; y Rodrigo y Lusiardo, 1992). La aceptación del CMASR como medida de ansiedad en países no angloparlantes ha llevado al desarrollo de una versión en idioma español del CMASR (Reynolds y Richmond, 1997; Richmond, Rodrigo y de Rodrigo, 1988) y también una versión en francés (Reynolds y Richmond, 1999; Turgeon y Chartrand, 2003).

Además de lo extenso de la investigación y del uso del CMASR a nivel internacional, el instrumento ha recibido apoyo para evaluar la ansiedad entre estudiantes de culturas y grupos étnicos diferentes dentro de Estados Unidos. Mennen (2004) reporta el uso del CMASR con alumnos latinoamericanos. White, Brure, Farrell y Kliever (1998) refieren su utilidad con alumnos afroamericanos, al igual que Cooley-Quille, Boyd, Frantz y Walsh (2001); Varela *et al.* (2004); y Silverman y La-Greca (1995). Cole, Hoffman, Tram y Maxwell (2000) señalan una correlación positiva entre las calificaciones del niño y de sus padres acerca del nivel de ansiedad del niño. En esencia, el CMASR sostiene su validez como medida de ansiedad en estudiantes en edad escolar entre un amplio rango de experiencias económicas, culturales y sociales. De manera consistente, el CMASR concuerda con otra literatura especializada en ansiedad en que la ansiedad manifiesta se expresa generalmente en un nivel más elevado para mujeres que para varones, y que la ansiedad conlleva una relación positiva o comorbilidad con determinados problemas físicos, depresión y otros trastornos psicosociales.

Si usted desea traducir o adaptar de otra manera el CMASR-2, debe contactar al Rights and Permissions department de Western Psychological Services (800-648-8857) antes de proceder con la labor. Aparte del requisito legal, este proceso ofrece la posibilidad de que WPS pueda estar al tanto de adaptaciones aprobadas de manera similar que ya se encuentren disponibles o que estén en vías de publicación. Los datos comparativos relevantes pero sin publicar pueden ser revelados también de este modo. Este proceso sirve para extender la generalización de los resultados que usted obtenga y para mantener la integridad colectiva del cuerpo medular de investigación que sustenta el uso del CMASR-2 en escenarios de investigación y clínicos. Se anticipa que en investigaciones futuras el CMASR-2 seguirá contribuyendo de manera significativa, como lo hizo su antecesora, a la comprensión de la ansiedad de niños y adolescentes, y al desarrollo de nuevas y efectivas modalidades de tratamiento en este campo.

7

Proceso de estandarización en México

El proyecto de estandarización de la escala CMASR-2 inició con la traducción del manual de aplicación y el autoinforme de 49 reactivos, una vez traducido se llevó a cabo la revisión y adaptación al lenguaje así como la formación del cuestionario-perfil para la versión mexicana de estandarización.

Con la finalidad de tener un instrumento confiable y válido para población mexicana, se decidió realizar la estandarización de esta nueva edición del CMASR-2, siguiendo los procedimientos de aplicación y análisis de los reactivos con respecto a la puntuación total de ansiedad para evaluar la sensibilidad de los mismos en población infantil y juvenil, asimismo se realizó un análisis de factores mediante las técnicas estadísticas tradicionales para estudiar el desempeño de los reactivos en cuanto a su homogeneidad y correlaciones, con el objetivo de contar con un instrumento que evalúe ansiedad debidamente adaptado y con propiedades de confiabilidad y validez acordes con las características de niños y jóvenes mexicanos.

Para la estandarización a población mexicana del CMASR-2 se consideró una muestra total de 2 490 niños y jóvenes de ambos géneros (1 311 mujeres y 1 179 varo-

nes, respectivamente). Se tomaron en consideración para la muestra nacional los intervalos de edad propuestos para el CMASR-2 de EUA, además de la inclusión de muestras homogéneas de cada estado: Norte (n = 633, donde Monterrey -188-, Tamaulipas -195- y Chihuahua -250-), Centro (n = 1673, donde Estado de México -198-, Jalisco -195-, Michoacán -195- y Ciudad de México -1085-) y Sur (Veracruz -184-), con una representación por tipo de escuela: pública (1 237) o privada (1 253).

Un primer paso para el desarrollo del proceso de estandarización fue realizar un análisis de reactivos para medir su consistencia con la puntuación total y el cálculo de la confiabilidad de dicho instrumento. En la tabla 7-1 se presentan los resultados del análisis de reactivos, donde se aprecia que 12 de ellos (1, 5, 14, 19, 20, 24, 25, 28, 30, 39, 45 y 47) presentaron una relación por debajo de .30, sin embargo, no afectan sustancialmente la confiabilidad total del CMASR-2, razón por la cual se consideró pertinente mantenerlos en la revisión para la estandarización mexicana. Además, el análisis de confiabilidad alfa de Cronbach permitió comprobar su confiabilidad (Alfa = .868).

Tabla 7-1. Análisis de reactivos del CMASR-2, estandarización mexicana

Reactivo	Media de la escala si se elimina el reactivo	Varianza de la escala si se elimina el reactivo	Correlación reactivo-total corregida	Alfa de Cronbach si se elimina el reactivo
1. Muchas veces siento asco o náuseas	28.97	68.373	.272	.866
2. Soy muy nervioso(a)	29.27	66.997	.388	.864
3. Muchas veces me preocupa que algo malo me pase.	29.37	67.273	.366	.865
4. Tengo miedo que otros niños(as) se rían de mí durante la clase.	29.01	67.148	.429	.864
5. Tengo demasiados dolores de cabeza.	28.98	68.886	.196	.867
6. Me preocupa no agradarle a los otros.	29.05	67.419	.369	.865
7. Algunas veces me despierto asustado(a).	29.04	67.961	.302	.866
8. La gente me pone nervioso(a).	29.06	67.357	.373	.865
9. Siento que alguien va a decirme que hago mal las cosas.	29.13	66.863	.418	.864
10. Tengo miedo que los demás se rían de mí.	29.02	67.122	.423	.864
11. Me cuesta trabajo tomar decisiones.	29.29	67.229	.361	.865
12. Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no salen como yo quiero.	29.31	67.421	.338	.865
13. Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí.	29.09	67.072	.404	.864
*14. Todas las personas que conozco me caen bien.	29.17	69.405	.094	.870
15. Muchas veces siento que me falta el aire.	28.97	67.974	.330	.865

Tabla 7-1. Análisis de reactivos del CMASR-2, estandarización mexicana (continuación)

Reactivo	Media de la escala si se elimina el reactivo	Varianza de la escala si se elimina el reactivo	Correlación reactivo-total corregida	Alfa de Cronbach si se elimina el reactivo
16. Casi todo el tiempo estoy preocupado(a).	28.95	67.641	.400	.864
17. Me siento mal si la gente se ríe de mí.	29.16	67.070	.386	.864
18. Muchas cosas me dan miedo.	29.03	67.386	.384	.864
*19. Siempre soy amable.	29.09	66.759	.182	.868
20. Me enoja con facilidad.	29.23	68.300	.227	.867
21. Me preocupa lo que mis papás me vayan a decir.	29.35	67.760	.301	.866
22. Siento que a los demás no les gusta cómo hago las cosas.	29.06	66.942	.430	.864
23. Me da miedo hablar en voz alta ante mis compañeros durante la clase.	29.04	67.384	.381	.864
*24. Siempre me porto bien.	29.31	68.942	.150	.869
25. En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a).	29.17	67.946	.275	.866
26. Me preocupa lo que la gente piense de mí.	29.07	66.877	.437	.863
27. Me siento solo(a) aunque esté acompañado(a).	28.97	67.546	.399	.864
28. En la escuela se burlan de mí.	28.91	68.340	.323	.866
*29. Siempre soy bueno(a).	29.23	68.572	.193	.868
30. Es muy fácil herir mis sentimientos.	29.13	67.080	.391	.864
31. Me sudan las manos.	29.22	68.031	.260	.867
32. Me preocupa cometer errores delante de la gente.	29.32	66.686	.432	.863
*33. Siempre soy agradable con todos.	29.14	66.646	.190	.868
34. Me canso mucho.	29.09	67.395	.360	.865
35. Me preocupa lo que va a pasar.	29.26	66.676	.428	.863
36. Los demás son más felices que yo.	28.94	67.929	.363	.865
37. Temo hablar en voz alta delante de un grupo.	29.07	67.218	.388	.864
*38. Siempre digo la verdad	29.33	69.012	.143	.869
39. Tengo pesadillas.	29.14	67.470	.338	.865
40. A veces me enoja.	29.58	69.342	.151	.868
41. Me preocupa que durante la clase me hagan participar.	29.02	67.652	.350	.865
42. Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir en la noche.	28.95	67.666	.395	.864
43. Me cuesta trabajo concentrarme en mis tareas escolares.	29.19	67.230	.362	.865
44. A veces digo cosas que no debería decir.	29.36	68.201	.247	.867
45. Me preocupa que alguien me dé una golpiza.	29.09	67.468	.351	.865
46. Me muevo mucho en mi asiento.	29.14	67.898	.284	.866
47. Muchas personas están en mi contra.	28.96	68.012	.330	.865
48. He dicho alguna mentira.	29.53	69.767	.071	.869
49. Me preocupa decir alguna tontería.	29.15	67.073	.386	.864

Igualmente, se comprobó la confiabilidad del CMASR-2 por el método de mitades para la estandarización mexicana, arrojando una correlación de Guttman de .881.

Un análisis factorial permitió corroborar que en su totalidad, los reactivos del CMASR-2 (estandarización mexicana), fueron sólidos y por lo tanto todos se conservaron. Las puntuaciones promedio de la muestra de estandarización del CMASR de 1985, las de la muestra de prueba del CMASR-2 y de la muestra de estandarización mexicana se muestran en la tabla 7-2, obsérvese que las puntuaciones promedio en la escala de Actitud Defensiva/Mentira son

muy semejantes, salvo que en las de la muestra de estandarización mexicana es mucho menor la desviación estándar de la puntuación promedio.

En las puntuaciones de Ansiedad Total (TOT), Ansiedad Fisiológica (DEF) y Preocupaciones Sociales/Concentración (SOC) las puntuaciones de la muestra de estandarización mexicana difieren significativamente debido a la reagrupación de los reactivos en ésta última.

Tabla 7-2. Puntuaciones naturales promedio de la muestra completa de referencia de CMASR-2, estandarización mexicana

Escala	Muestra de Estandarización del CMAS-R de 1985 (N = 4 972)		Muestra de prueba del CMASR-2 (N = 308)		Muestra de estandarización del CMASR-2 (N = 2490 mexicana)	
	M	DE	M	DE	M	DE
Mentira	3.1	2.6	3.8*	2.0	3.2	1.97
Ansiedad Total	11.7	5.6	11.6	6.1	26.6	7.98
Ansiedad Fisiológica	4.1	2.5	4.2	2.6	13.3	3.86
Inquietud/Hipersensibilidad	4.8	3.0	4.4	2.7	4.3	2.31
Preocupaciones Sociales/Concentración	2.8	1.4	3.0	1.9	9.0	3.76

Nota. N = 2490

*La diferencia en las puntuaciones promedio entre las dos primeras muestras es significativa en términos estadísticos, $p < 0.1$. Los tamaños del efecto para estas diferencias son moderados, con valores de .31 para la puntuación de mentira y .55 para la Ansiedad Total.

El análisis factorial de la muestra de estandarización mexicana se presenta en la tabla 7-3, mismo que difiere de la estructura factorial de la escala de la muestra de EUA, obsérvese que en la Ansiedad Fisiológica (FIS) el número de reactivos con cargas factoriales mayores a .30 y que se agruparon en este factor aumentó de 10 en la muestra de EUA a 19 en la muestra de estandarización mexicana; tales reactivos adicionales presentan, además de las cargas factoriales $>.30$, (con excepción del reactivo 31 *-me sudan las manos-* y 11, *me cuesta trabajo tomar decisiones*, cuya carga factorial es de .27), una congruencia conceptual con dicho factor. En el caso de estos dos últimos reactivos se consideró necesario dejarlos en este factor debido dos razones fundamentales: a que no existe correlación con ningún otro factor, además de su congruencia conceptual con el factor de Ansiedad Fisiológica. Los reactivos adicionales fueron el 8, *la gente me pone nervioso(a)*; 42, *me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir en la noche*, el 16, *casi todo el tiempo estoy preocupado*, el 27, *me siento solo(a) aunque esté acompañado*, el 47, *muchas personas están en mi contra*, el 5, *tengo demasiados dolores de cabeza*, el 36, *los demás son más felices que yo*; el 18, *muchas cosas me dan miedo*; el 13, *parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí*; el 28, *en la escuela se burlan de mí*; y el 43, *me cuesta trabajo concentrarme en mis tareas escolares*. Ocho de los reactivos del CMASR-2 de EUA, se mantienen en el CMASR-2 estandarización mexicana (reactivo 1, *muchas veces siento asco o náuseas*; 7, *algunas veces me despierto asustado(a)*; 11, *me cuesta trabajo tomar decisiones*; 15, *muchas veces siento que me falta el aire*; 20, *me enoja con facilidad*; 25, *en las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a)*; 31, *me sudan las manos*; 34, *me canso mucho*; y 39, *tengo pesadillas*; el reactivo 20 del Factor FIS del CMASR-2, *me enoja con facilidad*, y el 46, *me muevo mucho en mi asiento*; se cambiaron al Factor de Inquietud (INQ) del CMASR-2 estandarización mexicana.

De manera semejante al Factor Fisiológico (FIS), en el Factor de Inquietud (INQ) se agruparon 10 reactivos, cuyas cargas factoriales resultaron $>.30$, de los cuales sólo los reactivos 48, *he dicho alguna mentira*, 44, *a veces digo cosas que no debe-*

ría decir, 46, *me muevo mucho en mi asiento*, y 20, *me enoja con facilidad*; se añadieron a dicho factor en el CMASR-2, estandarización mexicana. Mientras que los reactivos 3, *muchas veces me preocupa que algo malo me pase*, y el reactivo 26, *me preocupa lo que la gente piense de mí*; pasaron al Factor Social (SOC) y los reactivos 16, *casi todo el tiempo estoy preocupado(a)*, el reactivo 18, *muchas cosas me dan miedo*, y el reactivo 42, *me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir en la noche*, pasaron al Factor Fisiológico (FIS).

En el caso del Factor de Preocupaciones Sociales (SOC), el número de reactivos que obtuvieron cargas factoriales $>.30$ fueron 14; a diferencia de los 7 incluidos en el CMASR-2 de EUA; de los cuales sólo dos de ellos se mantienen en la estandarización mexicana (reactivo 9, *siento que alguien va a decirme que hago mal las cosas*, y reactivo 22, *siento que a los demás no les gusta cómo hago las cosas*). Los reactivos 13, *parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí*; reactivo 27, *me siento solo(a) aunque esté acompañado(a)*, reactivo 36, *los demás son más felices que yo*, reactivo 43, *me cuesta trabajo concentrarme en mis tareas escolares*, y reactivo 47, *muchas personas están en mi contra*; Se agruparon en el Factor de Ansiedad Fisiológica (FIS).

Los 12 reactivos que se añadieron a este mismo factor fueron: el 4, *tengo miedo que otros niños se burlen de mí durante la clase*, reactivo 10, *tengo miedo que los demás se rían de mí*, reactivo 17, *me siento mal si la gente se ríe de mí*, reactivo 26, *me preocupa lo que la gente piense de mí*, reactivo 6, *me preocupa no agradarle a los otros*, reactivo 32, *me preocupa cometer errores delante de la gente*, reactivo 49, *me preocupa decir alguna tontería*, reactivo 37, *temo hablar en voz alta delante de un grupo*, reactivo 23, *me da miedo hablar en voz alta ante mis compañeros(as) durante la clase*, reactivo 45, *me preocupa que alguien me dé una golpiza*, reactivo 41, *me preocupa que durante la clase me hagan participar*, y reactivo 3, *muchas veces me preocupa que algo malo me pase*. Como puede observarse, todos ellos presentaron, además de cargas factoriales superiores a .30, una congruencia conceptual más acorde con el Factor de Preocupaciones Sociales (SOC).

Tabla 7-3. Cargas de factores para la muestra del CMASR-2, estandarización mexicana

Reactivos por escala		Factor		
		1	2	3
	Ansiedad fisiológica			
8. La gente me pone nervioso.		.282		.290
42. Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir en la noche.		.549		
34. Me canso mucho.		.534		
15. Muchas veces siento que me falta el aire.		.500		
39. Tengo pesadillas.		.499		
7. Algunas veces me despierto asustado(a).		.481		
16. Casi todo el tiempo estoy preocupado(a).		.475		
27. Me siento solo(a) aunque esté acompañado(a)		.468		
25. En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a)		.457		
47. Muchas personas están en mi contra.		.432		
5. Tengo demasiados dolores de cabeza.		.428		308
1. Muchas veces siento asco y nauseas.		.425		
36. Los demás son más felices que yo.		.424		
18. Muchas cosas me dan miedo.		.407		
13. Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí.		.376		
28. En la escuela se burlan de mí.		.344		
43. Me cuesta trabajo concentrarme en mis tareas escolares.		.343		
31. Me sudan las manos.		.270		
11. Me cuesta trabajo tomar decisiones.		.270		
	Inquietud			
40. A veces me enojo.			.569	.301
48. He dicho alguna mentira			.551	
44. Algunas veces digo cosas que no debería decir			.536	
12. Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no me salen como yo quiero.			.450	
21. Me preocupa lo que mis papás me vayan a decir.			.407	
35. Me preocupa lo que va a pasar.			.403	
2. Soy muy nervioso(a).			.392	
46. Me muevo mucho en mi asiento.			.328	
20. Me enojo con facilidad.			.318	
30. Es muy fácil herir mis sentimientos.			.312	
	Ansiedad Social			
4. Tengo miedo que otros(as) niños(as) se burlen de mí durante la clase.				.686
10. Tengo miedo que los(as) demás se rían de mí				.684
17. Me siento mal si la gente se ríe de mí.				.656
26. Me preocupa lo que la gente piense de mí.				.639
6. Me preocupa no agradarle a otros.				.550
32. Me preocupa cometer errores delante de la gente.				.537
49. Me preocupa decir alguna tontería.				.536
37. Temo hablar en voz alta delante de un grupo.				.536
23. Me da miedo hablar en voz alta ante mis compañeros(as) durante la clase.				.513
45. Me preocupa que alguien me dé una golpiza.				.478
41. Me preocupa que durante la clase me hagan participar.				.406
22. Siento que a los demás no les gusta cómo hago las cosas.				.390
9. Sentí que alguien va a decirme que hago mal las cosas				.366
3. Muchas veces me preocupa que algo malo me pase.				.345

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a. La Rotación ha convergido en 6 iteraciones.

Se utilizaron técnicas estadísticas tradicionales para analizar el desempeño de cada reactivo con respecto al total de la escala como medida de homogeneidad, así como correlaciones entre subescalas y análisis de factores. Este proceso dio como resultado que se conservaran los 49 reactivos del CMASR-2, con modificaciones en las cargas factoriales, como se ha señalado en párrafos anteriores.

En el caso de la Escala de Defensividad (DEF), se conserva también el mismo número de reactivos de los 9 identificados en el CMASR-2 EUA, salvo los reactivos 40 y reactivo 44, cuyas cargas factoriales son de .316 y .301 respectivamente; sin embargo, obtuvieron cargas factoriales mayores en el Factor de Inquietud (.551 y .536 respectivamente). No obstante, como esta escala no interfiere con los niveles de ansiedad de cada factor (FIS, INQ, SOC) ni con el total (TOT), o Total Abreviada, se consideró prudente dejarlos también para la evaluación de la Defensividad (DEF). Dichos reactivos pueden localizarse en la tabla 3-2 del capítulo 3.

En la tabla 7-4, se presenta la distribución del número de reactivos en las distintas versiones: las escalas del CMASR, del CMASR-2 EUA y del CMASR-2 estandarización mexicana. Se conservan los 9 pares de reactivos de la escala de Respuestas Inconsistentes (INC) y la escala de Defensividad (DEF); sin embargo, la distribución de los reactivos en la escala de Ansiedad Total (TOT), Ansiedad Fisiológica (FIS), Inquietud (INQ) y Ansiedad Social (SOC) se modifica de una revisión a otra. Aspecto de suma importancia cuando se trata de utilizar un instrumento de medida cuyas propiedades han de ser probadas en la población meta.

Tabla 7-4. Escalas incluidas en el CMASR, el CMASR-2 EUA y el CMASR-2 estandarización mexicana

Escala	Número de reactivos del CMASR	Número de reactivos del CMASR-2	Número de reactivos del CMASR-2 estandarización mexicana
Escalas de validez			
Índice de respuestas inconsistentes (INC)	—	9 pares	9 pares
Defensividad (DEF) (antes mentira)	9	9	9
Escalas de ansiedad			
Ansiedad Total (TOT)	28	40	43
Ansiedad Fisiológica (FIS)	10	12	19
Inquietud (INQ) (antes Inquietud/Hipersensibilidad)	11	16	10
Ansiedad Social (SOC) (antes Preocupaciones Sociales/Concentración)	7	12	14

Tabla 7-5. Características de la muestra de estandarización del CMASR-2, estandarización mexicana

Edad	Total	Porcentaje de la muestra	Varones	Mujeres
6	147	6.0	76	71
7	172	7.0	85	87
8	165	6.6	90	75
9	188	7.6	102	86
10	212	8.1	104	108
11	198	8.0	90	108
12	176	7.1	86	90
13	176	7.1	87	89
14	156	6.3	77	79
15	170	6.8	76	94
16	196	7.9	81	115
17	192	7.7	80	112
18	190	7.7	80	110
19	152	6.1	65	87
Total	2490	100.0	1179	1311
Región geográfica	Total	Porcentaje de la muestra	Varones	Mujeres
Norte	633	25.6	292	341
Centro	1673	67.0	792	881
Sur	184	7.4	95	89
Total	2487	100.0	1179	1311
Escuela	Total	Porcentaje de la muestra	Varones	Mujeres
Privadas	1253	50.3	611	642
Públicas	1237	59.7	568	669
Total	2490	100.0	1179	1311

Nota N = 2490

Las puntuaciones naturales promedio obtenidas por toda la muestra, así como las obtenidas por género, zona geográfica de la República Mexicana y edad se localizan en las tablas 7-6, 7-7, 7-8 y 7-9 respectivamente.

Después del análisis de reactivos y de factores, se realizó el cálculo de promedios y desviaciones estándar para cada factor así como el total para ver dichas puntuaciones por género, tipo de escuela (privada y pública) así como las zonas geográficas (Norte, Centro y Sur) de la República mexicana. Enseguida se calcularon las puntuaciones normalizadas de T y sus respectivos promedios.

Las puntuaciones naturales promedio obtenidas por el total de la muestra y las obtenidas por estudiantes de ambos géneros, edades, tipo de escuela se muestran en las tablas 7-6, 7-7, 7-8 y 7-9 respectivamente. Mientras que las puntuaciones estándar se desarrollaron en primer lugar para la muestra completa y se calcularon las puntuaciones T resultantes como en la versión estadounidense para los distintos subgrupos dentro de la muestra. También se calculó la significación de las

Tabla 7-6. Puntuaciones naturales promedio de la muestra completa de referencia del CMASR-2, estandarización mexicana

Escala	M	DE
Ansiedad Total (TOT)	26.4	7.8
Ansiedad Fisiológica (FIS)	12.6	3.7
Inquietud (INQ)	4.3	2.1
Ansiedad Social (SOC)	9.5	3.8
Defensividad (DEF)	3.2	1.9
Formulario Breve de Ansiedad Total (FB-TOT)	6.6	2.3

Nota. N = 2490

Tabla 7-8. Puntuaciones naturales promedio para subgrupos por zona geográfica en la muestra completa de referencia del CMASR-2, estandarización mexicana

Escala	Zona Norte (n = 634)		Zona Centro (n = 1673)		Zona Sur (n = 183)	
	M	DE	M	DE	M	DE
Ansiedad Total (TOT)	28.6	8.7	29.2	9.6	26.0	9.1
Ansiedad Fisiológica (FIS)	13.1	3.5	12.6	3.8	11.6	3.5
Inquietud (INQ)	6.9	3.2	7.5	3.3	6.5	3.1
Ansiedad Social (SOC)	8.6	3.5	9.1	3.7	7.9	3.7
Defensividad (DEF)	4.4	2.5	3.8	2.3	3.9	2.5
Formulario Breve de Ansiedad Total (FB-TOT)	6.6	2.1	6.7	2.3	5.8	2.2

Tabla 7-7. Puntuaciones naturales promedio para varones y mujeres en la muestra completa de referencia del CMASR-2, estandarización mexicana

Escala	Varones (1179)		Mujeres (1311)	
	M	DE	M	DE
Ansiedad Total (TOT)	29.9	9.2	27.8	9.4
Ansiedad Fisiológica (FIS)	12.9	3.6	12.4	3.7
Inquietud (INQ)	7.7	3.3	6.9	3.3
Ansiedad Social (SOC)	9.4	3.5	8.5	3.7
Defensividad (DEF)	3.9	2.3	3.9	2.5
Formulario Breve de Ansiedad Total (FB-TOT)	6.9	2.1	6.2	2.3

diferencias entre las submuestras, encontrando diferencias estadísticamente significativas por género, edad y zona geográfica; no se encontró evidencia estadística que sustentara diferencias significativas entre escuela particular y pública. En las tablas 7-10 y 7-11 se muestra la significación de las diferencias por género y tipo de escuela para el total de la muestra de estandarización.

Para el cálculo de las diferencias entre las distintas edades de los estudiantes se agruparon intervalos de edad de manera semejante a los realizados para el CMASR-2, los intervalos fueron de 6 a 8, de 9 a 14 y de 15 a 19 años respectivamente, encontrando diferencias significativas entre edades. Los resultados se muestran en la tabla 7-12 y los resultados del análisis de las diferencias por zona geográfica se presentan en la tabla 7-13, mismas que justifican la elaboración de normas para cada una de estas variables.

Tabla 7-9. Puntuaciones naturales promedio por grupo de edad en la muestra completa del CMASR-2, estandarización mexicana

Escala	6 (n = 147)		7 (n = 112)		8 (n=165)		9 (n=188)		10 (n=212)		11 (n=198)		12 (n=176)		13 (n=176)		14 (n=156)		15 (n=170)		16 (n=196)		17-19 (n=534)	
	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE	M	DE
Ansiedad Total (TOT)	23.6	9.3	24.3	7.7	24.2	9.1	24.3	10.1	27.4	9.5	28.4	9.4	27.7	8.5	30.5	8.7	31.3	8.4	31.7	8.7	32.4	8.9	32.3	8.4
Ansiedad Fisiológica (FIS)	10.8	3.8	11.2	3.4	10.7	3.7	10.8	4.1	12.3	3.7	12.5	3.6	12.8	3.5	13.5	3.4	13.6	3.3	13.7	3.6	13.7	3.2	13.6	3.2
Inquietud (INQ)	5.8	3.4	5.8	2.8	6.1	3.2	6.0	3.4	6.6	3.3	7.1	3.4	6.7	3.1	7.6	3.2	7.8	3.1	8.1	2.9	8.5	2.9	8.5	3.0
Ansiedad Social (SOC)	6.9	3.7	7.3	3.2	7.4	3.5	7.5	3.8	8.4	3.6	8.8	3.7	8.2	3.4	9.4	3.6	9.8	3.4	9.9	3.4	10.3	3.2	10.2	3.4
Defensividad (DEF)	5.6	2.0	5.6	2.3	5.1	2.5	4.4	2.5	4.2	2.5	3.6	2.5	3.5	2.4	3.2	2.2	3.4	2.2	3.5	2.2	3.6	2.2	3.4	2.2
Formulario Breve de Ansiedad Total (FB-TOT)	5.6	2.0	5.8	1.9	5.8	2.1	5.2	2.3	6.5	2.2	6.5	2.2	6.4	2.1	6.9	2.2	6.9	2.2	7.1	2.3	7.2	2.2	7.2	2.2

Tabla 7-10. Significación de las diferencias por género

Factor	Género	M	T	gl	Significación
Ansiedad Fisiológica (FIS)	Femenino	12.37	3.604	2488	.000
	Masculino	12.91			
Inquietud (INQ)	Femenino	6.91	-6.11	2488	.000
	Masculino	7.70			
Ansiedad Social (SOC)	Femenino	8.50	-5.902	2488	.000
	Masculino	9.36			
Ansiedad Total (TOT)	Femenino	27.78	-5.838	2488	.000
	Masculino	29.96			
Total Abreviada	Femenino	6.21	-8.739	2488	.000
	Masculino	6.99			

Probabilidad < a 0.01.

Tabla 7-11. Significación de las diferencias por tipo de escuela (Pública y Privada)

Factor	Género	M	T	gl	Significación
Ansiedad Fisiológica (FIS)	Privada	12.52	-1.435	2488	.151
	Pública	12.73			
Inquietud (INQ)	Privada	7.17	-1.688	2488	.092
	Pública	7.40			
Ansiedad Social (SOC)	Privada	8.84	-.930	2488	.353
	Pública	8.97			
Ansiedad Total (TOT)	Privada	28.53	-1.520	2488	.129
	Pública	29.10			
Total Abreviada	Privada	6.54	-.871	2488	.384
	Pública	6.62			

Tabla 7-12. Significación de las diferencias por intervalos de edad para toda la muestra

Factor	Comparaciones	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Significación
Ansiedad Fisiológica (FIS)	Inter-grupos	2374.644	2	1187.322	93.854	.000
	Intra-grupos	31462.511	2487	12.651		
	Total		2489			
Inquietud (INQ)	Inter-grupos	21.81.361	2	1090.680	109.121	.000
	Intra-grupos	24858.031	2487	9.995		
	Total	27039.392	2489			
Ansiedad Social (SOC)	Inter-grupos	2819.555	2	1409.778	113.873	.000
	Intra-grupos	30789.696	2487	12.380		
	Total	33609.251	2489			
Ansiedad Total (TOT)	Inter-grupos	21837.073	2	10918.536	137.322	.000
	Intra-grupos	197743.090	2487	79.511		
	Total	219580.	2489			
Total Abreviada	Inter-grupos	682.220	2	341.110	70.527	.000
	Intra-grupos	12028.536	2487	4.837		
	Total	12710.755	2489			
Defensividad (DEF)	Inter-grupos	1257.588	2	628.794	117.096	.000
	Intra-grupos	13353.966	2487	5.370		
	Total	14612.554	2489			

Significación <0.01

Tabla 7-13. Significación de las diferencias para toda la muestra por zona geográfica

Factor	Comparaciones	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Significación
Ansiedad Fisiológica (FIS)	Inter-grupos	304	2	152.374	11.301	.000
	Intra-grupos	33532.407	2487	13.483		
	Total	33837.155	2489			
Inquietud (INQ)	Inter-grupos	291.174	2	145.587	13.536	.000
	Intra-grupos	26748.218	2487	10.755		
	Total	27039.392	2489			
Ansiedad Social (SOC)	Inter-grupos	285.097	2	142.549	10.638	.000
	Intra-grupos	33324.154	2487	13.399		
	Total	33609.251	2489			
Ansiedad Total (TOT)	Inter-grupos	1689.713	2	844.857	9.643	.000
	Intra-grupos	217890.450	2487	87.612		
	Total	219580.163	2489			
Total Abreviada	Inter-grupos	129.851	2	64.926	12.835	.000
	Intra-grupos	12580.904	2487	5.059		
	Total	12710.755	2489			
Defensividad (DEF)	Inter-grupos	141.130	2	70.565	12.127	.000
	Intra-grupos	14471.424	2487	5.819		
	Total	14612.554	2489			

Tabla 7-14. Puntuaciones-T promedio de varones y mujeres en a muestra completa del CMASR-2 estandarización mexicana

Escala	Varones (1179)		Mujeres (1311)	
	M	de	M	de
Ansiedad Total (TOT)	51.5	9.9	49.7	9.8
Ansiedad Fisiológica (FIS)	50.8	9.8	49.3	10.0
Inquietud (INQ)	51.8	9.9	48.3	9.7
Ansiedad Social (SOC)	51.3	9.7	48.9	10.1
Defensividad (DEF)	50.0	9.6	49.9	10.3

Tabla 7-15. Puntuaciones-T promedio subgrupos en la muestra completa de zonas geográficas del CMASR-2 estandarización mexicana

Escala	Zona Norte (n = 633)		Zona Centro (n = 1673)		Zona Sur (n = 183)	
	M	de	M	de	M	de
Ansiedad Total (TOT)	50.6	9.5	50.1	10.2	50.1	10.2
Ansiedad Fisiológica (FIS)	51.2	9.5	49.9	10.2	49.9	10.2
Inquietud (INQ)	50.9	10.2	49.6	9.9	49.6	9.9
Ansiedad Social (SOC)	49.4	9.5	50.5	10.1	50.5	10.1
Defensividad (DEF)	51.9	10.5	49.3	9.7	49.3	9.7

Tabla 7-16. Puntuaciones-*T* promedio subgrupos en la muestra completa de las diferentes edades del CMASR-2 estandarización mexicana

	6 (n=147)		7 (n=172)		8 (n=165)		9 (n=188)		10 (n=212)		11 (n=198)		12 (n=176)		13 (n=176)		14 (n=156)		15 (n=170)		16 (n=196)		17-19 (n=534)	
Escalas	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>	<i>M</i>	<i>de</i>
Ansiedad Total (TOT)	47.0	10.3	47.8	8.5	46.3	10.3	46.1	11.5	49.5	10.4	50.1	10.1	49.0	9.3	51.3	9.9	51.9	9.4	51.8	10.1	52.1	8.9	53.2	9.4
Ansiedad Fisiológica (FIS)	45.1	10.3	46.3	9.3	44.8	10.1	45.0	11.2	49.2	9.9	49.8	9.4	50.4	9.5	52.3	9.1	52.7	8.7	52.9	9.8	52.7	8.7	52.7	8.8
Inquietud (INQ)	55.2	10.8	54.6	9.3	52.0	10.0	50.4	10.5	51.6	10.1	50.1	9.6	48.9	9.4	48.9	10.1	48.7	9.9	47.5	9.7	47.4	9.1	48.3	9.4
Ansiedad Social (SOC)	45.1	10.0	46.3	8.4	54.5	10.3	46.5	10.5	49.7	9.8	49.8	10.1	48.0	9.1	51.2	10.0	52.4	9.3	52.4	9.7	53.5	8.9	53.2	9.4
Defensividad (DEF)	56.2	8.3	56.2	9.5	54.5	10.3	51.9	10.3	51.4	10.1	49.7	10.0	48.0	9.8	47.1	8.9	47.7	9.6	47.9	9.1	48.6	9.4	47.8	9.05

Tabla 7-16. Correlaciones de pares de reactivos en el índice de Respuestas Inconsistentes (INC)

Par de reactivos	<i>r</i>
4. Tengo miedo que otros niños se rían de mí durante la clase.	
10. Tengo miedo que los demás se rían de mí.	.59
19. Siempre soy amable.	
33. Siempre soy agradable con todos.	.46
24. Siempre me porto bien.	
29. Siempre soy bueno(a).	.51
6. Me preocupa no agradarle a los otros.	
49. Me preocupa decir alguna tontería.	.28
23. Me da miedo hablar en voz alta ante mis compañeros durante la clase.	
37. Tengo miedo de hablar en voz alta delante de un grupo.	.60
7. Algunas veces me despierto asustado(a).	
39. Tengo pesadillas.	.30
3. Muchas veces me preocupa que algo malo me pase.	
35. Me preocupa lo que va a pasar.	.33
2. Soy muy nervioso(a).	
8. La gente me pone nervioso(a).	.27
38. Siempre digo la verdad.	
48. He dicho alguna mentira.	.32

Tabla 7-17. Estimación de confiabilidad para la muestra completa del CMASR-2 estandarización mexicana

Escala	Alfa de Cronbach
Ansiedad Total (TOT)	.87
Ansiedad Fisiológica (FIS)	.79
Inquietud (INQ)	.64
Ansiedad Social (SOC)	.83
Defensividad (DEF)	.75
Formulario Breve de Ansiedad (FB-TOT)	.66

Las variables cuyas diferencias fueron estadísticamente significativas, como ya se mencionó, fueron género, edad y zona geográfica. Las puntuaciones-T basadas en la muestra completa permiten el desempeño relativo de los subgrupos para ser evaluados con facilidad. Las puntuaciones-T prome-

dio para varones y mujeres, Zonas geográficas y edad en la muestra completa se presentan en las tablas 7-14, 7-15 y 7-16 respectivamente.

Conclusión

El desarrollo de las normas mexicanas para la escala CMASR-2 son resultado de una investigación que permitió obtener un instrumento válido y confiable para la evaluación de la ansiedad en niños y adolescentes, aspecto importante cuando se trata de utilizar un instrumento de medida cuyas propiedades han de ser utilizadas en la población a la cual esta dirigida.

Para la interpretación de los resultados desde el punto de vista clínico se aconseja al examinador asegurarse de que en cada reporte de evaluación se integre la información obtenida mediante la historia clínica del evaluado así como el uso de otras herramientas de evaluación que permita un diagnóstico integral.

Tabla 7-18. Correlaciones entre las escalas para la muestra completa del CMASR-2 y de estandarización mexicana

Escala	TOT CMASR-2	TOTBMX	FIS CMASR-2	FISBMX	INQ CMASR-2	INQBMX	SOC CMASR-2	SOC
Ansiedad Total (TOT)	-	-						
Ansiedad Fisiológica (FIS)	.83	.86	-	-				
Inquietud (INQ)	.93	.67	.64	.42	-	-	-	-
Ansiedad Social (SOC)	.88	.67	.59	.56	.73	.42	-	-
Defensividad (DEF)	.02	.21	.06	.12	.06	.44	.01	.01

Apéndice 1

Listado de estudios que utilizan el CMASR-2

Lo que sigue es un listado selecto de artículos relacionados con el CMASR que han aparecido en la bibliografía profesional desde la publicación del CMASR en 1985. Los artículos que se eligieron para ser incluidos aquí tratan aspectos psicométricos clave, se refieren a un tópico especialmente interesante o ejemplifican la amplitud de los escenarios en los que el instrumento ha sido de utilidad. Las citas completas aparecen en la sección de Referencias.

Propiedades psicométricas

- Cole, Hoffman, Tram y Maxwell (2000)
Structural differences in parent and child reports of children's symptoms of depression and anxiety
- Dadds, Perrin y Yule (1998)
Social desirability and self-reported anxiety in children: An analysis of the RCMAS Lie Scale
- Hagborg (1991)
The Revised Children's Manifest Anxiety Scale and social desirability
- Hodges (1990)
Depression and anxiety in children: A comparison of self-report questionnaires to clinical interview
- Joiner (1996)
The relations of thematic and nonthematic childhood depression measures to defensiveness and gender
- Joiner, Schmidt y Schmidt (1996)
Low-end specificity of childhood measures of emotional distress: Differential effects for depression and anxiety
- Lee, Piersel, Friedlander y Collamer (1988)
Concurrent validity of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale (RCMAS) for adolescents
- Lee, Piersel y Unruh (1989)
Concurrent validity of the physiological subscale of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale: A multitrait-multimethod analysis
- Lowe y Reynolds (2000)
Exploratory analyses of the latent structure of anxiety among older adults
- Muris, Merckelbach, Ollendick, King y Bogie (2002)
Three traditional and three new childhood anxiety questionnaires: Their reliability and validity in a normal adolescent sample
- Pavuluri, Henri y Allen (2002)
Anxiety and fear: Discriminant validity in the child and adolescent practitioner's perspective
- Perrin y Last (1992)
Do childhood anxiety measures measure anxiety?

- Pina, Silverman, Saavedra y Weems (2001)
An analysis of the RCMAS lie scale in a clinic sample of anxious children
- Ryngala, Shields y Caruso (2005)
Reliability generalization of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale
- Seligman, Ollendick, Langley y Baldacci (2004)
The utility of measures of child and adolescent anxiety
- Stark y Laurent (2001)
Joint factor analysis of the Children's Depression Inventory and the Revised Children's Manifest Anxiety Scale
- Tannenbaum, Forehand y Thomas (1992)
Adolescent self-reported anxiety and depression: Separate constructs or a single entity
- White (1999)
Structure of anxiety symptoms in urban children: A test of competing confirmatory factor analytic models of the RCMAS
- White y Farrell (2001)
Structure of anxiety symptoms in urban children: Competing factor models of Revised Children's Manifest Anxiety Scale

Evaluación psicopatológica – General

- Angold (1989)
Structured assessments of psychopathology in children and adolescents
- Auton Cuff (2005)
Neurophysiological, neuroendocrine, and neuropsychological correlates of aggression in aggressive rejected and low aggressive popular seventh and eighth grade children
- Curry, March y Hervey (2004)
Comorbidity of childhood and adolescent anxiety disorders: Prevalence and implications
- Demos y Prout (1994)
A review of scales for the brief assessment of anxiety
- James, Reynolds y Dunbar (1994)
Self-report instruments

- Resko (2004)
Self-reported depression and anxiety in youth with and without PTSD as a function of stressor type
- Saigh (1991)
The development of posttraumatic stress disorder following four different types of traumatization
- Schniering, Hudson y Rapee (2000)
Issues in the diagnosis and assessment of anxiety disorders in children and adolescents
- Schulz (2002)
ADHD symptomatology: The contribution of depression and anxiety measures to an accurate diagnosis

Evaluación psicopatológica – Niños

- Baxter (2000)
The relationship of attention deficit disorder and the internalizing dimension in males, ages 9-0 through 11-11
- Baxter y Rattan (2004)
Attention deficit disorder and the internalizing dimension in males, ages 9-0 through 11-11
- Biederman, Milberger, Faraone y Kiely (1995)
Impact of adversity on functioning and comorbidity in children with attention-deficit hyperactivity disorder
- Kovacs y Devlin (1998)
Internalizing disorders in childhood
- Landa (1995)
The relationship of conflicting stimuli, evaluation apprehension, and anxiety with a task of word recognition by children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
- Mattison, Bagnato y Brubaker (1988)
Diagnostic utility of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale in children with DSM-III anxiety disorders
- Pliszka, Rogeness y Medrano (1988)
DBH, MHPC, and MAO in children with depressive, anxiety, and conduct disorders: Relationship to diagnosis and symptom ratings
- Saigh (1989)
The validity of the DSM-III posttraumatic stress disorder classification as applied to children

Evaluación psicopatológica – Adolescentes

- Dan (1996)
Secondary traumatization in the adolescent offspring of Vietnam veterans with Posttraumatic Stress Disorder
- Dierker, Albano, Clarke, Heimberg, Kendall, Merikangas, et al. (2001)
Screening for anxiety and depression in early adolescence

- Hagborg (1992)
Prevalence and correlates of self-reported depressive mood among seriously emotionally disturbed adolescents
- Mather y Cartwright-Hatton (2004)
Cognitive predictors of obsessive-compulsive symptoms in adolescence: A preliminary investigation
- Westbrook (1998)
Positive affectivity and adolescent depression

Resultados

- Beery (1995)
Behavioral disinhibition, anxiety, and response to methylphenidate and behavior management in children with attention deficit hyperactivity disorder
- Bowers (2002)
A preliminary investigation of the additive effect of a parent training protocol in the treatment of phobic children
- Brehm, Rourke, Cassell y Sethuraman (2003)
Psychosocial outcomes of a pilot multidisciplinary program for weight management
- Chemtob, Nakashima y Carlson (2002)
Brief treatment of elementary school children with disaster-related posttraumatic stress disorder: A field study
- Cook (2000)
Gestalt treatment of adolescent females with depressive symptoms: A treatment outcome study
- Cullain (2000)
The effects of social stories on anxiety levels and excessive behavioral expressions of elementary school-aged children with autism
- Fiore (2000)
Parental evaluation of a four-step procedure designed to help parents alleviate their child's level of generalized anxiety
- Foret (1997)
The integration of projective expressive arts in therapeutic sessions: The initial study of "StoryCards" as a treatment modality for anxiety among adolescents
- Gerard y Reynolds (2004)
Characteristics and applications of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale (RCMAS)
- Ladd (2000)
An investigation of parental perceptions and evaluations of a four-step procedure designed to help parents alleviate their adolescents' level of generalized anxiety
- Lomas (2002)
Computer-assisted cognitive training with elementary school-age children diagnosed with attention-deficit/hyperactivity disorder and mild/moderate comorbidity: A short-term prospective study on attention, planning and behavior
- Mozes, Meiri, Ben-Amity, Sabbagh y Weizman (2005)
Reboxetine as an optimal treatment for Hyperkinetic Conduct Disorder: A prospective open-label trial
- Raleigh (2001)
A preliminary examination of the efficacy of a parent training protocol for separation anxiety disorder

Investigación transcultural

- Anderson-Cruz (1997)
The effects of gender and language of instruction on the levels of anxiety and academic achievement of fifth grade Chicano students
- Argulewicz y Miller (1984a)
Self-report measures of anxiety: A cross-cultural investigation of bias
- Argulewicz y Miller (1984b)
Validity of self-report measures of anxiety for use with Anglo-American, Mexican-American, and Black students
- Boehnke, Silbereisen, Reynolds y Richmond (1986)
What I think and feel: German experience with the revised form of the Children's Manifest Anxiety Scale
- Ferrando (1994)
Factorial structure of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale in a Spanish sample: Relations with Eysenck personality dimensions
- Kao (2001)
Children's stress and after-school lives in Taiwan (China)
- Ólason, Sighvatsson y Smámi (2004)
Psychometric properties of the Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC) among Icelandic schoolchildren
- Ollendick y Yule (1990)
Depression in British and American children and its relation to anxiety and fear
- Pina y Silverman (2004)
Clinical phenomenology, somatic symptoms, and distress in Hispanic/Latino and European American youths with anxiety disorders
- Richmond, Rodrigo y de Rodrigo (1988)
Factor structure of a Spanish version of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale in Uruguay
- Turgeon y Chartrand (2003)
Reliability and validity of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale in a French-Canadian sample
- Varela y Biggs (2006)
Reliability and validity of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale (RCMAS) across samples of Mexican, Mexican American, and European American children: A preliminary investigation
- Wilson, Chibaiwa, Majoni, Masukume y Nkoma (1990)
Reliability and factorial validity of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale in Zimbabwe

Escenarios médicos

- Collins-Jones (1997)
AIDS orphans: The psychological adjustment of children with multiple family members with a terminal illness

- Devault (2001)
Predictors of biopsychosocial health status in children with asthma
- DiFranza, Savageau, Rigotti, Ockene, McNeill, Coleman, et al. (2004)
Trait anxiety and nicotine dependence in adolescents: A report from the DANDY study
- Kodero (2001)
The effects of residential destination on the education and psychological status of AIDS orphans
- Landman (2001)
Having a parent with Human Immunodeficiency Virus: Impact on the surviving child's mental health
- Logue (1998)
Panic and anxiety disorders in an outpatient pediatric cardiology sample
- Markson y Fiese (2000)
Family rituals as a protective factor for children with asthma
- Northman (2003)
Predicting adherence with pediatric HIV/AIDS regimens: Understanding the role of the child
- Switaj (2000)
Identification and measurement of anxiety and obsessive-compulsive tendencies in the Williams Syndrome behavioral phenotype
- Williams, Steel, Sharp, DelosReyes, Phillips, Bates, et al. (2003)
Anxiety in children with epilepsy
- Young (1998)
HIV/AIDS-affected children: A study utilizing the Rorschach to identify depression

Aspectos familiares

- Dingwall (1997)
Perception of facial expressions of emotion by children with severe, moderate and low levels of physical discipline
- Donnelly (1995)
Effect of parental reaction on depression, anxiety, and self-esteem in sexually abused children
- Imeri (1997)
Emotional distress and behavioral problems in children of chronic pain patients
- Kalier, Lohnes, Chasin, Cain, Dunning y Rowan (2002-2003)
The adjustment of parentally bereaved children: I. Factors associated with short-term adjustment
- Lyons-Sjostrom (2004)
Adjustment in siblings of children with disabilities
- Niggemeyer-Hall (2001)
Family interaction factors and anxiety in adolescent females
- Palinski (1997)
Youthful anxiety and perceptions of family environment

Sgandurra (2001)

The relationship between family functioning and sibling adjustment in families with a child with a developmental disability

Singleton-Winston (2003)

Gender differences in adolescents' adjustment in remarried and recoupled families

Desarrollo del niño y del adolescente

Bouldin y Pratt (2002)

A systematic assessment of the specific fears, anxiety level, and temperament of children with imaginary companions

Friedman, Campbell y Okifuji (1991)

Specific fears as predictors of generalized anxiety in children

Lowe (2001)

Common and uncommon manifestations of anxiety across the life span

Michaels (2000)

Children's anxieties and social cognitions

Raney (1999)

The relationship between emotions, moral reasoning and rule violations in early adolescence

Reid (2004)

The nature of cognitive biases in childhood

Watt (2001)

Age and gender differences in perception of control: Implications for development of anxious and dysphoric mood

Williams (1997)

Relationships among DAP:SPED indicators, self-report anxiety and depression scores, and behavior ratings of children ages 8-11

Validación de otras medidas

Carrillo (2005)

Factor analysis of the Millon Adolescent Clinical Inventory: Testing the goodness-of-fit of Millon's measure of adolescent psychopathology

Inderbitzen-Nolan y Walters (2000)

Social Anxiety Scale for Adolescents: Normative data and further evidence of construct validity

Kamps, Roberts y Varela (2005)

Development of a new fear of hypoglycemia scale: Preliminary results

March y Parker (1999)

The Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC)

Muris, Merckelbach, Mayer, van Brakel, Thissen, Moulaert, et al. (1998)

The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) and traditional childhood anxiety measures

Wisniewski, Naglieri y Mulick (1988)

Psychometric properties of a Children's Psychosomatic Symptom Checklist

Escenarios sociales

Johnson (2004)

A comparative study of stress in public and Catholic elementary school fourth-grade students in relationship to after-school activities

Kubiak (1998)

The relationship between community crime level and the manifestation of anxiety in a referred sample of children

Menke y Wagner (1997)

A comparative study of homeless, previously homeless, and never homeless school-aged children's health

Qin-Mei y Qing-Hua (2003)

Investigation of responses of children with high or low anxiety to teacher's authority

Estudiantes que reciben servicios especiales

Coronado (1995)

The anxiety of learning-disabled school children with remedial instruction

Li (2004)

Fears and related anxieties in children having a disability

Snowden (2004)

The effects of inclusion on the anxiety and self-esteem of special education students in the regular education classroom

Apéndice 2

Equipo técnico de estandarización CMASR-2 México

Agradecemos a todas las instituciones, públicas y privadas, así como a las escuelas, niños y padres de familia por el apoyo y facilidades brindadas a lo largo del proceso de investigación para el desarrollo de las normas mexicanas de CMASR-2.

Coordinadores de zona y examinadores

Lorena Aguilar Vásquez
María del Carmen Aldana Tena
Yolanda Margarita Aquino Medina
Daniela Baltazar Bastida
Olga Cecilia Cano García
Diana Etna Carbajal López
Karla Paola Carrera Aguirre
Cinthya Chiman Cruz
Karla Patricia Cid Medina
Marco Antonio Consuelo Avilés
María Dolores Cruz Luna
Guadalupe Cruz Serrano
Fabiola Degollado Bardales
Lourdes Adriana del Toro Campos
Irma Nohemí Domínguez Román
María Teresa Domínguez Serrano
María Elena Enríquez Vega
Carlos Alejandro Fernández Enríquez
Guadalupe Figueroa Pérez
Olivia Emma Flores Ortiz
Ana Norberta García Escobar
Alejandra García Ortiz
Clelia María García Silvia Herrera
Martha Roberta Garza Tamez
Sonia Aurora Garza Frías
María Isabel Gaxiola Madrid
Andrea Jazmín González Parada
Michelle Irais Hernández Álvarez
Mónica Patricia Infante Lozano
Blas Sergio Jasso Hinojosa
Martha Julia Jasso Lara
Mario Jorge Hernández
Leticia Andrea Guadalupe Lira Lara Silva

Ignacio Salvador López Miguel
Efraín López Molina
Miguel Adrián Marengo González
María Norelo Mercado Chacón
Ignacio Morales Hernández
María de Lourdes Moreno Chávez
Romelia Muela Barrera
Manuel G. Muñiz García
Lorena Nares Burciaga
Leticia Orozco Cuate
Marcela Aída Palacio Piña
Norma Imelda Ponce Almeida
Gloria Alicia Quintana Avena
Vanessa Irene Quiros Lagunes
Estela Quezada Romero
Edith Ramírez Ogaz
Arturo Ramírez Torres
Claudia Alejandra Reynoso Zepeda
Marlen Rivera Sánchez
Noemí Rodea Sánchez
Eyra Melissa Rodríguez Gómez
Rocío Yolanda Rojas Ortiz
Roxana Romero Márquez
Samanta Sosa Rodríguez
Guillermo Sánchez Servín
Laura Cecilia Servín Leyva
Rosa Imelda Solís Hernández
Claudia Mercedes Sotelo Arias
Gisela Eréndira Sotelo Armendáriz
Ivonne Martha Sotelo Leyva
Zuleima Torres de la Cruz
Yadira Torres González
Katherine Velásquez Baltazar
Blanca Guadalupe Villanueva
María de Lourdes Zavala Olvera

Referencias

- Akiskal, H. S. (1985). Anxiety: Definition, relationships to depression, and proposal for an interrogative model. In A. H. Tuma & J. Maser (Eds.), *Anxiety and the anxiety disorders* (pp. 787-797). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Allison, D. E. (1970). Test anxiety, stress, and intelligence-test performance. *Canadian Journal of Behavioral Science*, 2(11), 26-37.
- American Psychological Association. (1974). *Standards for educational and psychological tests*. Washington, DC: Author.
- American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (1999). *Standards for educational and psychological testing*. Washington, DC: American Psychological Association.
- American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Text rev.). Washington, DC: Author.
- Anderson-Cruz, H. E. (1997). The effects of gender and language of instruction on the levels of anxiety and academic achievement of fifth grade Chicago students. *Dissertation Abstracts International*, 58(5), 1548A.
- Angoff, W. H. (1984). *Scales, norms, and equivalent scores*. Princeton, NJ: Educational Testing Service.
- Angold, A. (1989). Structured assessments of psychopathology in children and adolescents. In C. Thompson (Ed.), *The instruments of psychiatric research* (pp. 271-304). Hoboken, NJ: Wiley.
- Argulewicz, E. N., & Miller, D. C. (1984a). Self-report measures of anxiety: A cross-cultural investigation of bias. *Hispanic Journal of Behavioral Sciences*, 6(4), 397-406.
- Argulewicz, E. N., & Miller, D. C. (1984b). Validity of self-report measures of anxiety for use with Anglo-American, Mexican-American, and Black students. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 2(3), 233-238.
- Auden, W. H. (1947). *The age of anxiety*. New York: Random House.
- Auton Cuff, F. (2005). Neurophysiological, neuroendocrine, and neuropsychological correlates of aggression in aggressive rejected and low aggressive popular seventh and eighth grade children. *Dissertation Abstracts International*, 66(3), 1744B.
- Baxter, J. K. (2000). The relationship of attention deficit disorder and the internalizing dimension in males, ages 9-0 through 11-11. *Dissertation Abstracts International*, 61(4), 1287A.
- Baxter, J., & Rattan, G. (2004). Attention deficit disorder and the internalizing dimension in males, age 9-0 through 11-11. *International Journal of Neuroscience*, 114(7), 817-832.
- Beery, S. H. (1995). Behavioral disinhibition, anxiety, and response to methylphenidate and behavior management in children with attention deficit hyperactivity disorder. *Dissertation Abstracts International*, 56 (2), 1096B.
- Bennet, A. (1998). Vulnerability factors in the anxiety disorders. *British Journal of Medical Psychology*, 71(3), 311-321.
- Ben-noun, L. (1998). Generalized anxiety disorders in dysfunctional families. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatric*, 29(2), 115-122.
- Berk, R. A. (Ed.). (1982). *Handbook of methods for detecting test bias*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Biederman, J., Milberger, S., Faraone, S., & Kiely, K. (1995). Impact of adversity on functioning and comorbidity in children with attention-deficit hyperactivity disorder. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 34, 1495-1503.
- Bledsoe, J. C. (1973). Sex and grade differences in children's manifest anxiety. *Psychological Reports*, 32, 285-286.
- Bledsoe, J. C. (1975). Factor invariance in the measurement of children's manifest anxiety. *Psychological Reports*, 36, 12.
- Boehnke, K., Silbereisen, R. K., Reynolds, C. R., & Richmond, B. O. (1986). What I think and feel: German experience with the revised form of the Children's Manifest Anxiety Scale. *Personality and Individual Differences*, 7(4), 553-560.
- Bogels, S. M., & van Melick, M. (2004). The relationship between child report, parent self-report, and partner report of

- perceived parental rearing behaviors and anxiety in children and parents. *Personality and Individual Differences*, 37(8), 1583-1596.
- Bouldin, P., & Pratt, C. (2002). A systematic assessment of the specific fears, anxiety level, and temperament of children with imaginary companions. *Australian Journal of Psychology*, 54(2), 79-85.
- Bowers, J. W. (2002). A preliminary investigation of the additive effect of a parent training protocol in the treatment of phobic children. *Dissertation Abstracts International*, 63(2), 1015B.
- Boyce, M. W. (1974). Student teacher misconceptions of manifestations of anxiety in children from different socioeconomic/ethnicity backgrounds. *Australian and New Zealand Journal of Sociology*, 10(2), 138-139.
- Boyd, R. C., Cooley, M. R., Lambert, S. F., & Jalongo, N. S. (2003). First-grade child risk behaviors for community violence exposure in middle school. *Journal of Community Psychology*, 31(3), 297-314.
- Brackis-Cott, E., Melbins, C. A., & Block, M. (2003). Current life concerns of early adolescents and their mothers: Influence of maternal HIV. *Journal of Early Adolescence*, 23(1), 311-317.
- Brady, P. J., Richards, J. P., & Felker, D. W. (1975). Affective outcomes of evaluation strategies by self and another in children's learning from textbook material. *Psychological Reports*, 37(1), 311-317.
- Brehm, B. J., Rourke, K. M., Cassell, C., & Sethuraman, G. (2003). Psychosocial outcomes of a pilot multidisciplinary program for weight management. *American Journal of Health Behavior*, 27(4), 348-234.
- Brosnam, M. J. (1998). The impact of computer anxiety and self-efficiency upon performance. *Journal of Computer Assisted Learning*, 14(3), 348-354.
- Carrier, N. A., Orton, D. D., & Malpass, L. F. (1962). Responses of bright, normal, and EMR children to an orally administered Childre's Manifest Anxiety Scale. *Journal of Educational Psychology*, 53, 271-274.
- Carrillo, P. B. (2005). Factor analysis of the Millon Adolescent Clinical Inventory: Testing the goodness-of fit of Millon's measure of adolescent psychopathology. *Dissertation Abstracts International*, 66(4), 2298B.
- Castaneda, A., McCandless, B., & Palermo, D. (1956). The children's form of the Manifest Anxiety Scale. *Child Development*, 27, 317-326.
- Castaneda, A., Palermo, D. S., & McCandless, B. R. (1956). Complex learning and performance as a function of anxiety in children and task difficulty. *Child Development*, 27, 327-332.
- Cattell, R. B. (1966). Anxiety and motivation: Theory and crucial experiments. In C. D. Spielberger (Ed.), *Anxiety and behavior* (pp. 23-62). New York: Academic Press.
- Cattell, R. B. (1978). *The scientific use of factor analysis in the behavioral and life sciences*. New York: Plenum.
- Cattell, R. B., & Baggaley, A. R. (1960). The salient variable similarity index for factor matching. *British Journal of Statistical Psychology*, 13, 33-46.
- Cattell, R. B., & Scheier, I. H. (1961). *The meaning and measurement of neuroticism and anxiety*. New York: Ronald Press.
- Chansky, N. M. (1966). Anxiety, intelligence, and achievement in algebra. *Journal of Educational Research*, 60, 90-91.
- Chavira, D. A., Stein, M. B., Bailey, K., & Stein, M. T. (2004). Comorbidity of generalized social anxiety disorders and depression in a pediatric primary care sample. *Journal of Affective Disorders*, 80(2-3), 163-171.
- Chemtob, C. M., Nakashima, J., & Carlson, J. G. (2002). Brief treatment for elementary school children with disaster-related posttraumatic stress disorder: A field study. *Journal of Clinical Psychology*, 58(1), 99-112.
- Childre's fears and anxieties. (2004, December). *Harvard Mental Health Letter*, 21(6), 1.
- Cochran, I. L., & Cleland, C. C. (1963). Manifest anxiety of retarded and normals matched to academic achievement. *American Journal of Mental Deficiency*, 67, 539-542.
- Cohen, J. (1992). A power primer. *Psychological Bulletin*, 112, 155-159.
- Cole, D. A., Hoffman, K., Tram, J. M., & Maxwell, S. E. (2000). Structural differences in parent and child reports of children's symptoms of depression and anxiety. *Psychological Assessment*, 12(2), 174-185.
- Collins-Jones, T. L. (1997). AIDS orphans: The psychological adjustment of children with multiple family member with a terminal illness. *Dissertation Abstracts International*, 58(5), 2659B.
- Cook, D. A. (2000). Gestalt treatment of adolescent females with depressive symptoms: A treatment outcome study. *Dissertation Abstracts International*, 60(8), 4210B.
- Cooley-Quille, M., Boyd, R. C., Frantz, E., & Walsh, J. (2001). Emotional and behavioral impact of exposure to community violence in inner-city adolescents. *Journal of Child Psychology*, 30(2), 199-207.

- Conners, C. K. (1989). *Conners' Rating Scales (CRS)*. North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems.
- Coronado, V. (1995). The anxiety of learning-disabled school children with remedial instruction. *Dissertation Abstracts International*, 55(10), 3154A.
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16, 297-334.
- Cronbach, L. J. (1984). *Essentials of psychological testing* (4th ed.). New York: Harper & Row.
- Cronbach, L. J. (1988). Internal consistency of test: Analyses old and new. *Psychometrika*, 53, 63-70.
- Cullain, R. E. (2002). The effects of social stories on anxiety levels and excessive behavioral expressions of elementary school-aged children with autism. *Dissertation Abstracts International*, 62(7), 2383A.
- Curry, J. F., March, J. S., & Hervey, A. S. (2004). Comorbidity of childhood and adolescent anxiety disorders: Prevalence and implications. In T. H. Ollendick & J. S. March (Eds.), *Phobic and anxiety disorders in children and adolescents: A clinician's guide to effective psychosocial and pharmacological interventions* (pp. 116-140). New York: Oxford University Press.
- Dadds, M. R., Perrin, S., & Yule, W. (1998). Social desirability and self-reported anxiety in children: An analysis of the RCMAS Lie scale. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 26(4), 311-317.
- Dan, E. (1996). Secondary traumatization in the adolescent offspring of Vietnam veterans with Posttraumatic Stress Disorder. *Dissertation Abstracts International*, 56(12), 709B.
- Darwin, C. (1965). *Expression of the emotions in man and animals*. Chicago: University of Chicago Press. (Original work published in 1872).
- Demos, V. C., & Prout, M. F. (1994). A review of scales for the brief assessment of anxiety. In L. VandeCreek, S. Knapp, & T. L. Jackson (Eds.), *Innovations in clinical practice: A source book* (Vol. 13, pp. 167-178). Sarasota, FL: Professional Resource Press/Professional Resource Exchange.
- Devault, S. L. (2001). Predictors of biopsychosocial health status in children with asthma. *Dissertation Abstracts International*, 62(5), 2480B.
- Dierker, L. C., Albano, A. M., Clarke, G. N., Heimberg, R. G., Kendall, P. C., Merikangas, K. R., et al. (2001). Screening for anxiety and depression in early adolescence. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 40(8), 929-936.
- DiFranza, J. R., Savageau, J. A., Rigotti, N. A., Ockene, J. K., McNeill, A. D., Coleman, M., et al. (2004). Trait anxiety and nicotine dependence in adolescents: A report from the DANDY study. *Addictive Behaviors*, 29(5), 911-919.
- Dingwall, J. A. (1997). Perception of facial expressions of emotion by children with severe, moderate and low levels of physical discipline. *Dissertation Abstracts International*, 57(8), 5322B.
- Donald, D. R. (1993). Anxiety in the relationship of group acceptance to the academic achievement of pre-adolescents. *Psychologia Africana*, 15, 1-6.
- Donnelly, T. F. (1995). Effect of parental reaction on depression, anxiety, and self-esteem in sexually abused children. *Dissertation Abstracts International*, 56(5), 2896B.
- Drummond, E. H. (1997). *Overcoming anxiety without tranquilizers: A groundbreaking program for treating chronic anxiety*. Portsmouth, NH: Seacoast Mental Health Center.
- Ebel, R. L. (1965). *Measuring educational achievement*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Fenz, W. D., & Epstein, S. (1965). Manifest anxiety: Unifactorial or multifactorial composition? *Perceptual and Motor Skills*, 20, 773-780.
- Ferrando, P. J. (1994). Factorial structure of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale in a Spanish sample: Relations with Eysenck personality dimensions. *Personality and Individual Differences*, 16(5), 693-699.
- Ferrando, P. J., & Aguilar, A. A. (1992). Ansiedad manifiesta neuroticismo e introversión: un análisis factorial confirmatorio [Manifest anxiety, neuroticism and introversion: A confirmatory factorial analysis]. *Revista de Psicología General y Aplicada*, 45(4), 385-390.
- Finch, A. J., Anderson, J., & Kendall, P. C. (1976). Anxiety and digit span performance of emotionally disturbed children. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 44, 847.
- Finch, A. J., Kendall, P. C., & Montgomery, L. E. (1974). Multidimensionality of anxiety in children: Factor structure of the Children's Manifest Anxiety Scale. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 2, 331-336.
- Finch, A. J., Montgomery, L. E., & Deardoff, P. A. (1974). Children's Manifest Anxiety Scale: Reliability with emotionally disturbed children. *Psychological Reports*, 34, 68.
- Finch, A. J., & Rogers, R. T. (1984). Self-report instruments. In T. Ollendick & M. Hersen (Eds.), *Child behavioral assessment: Principales and procedures* (pp. 106-123). New York: Pergamon Press.

- Fiore, L. B. (2000). Parental evaluation of a four-step procedure designed to help parents alleviate their child's level of generalized anxiety. *Dissertation Abstracts International*, 61(2), 1110B.
- Flanagan, P. J., Peters, C. J., & Conry, J. L. (1969). Item analysis of the Children's Manifest Anxiety Scale with the retarded. *Journal of Educational Research*, 62(10), 472-477.
- Flesch, R. (1979). *How to write plain English: A book for lawyers and consumers*. New York: Harper & Row.
- Forest, M. T. (1997). The integration of projective expressive arts in therapeutic sessions: The initial study of "StoryCards" as a treatment modality for anxiety among adolescents. *Dissertation Abstracts International*, 57(10), 6570B.
- Frankl, V. (1963). *Man's search for meaning: An introduction to logotherapy*. New York: Pocket Books.
- Freud, S. (1924). *Collected papers* (Vol. 1). London: Hogarth Press.
- Friedman, A. G., Campbell, T., & Okifuji, A. (1991). Specific fears as predictors of generalized anxiety in children. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 13(1), 45-52.
- Gaudry, E., & Spielberger, D. (1971). *Anxiety and educational achievement*. Sydney, Australia: Wiley.
- Gerard, A. B., & Reynolds, C. R. (2004). Characteristics and applications of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale (RCMAS). In M. E. Maruish (Ed.), *The use of psychological testing for treatment planning and outcomes assessment: Vol. 2 Instruments for children and adolescents* (3rd ed., PP. 63-79). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Gillis, J. (1980). *Child Anxiety Scale*. Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing.
- Ginsburg, G. S., Siqueland, L., Masia-Warner, C., & Heatke, K. A. (2004). Anxiety disorders in children: Family matters. *Cognitive and Behavioral Practice*, 11(1), 28-43.
- Ginter, E. J., Glauser, A., & Richmond, B. O. (1994). Loneliness, social support, and anxiety among two South Pacific cultures. *Psychological Reports*, 74, 875-879.
- Ginter, E. J., Lufi, D., Trotzby, A. S., & Richmond, B. O. (1989). Anxiety among children in Israel. *Psychological Reports*, 65, 803-809.
- Goodenough, F. L., & Harris, D. B. (1963). *Goodenough-Harris Drawing Test*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Gottschalk, I. O., & Gleser, G. C. (1969). *The measurement of psychological states through the content analysis of verbal behavior*. Los Angeles: University of California Press.
- Guilford, J. P. (1954). *Psychometric methods* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Hagborg, W. J. (1991). The Revised Children's Manifest Anxiety Scale and social desirability. *Educational and Psychological Measurement*, 51(2), 423-427.
- Hagborg, W. J. (1991). Prevalence and correlates of self-reported depressive mood among seriously emotionally disturbed adolescents. *Psychological Reports*, 70(1), 23-26.
- Hare, T. A., Tottenham, N., Davidson, M. C., Glover, G. H., & Casey, B. J. (2005). Contributions of amygdala and strial activity in emotional regulation. *Biological Psychiatry*, 57(6), 624-632.
- Harman, H. H. (1976). *Modern factor analysis* (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Hathaway, S. R., & McKinley, J. C. (1943). *Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Heinrichs, N. (1998). Effekte von Autogenem Training und kognitiven Spielen bei der Behandlung von Prüfungsangst bei Kindern und Jugendlichen [Effects of autogenic training and cognitive games in treatment of test anxiety in children and adolescents]. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 12(2-3), 191-194.
- Hirshfeld-Becker, D. R., Biederman, J., & Rosenbaum, J. F. (2004). *Behavior inhibition in anxiety disorders in children and adolescents* (2nd ed.). New York: Guilford Press.
- Hodges, K. (1990). Depression and anxiety in children: A comparison of self-report questionnaires to clinical interview. *Psychological Assessment*, 2(4), 376-381.
- Hooper, S. R., Richmond, B. O., & McChesney, S. R. (1987). Concurrent validity of the Common Belief Inventory for students. *Perceptual and Motor Skills*, 64, 331-334.
- Hopko, D. R. (1998). Mathematics and working memory Support for the existence of a deficient inhibition mechanism. *Journal of Anxiety Disorders*, 12(4), 343-355.
- Horst, D. P., Tallmadge, G. K., & Wood, C. T. (1975). *A practical guide for measuring Project impact on student achievement* (Office of Education Monograph No. 1, Evaluation in Education Series), Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
- Hunter, J. E. (1975, December). *A critical analysis of the use of item means and item-test correlations to determine the presence or absence of content bias in achievement test items*. Paper presented at the National Institute of Education Conference on Test Bias, Annapolis, MD.

- Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (1976). Critical analysis of the statistical and ethical implications of various definitions of test bias. *Psychological Bulletin*, 83, 1053-1071.
- Imeri, D. S. (1997). Emotional distress and behavioral problems in children of chronic pain patients. *Dissertation Abstracts International*, 58(3), 1534B.
- Inderbitzen-Nolan, H. M., & Walters, K. S. (2000). Social Anxiety Scale for Adolescents: Normative data and further evidence of construct validity. *Journal of Clinical Child Psychology*, 29(3), 360-371.
- Izard, C. E. (1972). Anxiety: A variable combination of interacting fundamental emotions. In C. D. Spielberger (Ed.), *Anxiety: Current trends in theory and research* (pp. 51-106). New York: Academic Press.
- James, E. M., Reynolds, C. R., & Dunbar, J. (1994). Self-report instruments. In T. H. Ollendick, N. J., King, & W. Yule (Eds.), *International handbook of phobic and anxiety disorders in children and adolescents: Issues in clinical child psychology* (pp. 317-329). New York: Plenum.
- Jensen, A. R. (1980). *Bias in mental testing*. New York: Free Press.
- Johnson, J. J. (2004). A comparative study of stress in public and Catholic elementary school fourth-grade students in relationship to after-school activities. *Dissertation Abstracts International*, 65(5), 1663^a.
- Joiner, T. E. (1996). The relations of thematic and nonthematic childhood depression measures to defensiveness and gender. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 24(6), 803-813.
- Joiner, T. E., Schmidt, K. L., & Schmidt, N. B. (1996). Low-end specificity of childhood measures of emotional distress: Differential effects for depression and anxiety. *Journal of Personality Assessment*, 67(2), 258-271.
- Kalter, N., Lohnes, K., Chasin, J., Cain, A. C., Dunning, S., & Rowan, J. (2002-2003). The adjustment of parentally bereaved children: I. Factors associated with short-term adjustment. *Omega: Journal Of Death and Dying*, 46(1), 15-34.
- Kamps, J. L., Roberts, M. C., & Varela, R. E. (2005). Development of a new fear of hypoglycemia scale: Preliminary results. *Journal of Pediatric Psychology*, 30(3), 287-291.
- Kao, C. C. (2001). Children's stress and after-school lives in Taiwan (China). *Dissertation Abstracts International*, 62(4), 2093B.
- Katz, P. K., & Zigler, P. K. (1967). Self-image disparity: A development approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5, 186-195.
- Kendall, P. C., & Ollendick, T. H. (2004). Setting the research and practice agenda for anxiety in children and adolescence: A topic comes of age. *Cognitive and Behavioral Practice*, 11(1), 65-74.
- Kessler, W. C., Chiu, W. T., Demler, O., & Walters, E. E. (2005). Prevalence, severity, and comorbidity of twelve-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R). *Archives of General Psychiatry*, 62(6), 617-627.
- Kierkegaard, S. (1944). *The concepts of dread* (W. Lowrie, Trans.). Princeton, NJ: Princeton University Press. (Original work published in 1844).
- Kitano, H. L. (1960). Validity of the Children's Manifest Anxiety Scale and modified revised California inventory. *Child Development*, 31, 67-72.
- Kodero, H. M. N. (2001). The effects of residential destination on the education and psychological status of AIDS orphans. *Dissertation Abstracts International*, 62(5), 1733^a.
- Koppitz, E. M. (1977). *The visual-aural digit span test*. New York: Grune & Stratton.
- Koppitz, E. M. (1982). Personality assessment in the schools. In C. R. Reynolds & T. B. Gutkin (Eds.), *The handbook of school psychology* (pp. 273-295). New York: Wiley.
- Kovacs, M., & Davlin, B. (1998). Internalizing disorders in childhood. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 39(1), 47-63.
- Kovacs, M., & Multi-Health Systems. (2003). *Children's Depression Inventory: Technical manual update*. North Tarrytown, NJ: Multi-Health Systems.
- Krause, M. S. (1961). The measurement of transitory anxiety. *Psychological Review*, 68, 178-189.
- Kritzech, J. (1956). Philosophers of anxiety. *Common Weal*, 63, 572-574.
- Kubiak, C. H. S. (1998). The relationship between community crime level and the manifestation of anxiety in a referred sample of children. *Dissertation Abstracts International*, 58(7), 2546A.
- Ladd, G. T. (2000). An investigation of parental perceptions and evaluations of a four-step procedure designed to help parents alleviate their adolescents' level of generalized anxiety. *Dissertation Abstracts International*, 61(2), 509^a.
- Laksana, S., & Coffman, W. E. (1980). *A comparison of an ANOVA approach and an ICC approach for assessing item bias in an achievement test* (Occasional Paper #29). Iowa City, Iowa: Iowa Testing Program.

- Landa, M. C. (1995). The relationship of conflicting stimuli, evaluation apprehension, and anxiety with a task of Word recognition by children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. *Dissertation Abstracts International*, 55(10), 4607B.
- Landman, W. S. (2001). Having a parent with Human Immuno-deficiency Virus: Impact on the surviving child's mental health. *Dissertation Abstracts International*, 60(3), 1299-1304.
- Lee, S. W., Piersel, W. C., Friedlander, R., & Collamer, W. (1988). Concurrent validity of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale (RCMAS) for adolescents. *Educational and Psychological Measurement*, 48(2), 429-433.
- Lee, S. W., Piersel, W. C., & Unruh, L. (1989). Concurrent validity of the physiological subscale of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale: A multitrait-multimethod analysis. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 7(3), 246-254.
- Li, H. (2004). Fears and related anxieties in children having a disability. *Dissertation Abstracts International*, 64(9), 3190A.
- Logan, P., & Loo, R. (1979). Source of covariation between the state and trait scales of the State-Trait Anxiety Inventory. *Journal of Psychology*, 103, 3-5.
- Logue, M. B. (1998). Panic and anxiety disorders in an outpatient pediatric cardiology sample. *Dissertation Abstracts International*, 59(2), 0877B.
- Lomas, K. M. (2002). Computer-assisted cognitive training with elementary school-age children diagnosed with attention-deficit/hyperactivity disorder and mild/moderate comorbidity: A short-term prospective study on attention, planning and behavior. *Dissertation Abstracts International*, 63(1), 535B.
- Loo, R. (1979). The State-trait Anxiety Inventory A-Trait scale: Dimensions and their generalization. *Journal of Personality Assessment*, 43, 50-53.
- Lord, F. M. (1977). A study of item bias using item characteristic curve theory. In N. M. Poortinga (Ed.), *Basic problems in cross-cultural psychology* (pp. 19-29). Amsterdam: Swits & Vitlenger.
- Lowe, P. A. (2001) Common and uncommon manifestations of anxiety across the life span. *Dissertation Abstracts International*, 61(7)-3896B.
- Lowe, P. A., & Reynolds, C. R. (2000). Exploratory analyses of the latent structure of anxiety among older adults. *Educational and Psychological Measurement*, 60(1), 100-116.
- Lyons-Sjostrom, K. A. (2004). Adjustment in siblings of children with disabilities. *Dissertation Abstracts International*, 65(6), 3169B.
- Maher, B. A. (1966). *Principles of psychopathology*. New York: McGraw-Hill.
- March, J. S., & Parker, J. D. A. (1999). The Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC). In M. E. Maruish (Ed.), *The use of psychological testing for treatment planning and outcomes assessment* (2nd ed., pp. 299-322). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Markon, S., & Fiese, B. H. (2000). Family rituals, as a protective factor for children with asthma. *Journal of Pediatric Psychology*, 25(7), 471-479.
- Martin, B. (1961). The assessment of anxiety by physiological behavioral measures. *Psychological Bulletin*, 58, 234-255.
- Mather, A., & Cartwright-Harmon, S. (2004). Cognitive predictors of obsessive-compulsive symptoms in adolescence: A preliminary investigation. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, 33(4), 743-749.
- Mattison, R. E., Bagnato, S. J., & Brubaker, B. H. (1988). Diagnostic utility of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale in children with DSM-III anxiety disorders. *Journal of Anxiety Disorders*, 2(2), 147-155.
- May, R. (1977). *The meaning of anxiety*. New York: Norton.
- Melamed, B. G., & Siegel, L. J. (1975). Reduction of anxiety in children facing hospitalization and surgery by use of filmed modeling. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 43(4), 511-521.
- Menke, E. M., & Wagner, J. D. (1997). A comparative study of homeless, previously homeless, and never homeless school aged children's health. *Issues in Comprehensive Pediatric Nursing*, 20(3), 153-173.
- Mennen, F. E. (2004). PTSD symptoms in abused Latino children. *Child and Adolescent Social Work Journal*, 21(5), 477-493.
- Merrell, K. W., Anderson, K. E., & Michael, K. D. (1997). Convergent validity of the Internalizing Symptoms Scale for children with three self-report measures of internalizing problems. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 15(1), 56-66.
- Merryman, E. P. (1974). The effects of manifest anxiety on the Reading achievement of fifth grade students. *Journal of Experimental Education*, 42(3), 36-41.
- Michaels, A. F. (2000). Children's anxieties and social cognitions. *Dissertation Abstracts International*, 61(1), 541B.
- Miham, M. P., Nugent, A. C., Drevets, W. C., Dickstein, D. P., Leibenluft, E., Ernst, M., et al. (2005). Selective reduction in amygdala volumen in pediatric anxiety disorders: A voxel-based morphometry investigation. *Biological Psychiatry*, 57(9), 961-966.

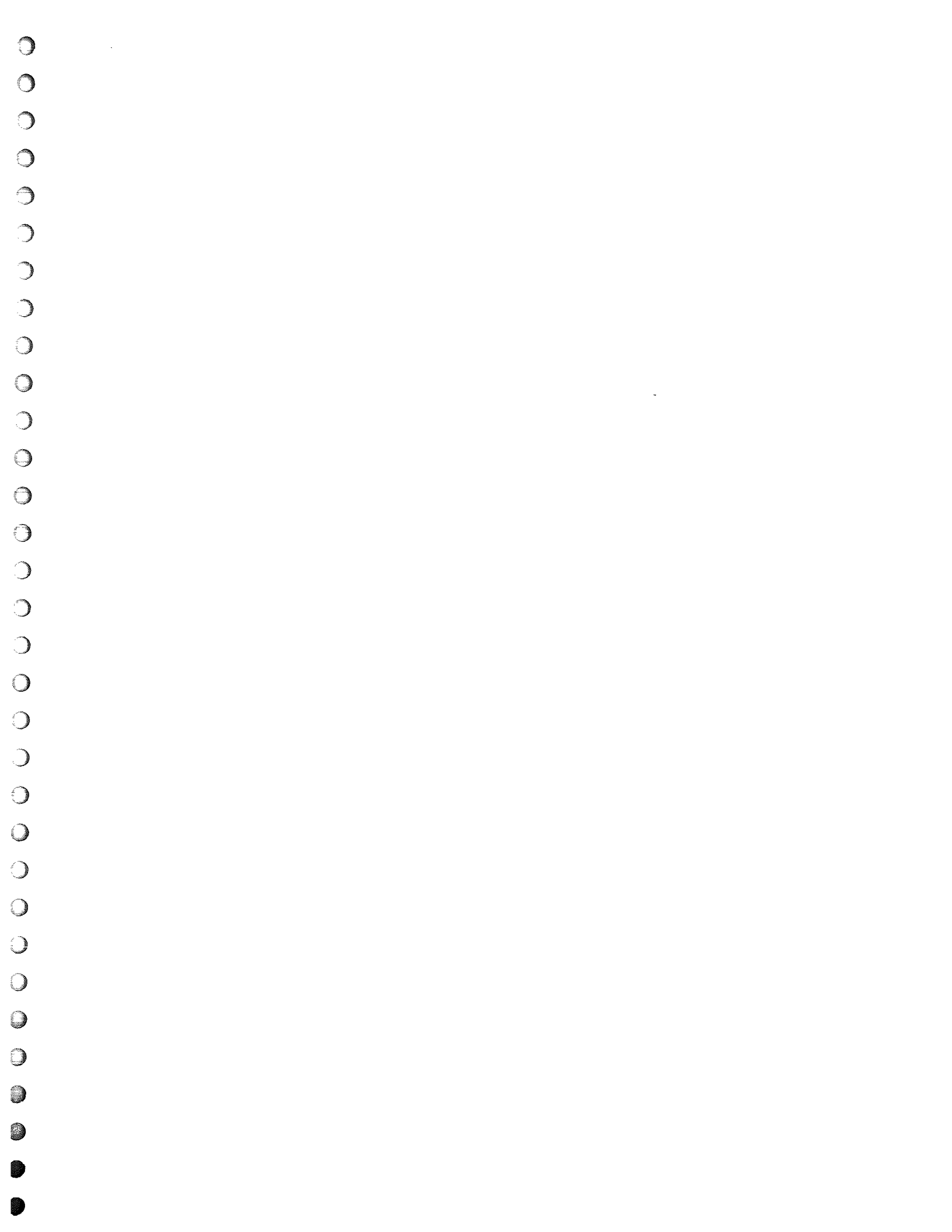
- Milton, J. (1993). *Paradise lost*. New York: Norton. (Original work published in 1667)
- Mosher, D. L. (1966). Differential influence of guilt on the verbal operant conditioning of hostile and "superego" verbs. *Journal of Consulting Psychology, 30*, 280.
- Moze, T., Meiri, G., Ben-Amity, G., Sabbagh, M., & Weizman, A. (2005). Rboxetine as an optional treatment for Hyperkinetic Conduct Disorder: A prospective openlabel trial. *Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 15*(2), 259-269.
- Mulaik, S. A. (1971). *The foundations of factor analysis*. New York: McGraw-Hill.
- Muralidharan, R., & Sharma, A. (1971). Manifest anxiety in Indian (Delhi) children. *Indian Educational Review, 6*(2), 67-68.
- Muris, P., Merckelbach, H., Mayer, B., van Brakel, A., Thissen, S., Moulaert, V., et al. (1998). The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) and traditional childhood anxiety measures. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 29*(4), 327-339.
- Muris, P., Merckelbach, H., Ollendick, T., King, N., & Bogie, N. (2002). Three traditional and three new childhood anxiety questionnaires: Their reliability and validity in a normal adolescent sample. *Behaviour Research and Therapy, 40*(7), 753-772.
- Naylor, F. D. (1978). Success and failure experiences and the factor structure of the State-Trait Anxiety Inventory. *Australian Journal of Psychology, 30*, 217-222.
- Niggemeyer-Hall, A. E. (2001). Family interaction factors and anxiety in adolescent females. *Dissertation Abstracts International, 62*(3), 1592B.
- Northman, L. M. (2003). Predicting adherence with pediatric HIV/AIDS regimens: Understanding the role of the child. *Dissertation Abstracts International, 64*(1), 427B.
- Nunnally, J. C. (1978). *Psychometric theory* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Ólason, D. T., Sighvatsson, M. B., & Smámi, J. (2004). Psychometric properties of the Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC) among Icelandic schoolchildren. *Sandinavian Journal of Psychology, 45*(5), 429-436.
- Ollendick, T. H., & Yule, W. (1990). Depression in British and American children and its relation to anxiety and fear. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 58*(1), 126-129.
- Paget, K. D., & Reynolds, C. R. (1984). Dimensions, levels and reliabilities on the Revised Children's Manifest Anxiety Scale with learning disabled children. *Journal of Learning Disabilities, 17*, 137-141.
- Palinski, C. O. (1997). Youthful anxiety and perceptions of family environment. *Dissertation Abstracts International, 58*(4), 2133B.
- Pavuluri, M. N., Henry, D., & Allen, K. (2002). Anxiety and fear: Discriminant validity in the child and adolescent practitioner's perspective. *European Child and Adolescent Psychiatry, 11*(6), 273-280.
- Peck, R. F., & Mitchell, J. V. (1967). *Mental health: What research says to the teacher*, Washington, DC: National Educational Association of Classroom Teachers.
- Pela, O. A., & Reynolds, C. R. (1982). Cross-cultural application of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale: Normative and reliability data for Nigerian primary school children. *Psychological Reports, 51*, 1135-1138.
- Perrin, S., & Last, C. G. (1992). Do Childhood anxiety measures measure anxiety? *Journal of Abnormal Child Psychology, 20*(6), 567-578.
- Piers, E. V., Harris, D. B., & Herzberg, D. S. (2002). *Piers-Harris Children's Self-Concept Scale, Second Edition (Piers-Harris 2): Manual*. Los Angeles: Western Psychological Services.
- Pina, A. A., & Silverman, W. K. (2004). Clinical phenomenology, somatic symptoms, and distress in Hispanic/Latino and European American youths with anxiety disorders. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33*(2), 227-236.
- Pina, A. A., Silverman, W. K., Saavedra, L. M., & Weems, C. F. (2001). An analysis of the RCMA Lie scale in a clinic sample of anxious children. *Journal of Anxiety Disorders, 15*(5), 443-457.
- Pliszka, S. R., Rogeness, G. A., & Medrano, M. A. (1988). DBH, MHPG, and MAO in children with depressive, anxiety, and conduct disorders: Relationship to diagnosis and symptom ratings. *Psychiatry Research, 24*(1), 35-44.
- Qin-Mei, X., & Qing-Hua, Y. (2003). Investigation of responses of children with high or low anxiety to teacher's authority. *Chinese Journal of Clinical Psychology, 11*(2), 119-120.
- Raleigh, H. A. (2001). A preliminary examination of the efficacy of a parent training protocol for separation anxiety disorders. *Dissertation Abstracts International, 62*(4), 2074B.
- Rajaratnam, N., Cronbach, L. J., & Gleser, G. C. (1965). Generalizability of stratified-parallel tests. *Psychometrika, 30*, 39-56.
- Raney, I. V. (1999). The relationship between emotions, moral reasoning and rule violations in early adolescence. *Dissertation Abstracts International, 59*(10), 5585B.
- Reid, S. C. (2004). The nature of cognitive biases in childhood. *Dissertation Abstracts International, 65*(6), 3202B.

- Resko, J. A. (2004). Self-reported depression and anxiety in youth with and without PTSD as a function of stressor type. *Dissertation Abstracts International*, 64(12), 4360^a.
- Reynolds, C.R. (1978). *Differential validity of several preschool assessment instruments for blacks, whites, males, and females*. Unpublished doctoral dissertation. University of Georgia, Athens.
- Reynolds, C. R. (1980). Concurrent validity of What I Think and Feel: The Revised Children's Manifest Anxiety Scale. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 48, 774-775.
- Reynolds, C. R. (1981). Long-term stability of scores on the Revised Children's Manifest Anxiety Scale. *Perceptual and Motor Skills*, 53, 702.
- Reynolds, C. R. (1982a). Methods for detecting construct and predictive bias. In R. A. Berk (Ed.), *Handbook of methods for detecting test bias* (pp. 100-227). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Reynolds, C. R. (1982b). The problema of bias in psychological assessment. In C. R. Reynolds & T. B. Gutkin (Eds.), *The handbook of school psychology* (pp. 178-208). New York: Wiley.
- Reynolds, C. R. (1982c). Convergent and divergent validity of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale. *Educational and Psychological Measurement*, 42, 1205-1212.
- Reynolds, C. R. (1985). Multitrait validation of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale for children of high intelligence. *Psychological Reports*, 56, 402.
- Reynolds, C. R. (1998). Fundamentals of measurement and assessment in psychology. In A. Bellak & M. Hersen (Series Eds.) & C. r. Reynolds (Vol. Ed.), *Comprehensive clinical psychology: Vol. 4. Assessment* (pp. 33-56). Oxford, England: Elsevier Science.
- Reynolds, C. R. (2006). *Koppitz Developmental Scoring System for the Bender Gestalt Test, Second Edition (KOPPITZ-2)*. Austin, TX: Pro Ed.
- Reynolds, C. R., Bradley, M., & Steele, C. (1980). Preliminary norms and technical data for use of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale for children of high intelligence. *Psychology in the Schools*, 17, 163-167.
- Reynolds, C. R., & Brown, R. T. (Eds.). (1984). *Perspectives on bias in mental testing*. New York: Plenum.
- Reynolds, C. R., & Harding, R. E. (1983). Outcome in two large studies of factorial similarity under six methods of comparison. *Educational and Psychological Measurement*, 43, 723-728.
- Reynolds, C. R., & Kamphaus, R. W. (2003). *Reynolds, Intellectual Assessment Scales (RIAS)*. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources.
- Reynolds, C. R., & Livingston, R. B. (in press). *Children's Measure of Obsessive-Compulsive Symptoms (CMOCS): Manual*. Los Angeles: Western Psychological Services.
- Reynolds, C. R., Livingston, R. B., & Willson, V. (2006). *Measurement and assessment in the classroom*. Boston: Allyn & Bacon.
- Reynolds, C. R., & Paget, K. D. (1981). Factor analysis of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale for blacks, whites, males and females with a national normative sample. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 49(3), 352-359.
- Reynolds, C. R., Plake, B. S., & Harding, R. E. (1983). Item bias in the assessment of children's anxiety: Race and sex interactions on items of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 1, 17-24.
- Reynolds, C. R., & Richmond, B. O. (1978). What I Think and Feel: A revised measure of children's manifest anxiety. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 6, 271-280.
- Reynolds, C. R., & Richmond, B. O. (1979). Factor structure and construct validity of "What I Think and Feel: The Revised Children's Manifest Anxiety Scale." *Journal of Personality Assessment*, 43, 281-283.
- Reynolds, C. R., & Richmond, B. O. (1985). *Revised Children's Manifest Anxiety Scale (RCMAS): Manual*. Los Angeles: Western Psychological Services.
- Reynolds, C. R., & Richmond, B. O. (1997). *Escala de ansiedad manifiesta en niños (revisada)* [Revised Children's Manifest Anxiety Scale] (G. J. Rodrigo, Trans.) Mexico City, Mexico: Editorial EL Manual Moderno, S.A. de C.V.
- Reynolds, C.R., & Richmond, B. O. (1999). *Echelle révisée d'anxiété manifeste pour enfant* [Revised Children's Manifest Anxiety Scale] (D. Castro, Trans.). Paris: Edition du Centre de Psychologie Appliquée.
- Reynolds, C. R., & Scholwinski, E. (1995). Dimensions of anxiety among high IQ children. *Gifted Child Quarterly*, 29, 125-130.
- Richmond, B. O. (1990). Anxiety: A cross-cultural phenomenon. *Directions*, 12(1), 37-43.
- Richmond, B. O., Rodrigo, G., & de Rodrigo, M. (1988). Factor structure of a Spanish version of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale in Uruguay. *Journal of Personality Assessment*, 52(1), 165-170.
- Richmond, B. O., Sukemune, S., Ohmoto, M., Kawamoto, H., & Hamazaki, T. (1984). Anxiety among Canadian, Japanese, and American children. *Journal of Psychology*, 116: 3-6.
- Roberts, G. E., & Gruber, C.P. (2005). *Roberts-2, Manual*. Los Angeles: Western Psychological Services.

- Rodrigo, G., & Lusiardo, M. (1992). Desarrollo de una versión en español de un instrumento de medida de la ansiedad manifiesta en niños y adolescentes [Development of a Spanish version of an instrument for measuring manifest anxiety in children and adolescents]. *Revista Interamericana de Psicología*, 26(2), 179-194.
- Rodriguez, C. M. (2003). Parental discipline and abuse potential affects on child depression, anxiety and attributions. *Journal of Marriage and Family*, 65(4), 809-817.
- Ryngala, D. J., Shields, A. L., & Caruso, J. C. (2005). Reliability generalization of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale. *Educational and Psychological Measurement*, 65(2), 259-271.
- Saigh, P. A. (1989). The validity of the DSM-III posttraumatic stress disorder classification as applied to children. *Journal of Abnormal Psychology*, 98(2), 189-192.
- Saigh, P. A. (1991). The development of posttraumatic stress disorder following four different type? Of traumatization. *Behaviour Research and Therapy*, 29(3), 213-216.
- Sarason, S. B., Davidson, K. S., Lighthall, F. F., Waite, R. R., & Ruebush, B. K. (1960). *Anxiety in elementary school children*. New York: Wiley.
- Schniering, C. A., Hudson, J. L., & Rapee, R. M. (2000). Issues in the diagnosis and assessment of anxiety disorders in children and adolescents. *Clinical Psychology Review*, 20(4), 453-478.
- Schutz, K. B. (2002). ADHD symptomatology: The contribution of depression and anxiety measures to an accurate diagnosis. *Dissertation Abstracts International*, 62(8), 3815B.
- Seligman, L. D., Ollendick, T. H., Langley, A. K., & Baldacci, H. B. (2004). The utility of measures of child and adolescent anxiety: A meta-analytic review of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale, the State-Trait Anxiety Inventory for Children, and the Child Behavior Checklist. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, 33(3), 557-565.
- Sgandurra, C. A. (2001). The relationship between family functioning and sibling adjustment in families with a child with a developmental disability. *Dissertation Abstracts International*, 62(3), 1598B.
- Sheftall, J. B. (1987). Levels of anxiety and stability of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale for elementary pupils. *Dissertation Abstracts International*, 47(8), 2965-2966A.
- Sheldon, H. (1998). Working with adult female survivors of childhood sexual abuse. *From hearing to healing: Working with the aftermath of child sexual abuse* (2nd ed., pp. 96-117). New York: Wiley.
- Silverman, W. K., & LaGreca, A. M. (1995). What do children worry about? Worries and their relation to anxiety. *Child Development*, 66(3), 671-685.
- Silverman, W. K., & Treffers, P. D. A. (2004). Bridging research and practice. In T. H. Ollendick & J. S. March (Eds.), *Phobic and anxiety disorders in children and adolescents* (pp. 506-529). New York: Oxford University Press.
- Singleton-Winston, L. L. (2003). Gender differences in adolescents' adjustment in remarried and recoupled families. *Dissertation Abstracts International*, 64(6), 2988B.
- Snowden, J. C. (2004). The effects of inclusion on the anxiety and self-esteem of special education students in the regular education classroom. *Dissertation Abstracts International*, 64(9), 3247A.
- Spielberger, C. D. (1972). Anxiety as an emotional state. In C. D. Spielberger (Ed.), *Anxiety: Current trends in theory and research* (p. 30). New York: Academic Press.
- Spielberger, C. D. (1973). *Preliminary manual for the State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC: "How I Feel Questionnaire")*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
- Spielberger, C. D. (1979). *Understanding stress and anxiety*. New York: Harper & Row.
- Stanwyck, D. J., & Felker, D. W. (1973). *Intellectual achievement, responsibility, and anxiety as functions of self-concept of third to sixth grade boys and girls*. Paper presented at the meeting of the American Educational Research Association. New York.
- Stark, K. D., & Laurent, J. (2001). Joint factor analysis of the Children's Depression Inventory and the Revised Children's Manifest Anxiety Scale. *Journal of Clinical Child Psychology*, 30(4), 552-567.
- Storch, E. A., Brassard, M. R., & Masia-Warner, C. L. (2003). The relationship of peer victimization to social anxiety and loneliness in adolescence. *Child Study Journal*, 33(1), 1-13.
- Storch, E. A., Roth, D. A., Coles, M. E., Nomberg, M. G., Bravata, E. A., & Moser, J. (2004). The measurement impact of childhood teasing in a sample of Young adults. *Journal of Anxiety Disorders*, 18(5), 681-694.
- Stroud, K. C., & Reynolds, C. R. (2006). *School Motivation and Learning Strategies Inventory (SMALSI): Manual*. Los Angeles: Western Psychological Services.
- Sullivan, H. S. (1953). *The interpersonal theory of psychiatry*. New York: Norton.
- Seveng, C., Zeman, J., Flannery-Schroeder, E., & Cassano, M. (2005). Emotion socialization in families of children with

- an anxiety disorder. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 33(2), 145-155.
- Switaj, D. M. (2000). Identification and measurement of anxiety and obsessive-compulsive tendencies in the Williams Syndromes behavioral phenotype. *Dissertation Abstracts International*, 61(3), 1622B.
- Tannenbaum, L. E., Forchand, R., & Thomas, A. M. (1992). Adolescent self-reported anxiety and depression: Separate constructs or a single entity. *Child Study Journal*, 22(1), 61-72.
- Taylor, J. A. (1951). The relationship of anxiety to the conditioned eyelid response. *Journal of Experimental Psychology*, 41(2), 81-92.
- Torrance, E. P. (1965). *Mental health and constructive behavior*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Torrance, E. P. (1966). *Torrance tests of creative thinking*. Columbus, OH: Personnel Press.
- Turgeon, L., & Chartrand, E. (2003). Reliability and validity of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale in a French-Canadian sample. *Psychological Assessment*, 15(3), 378-383.
- U.S. Census Bureau. (2000). *Statistical abstract of the United States: 2000* (120th ed.). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
- U.S. Department of Health and Human Services. (1999). *Mental health: A report of the Surgeon General*. Rockville, MD: Author. Available at <http://mentalhealth.samhsa.gov/features/surgeongeneralreport/home.asp>
- Varela, R. E., & Biggs, B. K. (2006). Reliability and validity of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale (RCMAS) across samples of Mexican, Mexican American and European American children: A preliminary investigation. *Anxiety, Stress and Coping: An International Journal*, 19(1), 67-80.
- Varela, R. E., Vernberg, E. M., Sanchez-Sosa, J. J., Riveros, A., Mitchell, M., & Mashunkashey, M. (2004). Anxiety reporting and culturally associated interpretation biases and cognitive schemas. A comparison of Mexican, Mexican American, and European American families. *Journal of Child and Adolescent Psychology*, 33(2), 237-247.
- Van Amerigen, M., Mancini, C., & Farvolden, P. (2003). The impact of anxiety disorders on educational achievement. *Journal of Anxiety Disorders*, 17(5), 561-571.
- Walker, H. M. (1971). *Walker Problem Behavior Identification Checklist (WPBIC)*. Manual. Los Angeles: Western Psychological Services.
- Watt, M. C. (2001). Age and gender differences in perception of control: Implications for development of anxious and dysphoric mood. *Dissertation Abstracts International*, 62(2), 1104B.
- Westbrook, M. G. L. (1998). Positive affectivity and adolescent depression. *Dissertation Abstracts International*, 59(3), 1404B.
- White, K. S. (1999). Structure of anxiety symptoms in urban children: A test of competing confirmatory factor analytic models of the RCMAS. *Dissertation Abstracts International*, 60(3), 1319B.
- White, K. S., Brure, S. E., Farrell, A. D., & Kliever, W. (1998). Impact of exposure to community violence on anxiety: A longitudinal study of family social support as a protective factor for urban children. *Journal of Child and Family Studies*, 7(2), 187-203.
- White, K. S., & Farrell, A. D. (2001). Structure of anxiety symptoms in urban children: Competing factor models of Revised Children's Manifest Anxiety Scale. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 69(2), 333-337.
- Wijnant, I. H. (2000). The challenges and opportunities for mental health in the third millennium. *Perspectives in Health*, 5, 1.
- Wilkinson, G. S., & Robertson, G. J. (2006). *Wide Range Achievement Test, Fourth Edition (WRAT-4)*. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources.
- Williams, K. S. (1997). Relationships among DAP: SPED indicators, self-report anxiety and depression scores, and behavior ratings of children ages 8-11. *Dissertation Abstracts International*, 57(10), 6643B.
- Williams, J., Steel, C., Sharp, G. B., DelosReyes, E., Phillips, T., Bates, S., et al. (2003). Anxiety in children with epilepsy. *Epilepsy and Behavior*, 4(6), 729-732.
- Wilson, D. J., Chibaiwa, D., Majoni, C., Masukume, C., & Nkoma, E. (1990). Reliability and factorial validity of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale in Zimbabwe. *Personality and Individual Differences*, 11(4), 365-369.
- Wisniewski, J. J., Mulick, J. A., Genshaft, J. L., & Coury, D. L. (1987). Test-retest reliability of the Revised Children's Manifest Anxiety Scale. *Perceptual and Motor Skills*, 65(1), 67-70.
- Wisniewski, J. J., Naglieri, J. A., & Mulick, J. A. (1988). Psychometric properties of a Children's Psychosomatic Symptom Checklist. *Journal of Behavioral Medicine*, 11(5), 497-507.
- Yaghi, H. M., & Bentley Abu-Saba, M. (1998). Teacher's computer anxiety: An international perspective. *Computers in Human Behavior*, 14(2), 1807-1814.

- Young, A. J. (1998). HIV/AIDS- affected children: A study utilizing the Rorschach to identify depression. *Dissertation Abstracts International*, 58(9), 5149B.
- Zeidner, M. (1998). *Test anxiety: The estate of the art*. New York: Plenum.
- Ziv, A., & Luz, M. (1973). Manifest anxiety in children of different socio-economic levels. *Human Development* 16(2), 24-32.
- Ziv, O., & Shauber, H. (1969). Contribution to a cross-cultural study of manifest anxiety in children. *Human Development*, 12, 178-191.





www.manualmoderno.com

MP 90-1

ISBN: 978-607-448-265-2

